患者与家属的循证治疗科普

精神分裂症治疗

从幻觉妄想到药物、康复与长期管理

13 个模块 · 64 篇 · V1.0 / 2026-10

本资料库仅用于科普学习，不能替代精神科医生面诊、诊断与处方。

出现自杀念头、意识障碍、严重过敏、胸痛晕厥等情况，请立即拨打 120 或前往急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

使用边界与安全声明

这是一本写给患者和家属的治疗科普书。它把精神分裂症治疗拆成 13 个模块，覆盖从初诊、选药、心理治疗、物理治疗，到疗程、停药、复发和危机应对的完整路径。

它不能替代面诊、诊断和处方。所有具体用药、剂量、减量、住院与特殊人群决策，都必须由具备资质的精神科医生结合个体情况作出。

请先记住三件事

- 抗精神病药的起效通常以天到周计，阳性症状可能较快减轻，但阴性症状、认知和功能恢复需要更长时间。
- 不要自行突然停药、减量、换药或叠加药物；停药需要在医生指导下缓慢进行。
- 出现自杀念头、自伤行为、意识障碍、高热、严重过敏、胸痛、晕厥、抽搐，立即拨打 120 或去急诊。

版本与引用

版本 V1.0，最后更新 2026-10。指南、药物适应证、医保政策与热线号码会变化；与面诊医生或最新指南不一致时，以医生和最新指南为准。引用请注明《精神分裂症治疗资料库》V1.0，并附具体篇目。

书中案例均为合并、改写后的示意，不对应任何真实个人。

总目录

按模块顺序排列。每篇正文都可独立阅读；书末附 60 个术语与主要指南来源。

使用说明

00 使用说明与免责声明

模块 1：基础与总论

1.1 精神分裂症是什么：症状、病程与常见误解

1.2 诊断分类与谱系：ICD-11、DSM-5-TR

1.3 流行病学、起病年龄与预后

1.4 常见名词与误区

模块 2：临床表现与评估

2.1 阳性症状：幻觉与妄想

2.2 阴性症状：情感平淡、意志缺乏与社交退缩

2.3 认知损害：注意、记忆与执行功能

2.4 行为与情绪表现：激越、紧张症、抑郁与自杀风险

2.5 疾病分期：前驱期、急性期、巩固期、维持期

2.6 精神检查与评估工具

模块 3：病因与机制

3.1 遗传与家族风险

3.2 神经递质：多巴胺、谷氨酸与 GABA

3.3 脑结构、神经发育与炎症

3.4 环境风险：孕产期、感染、移民、城市、大麻

3.5 心理社会因素、研究局限与“致病家庭”误区

模块 4：就医与诊断

4.1 就诊渠道与首诊时机

4.2 初诊准备与病史采集

4.3 诊断流程与鉴别诊断

4.4 共病筛查与躯体检查

模块 5：药物治疗

5.1 抗精神病药总览：一代与二代

5.2 首发、复发与难治性：如何选药

5.3 剂量、疗程与血药浓度

5.4 常见副作用与处理

5.5 锥体外系反应与迟发性运动障碍

5.6 代谢综合征、体重与血糖血脂

5.7 高催乳素、性功能、QT 与低血压

5.8 氯氮平：难治性精神分裂症与监测

5.9 长效针剂、换药、联合与停药

模块 6：心理社会治疗与康复

6.1 心理社会干预总览

6.2 心理教育

6.3 CBTp：针对精神病性症状的认知行为治疗

6.4 家庭干预

6.5 社交技能训练

6.6 职业康复与支持性就业

6.7 认知矫正、同伴支持与个案管理

模块 7：物理与其他治疗

7.1 无抽搐电休克 ECT

7.2 rTMS 与 tDCS

7.3 中医、针灸与补充剂证据

模块 8：特殊人群

8.1 儿童青少年精神分裂症

8.2 老年精神分裂症

8.3 孕产期精神分裂症

8.4 躯体疾病与物质使用共病

模块 9：风险管理

9.1 自杀风险

9.2 暴力风险评估

9.3 紧张症与恶性综合征

9.4 药物与躯体急症：EPS、NMS、噎食、跌倒

模块 10：复发预防与长期管理

10.1 复发预警信号

10.2 维持治疗与依从性
10.3 社区随访与个案管理
10.4 康复目标与生活质量

模块 11：危机、住院与法律

11.1 急性兴奋激越的现场处理
11.2 住院指征与自愿非自愿
11.3 精神卫生法与权益
11.4 监护、残疾、病假与医保

模块 12：家庭、社会与污名

12.1 家属照护手册
12.2 沟通与边界
12.3 病耻感与社交
12.4 工作、学习与社区融入

模块 13：误区、问答与工具

13.1 症状日记与复发预警表
13.2 常用量表：PANSS、BPRS、SAPS、SANS、PSP
13.3 复诊沟通单与用药记录
13.4 常见误区与高频问答

附录：术语与参考文献

A 术语表
B 参考文献与指南版本

使用说明

00 使用说明与免责声明

> 这是一套写给精神分裂症患者和家属的治疗科普资料，共 13 个模块、64 篇。它想帮你把“精神分裂症”这件事看清楚：有哪些症状、怎么诊断、药物和心理社会治疗各自能做什么、副作用怎么监测、复发和危机怎么处理。它**不能替代面诊、诊断和处方**。

这套资料想解决什么问题

精神分裂症常被两种极端说法包围：一种是“疯了、没救了”，另一种是“想开点、别胡思乱想”。前者让人绝望，后者让人延误治疗。两种说法都不符合事实。

这套资料想把治疗拆成可以理解、可以讨论、可以执行的小块：

- **知道疾病是什么**：阳性症状、阴性症状、认知损害分别指什么，为什么不是“人格分裂”。
- **知道治疗的全貌**：抗精神病药、心理社会干预、康复、家庭支持各自站在什么位置。
- **知道药怎么用、怎么监测**：疗效、副作用、血药浓度、氯氮平监测、长效针剂。
- **知道怎么预防复发**：早期信号、维持治疗、依从性、社区随访。
- **知道什么时候危险**：自杀、暴力、紧张症、恶性综合征、噎食、氯氮平相关发热。
- **知道家庭和社会怎么参与**：沟通、边界、病耻感、工作学习、法律权益。

它不是什麼

- 不是诊断工具。对照症状给自己或家人“确诊”，可能把双相障碍、抑郁伴精神病性症状、物质所致精神病、器质性精神病误当成精神分裂症。
- 不是处方集。本资料刻意不写起始剂量、加量速度和减量方案，这些必须由医生结合诊断、年龄、体重、肝肾功能、合并用药、既往反应决定。
- 不是“靠意志力就能好”的励志手册。精神分裂症需要规范治疗和长期管理，意志力不能替代药物和康复。
- 不是“所有患者都会暴力”的恐吓材料。大多数患者并不暴力，暴力风险与特定症状、物质使用、治疗中断等因素有关。
- 不是法律意见。非自愿住院、监护、残疾、病假、医保，以现行法律和当地政策为准。

三种读法

第一种：从头读。 适合刚被诊断、时间比较充裕的人。按模块 1 → 2 → 4 → 5 → 6 → 10 的顺序，先理解疾病，再看诊断、治疗和长期管理。

第二种：带着问题查。 适合已经在治疗中的人。直接看总目录里“这一页解决什么”，找到对应篇目；每篇都能独立阅读。

第三种：只看最要紧的。 如果现在正被急性症状、激越、拒食或副作用困住，先读三页：

1. 11.1 急性兴奋/激越的现场处理
2. 9.1 自杀风险
3. 5.4 常见副作用与处理

五种内容标签

标签	含义	你该怎么用
【指南】	NICE、中国精神分裂症防治指南等有明确推荐	可以作为和医生讨论的依据
【研究】	随机对照试验、系统综述支持，但未必进入所有指南	可以了解，别当成唯一答案
【临床经验】	临床常见做法，个体差异大，证据等级较低	参考，不要照搬
【待验证】	机制推测、小样本研究、争议观点	保持开放，别当结论
【个人体验】	康复者或家属的主观感受	共情用，不代表普遍规律

标签不是“真假”的判决，而是提醒你：**这条信息有多硬，适不适合拿来指导自己的治疗。**

安全声明（请先读）

精神分裂症治疗里，有些情况不能等：

- **出现自杀念头、自伤行为，或已经做出计划：**不要独处，联系信任的人陪着，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- **出现命令性幻听、坚信自己被追杀/被控制、明显激越或伤人风险：**不要争辩、不要围堵，先保证安全，拨打 120 或 110，尽快精神科急诊评估。
- **服用氯氮平后出现发热、咽痛、口腔溃疡、乏力：**立即查血常规，可能是粒细胞缺乏，不能等下次复诊。
- **出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快、尿少：**可能是恶性综合征，立即急诊。
- **出现木僵、缄默、拒食、违拗、蜡样屈曲：**可能是紧张症，需急诊精神科评估。
- **突然出现吞咽困难、进食呛咳、呼吸困难：**警惕噎食或吸入性肺炎，立即急诊。
- **抗精神病药突然停药后出现严重失眠、激越、幻觉加重、头痛、恶心：**尽快联系医生；不要自行硬停或自行加回原量。

如果你不确定“算不算严重”，按严重处理。**宁可白跑一趟，不要赌。**

关于治疗：三句最重要的话

1. **精神分裂症是可以治疗的。** 抗精神病药能控制大部分阳性症状，心理社会干预和康复能改善功能与生活质量。
2. **治疗是长期的。** 首发患者通常也需要较长时间的维持治疗；停药几乎会不可避免地增加复发风险，减停必须由医生计划。
3. **副作用需要主动监测。** 体重、血糖、血脂、心电图、催乳素、锥体外系症状、氯氮平血常规，都是治疗的一部分，不是“额外麻烦”。

关于心理社会治疗

药物不是全部。心理教育、CBTp、家庭干预、社交技能训练、职业康复、认知矫正、同伴支持和个案管理，都能在不同阶段发挥作用。它们不能替代药物，但能帮助人重新进入生活。具体见 6.1 心理社会干预总览。

关于隐私与案例

文中出现的“小 A”“一位来访者”等，都是合并、改写后的示意案例，不对应任何真实个人。诊断、用药、住院记录属于敏感信息，分享给医生之外的人之前，先想清楚边界。

如何纠错与更新

- 本资料版本：V1.0，最后更新 2026-10。
- 指南会更新，药物适应证会变化，法律和地方政策会调整。看到与医生说法不一致时，**以面诊医生的个体化判断和最新指南为准**，并把差异告诉医生。
- 如果发现事实错误、失效链接、表述可能误导，请在资料库维护记录里标注“待核”，不要直接照用。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 1：基础与总论

先理解精神分裂症是什么、不是什么，再谈诊断和治疗。这个模块也负责拆掉最常见的污名。

1.1 精神分裂症是什么：症状、病程与常见误解

如果你刚被诊断，或者家人刚被诊断，最想知道的往往不是“吃哪个药”，而是“这到底是个什么病”。这一页用尽量少的术语讲清三件事：症状分哪几类、病程通常怎么走、为什么它不是很多人以为的“人格分裂”。读完你大概能用三句话向别人解释它，也知道该把注意力放在哪里。

一、它影响的是“与现实对接”的能力

精神分裂症是一种以精神病性症状为核心的精神障碍。所谓“精神病性症状”，是指一个人对现实的判断出现明显偏差：听到别人听不到的声音，或者坚信一些与事实不符、旁人怎么解释都难以动摇的事。

大脑每天都在做一件事：把外面真实发生的信息，和自己脑子里冒出来的想法、记忆、联想分开。这个过程大部分时候是自动的，我们感觉不到。精神分裂症患者在这方面出了问题——内部产生的体验被当成了外部真实发生的事，于是“听到”了声音，觉得“有人在针对我”。【指南】

所以它不是“想太多”，不是性格软弱，也不是父母教育方式造成的。用意志力去对抗幻听，就像用意志力让自己不发烧一样，方向不对。

诊断上，医生通常会看四件事：症状是否符合、持续了多久、功能有没有受影响、有没有别的原因可以解释（药物、躯体疾病、情绪障碍）。四件事缺一不可，这也是为什么初诊常常需要一次以上的面谈，还要抽血、做必要的检查。

二、三类症状：阳性、阴性、认知

“阳性”和“阴性”不是好坏的意思，而是“多了什么”和“少了什么”。

症状类型	通俗解释	常见表现	对生活的影响
阳性症状	多了本来没有的体验	幻听、妄想、言语紊乱、行为紊乱	急性期最显眼，药物反应通常较好
阴性症状	少了本来该有的表现	情感平淡、言语贫乏、意志缺乏、快感缺失、社交退缩	最影响长期功能，常被误认为“懒”
认知症状	注意、记忆、计划能力下降	注意力难集中、记不住刚说的话、做事没条理、听不懂言外之意	影响学习、工作与独立生活

阳性症状里最常见的是幻听和妄想。幻听是听到并不存在的声音，可能是评论你、议论你，也可能是命令你做什么。妄想是一种坚定不移的信念，比如坚信被监视、被下毒、被替换。言语紊乱表现为说话跳跃、答非所问，别人很难跟上。

阴性症状是“少掉的”：表情和语气变平，话变少，缺乏做事的动力，对以前喜欢的事提不起兴趣，慢慢回避社交。它最容易被误读为“懒”“不孝”“故意气人”，其实和阳性症状一样是疾病表现，而且更难治。【研究】

认知症状常被忽略。它不像幻听那样吵，却常常决定一个人能不能回到学校或岗位：注意力维持不住、工作记忆容量小、计划一件事很吃力、读不懂别人的表情和语气。它也是预测长期功能的重要指标之一。【研究】

三类症状常常同时存在，只是比例不同。药物对阳性症状通常反应较好，对阴性症状和认知损害效果有限，这两块更依赖康复训练、环境调整和家人支持。【指南】

三、病程：不是一条直线

精神分裂症的病程个体差异很大，但常见的过程可以分成几段，理解这几段有助于判断“现在处在哪一步、该做什么”。

前驱期。 在明显的精神病性症状出现之前，可能已经有几个月甚至更久的微妙变化：成绩下滑、不愿出门、变得多疑、睡眠乱、说话绕、对人对事冷淡。这些变化本身不特异，青春期也常见，所以很难单凭它下诊断。

急性期。 幻听、妄想、言语和行为紊乱变得明显，学习、工作、生活明显受影响，本人常常不认为有问题，反而是家人先着急。

巩固期与维持期。 症状控制之后，还有一个巩固和维持的阶段。这时候人看起来好了，但疾病并没有“清零”，贸然减停容易复发。

复发。 常见诱因包括自行停药或漏服、强烈应激、长期睡眠不足、使用大麻或兴奋剂等。每一次复发都可能带来功能上的损失，恢复一次往往比上一次吃力。【指南】

功能影响落在几个方面：工作或学业、人际交往、自理能力、经济状况、身体健康。受损程度差异很大，有人几乎不受影响，有人需要长期支持。把“功能”单独拿出来看，是因为它和症状并不完全同步：症状轻了，功能未必马上回来；功能好转，也不代表可以停药。

四、为什么不是“人格分裂”

这是最常见的一个误会，值得单独说清楚。

“精神分裂”里的“分裂”，指的是心理功能之间的不协调——思维、情感、行为彼此脱节。比如讲一件悲伤的事却在笑，或者想法跳跃到别人跟不上。它不指“人格裂成好几个”。

大众口语里的“人格分裂”，多数时候指“一个人身上像住了好几个不同的人”，对应的是解离性身份障碍（旧称多重人格障碍）。那是另一种病，表现、成因、治疗都不同，和精分不能混为一谈。

患者不会“变成另一个人”，也不存在“白天一个人、晚上另一个人”。电影和小说为了戏剧效果常把两者混在一起，看的时候可以提醒自己一句：那是剧情需要，不是诊断手册。

还有一个用词建议：日常说“精神分裂症”，比说“精神分裂”更准确，也能少一点和“分裂样人格障碍”的混淆——后者是一种人格特质的模式，不是同一种病。

五、可治疗，但要按长期病来管理

精神分裂症是可以治疗的。抗精神病药能控制大部分阳性症状，心理社会干预、康复训练和家庭支持能帮助人恢复功能、减少复发。治疗的目标通常写作四个词：**应答**（症状开始好转）、**缓解**（症状基本消失）、**康复**（功能和生活重新建立）、**维持治疗**（防止复发）。

但“可治疗”不等于“治几周就结束”。多数人需要较长时间的维持治疗，停药后复发风险明显升高，减量或停药需要在医生计划下缓慢进行，不能自己决定。【指南】

比较现实的目标是：

- 症状控制到不明显干扰日常生活；
- 复发次数减少、间隔拉长；
- 能做一些自己想做的事：上学、工作、照顾自己、维持几段关系；
- 副作用在可接受范围内，不影响长期坚持。

不承诺“根治”，也不把“终身服药”说成唯一结局。治疗要多久因人而异，医生会根据病程、复发史、功能状态和副作用耐受情况来判断，这个判断会随时间调整。

长期管理听起来抽象，其实可以拆成几件具体的小事。下面这份清单不用一次做完，先挑一两项开始：

- ☐ 固定一个取药和分装药盒的节奏，配合手机提醒
- ☐ 每次复诊带上用药清单（药名、每天几次、吃了多久）
- ☐ 和家人约定两三条“我复发时最早的信号”，写下来贴在冰箱上
- ☐ 每周固定一天称体重、量血压，记在同一张纸上
- ☐ 手机里存好就近的精神科急诊地址、120 和 12356 热线
- ☐ 知道自己不能自行停药，遇到副作用先联系医生而不是硬扛

六、常见误解快问快答

“是不是父母教育不好造成的？” 不是。家庭沟通方式会影响复发风险和康复进度，但不是致病原因。把病因归给父母，既不公平，也会让家庭错过真正能帮上忙的位置。

“会不会传染？” 不会。精神分裂症不是传染病，和患者一起吃饭、生活、工作都不会被“传染”。

“是不是智商低？” 不是。认知损害和智力不是一回事，很多患者智力正常，只是在注意、记忆、组织信息上更吃力。

“得了这个病是不是就废了？” 不是。有人长期稳定地工作和生活，有人需要调整节奏和岗位，也有人需要较多支持。结局不是预先写好的。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经在准备方法：不要独处，联系信任的人陪着，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现命令性幻听（声音让你伤害自己或别人）、坚信被追杀而准备“自卫”：先保证安全，远离可伤人的物品，拨打 120，必要时 110。
- 出现木僵、缄默、拒食、长时间保持一个姿势不动：可能是紧张症，需急诊精神科评估。
- 出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快：警惕恶性综合征，立即急诊。
- 服用氯氮平期间出现发热、咽痛、口腔溃疡、明显乏力：立即查血常规，不要等下次复诊。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

1.2 诊断分类与谱系：ICD-11、DSM-5-TR

拿到诊断时，你可能会遇到好几个名字：精神分裂症、分裂情感性障碍、短暂精神病性障碍、妄想障碍，还有“物质所致”“躯体疾病所致”。在不同的医院，甚至同一个人不同时间，诊断也可能不一样。这一页讲清两套最常用的分类系统怎么用、谱系里几个“邻居”差在哪里、为什么诊断会变。读完你能看懂病历上的诊断名称，也知道该向医生追问什么。

一、诊断是“排除”出来的，不是“对上一个症状”

很多人的想象是：医生问几个问题，对照一张症状表，对上就打勾。实际流程更接近“排查”。

医生通常要做四件事：

1. **看症状**：有没有幻觉、妄想、言语紊乱、阴性症状，出现多久，怎么变化。
2. **看病程**：是几天、几周，还是几个月、几年。病程长短直接决定落在哪个诊断上。
3. **看功能**：学习、工作、自理、人际受影响到什么程度。
4. **排除其他原因**：情绪障碍、物质或药物、躯体疾病、发育问题。

第四步最容易被忽略，却最关键。需要排除的包括：双相障碍的躁狂期、抑郁伴精神病性症状、大麻或兴奋剂所致的精神病性症状、酒精戒断、甲状腺功能异常、癫痫、自身免疫性脑炎、谵妄、某些维生素缺乏、听力或视力障碍带来的误解等。老年人第一次出现精神病性症状，尤其要先查躯体原因。

信息来自三个方向：本人怎么讲、家属怎么补充、既往病历和检查结果。缺了哪一块，诊断都容易偏。所以初诊常需要一次以上面谈，这不是医生拖，而是在收集够用的信息。【指南】

二、两套常用分类：ICD-11 与 DSM-5-TR

国际上最常被引用的是世界卫生组织的 ICD-11 和美国精神医学学会的 DSM-5-TR。中国临床和医保、残疾评定更多参照 ICD 体系，研究论文里则两套都常见。

对比项	ICD-11	DSM-5-TR
发布机构	世界卫生组织（WHO）	美国精神医学学会（APA）
使用场景	国际疾病分类，中国临床与行政常用	北美临床与研究常用，国际研究广泛引用
精神分裂症要点	核心症状至少两项、持续约一个月，功能受影响	核心症状至少两项（其中至少一项是妄想、幻觉或言语紊乱），总病程至少六个月，功能下降
对“亚型”的处理	取消偏执型、青春型等经典亚型，改用症状维度描述	同样取消经典亚型，紧张症作为独立标注
共同点	都要排除物质、药物与躯体疾病所致；都强调病程与功能	同左

两套系统的大方向一致，细节门槛不同，所以同一个人在两套标准下可能落到不同名称上。这不代表谁“诊错了”，而是分类系统本来就是人为划定的工具。具体条款以最新版原文和医生的解释为准。

【指南】

ICD-11 的一个变化值得知道：它不再把人分成“偏执型”“青春型”，而是描述这个人以哪类症状为主——阳性症状明显、阴性症状明显、抑郁、躁狂、精神运动异常、认知受损。这种描述更贴近临床，因为同一个人的症状构成会随时间变化。

三、谱系里的几个“邻居”

“精神分裂症谱系”不是一种病，而是一组在症状上有重叠、在病程和结局上不同的障碍。分清它们，直接影响治疗选择。

名称	核心特点	病程	与精神分裂症的关键区别
精神分裂症	妄想、幻觉、言语紊乱、阴性症状等组合	至少一个月（DSM-5-TR 要求总病程六个月以上）	症状更全面、功能受影响更明显
分裂情感性障碍	精神病性症状与心境发作同时存在	心境症状占据病程大部分时间	情绪发作是核心部分，不是“附带”
短暂精神病性障碍	急性起病的精神病性症状	至少一天、不足一个月，之后完全恢复	时间短，功能可回到病前
妄想障碍	以持续的妄想为主	至少一个月	除妄想相关外，行为与功能相对保留
物质/药物所致	使用或停用某物质后出现	与物质作用时间吻合	停用后多可改善，需尿检等佐证
躯体疾病所致	由甲亢、癫痫、脑炎等引起	随原发病波动	治原发病为主，精神症状常随之缓解

分裂情感性障碍。 要点是：精神病性症状和一次完整的心境发作（抑郁或躁狂）重叠出现，心境症状占据病程的大部分时间；同时，病程中有一段时间只有精神病性症状、没有明显心境症状。它既不是“精分加抑郁”，也不是“双相加幻觉”，治疗上常需要抗精神病药与心境稳定剂或抗抑郁药配合，具体由医生判断。

短暂精神病性障碍。 起病往往很急，可能在前几天还有明显应激。症状持续至少一天但不到一个月，之后完全恢复到病前水平。名字里的“短暂”容易让人松劲，但急性期的风险（自伤、冲动、走失）一样真实，而且需要随访确认没有转为更长的病程。

妄想障碍。 以妄想为核心，内容常涉及被害、嫉妒、躯体或“某个人爱上我”。除了与妄想直接相关的部分，言谈和行为可以相当正常，工作生活也可能维持得不错。这带来一个现实问题：本人往往不觉得需要治疗，家属也很难劝。建立信任比争论内容更有效。

物质或药物所致的精神病性障碍。 大麻、兴奋剂、酒精戒断、某些激素和药物都可能引起幻觉或妄想。判断线索是时间关系：症状在物质使用期间或戒断期间出现，停用后减轻。尿检、用药史、家属观察都很重要。把这类情况当成精分来长期用药，会错过真正该做的事。

躯体疾病所致的精神病性障碍。 甲状腺功能异常、癫痫、自身免疫性脑炎、谵妄、严重感染、营养缺乏都可能表现为“像精分”。这类情况的处理核心是原发病。若只按精分治，既延误病情，也可能让躯体问题恶化。

四、边界为什么重要：诊断会改，治疗也不同

不同诊断对应不同的治疗重心：

- 双相障碍的精神病性症状，重点是心境稳定，单用抗精神病药可能不够；
- 物质所致的精神病性症状，第一步是停用与戒断管理；
- 躯体疾病所致，先治原发病；
- 短暂精神病性障碍，需要短期治疗并密切随访，而不是直接按终身病来安排。

误诊的代价不是抽象的：可能吃错药、错过治疗窗口、背上不必要的标签，也可能漏掉真正危险的躯体问题。

也要接受一件事：**诊断会变**。随着信息增加（症状演变、对治疗的反应、检查结果），医生修正诊断是正常的临床过程，不是“水平不行”。有一类情况叫“诊断漂移”，在病程早期尤其常见，因为那时候证据本来就不够。

五、分类不是贴标签

诊断有用：它让医生之间能沟通，让治疗有依据，让医保和残疾评定有标准，让研究能比较不同人群。这些都是真实的好处。

诊断也有局限：

- 同一个诊断的人，症状组合、功能水平、治疗反应可能差别极大；
- 诊断描述的是“现在符合哪一组标准”，不预测某一个人的具体结局；
- 标签一旦写进档案，可能带来就业、保险、婚恋上的歧视；
- 诊断不能定义一个人是谁，也不能解释全部行为。

所以更合适的用法是：把诊断当成“当前最合理的解释和沟通工具”，而不是“关于你这个人的最终结论”。

下次复诊时，可以带着这几个问题去问：

- ☐ 我是否知道自己的完整诊断名称，以及医生依据的是哪几条？
- ☐ 有没有做过排除物质、躯体原因的检查？结果在哪里？

- ☐ 医生预计多久复评一次诊断？
- ☐ 如果症状变化，什么情况下需要重新评估诊断？
- ☐ 诊断信息会出现在哪些材料里，谁可以看到？

六、常见问题

两家医院诊断不一样，听谁的？ 不必急着选边。把两份病历都带给现在的医生，说明各自的依据和时间。诊断不一致本身是有价值的信息，通常说明某些关键信息还不确定。

会不会过几年变成双相？ 有可能，尤其在早期。心境发作出现后，诊断需要重新评估。这不是坏消息，而是治疗可能因此更对症。

需要做基因检测或脑影像吗？ 目前这些检查不用于个体确诊精神分裂症。脑影像主要用于排除肿瘤、卒中、脑炎等结构性或炎症性问题；基因检测在少数情况（如遗传咨询）有帮助，但不是常规诊断工具。【待验证】

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 症状突然加重，出现命令性幻听或明确的伤人、自伤念头：不要独处，拨打 120，必要时 110。
- 急性起病、意识模糊、发热、抽搐：先按躯体急症处理，立即急诊，不要只当成“精神病发作”。
- 老年人首次出现幻觉、妄想，或伴有记忆明显下降：尽快就诊，需要排除谵妄、脑卒中、感染等。
- 使用大麻、兴奋剂后出现持续幻觉、极度兴奋或胸痛、心悸：立即急诊。
- 出现木僵、拒食、缄默、长时间不动：警惕紧张症，急诊精神科评估。

参考来源

- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

1.3 流行病学、起病年龄与预后

“这病常见吗？”“为什么是他？”“以后会怎么样？”这三个问题，几乎是每个家庭在确诊后都会问的。这一页讲三件事：精神分裂症在人群中的分布、起病年龄与性别差异、以及哪些因素和更好的预后有关。数字部分会尽量谨慎，因为精确的统计数字在不同研究之间差别很大，而“预后”从来不是一个写好的结局。

一、有多少人会得：一个谨慎的说法

精神分裂症不算罕见病，但也远没有到“身边到处都是”的程度。国际上常用的粗略估计是：**终生患病风险低于百分之一**。不同研究报告的数字并不一致，从千分之几到百分之一上下都有，差异来自诊断标准、随访年限、年龄结构和地区人群的不同。【研究】

这里要区分两个词：

- **患病率**：某个时间点上，人群中符合诊断的人占多少。
- **发病率**：一段时间内，新发病人占多少。

大众常说的“发病率”往往是患病率。两者不能混着比。

另外，统计数字受“诊断口径”影响很大。用宽的标准，数字会高；用严的标准，数字会低。所以看到“某地精神病患者激增”这类说法，先问一句：是病人真的变多了，还是诊断标准、就诊率、登记制度变了？

还有一点值得说：精神分裂症在全世界各个文化、各个国家都能见到，不是某个地区或某种生活方式特有的病。城市化、移民、社会经济地位较低的人群中报告的发病率偏高，但这些是风险因素层面的观察，不能推到一个具体的人身上。【研究】

二、起病年龄：两个高峰

起病年龄是精神分裂症最重要的特征之一，也是它和很多其他精神障碍不同的地方：**它主要攻击年轻人**。

阶段	大致年龄	特点与注意点
儿童青少年期	十几岁以前	少见，诊断更谨慎，需排除发育、孤独症、创伤等因素
青年早期	十几岁末到二十岁出头	男性更常见，起病常较隐匿，前驱期长
青年后期到三十岁出头	二十几岁	女性更常见，情感症状可能更突出
中年以后	四十岁以后	首次发病需认真排除躯体、物质、情绪障碍
老年期	六十岁以后	极少见，必须排除痴呆、谵妄、脑卒中、感染、药物

男性起病通常更早，很多在二十岁前后；女性的起病年龄分布更宽，二十几岁是一个高峰，绝经前后还会出现一个小高峰。总体终生风险男女大体接近，差别更多体现在起病时间、症状构成和病程走向上。【研究】

为什么起病年龄重要？ 因为它正好撞上人生几个关键节点：高考、上大学、第一份工作、开始独立生活、建立亲密关系。疾病在这些节点上打断的不只是身体，还有身份和计划。这也是为什么“早识别、早治疗”在精神分裂症里被反复强调——不是为了抢时间，而是为了少丢东西。【指南】

晚发不等于轻。 四五十岁以后第一次出现精神病性症状，首先要做的不是急着贴精分标签，而是查清楚：有没有甲状腺问题、自身免疫性疾病、神经系统疾病、听力视力下降带来的误解、长期物质使用、抑郁或双相。老年人还要特别警惕谵妄——它起病急、波动大、伴意识不清，是急症。

三、性别差异：不是“谁更严重”，而是“哪里不同”

把男女差异讲成“男性更重、女性更轻”是不准确的。更贴近临床的说法是：

方面	男性常见	女性常见
起病年龄	更早，多在二十岁前后	更晚，分布更宽，绝经前后有小高峰
症状构成	阴性症状、认知损害更突出	情感症状、抑郁焦虑更突出
物质使用	合并酒精、大麻等比例较高	相对较低，但并非少见
社会功能	病前功能较差者较多，就业受影响明显	病前功能相对较好，但照护责任更重
特殊风险	就医晚、隐瞒症状	孕产期复发、产后精神病、催乳素相关月经问题

这些是群体层面的倾向，不能拿来判断某一个人。一个具体的人，可能完全不符合上面任何一条。

对女性来说，有几个时间点需要提前和医生讨论：备孕、怀孕、产后、哺乳、围绝经期。产后是复发和产后精神病风险明显升高的时期，需要提前安排随访，而不是等出事再处理。对男性来说，更常见的问题是拖到很晚才就诊、用酒精或大麻自我“治疗”、以及不愿意承认需要帮助。

四、病程的几种走向：异质性有多大

精神分裂症最被低估的一点，是它的**异质性**——同样一个诊断，不同人的走向可以差得很远。

走向	大致表现	在人群中
单次发作后长期稳定	一次急性期后症状缓解，功能基本恢复，停药后也未再发	少数
复发—缓解型	有发作，治疗后缓解，间隔数月到数年再发	较常见
持续症状伴部分功能	阳性症状时轻时重，阴性症状和认知损害持续，需要长期支持	相当一部分
慢性化、功能受损明显	症状持续，自理和社交长期受限，需要较多照护	少数，但最耗资源

要提醒的是：这些“比例”在不同研究里差别很大，随访时间越长，越多人出现复发；而“康复”的定义不同，结论也会不同。所以不要拿某一篇研究里的百分比往自己身上套。

可以确定的是：**最坏的结局不是默认结局**。多数人处在中间地带——有症状，也有生活；需要治疗，也能做点事。把“要么痊愈、要么废掉”这种二选一扔掉，才看得见中间那条路。

五、影响预后的因素

研究者反复找到一些和结局相关的因素。它们不是命运，但值得知道，因为其中一部分是可以改变的。

有利因素	不利因素
起病较急、有明显诱因	起病隐匿、前驱期长
病前社会功能、学业工作表现较好	病前已有明显回避、学业倒退
首次治疗及时，未治疗期短	从出现症状到开始治疗拖了很久
阳性症状为主，对药物反应好	阴性症状、认知损害突出
家庭支持稳定、不过度批评或包办	家庭冲突高、缺乏支持
能规律服药、定期复诊	反复自行停药、失访
不合并物质使用	长期大量使用大麻、酒精、兴奋剂
没有明显共病（抑郁、躯体病）	共病多、躯体健康差
有工作、学习或社会角色	长期隔离、无事可做

【指南】【研究】

有几条值得展开：

未治疗的精神病期（DUP）。 从出现明显精神病性症状到开始规范治疗之间的时间，越长，预后通常越差。这是“早发现早治疗”最硬的证据基础之一。但也要避免另一种极端：为了抢时间而随便找个地方开药，不如尽早找到能系统评估的精神科。【研究】

阴性症状和认知损害。 这两块对长期功能的影响，往往比幻听妄想更大。它们对药物反应有限，更需要康复训练、结构化活动和环境支持。【研究】

依从性。 停药是复发最强的预测因素之一。很多人停药不是因为“不想好”，而是因为副作用难受、觉得好了、没人解释清楚、或者经济压力。这些都可以摊开来和医生谈。【指南】

家庭情绪氛围。 高情感表达（频繁批评、敌意、过度介入）与更高的复发率相关。这不是说家属“做错了”，而是提醒：少一点指责、多一点稳定的支持，是有意义的。【研究】

病耻感。 怕被贴标签而不敢就医、不敢复工、不敢社交，会通过“回避”这条路，慢慢把功能耗掉。病耻感是可以被讨论和处理的。

六、预后不是判决

“预后”在医学上是一个概率判断：在相似条件下，一群人里大概会有多少种走向。它不能告诉你某一个具体的人会怎样。

有几件事，是个人和家庭可以主动做的，也是这份资料库反复强调的：

- ☐ 尽早接受系统评估，别在“是不是中邪”“是不是青春期”上耗太久
- ☐ 把药吃对、吃够时间，副作用及时说，而不是自己减停
- ☐ 学会识别自己的复发早期信号，写下来，和家人共享
- ☐ 保持基本的生活结构：睡眠、吃饭、出门、有事做
- ☐ 处理物质使用问题，不把酒精和大麻当“自我治疗”
- ☐ 让家庭沟通从“管教”转向“合作”，减少高频批评
- ☐ 给自己设定小而具体的目标：先恢复作息，再谈复学复工
- ☐ 定期体检，关注体重、血糖、血脂、心电图

预后不是一个等着被宣布的结果，而是一条被很多小决定慢慢推着走的路。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 起病急、伴发热、意识模糊、抽搐：先按躯体急症处理，立即急诊。
- 老年人首次出现幻觉、妄想，或记忆、定向力突然变差：尽快就诊，排除谵妄与神经系统疾病。
- 孕产期症状加重或出现伤害自己或婴儿的念头：立即联系产科与精神科，必要时急诊。
- 出现木僵、拒食、缄默、长时间不动：警惕紧张症，急诊精神科评估。

参考来源

- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

1.4 常见名词与误区

“精神分裂”和“人格分裂”是一回事吗？“疯子”这个词到底伤人在哪里？得了这个病是不是就废了、要住一辈子院？这一页把最容易混淆的几个名词摆在一起，再逐条拆掉最常见的误解。读完你能分清几个关键概念，也能在听到偏见时，用一两句话把话说回去，而不是吵起来。

一、先把几个词分清楚

中文里和“精神”有关的词特别多，日常混着用，一混就出误会。先看一张对照表：

说法	实际指什么	最容易混淆的点
精神分裂症	以幻觉、妄想、阴性症状、认知损害为核心的精神障碍	不是“人格分裂”，不是“多个自己”
“人格分裂”	大众口语，多指解离性身份障碍（旧称多重人格）	与精分是两种病，表现完全不同
分裂样人格障碍	一种长期的人际疏离、情感表达受限的人格模式	名字像，但它不是精神病性障碍
双相障碍	抑郁与躁狂（或轻躁狂）交替出现的心境障碍	躁狂期可以有精神病性症状，但诊断不同
精神病性症状	幻觉、妄想、严重思维紊乱等“与现实脱节”的表现	是一个症状，不是一个诊断
神经病	口语里常指行为古怪，医学上指神经系统疾病	和“精神病”不是一回事
心理问题	情绪、关系、压力等层面的困扰	不等于精神障碍，但也不该被轻视

几个要点：

“精神分裂”的“分裂”，指心理功能之间的不协调。 思维、情感、行为彼此脱节，而不是人格裂成几块。这个译名从外文直译过来，本身就容易误读，所以正式场合更推荐说“精神分裂症”。

“精神病性”是症状层面的词。 一个人可以有精神病性症状，但不一定是精神分裂症——双相、抑郁、物质使用、躯体疾病都可能出现。

“神经病”和“精神病”在医学上是两套系统。 前者是神经系统的问题（比如癫痫、卒中），后者是精神障碍。日常骂人时混用，既不准，也不尊重。

【指南】

二、“疯子”“危险”：污名是怎么来的

先给结论：**绝大多数精神分裂症患者并不暴力，他们更常是暴力的受害者，而不是施暴者。** 研究里，精神分裂症与暴力行为的关联，主要集中在一小部分有特定风险因素的人身上，而且这些因素大多与“有没有治疗”“有没有物质使用”有关，而不是“有这个诊断”本身。【研究】

那为什么大众印象里“精神病人都很危险”？因为新闻会选择性地报道极端个案，电影需要一个吓人的反派，而日常里安静生活的患者不会上新闻。这种“可得性偏差”让少数极端事件占据了全部想象。

把风险讲清楚，比简单否认更有用。与暴力行为相关的风险因素和情境包括：

- 精神病性症状未治疗或治疗中断，尤其是被害妄想、被控制感；
- 命令性幻听，且内容指向伤害他人；
- 合并酒精、大麻、兴奋剂等物质使用；
- 既往有暴力行为史，或近期明显激越、冲动；
- 年轻男性、社会经济处境差、缺乏支持网络；
- 可轻易获得武器或其他危险物品；
- 极度恐惧、觉得“先下手为强”的封闭信念系统。

这些是“风险因素与情境”，不是“某类人必然如何”。同一个诊断下，多数人没有暴力行为；反过来，没有这个诊断的人也可能因为愤怒、酒精、人格问题而暴力。把暴力归因于诊断，既解释不了事实，也让真正该做的风险评估被忽略。

语言也在塑造现实。“疯子”“精神病”“脑子坏了”这类词，会让人不敢就医、不敢告诉同事、不敢让孩子上学。换成“他患有精神分裂症”“他现在有幻觉”，描述的是事实，不是判决。

三、关于药物的误解

“吃药会成瘾。” 抗精神病药不属于成瘾性物质。成瘾通常指强迫性使用、越吃越多、明知有害仍停不下来，抗精神病药不符合这些特征。但有两件事需要分清：一是突然停药会出现失眠、激越、恶心、幻觉加重等撤药样反应，并显著增加复发风险；二是部分辅助用药（如某些镇静催眠药）确实可能产生依赖，需要医生管理。把“不能随便停”误读成“会成瘾”，是两回事。【指南】

“吃药会变傻。” 常见的原因是镇静作用、注意力变慢，或者阴性症状和认知损害本身。药物相关的“迟钝”很多是可逆的，调整方案后能改善；而疾病本身的认知损害，不治疗反而可能更重。真正需要警惕的是长期大剂量、多种药物叠加带来的负担，这要靠定期评估来解决，不是靠停药。【临床经验】

“镇静就是治病。” 不是。让人觉得困、反应慢，是抗组胺等作用带来的副作用；抗精神病药的治疗作用主要来自对多巴胺系统的调节。一个药让人很困，不代表它更“有效”；不困，也不代表没效。用“吃完有没有镇静”来判断药好不好，是常见的误判。

“症状好了就能停。” 症状消失只是进入巩固期，不代表病好了。停药后复发风险明显升高，减停要在医生计划下缓慢进行。

“西药伤肝伤肾，中药安全。” 任何有效药物都有代价。抗精神病药需要监测体重、血糖、血脂、心电图、催乳素等；中药和保健品同样可能影响肝肾功能，还可能与西药相互作用。用“天然”推断“安全”，是逻辑跳跃。【待验证】

四、关于人生的误解

“要住一辈子院。” 住院是急性期的安全措施，不是终身安排。多数人病情稳定后在社区生活、门诊随访。需要长期住院的是少数，通常合并严重功能损害、反复危机或缺乏照护条件。

“不能工作、不能结婚、不能生孩子。” 这些不是诊断本身禁止的。很多人维持工作、建立家庭、养育子女。真正需要提前规划的是：病情稳定程度、药物在孕期的调整、产后复发风险、遗传咨询、照护分工。这些都可以和医生一条条谈，而不是被一句“不行”堵死。

“会遗传，所以不该生。” 遗传风险确实比一般人群高，但它是概率，不是命运；多数患者的子女并不会患病。生育决定涉及医学、经济、照护、伴侣支持，属于个人和家庭的选择，医生能做的是把风险讲清楚，而不是替人决定。【研究】

“得病的人都是天才。” 这种浪漫化听起来像夸奖，实际也在否认疾病带来的真实痛苦，还会让“治不好是因为你不够特别”这种话有了市场。精神分裂症和创造力之间没有必然联系。

“这病会传染。” 不会。一起吃饭、上学、工作、住在一起，都不会传染。

“是父母害的。” 家庭沟通会影响复发，但不是病因。这个旧观点伤害了很多家庭，也让真正的生物学和环境风险被忽略。

五、十二句话，逐条澄清

常听到的说法	更接近事实的说法
“他就是想不开。”	这是大脑功能层面的障碍，不是态度问题，靠“想开”无法消除幻听
“精神病人都很危险。”	多数患者不暴力，风险集中在未治疗、物质使用、被害妄想等特定情境
“吃药会成瘾。”	抗精神病药不成瘾，但不能突然停，停药会显著增加复发
“吃药会吃傻。”	迟钝多与镇静、阴性症状、认知损害有关，可评估调整，不等于被药物毁掉
“不困就是没效。”	镇静是副作用，不是疗效指标
“好了就不用吃了。”	症状缓解后仍需巩固和维持，减停需医生计划
“中药没有副作用。”	中药和保健品也有不良反应与相互作用，不能替代抗精神病药
“得了病就废了。”	结局差异很大，很多人恢复工作、学习和家庭生活
“会遗传，别生了。”	风险升高但不等于必然，生育是个人与家庭的选择
“住院就是被关起来。”	住院用于急性期安全与治疗，自愿原则是法律基础，非自愿有严格条件
“他打人是因为有病。”	暴力要看具体情境与风险因素，不能用一个诊断解释所有行

常听到的说法	更接近事实的说法
	为
“千万不能告诉别人。”	是否披露由本人决定，可以分层披露，不必一次全说

六、说话前，先过一遍这份清单

- ☐ 我有没有用“疯子”“神经病”这类词称呼对方
- ☐ 我有没有把症状说成“装的”“懒”“不孝”
- ☐ 我有没有承诺“治好”“不会再犯”
- ☐ 我有没有替对方决定要不要告诉别人、要不要结婚
- ☐ 我有没有把“暴力”当成这个诊断的必然结果
- ☐ 我有没有在对方表达幻听时急着争辩“那是假的”
- ☐ 我有没有把“吃药”说成唯一重要的事，忽略生活与关系
- ☐ 我有没有在劝人时，先把对方的选择权拿掉

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现命令性幻听、坚信被追杀并准备“先下手”：先保证安全，远离危险物品，拨打 120，必要时 110。
- 出现木僵、拒食、缄默、长时间不动：警惕紧张症，急诊精神科评估。
- 出现高热、肌肉僵硬、意识改变：警惕恶性综合征，立即急诊。
- 服用氯氮平期间发热、咽痛、口腔溃疡：立即查血常规。

参考来源

- NICE. Violence and aggression: short-term management in mental health, health and community settings (NG10), 2015. https://www.nice.org.uk/guidance/ng10
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 2：临床表现与评估

精神分裂症不只有幻觉妄想。阴性症状和认知损害往往更影响长期功能。

2.1 阳性症状：幻觉与妄想

精神分裂症最容易被外人注意到的，是“多出来的”体验：听到别人听不到的声音，坚信自己被监视、被控制，说话跳来跳去接不上。这一页把这些体验拆开讲清楚，适合刚出现异常体验的人、被吓到的家属，以及想弄明白“他到底在经历什么”的读者。读完你能分清普通的多疑和妄想、知道命令性幻听为什么要当急症处理，也知道家属怎么观察和记录，而不是靠争辩。

一、“阳性症状”指的是“多出来的东西”

精神科把症状粗略分成三类。阳性症状是正常功能里多出来的部分：幻觉、妄想、思维形式紊乱、明显紊乱或激越的行为。阴性症状是正常功能里少了的部分：情感表达变少、话变少、没劲、不愿社交。认知损害则是注意、记忆、计划能力下降。三类常常同时存在。【指南】

“阳性”没有任何褒贬，只是在描述“加出来的症状”。这类症状通常对药物治疗反应相对明显，也常在复发早期最先冒头：睡眠变差、疑心变重、声音又出现了。所以它们既是治疗目标，也是复发预警信号。【指南】【临床经验】

需要先说明一句：出现幻觉或妄想，并不等于精神分裂症。严重抑郁、双相障碍、物质使用、某些躯体疾病和药物都可能引起类似体验，这正是需要医生鉴别的理由。

二、幻觉：没有外界刺激，却有真实感受

幻觉是在没有相应外界刺激时出现的真实知觉：没有人说话却听到声音，没有人在却看到人影，没有气味却闻到异味。它和错觉不同，错觉是“有东西但看错了”，比如把衣架看成一个人。幻觉也不等于想象，患者不是“假装听到”，他的体验往往和真实听到一样清楚。

五种感官都可能出现幻觉，其中听幻觉最常见，也最影响诊断和治疗。【指南】

听幻觉的几种样子

- 简单的声音：嗡嗡声、敲门声、一段音乐。
- 说话声：一个或多个“人”在讲话，可能是熟人，也可能是陌生人。
- 评论性幻听：声音像旁白一样评论患者正在做的事，比如“他又在发呆了”。
- 对话性幻听：两个或多个声音在争论、商量，甚至议论患者。
- 命令性幻听：声音直接下指令，“别吃了”“跳下去”“去打他”。

- 思维鸣响：自己的想法刚出现，就同时被一个声音念出来。

患者对声音来源的判断常常很确定：“就在门外”“在墙里”“是邻居装的设备”。这时争辩“根本没有声音”通常无效，还会让他觉得你也在骗他。

命令性幻听：按急症对待

命令性幻听是自伤和暴力风险的重要风险因素之一，但不是“一定会执行”。风险高低与这些情况有关：命令内容是否具体、患者是否相信那个声音无所不能、是否同时有被害妄想、是否饮酒或使用兴奋剂、是否刚停药、身边有没有可用的危险物品。绝大多数患者不会照着声音去做，但少数情况确实危险，不能赌。【指南】【临床经验】

只要出现下面任何一种，不要等门诊，直接去精神科急诊；患者拒绝就医或已经准备行动时，拨打120，有伤人风险时拨打 110：

- 声音命令伤害自己或他人；
- 患者开始按命令做准备，比如囤药、找刀、写告别信、反复站到窗边；
- 患者说“不照做就会被惩罚”，表现出明显恐惧；
- 同时有被害妄想，坚信某人要伤害自己，并打算“先下手”。

三、妄想：改不掉的错误信念

妄想是一种与现实不符、与所处文化背景也不相符的坚定信念。它不因相反证据而改变，也不是靠讲道理能说通的。判断时要考虑文化背景：某些信念在特定宗教或民俗语境里并不算妄想。

类型	患者可能怎么说	家属看到的样子
被害妄想	“有人在饭里下毒”“他们在跟踪我”	反复锁门、检查食物、不敢出门、偷偷录音
关系妄想	“电视里那句话是在说我”“路人都在议论我”	觉得陌生人都在针对自己，回避公共场所
被控制妄想	“我的脑子被机器控制了”“身体不由我做主”	说想法、动作被外力操纵，可能因此攻击“操控者”
夸大妄想	“我是重要人物，有特殊使命”	说话夸张、要做大事、拒绝常规治疗
嫉妒妄想	“伴侣一定出轨了”	反复查手机、跟踪、质问，冲突不断升级
躯体妄想	“我身体里长了东西、烂掉了”	反复就医、要求手术，检查正常也不相信

被害妄想与关系妄想

被害妄想是最常见的一类。患者不是在“演戏”，而是真的感到威胁，所以可能锁门、拉窗帘、囤积食物、拒绝吃喝别人给的东西。关系妄想则是把外界中性的事件读成针对自己：广告牌、新闻、同事的笑声。两者常一起出现，情绪底色是恐惧和警觉。

家属最容易犯的错是“举证式辟谣”：拿出监控、找人作证、逼患者承认自己错了。证据越硬，患者越可能把家属也算进“他们”里。更稳的做法是先接住情绪：“你现在很害怕，我先陪着你”，再把具体的安全安排交给医生。

被控制感

被控制感指患者觉得自己的想法、情绪或动作被外部力量操纵，比如“脑子里被植入了芯片”“手自己动起来”。这种体验非常可怕，也容易引发针对“操控者”的冲动行为。它属于需要尽快药物干预的症状，不适合只做心理疏导。

和“多疑”“固执”的区别

普通人也会多疑，但通常能被解释松动，也会随着情境变化。妄想的几个特点是：坚信程度极高、不因反证改变、内容离奇或与背景明显不搭、明显影响生活。是否“离奇”要由医生结合文化背景判断，家属不必自己下结论。

四、思维形式障碍：想法“接不上”

思维形式指“怎么组织想法”，思维内容指“想的是什么”。妄想是内容出了问题，思维形式障碍是结构出了问题。

- 思维松弛：句子之间失去逻辑连接，听着像各说各的。
- 思维破裂：严重时句子内部也断裂，词和词拼不起来。
- 答非所问、思维中断：说着说着停住，说“有人把想法拿走了”。
- 语词新作：自造词，只有他自己懂。
- 病理性赘述：绕一大圈说不到重点。
- 思维贫乏：内容空、话少，更偏阴性症状。

家属常把这些概括成“胡言乱语”，但医生需要的是原话。用手机记几句、或者事后照抄，比“他说话没逻辑”有用得多。

五、家属怎么观察和记录

- ☐ 记下第一次出现的时间，当时有没有熬夜、饮酒、使用大麻或兴奋剂、刚停药。
- ☐ 尽量记原话，不改写、不概括成“他说胡话”。
- ☐ 记录频率和持续时间：一天几次、每次多久、最近是变多还是变少。
- ☐ 记录伴随情况：睡眠、吃饭、上班上学、愿不愿出门。
- ☐ 记录安全相关内容：有没有命令、有没有提到具体的人或地点、家里有没有刀和大量药物。
- ☐ 记录服药情况：吃没吃、有没有自己减量、有没有副作用。
- ☐ 观察情绪：害怕、愤怒、低落、麻木，各持续多久。

☐ 复诊时按时间顺序讲，不要一次抛十个问题。

不要偷偷录音录像后到处传播，也不要在患者不知情时把他的原话发到亲戚群。这类做法一旦被发现，会严重破坏信任，也会让后续治疗更难进行。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

出现以下情况，立即去精神科急诊；患者拒绝或无法配合时拨打 120，有伤人风险时拨打 110：

- 命令性幻听，或患者已经开始按命令行动。
- 被害妄想伴随明确的“自卫”准备，或已经发生推搡、持物威胁。
- 幻觉、妄想突然加重，伴整夜不睡、不进食、到处乱走。
- 新出现的幻觉妄想伴发热、头痛、意识时清时浊、抽搐、走路不稳——要排除脑部或躯体疾病，走急诊而不是门诊。
- 出现自伤、自杀的言语或行为。

可以先联系门诊医生、调整复诊时间的情况：

- 症状比上周多一些，但能正常吃饭睡觉，没有伤害自己或他人的想法。
- 药物副作用让人难受，比如手抖、坐不住、发胖。
- 家属不知道怎么应对，需要有人教具体的说法。

容易踩的坑

1. **和声音争辩。** “根本没有声音”会让患者觉得你不信他。先接住情绪：“那个声音在骂你，一定很难受。”
2. **顺着妄想一起演。** 为了安抚而一起“对付邻居”，会让妄想更牢固。可以说“我不确定，但我相信你现在很害怕”。
3. **把妄想当成故意找茬。** 患者不是想控制你，他是真的相信。
4. **只盯幻觉，不看功能。** 声音还在但能上班、能吃饭，和声音没了却整天躺着，处理重点完全不同。
5. **用“中邪”“想太多”拖延。** 首次出现精神病性症状越早评估越好，拖延会拉长未治疗的时间。
6. **自行加药或停药。** 突然停药可能引起失眠、激越、幻觉加重和复发。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.2 阴性症状：情感平淡、意志缺乏与社交退缩

幻觉和妄想会被看见，阴性症状却常常被当成“懒”“冷漠”“不孝”。这一页讲清楚阴性症状是什么、为什么容易被误读、怎么和抑郁与药物副作用区分，适合觉得“他好像变了个人”的家属，也适合自己感到“什么都不想做”的患者。读完你能带走一份可照做的观察清单，和几句比“你怎么又这样”更有用的话。

一、阴性症状是“少了什么”

阴性症状指正常功能里缺失的部分。临床上常看五个方面：情感表达减少、言语贫乏、快感缺失、意志缺乏、社交退缩。【指南】

- **情感平淡**：面部表情少、语调平、手势少，说到伤心事脸上也没什么变化。
- **言语贫乏**：主动说话少，回答简短，常常只有“嗯”“还行”。
- **快感缺失**：对以前喜欢的事提不起兴趣，说“没意思”“都差不多”。
- **意志缺乏**：不主动开始做事，洗漱、吃饭、找工作都要别人推。
- **社交退缩**：不联系朋友，不出门，回避人多的地方。

症状	患者身上的表现	常被误认为
情感平淡	表情少、语调平、眼神少	冷漠、不关心家人
言语贫乏	回答简短、几乎不主动开口	不爱搭理人、耍脾气
快感缺失	“没意思”“无所谓”	抑郁、不知足
意志缺乏	不洗漱、不上学、整天躺着	懒、堕落、啃老
社交退缩	不接电话、不见朋友	孤僻、记仇、摆架子

这里要区分“原发”和“继发”。原发阴性症状来自疾病本身；继发的“看起来像阴性”的表现，可能来自抑郁、药物镇静、锥体外系反应（手抖、动作慢、面具脸）、长期住院后的环境剥夺，或者被照顾得太周到而不需要动手。这个区分非常关键：原发的需要调整抗精神病药和心理社会干预，继发的要先处理背后的原因。【指南】【临床经验】

二、逐项看得更细一点

情感平淡：脸不动，不等于心不动

很多患者主观上仍有情绪，只是表达通道变窄了。家属最受伤的时刻，往往是说了很重的话，对方一点反应都没有。这时可以提醒自己：反应少可能是症状，不是不在乎。

也要分清几种相似的表现。抑郁的表情常是愁苦、眉头紧、容易落泪；锥体外系反应造成的“面具脸”常伴动作迟缓、手抖、走路小步；药物镇静则是困倦、反应慢、说话含糊，和服药时间明显相关。这几种混在一起时，只有医生能拆开。【临床经验】

言语贫乏：不是拒绝，是“想不出话”

被问“你今天怎么样”，患者可能真的组织不出答案。开放式问题会让他更卡，换成选择题会好很多：“今天是想在家吃，还是出去吃？”一次只给两个选项，等十秒，不催。

快感缺失：期待变少，当下的快乐可能还在

研究提示，精神分裂症的快感缺失更多体现在“预期性愉快”下降——对将要发生的好事没有期待；而当下真正体验到愉快的能力，受损可能没那么重。这解释了一个常见现象：怎么劝都不肯出门，真带出去了，好像也还行。【研究】

所以“等他愿意了再去”往往等不到。更现实的做法是把门槛降到很低：走到楼下、坐十分钟、随时可以回。

意志缺乏：不是不愿意，是启动困难

从“想”到“做”之间那一步，对患者来说可能像推一堵墙。任务越大越推不动。把“把房间收拾干净”拆成“先把桌上的三个杯子拿到厨房”，成功率会高很多。

社交退缩：背后可能有三种原因

一种是阴性症状本身，社交这件事不再带来动力；一种是怕被议论，常和关系妄想一起出现；还有一种是能力下降后的回避——听不懂别人在聊什么，索性不去。三种原因对应三种做法，所以别急着用“多出去走走”一把抓。

三、为什么总被当成“懒”和“不孝”

在很多家庭里，“有没有精神”是被当作道德问题评价的。父母看到孩子整天躺着，第一反应是“我们这么辛苦，你怎么能这样”。这句话背后是真实的疲惫，但落到患者身上，往往变成“我果然是个废物”。

接着是一个很典型的循环：责骂——退缩——更重的责骂。家庭情感表达过于激烈（临床上叫“高情感表达”），和复发风险升高有关；家庭干预的目标之一，就是把这个循环打断。【指南】

不过也要避免走到另一个极端：把所有不做事都归给疾病。如果一个原本退缩的人突然开始熬夜、话变多、说要干大事，那可能不是“阴性症状好转”，而是要警惕躁狂或病情变化。

四、怎么和抑郁、药物镇静、锥体外系反应区分

特征	阴性症状	抑郁	镇静或锥体外系反应
起病方式	与病情平行，缓慢持续	可急性出现，也可在病情好转后出现	与加量、换药时间相关
情绪底色	平淡、无所谓	低落、想哭、自责、无望	困倦，但情绪不一定低落
自责无望	少	常见，甚至出现自杀观念	少
面部与动作	表情少，但动作灵活度尚可	愁苦面容，动作可正常	面具脸、动作慢、手抖、僵

特征	阴性症状	抑郁	镇静或锥体外系反应
			硬
对鼓励的反应	变化小	可短暂好转，随后又低落	与服药时间、剂量相关

这张表只是帮助你和医生沟通，不能用来自己判断。三种情况经常同时存在，而且“阴性症状加重”本身也可能是抑郁、锥体外系反应或剂量不合适。任何调整都要由医生决定，不要自行加减药。【临床经验】

五、家里能做的几件事

- ☐ 把“你怎么又不洗澡”换成具体的一件事：“水烧好了，去冲五分钟，我等你。”
- ☐ 用选择题代替开放题，一次只问一件事，问完等十秒。
- ☐ 把一天排成简单的固定顺序，贴在墙上，用图画或大字。
- ☐ 奖励要小、要立刻：出门回来就一起喝杯东西，而不是“坚持一个月就给你买手机”。
- ☐ 不要替他做完所有事。全包代办会让退缩更稳固，但可以保留底线，比如吃饭、吃药、复诊。
- ☐ 记录可数的指标：这周洗澡几次、出门几次、主动开口几次。复诊时给医生看。
- ☐ 和医生核对三件事：有没有抑郁、有没有锥体外系反应、现在的镇静程度是否影响生活。
- ☐ 家属自己要有休息和喘气的时间，照护者垮了，照护也维持不住。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 突然不说话、不吃不动、保持一个姿势很久、叫不应——可能是紧张症，不要只当“不配合”。
- 连续几天几乎不进食、不喝水，或体重明显下降、尿量很少。
- 出现“活着没意思”“拖累你们”这类话，或交代后事、送东西——按自杀风险处理。
- 出现发热、意识不清、肌肉僵硬、大汗。

尽快联系门诊医生：

- 退缩在几周内明显加重，同时睡眠变差、疑心变重——可能是复发的前兆。
- 吃药后出现面具脸、手抖、走路变慢、坐立不安。
- 情绪持续低落超过两周，或对什么都提不起兴趣。
- 家属已经不知道该怎么开口，需要具体的沟通指导。

容易踩的坑

1. **用“懒”解释一切。** 骂得越狠，退缩越重。
2. **全部代劳。** 短期省事，长期让患者彻底退出生活。
3. **逼着社交。** 一次塞进十几人的饭局，多半以失败收场。
4. **把抑郁当成阴性症状。** 抑郁可以治，漏掉就可能拖成自杀风险。

5. **觉得“是药吃傻了”就自行停药。** 突然停药可能引起失眠、激越和幻觉加重，先和医生讨论。
6. **期待“回到病前”。** 更现实的目标是找回能做的部分，而不是复原成另一个人。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.3 认知损害：注意、记忆与执行功能

很多患者和家属会发现，症状控制住了，人却还是“回不去”：记不住刚说过的话，做一顿饭步骤全乱，出门总是忘带东西。这背后常常是认知损害，而不是“不用心”。这一页讲清楚认知损害包括哪些方面、为什么它比幻觉更影响工作和独立生活，以及家里能做哪些代偿。读完你能分辨“能力下降”和“态度问题”，也不会再把所有事都推给“懒”。

一、认知损害不是“变笨了”，是“处理不过来”

认知损害指注意、记忆、思考速度、计划能力这些“脑力工具”的效率下降。它和智力不是一回事：很多患者在智力测验上处于正常范围，但一放到真实生活里就处处卡住——不是不懂，是同时要处理的信息太多，脑子转不过来。

患者常这样描述：“话我都听见了，但拼不起来”“想做事，脑子里一片空白”“看一页书要看三遍”。这些描述比“记忆力差”更接近实情。

认知损害在精神分裂症里非常常见，而且在首次发作时就可能存在，不一定随阳性症状缓解而完全恢复。它和功能结局的关系，往往比幻觉妄想更紧密。【指南】【研究】

二、五个常受影响的领域

领域	通俗解释	生活里的表现
工作记忆	脑子里临时“存”住信息并操作	记不住刚说的号码；边听边记就乱；算账算到一半忘了
注意与警觉	持续专注、过滤无关信息	看电视看不下去；人多就烦；别人说话听不进去
处理速度	反应和思考的速度	说话慢半拍；跟不上对话；做事比别人费时间
执行功能	计划、排序、切换、控制冲动	做饭步骤乱；不会安排一天；一件事没做完又去做别的
社会认知	读表情、猜意图、理解玩笑和隐喻	误解别人好意；把玩笑当讽刺；觉得所有人都在针对自己

每个领域大概是什么样

工作记忆像一块小白板。别人说“把盐、酱油、醋拿过来”，白板小的人走到厨房只记得“盐”。这不是不听指令，是信息在半路掉了。

注意的问题有两头：一头是撑不住，几分钟就走神；另一头是过滤不掉，背景里的电视声、走路声全都涌进来，很快就累。

处理速度慢最容易被误解成“反应迟钝”“不尊重人”。给对方多几秒，结果往往不一样。

执行功能是“总指挥”。它弱的时候，人会显得没条理、拖延、冲动，很像性格问题，其实是能力问题。

社会认知受损和关系妄想不是一回事，但会互相加重：读不准表情，就容易把中性的话当成敌意。

三、为什么它比幻觉更影响工作和独立生活

幻觉很显眼，但它可以是间歇的；认知损害却是每天都在的底色。

- **吃药**：一天几次、哪几种、饭前饭后，全靠工作记忆和计划能力。
- **做饭**：买菜、洗切、看火、算时间，是典型的多任务执行。
- **出门**：查路线、看站牌、记住在哪下车、临时改道。
- **工作**：同时接两件事、被临时打断后回到原来的任务、记住口头交代。
- **管钱**：算账、比较、抵抗“现在就想买”的冲动。
- **复诊**：记住医生说的三件事，回家还能复述。

研究普遍发现，认知损害对职业与社会功能的预测力较强，甚至强于阳性症状的严重程度。【研究】这也解释了为什么“症状好了却上不了班”，不是患者不努力，而是支持没跟上。

四、怎么评估

认知损害不能靠“我觉得他变笨了”来判断，也不能靠网上的自测题确诊。

- **成套测验**：如 MATRICS 共识认知成套测验（MCCB）、简短认知评估（BACS），覆盖上述几个领域，多用于研究或较完整的评估。
- **床旁筛查**：医生在门诊用连线测验、数字广度、词语回忆等简单任务做初步判断。
- **功能评估**：PSP 量表看的是实际生活能力，比分数更贴近真实处境。
- **访谈**：问“最近做饭、买东西、坐车有没有变难”，往往比测验更有信息。

要注意，分数会被很多因素拉低：没睡好、抑郁、焦虑、药物镇静、抗胆碱能作用（一类让人口干、便秘、反应慢的副作用）、饮酒、甲状腺功能异常。所以“测出来差”不等于“脑子坏了”，需要医生结合背景解释。

五、能做点什么

认知矫正训练（针对注意、记忆、解决问题的结构化练习）有一定证据，但效果通常是中等程度，需要和具体的生活目标绑在一起才有意义，比如“为了能自己去超市”而练，而不是为了刷分。【研究】

日常代偿往往更直接：

- ☐ 药物用分格药盒加手机闹钟，闹钟响时人必须在场。
- ☐ 一天的事写在一页纸上，只写三件，做完划掉。

- ☐ 复杂任务拆成三步，写在便利贴上，贴在做事的地方。
- ☐ 钥匙、眼镜、医保卡固定放在同一个位置。
- ☐ 家里人一次只交代一件事，说完让对方复述一遍。
- ☐ 重要决定延后一天，先写下来，第二天再看。
- ☐ 睡眠、运动、戒烟限酒，对注意和速度都有实际帮助。
- ☐ 复诊时问医生：现在的镇静程度、抗胆碱能负担、情绪问题，有没有可以调整的空间。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊：

- 认知状态在几天内明显变差，伴发热、头痛、意识时清时浊、抽搐、走路不稳——要先排除脑部或躯体疾病。
- 突然不认识人和地方、说胡话、昼夜颠倒，可能是谵妄，按急症处理。
- 因为记不住吃药而反复漏服、重复服药，或出现明显过量。

尽快联系门诊医生：

- 记忆和注意力在几周内持续下降，影响到吃饭、吃药、安全。
- 同时出现情绪低落、什么都不想做、觉得拖累家人——要评估抑郁和自杀风险。
- 换了药或加了药以后反应明显变慢，先记录时间关系再反馈，不要自行停药。

容易踩的坑

1. **把认知损害当懒。** 越催越乱，越乱越不敢做。
2. **觉得“是药吃傻了”，自己停药。** 镇静和认知下降要由医生区分，突然停药的风险更大。
3. **只做“脑力训练”App。** 练了游戏分数，不一定迁移到做饭和上班。
4. **拿病前水平要求。** 目标应该是“能完成”，不是“和以前一样快”。
5. **一次交代五件事。** 结果往往一件都没完成，双方都受挫。
6. **忽视抑郁。** 抑郁造成的“假性痴呆”可以改善，漏诊代价很大。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- NICE. Rehabilitation for adults with complex psychosis (NG181), 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng181
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.4 行为与情绪表现：激越、紧张症、抑郁与自杀风险

精神分裂症不只有幻觉妄想。有人会突然激动、砸东西、威胁人；有人一动不动、不吃不喝、叫也不应；有人在病情好转后陷入深深的低落。这一页把这些表现分开讲，重点标出哪些必须立刻去急诊。适合家属在慌乱时快速对照，也适合患者自己理解“我身上发生了什么”。读完你能分清“闹脾气”和“急症”，也知道自杀风险该怎么问、怎么陪。

一、激越：先保证安全，再谈原因

激越指明显升高的紧张、坐不住、易怒、喊叫、摔东西甚至攻击。它是一个“状态”，不是一个诊断，背后可能有很多原因：

- 幻觉、妄想带来的恐惧，比如觉得有人要杀自己；
- 身体不舒服：疼痛、憋尿、便秘、发热、低血糖；
- 药物副作用：静坐不能（一种坐不住、心里发慌的副作用）；
- 戒断：酒精、苯二氮䓬类药物突然停用；
- 谵妄：意识不清、注意力涣散，常见于感染、电解质紊乱。

现场处理的原则是先降刺激、再加沟通：人少一点、声音低一点、灯亮一点、给对方留出能走出去的空间；用短句说清楚“我在，你很安全”；不要围堵、不要拉扯、不要争辩症状真假。药物由医生决定，家属不要自行加药。【指南】（NICE NG10 对急性激越的处理有专门推荐。）

静坐不能容易被误认为“激越”

有一种副作用叫静坐不能：心里发慌、腿发软、坐不住、来回走，但患者并没有愤怒或敌意。它常在加量或换药后出现，患者会说“我就是难受，说不清”。如果误当成“病情加重”而加药，反而会更重。遇到这种情况，记录出现时间和用药变化，尽快反馈给医生。

二、紧张症：不是“不配合”

紧张症是一组以运动和反应异常为主的表现，可能出现在精神分裂症、双相障碍、抑郁障碍，也可能由脑炎等躯体疾病或恶性综合征引起。它的危险在于：患者看起来只是“不理人”，实际上可能已经脱水、电解质紊乱，甚至出现血栓。

表现	家属看到的样子	紧急程度
木僵	几乎不动、不反应，像“定住了”	急症
缄默	完全不说话，问也不答	急症
拒食	不吃饭、不喝水，或含在嘴里不咽	急症
违拗	让他抬手偏放下，让他张嘴偏闭紧	急症
蜡样屈曲	摆成什么姿势就保持什么姿势	急症
装相、刻板动作	反复做同一个怪动作、保持怪异姿势	需尽快评估

表现	家属看到的样子	紧急程度
凝视、模仿言语	长时间盯着看、重复别人的话	需尽快评估

关键点：

- 紧张症需要急诊精神科评估，不能只当“闹情绪”或“对抗”。
- 不要强行喂食。吞咽反射可能有问题，硬灌容易呛入气管，造成窒息或吸入性肺炎。
- 拒食超过一两天、尿量明显减少、口干、站起来头晕，就要走急诊，可能需要静脉补液。
- 紧张症的治疗包括苯二氮䓬类药物和电休克（ECT），具体选择由医生判断；剂量和疗程不在科普里给。

三、抑郁与焦虑

抑郁可以出现在精神分裂症的任何一个阶段：急性期、症状缓解后、维持期。症状缓解后出现的抑郁，有时叫“精神病后抑郁”，表现是情绪低落、自责、无望、睡不好、不想动，严重时出现自杀观念。【指南】

它和阴性症状容易混：两者都可能表现为不说话、不动、退缩。区别在于抑郁有“低落”的底色——患者会觉得痛苦、自责、觉得拖累别人；阴性症状更多是“平淡、无所谓”。当然，两者可以同时存在。

焦虑也很常见，可能来自症状本身、对复发的担心、社会歧视，也可能来自咖啡因、尼古丁戒断，或药物的副作用（比如静坐不能带来的心慌）。持续的心慌、手抖、出汗，先排除躯体原因和药物原因。

四、自杀风险：要问、要陪、要限制手段

精神分裂症患者的自杀风险高于一般人群，风险较高的时段包括病程早期、病情好转后、出院后不久，以及伴发抑郁、绝望、命令性幻听、物质使用、既往自杀未遂的时候。【指南】

很多人怕“问了会教坏他”，事实相反：直接问不会增加风险，反而常常让人松一口气。

可以这样问：

- “最近有没有觉得活着没意思？”
- “有没有想过不想活了？”
- “有没有想过具体怎么做？家里有没有你打算用的东西？”

如果答案是肯定的，接下来做三件事：不让他独处、把手段拿远（药物由家属保管、刀具收好、高层窗户限位）、联系医生或急诊。必要时拨打 120，或拨打 12356 心理援助热线。

安全计划可以写下来，内容包括：出现念头时先打给谁、去哪里、把什么东西交给谁保管、哪些话对自己有用。写下来比记在脑子里可靠。

五、哪些情况算急症

- 明确的自杀计划、自杀未遂、正在交代后事；
- 命令性幻听，或已经按命令行动；
- 明显激越伴伤人威胁、持物、堵门；
- 木僵、缄默、拒食超过一两天；
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快——警惕恶性综合征；
- 突然吞咽困难、进食呛咳、呼吸困难——警惕噎食；
- 意识时清时浊、抽搐、剧烈头痛、频繁呕吐。

以上任何一条，都不要等门诊，直接去急诊；无法配合时拨打 120，有伤人风险时拨打 110。

六、家里可以怎么做

- ☐ 提前写好一张“紧急联系卡”：主治医生、医院急诊、社区精防人员、两位能立刻到场的亲友、12356。
- ☐ 把药物、刀具、绳索、过量可能致命的物品集中管理，钥匙由家属保管。
- ☐ 学会观察三件事：睡眠、进食、情绪基调。这三样变化常早于大波动。
- ☐ 不在激动时讲道理，等平静后再谈；一次只谈一件事。
- ☐ 不用“你想开点”“别人比你更惨”来回应低落，先承认“这确实很难”。
- ☐ 记录症状和用药的时间线，复诊时带着。
- ☐ 家属轮流照看，避免一个人长期硬扛。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> **立即急诊或拨打 120：** 自杀计划或行为；命令性幻听并准备执行；伤人威胁或已发生冲突；木僵、缄默、拒食；高热加肌肉僵硬加意识改变；噎食、呼吸困难、抽搐、意识不清。
>
> **尽快联系门诊：** 情绪低落持续两周以上；焦虑心慌影响睡眠；加药后坐不住、手抖；拒食一餐但能喝水、精神尚可；家属不知道该怎么应对。

容易踩的坑

1. **把紧张症当“赌气”。** 拖延的代价可能是脱水、电解质紊乱和血栓。
2. **强行喂饭喂水。** 呛咳和窒息风险很高。
3. **认为“问自杀不吉利”。** 不问才是真的风险。
4. **好转就放松看护。** 出院后和症状缓解初期，反而是风险较高的时段。
5. **把静坐不能当成“病情加重”。** 可能越加药越重。
6. **只靠“陪着他”而不联系医生。** 陪伴重要，但不能替代评估。

参考来源

- NICE. Violence and aggression: short-term management in mental health, health and community settings (NG10), 2015. https://www.nice.org.uk/guidance/ng10
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.5 疾病分期：前驱期、急性期、巩固期、维持期

同一句“他病了”，在不同阶段要做的事完全不同：早期是“要不要就诊”，急性期是“怎么保证安全”，缓解后是“怎么不复发、怎么回到生活”。这一页按前驱期、急性期、巩固期、维持期四个阶段讲目标与家属的位置，适合刚接触这个病、想弄明白“现在算哪一步”的人。读完你会知道分期是医生用来决定治疗强度的工具，而不是给自己贴标签的尺子。

一、分期是为了决定“现在该做什么”

精神分裂症的病程差异很大：有人一次发作后长期稳定，有人反复波动，有人以阴性症状和功能下降为主。分期不是给病程画一条直线，而是帮助医生判断三件事——现在的主要矛盾是控制症状、防止复发，还是恢复功能。

需要提前说明：分期主要由医生根据症状、病程、功能、治疗反应来综合判断，患者和家属很难自己“对号入座”。把分期当成理解治疗逻辑的框架可以，当成自我诊断的依据不行。

二、前驱期：模糊、非特异、不能据此下诊断

前驱期指正式发病前的一段变化期，可能持续数月到数年。常见表现是“整个人慢慢不对了”：

- 成绩或工作表现下降，注意力不集中；
- 变得孤僻，不愿见人，和家人说话变少；
- 情绪不稳、易怒、焦虑、睡眠差；
- 变得多疑，觉得别人在议论自己；
- 说话开始绕、难懂，或内容变得奇怪；
- 偶尔出现很轻的幻觉，比如听到叫自己名字，但很快过去；
- 个人卫生变差，兴趣减少。

这些表现单独看都很普通，青春期、抑郁、压力大、熬夜都可能出现。所以前驱期不能靠“对症状”来确诊。

研究显示，被列为“临床高危”的人里，多数并不会发展为精神病；一部分会，一部分会缓解，还有一部分会走向其他精神障碍。【研究】这也是为什么对高危状态的处理以“减少应激、治疗共病、定期随访、避免大麻等物质”为主，而不是急着长期用药。

需要提醒的是：如果家里有青少年出现上述变化，还伴随成绩断崖式下降、说话让人听不懂、明显疑心，值得尽快看精神科，而不是等到“确定是精神病”再去。

三、急性期：目标是控制症状、保证安全

急性期的典型表现是阳性症状突出：幻觉、妄想、思维紊乱、行为紊乱，常伴睡眠差、进食差、情绪激动。这个阶段的主要目标很明确：

1. **保证安全**：自杀、伤人、拒食、走失、意外。
2. **控制症状**：以抗精神病药为主，医生通常从低剂量开始、逐步调整，具体方案个体差异很大，以处方为准。
3. **处理诱因和共病**：物质使用、感染、睡眠剥夺、躯体疾病。
4. **建立治疗关系**：让患者和家属理解“为什么要治、治多久”。

急性期通常需要数周才能看到明显改善，不要期待吃几天药就“恢复正常”。部分患者需要住院：有明显自伤伤人风险、拒食、木僵、门诊调整无效、需要排除躯体病因时，住院是更安全的选择。是否住院、自愿还是非自愿，按精神卫生法和医生评估决定。

四、巩固期与维持期：目标是防复发、恢复功能

症状缓解不等于病好了。急性期之后，症状可能残留，复发的风险也仍然存在。

巩固期的目标是“稳住”：在症状明显缓解后继续原有治疗一段时间，避免过早减量导致反弹；同时开始处理阴性症状、认知损害和情绪问题。这个阶段最容易出现两种偏差：家属觉得“好了可以停了”，患者觉得“我没病了为什么还吃”。两种情况都需要在复诊时摊开来谈。

维持期的目标是“长期不复发 + 回到生活”：继续维持治疗、定期随访、识别复发前兆、恢复学习工作与社交。维持多久没有适用于所有人的答案，指南普遍建议在缓解后继续较长时间的维持治疗，具体由医生根据发作次数、既往停药后复发的历史、症状残留、副作用耐受性和患者意愿来决定。【指南】

一个常被低估的事实：停药后复发的风险很高，而且每次复发都可能带来功能上的倒退。所以减量、停药必须是医生的计划，不能自己决定。突然停药还可能出现失眠、激越、幻觉加重等反应。

五、四个阶段的目标对照

阶段	主要目标	家属能做什么
前驱期	识别变化、减少应激、治疗共病、定期随访	记录变化时间线；不贴标签；督促睡眠与就诊
急性期	控制症状、保证安全、排除躯体病因	陪同就诊；管理危险物品；如实提供病史；不争辩症状
巩固期	稳住疗效、处理残留症状、重建作息	提醒服药；观察副作用；不因“看起来好了”就自行减药
维持期	预防复发、恢复功能、提高生活质量	识别复发前兆；支持上学上班；维持随访；准备危机预案

每个阶段都可以做的一张小清单

- ☐ 这周睡眠大约几点到几点，有没有连续几天明显减少。
- ☐ 药有没有漏，有没有自己加减。
- ☐ 情绪是往“烦躁、话多”走，还是往“低落、沉默”走。
- ☐ 有没有新的疑心、新的声音、新的奇怪说法。
- ☐ 吃饭、洗漱、出门这三件事，比上个月是多了还是少了。
- ☐ 下次复诊是哪天，要问的三个问题写好了没有。
- ☐ 家里的危险物品和紧急联系电话，是不是还在原处。

不同阶段，家里说话的方式也不一样

急性期，少讲道理，多给安全感：“我在，我们去看医生。”巩固期，重点在稳定：“这周过得怎么样，药有没有漏？”维持期，重点在生活：“你想先试着做哪一件？”同一句话放在不同阶段，效果可能完全相反。

不要用分期给自己或家人“分期诊断”

- 分期是回顾性判断。当下很难说“我在前驱期还是急性期”，医生也要看一段时间的变化。
- “前驱期”这个标签会带来焦虑和歧视。孩子只是最近成绩差、不爱说话，不等于要发病。
- 症状波动不等于“进入新阶段”。睡不好、压力大、漏服药都会让症状暂时变重，先找原因。
- 不同医院的记录可能用不同说法，复诊时直接问：“现在这个阶段，治疗重点是什么？”

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 出现自杀念头、自杀计划或自伤行为；
- 命令性幻听，或已经按命令行动；
- 木僵、缄默、拒食超过一两天，或明显脱水；
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗；
- 明显激越伴伤人威胁；
- 首次出现精神病性症状，同时有发热、头痛、抽搐、意识波动。

尽快联系门诊医生：

- 睡眠连续几天明显减少，疑心变重，说话又开始绕；
- 患者提出想减药或停药；
- 出现明显的情绪低落、焦虑、坐立不安；
- 服药后有让人难以忍受的副作用；
- 学校或单位反馈“状态不对”，而家里说不清哪里不对。

容易踩的坑

1. **“好了就不用吃药了”。** 症状消失是治疗起效，不是疾病消失。
2. **把前驱期当命运。** 高危不等于发病，多数人不会发展成精神病。
3. **用分期互相指责。** “你就是不肯好”这类话，会把人推得更远。
4. **只盯症状，不管功能。** 能上学、能做饭、能和人说话，和症状分数一样重要。
5. **复发后自己把药加回去。** 剂量和方案要医生定，自行加量可能带来副作用。
6. **忽略躯体原因。** 首次发作、非典型表现，都要排除脑部和躯体疾病。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.6 精神检查与评估工具

你坐在诊室里，医生没有开检查单，而是问了很多看起来“闲聊”的问题：睡得好不好、有没有人跟你说话、觉得自己为什么来。这就是精神检查，精神科最重要的一项“检查”。这一页讲精神检查到底看什么、PANSS、BPRS、SAPS、SANS、PSP 这些量表各自做什么用、有什么局限。读完你能明白为什么诊断不能只靠量表分数，也知道复诊时该提供什么信息。

一、精神检查：医生“看”的是什么

精神检查和抽血、拍片不一样，它没有机器，靠的是观察和提问。医生一边和你说话，一边在记录：你走进来的样子、说话的条理、情绪的变化、对问题的反应、对自己状况的看法。

它有结构，但不是问卷。医生会先问开放的问题（“最近怎么样”），再逐步追问细节（“那个声音是男是女，说什么，你信吗”），中间还要判断你的回答是否可靠、是否需要向家属补充。

一次完整的精神检查通常需要几十分钟；急诊时会缩短到几分钟，先抓最关键的风险。

二、精神检查的八个部分

部分	医生在看什么	家属可能被问到
外观与行为	衣着、卫生、姿势、动作、眼神接触、有无紧张症表现	最近是不是不洗澡、整天躺着、动作变慢
言语	语速、音量、连贯性、是否答非所问	说话是不是变少、变绕、听不懂
情绪与情感	主观情绪（低落、焦虑、愤怒）与客观表达（平淡、不稳）	最近情绪怎么样，有没有哭、有没有发火
思维	内容（妄想）与形式（松弛、破裂、中断）	他最近说过什么奇怪的话
知觉	幻觉（听、视、触）、错觉、人格解体	有没有自言自语、捂耳朵、盯着空处看
认知	定向、注意、记忆、计算、执行	会不会迷路、忘事、算不清账
自知力	是否认为自己有病、是否愿意治疗	他觉得自己需要吃药吗
风险	自杀、自伤、暴力、走失、拒食	有没有说过不想活、家里有没有危险物品

自知力为什么重要

自知力指患者对自己状况的认识。它不是“听话不听话”，而是一个连续谱：有人完全否认自己有病，有人知道自己“有点问题”但归因于压力，有人能接受生病但不愿意长期吃药。自知力差会影响依从性，也会影响非自愿住院的评估。它可以通过心理教育和时间慢慢改善，不是一次谈话就能扭转。

三、常用量表：各自测什么

量表	测什么	怎么用	主要局限
PANSS	阳性、阴性、一般精神病理	半结构化访谈加知情者信	分数受访谈者影响；不能单

量表	测什么	怎么用	主要局限
	三大类，共 30 项	息，需培训，约半小时到四十分钟	独用来确诊；对认知损害覆盖不足
BPRS	较广的精神病理，偏症状总评	用时较短，适合急性期快速评估	对阴性症状和认知的区分不如专门量表
SAPS	阳性症状（幻觉、妄想、思维紊乱等）	多用于研究，细分症状维度	临床常规少用；不覆盖阴性症状
SANS	阴性症状（情感平淡、言语贫乏等）	多用于研究，评估阴性症状的严重度	与抑郁、锥体外系反应区分有限
PSP	社会功能：工作学习、人际、自我照料、干扰行为	0 到 100 分，分数越低功能越差	评的是功能不是症状；受环境和支持影响大

补充两个常用的：CGI（临床总体印象，医生给一个总体严重度和改善程度评分，简单快速）；以及认知成套测验（如 MCCB、BACS），用于较完整地评估注意、记忆、执行功能。

量表的作用是让不同时间、不同评估者之间的比较更可靠。比如这次 PANSS 比上次低，说明症状有改善；PSP 从低分升到中段，说明功能在恢复。这类变化比“我觉得好一点”更适合用来调整治疗。

四、量表能做什么，不能做什么

能做：

- 追踪同一个人的变化，判断治疗有没有起效；
- 让不同医院、不同研究者说同一种“语言”；
- 帮助医生把“很严重”拆成具体维度，比如阳性重、阴性轻；
- 在科研和药物试验里作为主要指标。

不能做：

- 不能用来确诊。诊断靠病史、精神检查、病程和功能损害，量表只是辅助。
- 不能替代面诊。分数背后的痛苦、恐惧、生活处境，量表测不出来。
- 不同量表之间不能直接换算。PANSS 的分数和 BPRS 的分数不是一回事。
- 一次分数不能定终身。睡眠、情绪、是否配合、评估者风格都会影响结果。

五、患者和家属怎么配合

- ☐ 复诊前写下三件最困扰你的事，按影响生活的程度排序。
- ☐ 记录症状的频率和持续时间，比如“这周有四个晚上听到声音，每次十几分钟”。
- ☐ 如实说用药情况，包括漏服、自行减量、自行加药。
- ☐ 如实说饮酒、吸烟、使用大麻或其他物质的情况。
- ☐ 带上之前的病历、出院小结、化验单、药盒。

- ☐ 家属补充时先说事实，再说看法：“他这周有三个晚上没睡，说有人在门外”比“他最近很不对劲”有用。
- ☐ 如果对评分有疑问，可以直接问：“这个分数说明什么，接下来会怎么调整？”

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 评估过程中或评估后出现明确的自杀计划、自伤行为；
- 命令性幻听，或已经按命令行动；
- 木僵、缄默、拒食，或高热伴肌肉僵硬、意识改变；
- 明显激越伴伤人威胁；
- 新发精神症状伴发热、头痛、抽搐、意识波动——先排除脑部和躯体疾病。

尽快联系门诊医生：

- 量表分数变化明显，同时睡眠、进食、工作学习也变差；
- 服药后出现手抖、坐不住、发胖、月经紊乱等副作用；
- 患者拒绝复诊或拒绝服药，家属需要具体应对方法；
- 对诊断或治疗方案有疑问，想再听一次解释。

容易踩的坑

1. **拿网上的自评量表给自己确诊。** 自评量表只提示“值得就诊”，不能下诊断。
2. **把分数当判决。** 分数高说明现在症状重，不代表一辈子都好不了。
3. **只报好消息。** 怕医生加药而隐瞒症状，最后吃亏的是自己。
4. **频繁换医院重做评估。** 不同评估者的分数不能直接比，反而看不清变化。
5. **要求医生“按量表开药”。** 治疗依据是综合评估，不是某一个数字。
6. **把精神检查当成“聊天”。** 它是诊断的核心环节，值得认真配合。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 3：病因与机制

精神分裂症不是单一原因造成的。遗传、神经发育、环境风险和心理社会因素共同作用。

3.1 遗传与家族风险

很多人第一次听到“精神分裂症有遗传倾向”，心里会立刻冒出两个问题：是不是我传给了孩子？我家里明明没有病人，为什么偏偏是我？这一页想把这两团乱麻理清楚：家族聚集到底说明了什么，遗传度这个常被引用的数字被误读成了什么，以及“有遗传风险”为什么不等于“一定会发病”。读完希望你能带走三句话——遗传是重要的风险因素，但不是命运；不存在一个叫“精神分裂症基因”的东西；有家族史的人真正能做的，是减少其他风险、早点识别、早点求助。

一、家族聚集：一个被观察了很久的事实

精神分裂症在家族中有聚集现象，这是精神医学里最早被确认的线索之一。早在上世纪初，医生就注意到：一个家庭里出现一位患者后，其亲属患病的可能性比一般人群高。此后一百年里，家系调查、双生子研究、寄养子研究反复验证了这一点，方向相当一致。【研究】

但“聚集”这个词需要拆开看。家族成员之间共享的不只是基因，还有居住环境、经济状况、饮食习惯、教养方式、甚至同一场灾难或同一种歧视经历。家族聚集只能说明“这个家庭里出现精神分裂症的概率高于平均水平”，不能直接说明“原因是基因”。

下表把常见亲属关系的风险相对水平排了一下。这里刻意不写具体百分比，因为不同研究给出的数字差别不小，而且任何数字放到某一个具体的人身上，都会失真。

亲属关系	风险相对水平	可以怎么理解
一般人群（无近亲患病）	基线	绝大多数人一生不会发病
父母一方患病	高于基线	风险升高，但多数子女并不发病
父母双方均患病	进一步升高	仍然不是“必然发病”
兄弟姐妹患病	高于基线	共享基因，也共享家庭环境
同卵双生子一方患病	各类亲属中最高	共享全部基因，仍有相当一部分同卵双生子不发病
二级亲属（祖父母、叔伯姑舅、侄甥）	轻度升高	血缘越远，风险越接近基线
三级亲属（表亲等）	接近基线	在个体层面几乎无法据此判断什么

这张表最容易被读错的地方，是把“相对水平”读成“命中率”。同卵双生子共享全部基因，同病率在各类亲属中最高，但仍有相当一部分同卵双生子并不发病——这一件事本身就说明，基因不是全

部。反过来说，绝大多数精神分裂症患者并没有一位患精神分裂症的直系亲属。家族史阴性，一点也不奇怪。【研究】

二、遗传度：最容易被误读的一个词

“遗传度”是行为遗传学里的一个统计量，描述的是：在某个特定人群中，人与人之间的差异有多大比例可以归因于基因差异。它回答的是群体问题，不是个人问题。

这个区别听起来学究气，实际影响很大。假设某地成年人的身高差异大部分可以归因于遗传，这不意味着你的身高也大部分“由基因决定”、剩下一小部分“靠后天努力”。它只意味着：在那个群体里，人与人身高不同的原因，大部分与基因差异有关。营养、疾病、睡眠同样影响身高，只是在这个群体里它们造成的差异相对小一些。精神分裂症的遗传度也是同样的逻辑。它是一个群体指标，不能拆开来分配给某一个人。【研究】

遗传度高，也不等于“环境不重要”。遗传度是在特定环境范围内估算的，环境一旦大幅改变，遗传度的估计也会变。更重要的是，遗传度高不等于“不可改变”。遗传度高的疾病里，照样有大量可以通过环境干预降低风险的部分——这一点在后面几节会展开。

还有一层常被忽略：遗传度不是“某个基因的作用大小”。精神分裂症不是单基因病，不存在“携带就发病、不携带就安全”的位点。

三、多基因风险：没有“精神分裂症基因”

过去十几年，全基因组关联研究（把成千上万人的基因位点与疾病做统计比对）带来的核心结论是：精神分裂症与很多很多个常见基因变异有关，每一个的作用都很小。把它们的作用加总起来，形成一个“多基因风险评分”，在群体层面能区分出风险高低。【研究】

但多基因风险评分目前仍是研究工具，不是临床检查。它不能告诉你“你一定会得”，也不能告诉你“你一定不会得”。原因很直接：这些变异单个效应太微弱，评分只在人群统计上有意义，落到个人身上预测力很有限。目前没有任何一家正规医疗机构会用基因检测来诊断或预测精神分裂症。

另一类变异效应较大，比如 22q11.2 缺失综合征（一小段染色体缺失），携带者患精神病性障碍的风险明显升高。但这类拷贝数变异只解释极少数病例，而且大多在儿童期就因其他躯体问题被识别。它重要，但它不是精神分裂症的主要解释。【研究】

所以更准确的说法是：精神分裂症是“多基因易感性 + 环境风险 + 发育过程”共同作用的结果，而不是某个基因打开了一个开关。

四、遗传不是命运：同卵双生子为什么不一起发病

如果基因决定一切，同卵双生子应该总是一起发病。事实不是这样。这是理解“遗传不是命运”最直观的入口。

差异来自哪里？目前能想到的至少有四类。第一，基因表达会被环境调控，同样一套基因在不同经历下“打开”的程度不同，这类机制常被归到表观遗传，具体到精神分裂症仍属【待验证】。第二，双生子在子宫里的位置、胎盘供血、出生体重可能不同，早年的营养与缺氧暴露也不同。第三，成长过程中的感染、压力、物质使用、社会处境各自不同。第四，随机性——大脑发育本身带有随机成分，不是一段写死的程序。【待验证】

还有“基因与环境的互动”。同样携带较高易感性的人，在一个支持充足、没有大麻、睡眠规律、压力可控的环境里，可能一辈子不发病；换一个环境，可能就被推过阈值。这就是为什么预防工作有意义：你改不了基因，但能改其中一部分环境侧的风险。

对家族史阳性的人来说，可行的做法不是“定期筛查基因”，而是照着下面这份清单做：

- 了解并记录家族中精神疾病、住院、自杀的情况，就诊时主动告诉医生；
- 避免大麻等物质，尤其是青少年期和成年早期；
- 保持规律睡眠，减少长期昼夜颠倒；
- 学会识别早期信号：持续猜疑、听见别人听不到的声音、成绩或工作能力明显下滑、社交退缩、情绪变得平淡；
- 出现上述信号时尽早看精神科，而不是等“严重了再说”；
- 不因为“家里有这个病”就放弃学业、工作或生育计划。

五、生育、家族史与家属的自责

“我是患者，能不能要孩子？”这是门诊里最常见、也最难用一句话回答的问题。可以谈，而且应该谈，但它不是一道“能或不能”的判断题。合适的做法是找精神科医生做一次孕前咨询，把几件事摆到桌面上：目前病情稳定多久、正在用什么药、停药或换药的风险、孕期随访条件、家庭支持情况。遗传风险是其中一项，不是全部。【指南】

需要说清楚的是：目前没有任何产前检查能预测一个孩子将来会不会得精神分裂症。它不是唐氏综合征那样的染色体问题，无法通过羊水穿刺或基因芯片给出“是或否”。任何声称能“孕前基因筛查精神分裂症”的商业服务，都应该高度警惕。

另一半常被忽略的是家属的自责。有些父母在得知诊断后反复回想：是不是我当年太严厉？是不是我孕期感冒了？是不是我遗传给了他？关于“父母造成精神分裂症”的旧观点，资料库在 3.5 心理社会因素、研究局限与“致病家庭”误区 里有专门澄清。这里只说一句：把病因归到父母的人格或教养上，既不符合现在的证据，也帮不到任何人。遗传风险是概率，不是某个人的过错。

六、常见问题与容易踩的坑

“家里没人得过，我是不是特别倒霉？” 不是倒霉，也不罕见。大多数患者没有患精神分裂症的直系亲属，这符合疾病本身的分布规律。

“亲属患病，我要不要提前吃点药预防？” 不需要。目前没有用于“预防精神分裂症”的药物，健康人服用抗精神病药反而要承担副作用风险。真正有效的预防是识别高危状态、处理共病、减少物质使用，并在症状出现时尽早治疗。【指南】

“基因检测能不能告诉我孩子会不会得？” 不能。多基因风险评分目前只在研究中使用，个体预测力有限；宣传“一测就知道”的机构不可信。

“遗传度高，是不是说明治疗没用？” 不是。遗传度描述的是群体差异的来源，不描述治疗反应。抗精神病药、心理社会干预、家庭支持的作用与遗传度是两回事。

> **出现以下情况，请当天联系医生或尽快复诊：**
>
> - 想做孕前咨询、遗传咨询，或对家族史有疑问——挂精神科或遗传咨询门诊，不要靠网络自测下结论
> - 服用抗精神病药后自行停药，出现失眠、激越、幻觉加重——尽快联系医生，不要自行加回原量或硬扛

> **出现以下情况，立即去急诊或拨打 120：**
>
> - 坚信被监视、被针对，听见别人听不到的声音，说话变得跳跃难懂，且持续两周以上
> - 出现自杀念头、自伤行为，或已经写好了计划——不要独处，立即联系信任的人陪同，必要时拨打 110
> - 出现木僵、缄默、拒食、保持一个姿势不动（警惕紧张症）
> - 出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快（警惕恶性综合征）

参考来源

- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.2 神经递质：多巴胺、谷氨酸与 GABA

“精神分裂症是不是大脑里某种化学物质太多了？”这是门诊里最常见的问题之一。抗精神病药确实作用于多巴胺系统，这一点有相当硬的证据；但把病因概括成“多巴胺太多”，既解释不了药物的起效延迟，也解释不了为什么有一部分人吃了药仍然不好。这一页讲三件事：多巴胺假说从哪里来、它解释了什么、它解释不了什么；谷氨酸与 GABA 这两条线目前走到哪一步；以及“知道机制”对患者和家属到底有什么用。

一、多巴胺假说：从一次偶然发现开始

多巴胺假说不是先有理论再找证据，而是反过来。上世纪五十年代，氯丙嗪原本被当作麻醉辅助用药，却意外让精神病患者的幻觉和躁动减轻。此后研究者发现了一条规律：抗精神病药阻断多巴胺 D2 受体（可以理解为细胞表面接收多巴胺信号的“接口”）的能力越强，临床用量往往越小。这个相关性在几十种药物上重复出现，成了假说的第一根支柱。【研究】

第二根支柱来自“反向证据”。治疗帕金森病的左旋多巴（它在体内会转成多巴胺）可能诱发幻觉和妄想；苯丙胺类物质会大量释放多巴胺，长期大量使用可产生与精神分裂症非常相似的精神病性症状。两条线一正一反，都指向多巴胺信号过强。【研究】

第三根支柱来自活体影像。用正电子发射断层扫描（PET）可以看到，部分未用药患者纹状体的多巴胺合成能力高于对照，受到刺激时释放也更多。这个发现把“多巴胺异常”从间接推理变成了可测量的现象，但它仍然只在群体层面成立，个体之间重叠很大。【研究】

需要提醒的是，早期研究里“患者脑内多巴胺代谢产物升高”的结果并不一致，有些研究甚至得出相反结论。这正是假说后来被不断修订的原因：问题不在“全身多巴胺总量”，而在特定脑区、特定通路的活动调节。

二、四条通路：疗效和副作用为什么总是绑在一起

理解了通路，很多副作用就不再神秘。大脑里的多巴胺通路不止一条，抗精神病药阻断 D2 时并不区分“哪条通路该管、哪条不该管”，于是治疗作用与不良反应常常同时出现。

通路	大致走向	阻断后可能的结果
中脑边缘通路	中脑腹侧被盖区 → 伏隔核等	幻觉、妄想等阳性症状减轻
中脑皮质通路	中脑腹侧被盖区 → 前额叶	可能加重情感平淡、动力不足等阴性表现
黑质纹状体通路	黑质 → 纹状体	手抖、僵硬、动作变慢、静坐不能等锥体外系反应
结节漏斗通路	下丘脑 → 垂体	催乳素升高，出现月经紊乱、溢乳、性功能改变

这张表解释了一件常让患者困惑的事：为什么药能压住幻觉，却让人发僵、发胖、月经不调。不是药“用错了地方”，而是它作用的目标在脑子里本来就有多个岗位。也正因为如此，医生调整药物时，往往是在“压住症状”和“减少副作用”之间找平衡，而不是简单地“加量就更好”。【临床经验】

另外要说明，中脑皮质通路被阻断后可能加重阴性症状，这是一个理论上的担忧，临床上的实际影响因人而异，不同药物的表现也不同。【待验证】

三、“多巴胺太多”这个说法，至少有四个地方对不上

第一，时间对不上。 药物阻断 D2 受体是在几小时内完成的，但幻觉和妄想的明显减轻通常要几天到几周。如果病因只是“多巴胺过多”，把接口堵上应该立刻见效。起效延迟说明，真正起作用的是下游一连串缓慢的适应过程。【研究】

第二，反应率对不上。 有相当一部分患者对充分的 D2 阻断反应不佳，阳性症状只部分减轻或几乎不变。如果多巴胺是唯一原因，不该有这么多人“堵了也没用”。

第三，症状谱对不上。 阴性症状（情感平淡、意志缺乏）和认知损害往往比幻觉更影响长期生活，而它们对 D2 阻断的反应相当有限。这说明这些症状背后另有机制，或者至少不只是多巴胺。

第四，个体对不上。 有些患者的多巴胺代谢指标与健康人没有明显差别，也有些健康人在药物或物质作用下出现类似表现却不会发展成精神分裂症。

所以更准确的说法是：多巴胺信号异常是精神分裂症发病链条中的**一个关键环节**，也可能是抗精神病药起效的**共同下游**，但它不是全部病因。把“多巴胺太多”当成结论，会带来两个坏处：一是让人以为“把多巴胺降下去就万事大吉”，二是让人对药物反应不佳产生不必要的自责。

四、谷氨酸与 GABA：另一条更“完整”的线索

谷氨酸是大脑里最主要的兴奋性递质，GABA 是最主要的抑制性递质（递质可以理解为神经元之间传递信号的化学信使）。这两套系统和多巴胺一起，决定了大脑网络的兴奋与抑制是否平衡。

谷氨酸这条线最有说服力的证据来自“药物模型”。苯环己哌啶（PCP，一种曾被滥用的麻醉剂）和氯胺酮都能阻断 NMDA 受体（谷氨酸的一种受体），健康人使用后会出现幻觉、猜疑、思维散乱，同时还有情感平淡、注意和记忆下降——也就是说，它模拟出的症状比“单纯多巴胺过多”更接近精神分裂症的全貌。【研究】

由此产生了“NMDA 受体功能低下”假说：如果谷氨酸信号不足，皮层与皮层下网络的协调就会出问题，继发多巴胺系统失调。这个假说的吸引力在于，它能同时解释阳性、阴性和认知三类症状。【研究】

但把假说变成治疗并不顺利。补充甘氨酸、D-丝氨酸等“增强 NMDA 受体功能”的尝试，结果很不一致；有些小样本研究显示辅助治疗可能改善部分症状，较大的试验却没能重复。拉莫三嗪等药物用于

难治性患者的辅助治疗，也有一些阳性结果，但证据仍不足以成为常规推荐。这些方向目前只能标为【待验证】。

GABA 这条线更靠近“网络同步”。尸检和影像研究提示，部分患者前额叶的 PV 型中间神经元（一种负责给兴奋“踩刹车”的抑制性神经元）功能可能减弱，导致神经振荡异常。这类研究样本小、方法差异大，目前主要用于解释“为什么信息整合会出问题”，还不能指导用药。【待验证】

五、抗精神病药到底做了什么

把前面几节收拢一下：抗精神病药的共同点是阻断 D2 受体，但不同药物还作用于 5-HT2A、D3、5-HT1A、H1、M1、α1 等多种受体，这解释了它们在副作用谱上的差别——比如抗组胺作用强的更嗜睡、增重更明显，抗胆碱作用强的更容易口干、便秘。

临床上有一个有帮助的概念叫“D2 占位率”：药物占据了多大比例的受体。占位太低，疗效不足；占位过高，锥体外系反应和催乳素升高的风险上升。这也是为什么医生不会一味加量，而会在疗效与副作用之间找一个合适的点。不同人对同一个占位率的反应差别很大，所以“别人吃这个量有效”不能直接搬到自己身上。【临床经验】

要强调的是：抗精神病药不是“补充”大脑缺少的东西，也不是“排毒”。它做的是调低某些通路的信号强度，让症状有机会缓解，同时给心理社会康复创造条件。它不修复病因，作用是控制症状、降低复发风险。

六、机制解释的局限，以及患者常踩的坑

机制研究最大的价值，是帮我们理解“为什么这些药有效、为什么会这样副作用”，从而更好地配合治疗。它最大的风险，是被当成“我已经知道病因了”的错觉。

一个常被忽略的逻辑是：药物有效，不等于病因就是药物作用的靶点。阿司匹林能退烧，不代表发烧的原因是“缺乏阿司匹林”。同理，抗精神病药阻断 D2 有效，不等于精神分裂症就是“D2 过多症”。

基于这些，下面这份清单上的事都不建议做：

- 不要自行购买宣称“调节多巴胺”“修复神经递质”的保健品或氨基酸类产品，它们不能替代抗精神病药，还可能干扰睡眠或与药物相互作用；
- 不要因为“机制上应该有效”就要求医生换药或加药，机制推断不能替代临床评估；
- 不要因为“多巴胺假说过时了”就停药。假说会被修订，但药物的疗效证据是独立的；
- 不要用“我的多巴胺不平衡”来解释所有情绪波动，情绪、睡眠、压力、躯体疾病都会影响状态。

出现以下情况，请当天联系医生或尽快复诊：

- 脖子突然歪向一侧、眼睛上翻、舌头不受控、坐立不安到无法静坐（警惕急性肌张力障碍或静坐不能）
- 发热、咽痛、口腔溃疡、乏力（尤其正在服用氯氮平）——立即查血常规，警惕粒细胞缺乏
- 自行停药后出现失眠、激越、幻觉加重、头痛、恶心——尽快联系医生，不要自行加回原量

出现以下情况，立即去急诊或拨打 120：

- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快、尿少（警惕恶性综合征）
- 出现自杀念头、自伤行为，或命令性幻听让自己做危险的事——不要独处，必要时拨打 110
- 出现木僵、缄默、拒食、保持固定姿势不动（警惕紧张症）

参考来源

- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.3 脑结构、神经发育与炎症

做过核磁的患者常拿着报告问：上面写着“脑室略大”“皮层萎缩”，是不是脑子坏掉了？也有人反过来问：既然说是脑子的病，为什么医生不给我做一个脑扫描确诊？这一页讲三件事：影像研究在群体层面发现了什么，神经发育与免疫炎症这两条解释线走到哪一步，以及为什么这些发现不能拿来给任何一个人下诊断。读完之后，希望你对“脑影像异常”这件事少一点恐慌，也少一点不切实际的期待。

一、脑影像看到了什么：差异是真的，但只在群体里

过去几十年，结构核磁研究反复报告了一些平均差异：与健康对照相比，精神分裂症患者组的侧脑室平均更大，颞上回、海马、前额叶等区域的灰质体积平均更小，白质纤维束的完整性指标平均更低。【研究】

这些发现是真实的统计差异，不是编出来的。但它们有几个必须同时说清的性质。

第一，差异是“组的平均”。把两组人的数值画成两条分布曲线，中间大部分是重叠的。很多患者在这些指标上完全落在健康人范围内，也有很多健康人的数值落在患者那一侧。用一个人的扫描结果去判断他有没有精神分裂症，准确率并不比抛硬币好多少。

第二，效应量只能算中等。所谓效应量，可以理解为“两组差距相对于人群自然波动的幅度”。中等效应意味着差异看得见，但远不足以作为个体层面的标签。

第三，混杂因素很多。病程长短、是否用药、用药种类与年限、吸烟、体重、饮酒、社会处境，都会影响脑结构。有些研究提示抗精神病药可能影响灰质体积变化，这类问题在伦理上很难做严格的对照试验，所以因果方向至今没有定论。【待验证】

常见发现	主要研究方法	群体层面的含义
侧脑室平均扩大	结构核磁	提示部分患者存在脑脊液腔隙增大，机制不明
颞上回、海马、前额叶灰质体积平均减少	结构核磁、纵向随访	可能与症状严重度、认知表现相关，个体差异大
白质完整性指标下降	弥散张量成像	提示部分纤维束连接受影响，解释力有限
皮层厚度或表面积差异	结构核磁	结果不一致，受年龄、用药、扫描参数影响

二、神经发育假说：一条从孕期就开始的线

为什么一个十八九岁的人会突然发病，而大脑的“问题”却可能更早？神经发育假说给了一个思路：风险在生命很早就埋下，症状只是在特定发育阶段才显现。

支持这条线的证据大致有三类。第一类是产科与围产期因素：母体感染、营养不良、妊娠高血压、早产、低出生体重、分娩缺氧等，在流行病学上与后来的精神分裂症相关。第二类是童年期的细微异

常：部分后来发病的孩子，在儿童期就有动作协调、注意力、社交理解上的轻微落后，只是往往不足以引起重视。第三类是前驱期的变化：在正式发病前的几个月到几年，常出现成绩下滑、社交退缩、猜疑、言语变得空泛等。【研究】

一个被广泛讨论的机制是“突触修剪”。青春期大脑会主动修剪用得不多的神经连接，让网络更高效。有假说认为，部分人的修剪过程过度或失调，导致关键环路连接不足。这个假说能解释“为什么起病年龄集中在青春期到成年早期”，但目前仍属于【待验证】，还无法直接指导治疗。

还有“神经退行”与“神经发育”的争论：病后的功能下降，是持续退化，还是一次发育性偏离之后的稳定状态？纵向影像研究的结果并不统一，部分患者病程中确有更明显的灰质变化，但很难与用药、生活方式、反复发作区分开。目前比较稳妥的说法是：两者可能都参与，比例因人而异。【待验证】

需要强调的是，这条线不等于“小时候就注定了”。神经发育风险是概率性的，绝大多数有产科并发症的孩子并不会得精神分裂症；反过来，很多患者并没有明显的早年风险。

三、炎症与免疫：从“相关”到“因果”还有很长的路

免疫这条线近几年很热，值得认真讲，也值得认真泼一点冷水。

支持性的观察包括：母体在孕期感染某些病原体，与子代患病风险升高相关；部分患者存在自身免疫病共病；一些研究发现患者血液中某些细胞因子（免疫系统用来传递信号的蛋白）水平与健康对照不同；尸检研究提示部分患者脑内微胶质细胞（大脑里的免疫细胞）活化标志物增加。【研究】

但“相关”不等于“因果”。细胞因子升高可能来自睡眠紊乱、吸烟、体重、应激、感染，也可能是疾病过程的结果而不是原因。更关键的是，免疫指标在个体之间波动很大，目前没有任何一个血液炎症指标可以用来诊断精神分裂症。

治疗转化同样谨慎。塞来考昔、米诺环素、N-乙酰半胱氨酸等抗炎或抗氧化辅助治疗的试验，结果不一致：有的小样本显示对部分症状有帮助，较大的试验却没能重复。因此这类做法目前只能算研究性尝试，标为【待验证】，不能作为常规推荐，更不应该自行购买服用。【待验证】

这里有一个必须说清的安全点：**不要因为“炎症假说”就自行服用抗生素、激素或大剂量消炎药。**这些药有明确的副作用和相互作用风险，没有医生评估的自行使用可能造成伤害。

四、为什么这些发现不能用于个体诊断

精神分裂症至今仍是临床诊断：靠症状、病程、功能损害和排除其他原因，不靠任何一项检查。脑影像在精神科的主要用途是**排除**——排除肿瘤、脑卒中、脑炎、多发性硬化、颞叶癫痫等可能引起精神病性症状的器质性疾病，而不是“确认”精神分裂症。

那么什么时候医生会建议做影像？通常是有一些“不像单纯精神科问题”的线索时：首次发作、年龄偏大或偏小、有局灶性神经体征（比如一侧肢体无力、视野缺损）、新发癫痫、意识障碍、头痛呕吐、症状在短时间内快速进展、有肿瘤病史或免疫抑制状态。这些情况下做影像，是为了不漏掉可以治疗的躯体疾病。【指南】

对已经确诊、病情稳定的患者，反复做核磁并不会带来治疗上的好处，反而增加花费和焦虑。这也是为什么医生常常不做——不是不重视，而是这项检查对诊断没有帮助。

同样重要的是，别把影像报告上的“脑室扩大”“轻度萎缩”当成判决书。第一，放射科报告的措辞常常是描述性的，很多“轻度”改变在健康人里也能见到；第二，大脑有可塑性，功能结局更多取决于症状控制、康复、社会支持，而不是某一张片子上的一条线；第三，报告需要结合年龄、病史来读，脱离上下文解读容易吓到自己。

五、听到“脑子有变化”之后，可以做的事

如果你或家人刚拿到一份让人不安的影像报告，下面这份清单可以带去门诊：

- 问清楚：这个发现是“排除性检查的正常描述”，还是需要随访的异常？
- 问清楚：以目前的症状和病程，这个发现会改变治疗方案吗？
- 问清楚：需要复查吗？多久复查？复查要解决什么问题？
- 问清楚：这个发现和年龄、用药、吸烟、体重有没有关系？
- 主动提供：完整用药史、物质使用史、既往头部外伤与癫痫史；
- 主动询问：有没有可能影响影像解读的其他疾病，比如甲状腺问题、自身免疫病、感染；
- 不要自行购买“补脑”“修复神经元”的保健品，也不要用它替代药物；
- 如果报告里出现“占位”“出血”“梗死”“脑炎可能”等字样，尽快找医生当面解读，不要等。

六、常见问题与容易踩的坑

“脑室扩大是不是说明脑子萎缩了、没救了？” 脑室扩大常被通俗地称为“脑萎缩”，但在精神分裂症研究中，它更多是一个群体层面的统计差异，幅度有限，不能用来预测某个人的结局。功能结局与治疗、康复、支持的关系，比与影像的关系更直接。

“炎症假说是不是说明要吃消炎药？” 不是。目前的抗炎辅助治疗证据不一致，属于研究性尝试。自行服用抗生素或激素有实际风险。

“能不能用影像预测我会不会发病、吃哪种药有效？” 目前不能。影像标志物还停留在研究阶段，没有进入常规临床决策。

“那我做这些检查是不是白做了？” 不白做。排除器质性疾病是诊断流程的一部分，只是它的意义在于“排除”，不在于“确诊”。

出现以下情况，请当天联系医生或尽快复诊：

- 对影像报告有疑问、被“脑萎缩”吓到、想讨论复查计划——挂精神科门诊，带上片子和报告当面问
- 出现口唇、舌头、下颌或四肢的不自主动作——尽快复诊，不要自行停药

出现以下情况，立即去急诊或拨打 120：

- 新发剧烈头痛、呕吐、视物模糊、一侧肢体无力、说话不清、抽搐——这是神经系统急症，不能按“精神病症状”处理
- 发热、颈项强直、意识模糊、行为紊乱且进展很快——警惕脑炎等中枢感染
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗——警惕恶性综合征，立即停药并急诊
- 出现木僵、缄默、拒食、保持固定姿势不动（警惕紧张症）
- 出现自杀念头、自伤行为，或命令性幻听让自己做危险的事——不要独处，必要时拨打 110

参考来源

- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.4 环境风险：孕产期、感染、移民、城市、大麻

读到“环境风险”这四个字，很多家属会紧张：是不是我怀孕时感冒了？是不是我们搬到大城市？是不是他大学时抽过几次大麻？这一页把常见环境风险一个个拆开讲：哪些有证据、证据有多硬、哪些是可以改变的，以及为什么“有风险因素”不等于“找到病因”。读完希望你能明白一件事：风险因素是概率的推手，不是某个人、某件事的罪证。

一、先弄清“风险因素”是什么意思

流行病学里的“风险因素”，指的是**与发病概率升高相关**的因素，它不承诺因果，也不指向某一个具体的人。吸烟与肺癌的关系已经算很硬了，但仍有长期吸烟者不得肺癌，也有从不吸烟的人得肺癌。精神分裂症的环境风险更是如此，每个因素的效应都不大。

这里有两个容易混淆的概念。**相对风险**是“暴露组比未暴露组高多少”；**绝对风险**是“一个人一生中实际发生的可能性”。一个因素可以把相对风险提高不少，但如果基线风险本来就不高，绝对风险的增加可能很小。媒体常报道“某某因素让风险翻倍”，读者容易听成“我有一半概率会得”，这是两回事。

目前比较被接受的整体图景是“多重打击”：遗传易感性打底，加上孕期、围产期、童年、青春期的一连串风险，累积到某个阈值才发病。没有任何单一因素能解释大多数病例。也正因如此，**无法通过回溯找到“你的病因”**——医生能做的是评估整体风险，而不是给每个患者开一张归因清单。

二、产前与围产期：证据较多，但效应温和

这是环境风险里研究最扎实的一块。比较一致的方向包括：母体在孕期感染（尤其是流感类呼吸道感染）、孕期营养不良、妊娠高血压与妊娠糖尿病、早产与低出生体重、分娩时缺氧、产伤等，与子代后来患精神分裂症的风险升高相关。【研究】

其中“营养不良”的证据来自历史事件的自然实验：战时饥荒期间受孕或孕早期经历严重饥饿的人群，子代患病率有所升高。这类研究设计巧妙，但也受限于当时的诊断标准和记录质量。

父亲生育年龄偏高也与风险升高相关，机制可能涉及新生突触突变累积，目前仍属【待验证】。

需要非常小心的一件事：这些发现**不是用来指责母亲的**。“孕期感冒”是极常见的事，绝大多数孕期感染并不会导致孩子患病；把病因归到某一次感冒、某一次没休息好，既不符合证据，也会给家庭增加不必要的内疚。

三、感染与免疫：有关联，但还不能当因果

除了孕期感染，早年中枢神经系统感染（如脑炎、脑膜炎）与后来的精神病性障碍相关；部分自身免疫病（如狼疮、自身免疫性甲状腺病）患者的精神病性症状发生率较高；弓形虫感染也被反复讨论，但结果不一致，且很难排除社会经济状况、宠物接触、饮食习惯等混杂因素。【待验证】

这类研究的价值在于提示“免疫系统可能参与”，但它离“感染导致精神分裂症”还很远。绝大多数感染过的人不会患病，绝大多数患者也没有明确的感染史。具体到免疫机制与抗炎治疗的可能性，详见 3.3 脑结构、神经发育与炎症。

四、移民与城市生活：更像是社会处境的问题

移民与少数族裔群体中，精神分裂症的发病率在多项研究中高于当地多数族群。这个发现一度被误读为“某些种族的基因问题”，但后续研究并不支持这种解释：风险升高在不同原籍国、不同族群的移民中都出现，而且与移民第二代、社会歧视体验、失业、住房不稳定、社会支持缺乏关系更密切。【研究】

目前比较主流的解释是“社会挫败”与长期压力：持续的歧视、边缘化、身份被否定，会改变人的应激反应、睡眠和社会连接，进而影响易感个体的发病风险。这也解释了为什么“移民比例高的社区里，少数族群占比越低，风险越高”这类看似奇怪的现象会出现。

城市生活与发病风险之间也有统计关联，且呈现“城市化程度越高、风险略高”的趋势，但效应很小，远不足以解释城市里大多数人的健康状况。城市里同时聚集了更多的人口流动、社会孤立、物质使用和压力事件，这些才是更值得关注的中介因素。

与此相关的一个经典争论是“社会因果”与“社会漂移”：是贫困与压力导致发病，还是发病导致人往下流动、失去工作与住所？两种过程很可能同时存在。对家庭来说，这个争论的实际含义是：**不要把患者的社会处境当成他“不努力”的证据**。

五、大麻与兴奋剂：目前最值得重视的可改变因素

在所有环境因素里，物质使用是少数“证据较硬、又确实可以改变”的一项。

关于大麻，比较一致的发现是：使用越早、频率越高、THC（大麻中主要的精神活性成分）浓度越高，精神病性症状与精神分裂症的风险越高；在遗传易感人群中，这种关联更强。【研究】合成大麻素（俗称“香料”“K2”等）风险更高，因为它们对受体的作用强度远超天然大麻。

但因果推断并不轻松。使用大麻的人可能同时吸烟、饮酒、睡眠紊乱、社会压力更大，这些都可能是混杂因素；也可能存在“反向因果”——已经出现早期症状的人更倾向于用大麻缓解不适。即便如此，考虑到大麻使用的普遍性和可改变性，“减少或停止使用”仍是目前最值得做的事之一。【指南】

兴奋剂类物质（苯丙胺、甲基苯丙胺、可卡因等）能直接诱发类似精神分裂症的精神病性状态，常被称为“苯丙胺精神病”，表现为被害妄想、听幻觉、激越。多数人在停用后数天到数周内缓解，但有一部分人会持续更久，甚至发展为独立于物质使用的病程。判断“这是物质所致还是精神分裂症”，需要医生结合使用史、停药后的病程和随访来判断，不能自己下结论。

这里要避免一种污名化：使用物质的人不是“自甘堕落”，物质使用障碍本身是需要治疗的健康问题。把“他抽大麻所以活该”挂在嘴边，只会让人隐瞒使用情况，耽误评估。

六、把这些风险放在一起看

风险因素	证据强度	能否改变
孕期感染、营养不良、产科并发症	中等，方向一致	部分可改变（产检、营养、戒烟酒）
童年期中枢感染、自身免疫病	较弱，结果不一致	部分可治疗
移民、少数族群处境、歧视	中等，机制偏向社会因素	社会层面可改善，个人层面有限
城市生活	弱，效应小	有限
大麻（尤其高效力、早期、频繁）	中等偏强	**可以改变**
兴奋剂类物质	较强（急性精神病性症状）	**可以改变**

这张表最实用的读法是看最后一列。遗传、孕期、童年经历都已经过去，无法重来；而物质使用、睡眠、社会支持、是否及时就医，是现在还能动的部分。把注意力放在这里，比反复追问“到底是哪件事造成的”更有帮助。

家属可以做的事

- 不翻旧账式追问“是不是我怀孕时……”，这类自责对治疗没有帮助；
- 了解家族里是否有精神疾病、住院、自杀的情况，就诊时主动告诉医生；
- 青少年期避免大麻和其他成瘾物质，家里不存放、不默许；
- 出现持续猜疑、听见声音、成绩骤降、社交退缩，尽早就诊，不要等“确诊了再说”；
- 如果家人已经在使用大麻，先谈“减少伤害”（不空腹、不独自、不用合成大麻素、不驾车），再谈戒断，必要时找成瘾专科；
- 关注睡眠：长期昼夜颠倒、通宵打游戏往往是复发的前奏，而不只是“生活习惯问题”；
- 保持社会连接：一份工作、一个固定活动、几个能说话的人，都是实打实的保护因素；
- 不把“环境风险”当成指责患者的理由，风险因素不等于个人选择。

常见问题

“孕期感冒过一次，是不是我害了孩子？” 不是。孕期感染很常见，绝大多数并不会导致子代患病。把病因锁定在某一次感冒上，既没有证据支持，也会让家庭背上不该背的负担。

“搬到大城市生活，是不是风险很高？” 城市生活与发病的统计关联很弱，远不足以成为搬不搬家的决策依据。相比之下，睡眠、物质使用、社会支持这些具体因素更值得关注。

“偶尔抽一次大麻，会不会就得病？” 单次使用导致精神分裂症的可能性很低，但风险随频率、效力、开始年龄上升，在易感人群中更明显。对已经有精神病性体验或家族史的人，最稳妥的选择是不用。

“疫苗会不会导致精神分裂症？” 目前没有可靠证据支持这种说法。相反，孕期严重的感染性疾病本身才是需要防范的风险，按医嘱接种推荐的疫苗属于常规产检的一部分。

出现以下情况，请当天联系医生或尽快复诊：

- 孕期或备孕期间正在服抗精神病药，想讨论用药调整——挂精神科与产科联合门诊，不要自行停药
- 使用大麻或兴奋剂后出现幻觉、被害感、激越、行为失控——立即停止使用并尽快就医

出现以下情况，立即去急诊或拨打 120：

- 出现自杀念头、自伤行为，或命令性幻听让自己做危险的事——不要独处，必要时拨打 110
- 出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快（警惕恶性综合征或物质中毒）
- 出现抽搐、意识丧失、剧烈头痛、胸痛、呼吸困难
- 出现木僵、缄默、拒食、保持固定姿势不动（警惕紧张症）

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.5 心理社会因素、研究局限与“致病家庭”误区

几乎每一位家属都在某个深夜想过同一个问题：是不是我们哪里做错了？是不是我太严厉、太冷漠、太忙，才让他变成这样？这个念头不是凭空来的——上世纪中叶，精神医学界真的流行过“父母造成精神分裂症”的说法，它影响了几代人。这一页做三件事：讲清楚心理社会因素在精神分裂症里到底扮演什么角色；把“致病家庭”这段历史错误摊开说明；以及教你怎样判断一条“新研究说”的结论值不值得信。

一、应激—易感模型：压力常常是扳机，不是子弹

目前最被广泛接受的框架叫“应激—易感模型”。它说的是：一个人先有生物学上的易感性（遗传、神经发育），在遇到足够强的应激时，才可能跨过发病的阈值。易感性像火药，应激像火星；没有火药，火星点不着；没有火星，火药也可能一直不响。

这个模型能解释几个临床现象。第一，同样的压力事件，有人发病，有人没事。第二，很多患者在发病前确实经历了明显的生活事件：高考失利、失恋、被辞退、亲人去世、搬迁、长期失眠。第三，发病之后，压力仍然会影响复发——这也是为什么家庭沟通、工作节奏、睡眠管理在康复期那么重要。

但要小心因果方向。生活事件与发病在时间上接近，不等于事件导致了疾病。有时候是疾病的前驱期已经开始，人的状态在变化，才导致了失恋、失业、冲突——也就是说，**症状可能是“原因”而不是“结果”**。这类“反向因果”在横断面研究里几乎无法排除。

二、哪些心理社会因素有证据

心理社会因素对精神分裂症的作用，可以粗略分成两类：对“起病”的作用，和对“复发与结局”的作用。后者的证据通常更硬。

因素	证据强度	主要作用在哪个环节
童年期虐待、忽视、霸凌	中等，与精神病性体验相关	起病风险与症状严重度
社会孤立、缺乏支持	中等	起病风险、复发、结局
重大生活事件、长期压力	中等（复发证据更硬）	复发
移民、歧视、少数族群压力	中等	起病风险
家庭高情感表达	较强（复发）	复发
就业、稳定住所、社会资本	中等	结局与功能

关于童年创伤，需要说清楚：它与精神病性体验的关联在多项研究中重复出现，但“关联”不等于“必然”。大多数经历过创伤的人并不会得精神分裂症；而且创伤的影响往往是跨诊断的，与抑郁、焦虑、人格问题都相关。【研究】

关于社会孤立，因果方向同样纠缠：是社会孤立导致发病，还是发病导致社会孤立？很可能两者互为因果，形成越孤立越难走出、越难走出越孤立的循环。这也意味着干预可以从任何一端切入——恢复一点点社会连接，就可能打断循环。

三、高情感表达：一个有用的临床概念，不是给家属定罪

“高情感表达”（英文缩写 EE）是研究复发时常用的一个概念，指的是家属在言语和态度中表现出的三类特征：**批评**（频繁指出对方的错）、**敌意**（带有攻击性、否定对方人格）、**情感过度卷入**（过度介入、替对方做所有决定、把自己的情绪完全绑在对方身上）。

研究反复发现：高情感表达的家庭环境与更高的复发率相关；而结构化的家庭干预（心理教育、沟通训练、问题解决训练）能降低复发风险。这一点写进了多部指南。【指南】

但这里有几个必须同时讲的限定。

第一，情感表达是**互动模式**，不是家属的人格缺陷。一个人长期照顾患病的亲人、睡眠不足、经济压力大、被邻居指指点点，说话变得急躁、批评变多，是完全可以理解的反应。把它当成“你有问题”，既不准确也不公平。

第二，情感表达有**文化差异**。在一些文化里，家人高度参与、表达强烈，是关心的常态；研究工具原本是在西方家庭里发展出来的，直接套用可能失真。

第三，**降低情感表达不等于冷漠疏远**。有些家属听到这个概念后，变得不敢说话、不敢关心，这其实是误解。目标不是“少爱一点”，而是“换一种方式”。

容易变成高情感表达的说法	可以替换的说法
“你又胡思乱想了，跟你说多少遍是假的！”	“我知道你听到的声音对你来说很真实，我们一起看看怎么应对。”
“你要是不吃药，我就当没你这个儿子。”	“不吃药会让我们都很担心，能不能一起跟医生谈谈你的顾虑？”
“我这辈子都被你毁了。”	“我最近很累，需要找人搭把手，我们看看社区有没有支持。”
替他决定所有事，不允许他自己出门	一起制定一个双方都能接受的安全计划，逐步放回自主权

四、“致病家庭”：一段必须澄清的历史错误

上世纪四十到五十年代，精神分析在精神医学里占主导，一种说法流行起来：精神分裂症是早年母婴关系出了问题造成的。代表人物提出了“精神分裂症源性母亲”这个概念，媒体把它简化成“冰箱母亲”——母亲冷漠、控制、缺乏温情，孩子因此发病。

另一个相关的理论叫“双重束缚”：父母同时发出互相矛盾的指令，孩子无论怎么做都错，长期下来就“疯”了。

这些说法为什么当时能流行？因为那时没有脑影像、没有遗传学、没有可靠的药物，理论只能从访谈和临床印象里生长；而照护者主要是母亲，观察者看到的“母子互动问题”，自然被归因到母亲身上。这里面还夹着明显的性别偏见。

它们为什么是错的？主要有四点。第一，研究方法是回顾性的：先知道谁患病，再回头审视他的家庭，很容易把疾病造成的结果当成原因。第二，没有对照：没有人去比较“健康孩子的母亲”是不是也有同样的行为。第三，无法解释为什么同一家庭里有的孩子发病、有的不发病，也无法解释为什么不同文化、不同家庭结构下都有精神分裂症。第四，后来的双生子、寄养子、遗传与神经发育研究，都把解释重心移到了生物学与发育过程上。

这段历史造成的伤害是真实的。几代母亲在毫无根据的指责中生活，很多家庭因此隐瞒病情、拒绝就医、彼此怨恨。今天必须说清楚：**家庭不是精神分裂症的病因。** 家庭可以是压力源，也可以是保护因素，但它不在病因的位置上。

五、研究局限：为什么“新研究说”要打折听

理解研究怎么做，能帮你少被标题党带走。心理社会研究尤其容易出问题，常见的有以下几类。

横断面研究：只在一个时间点测量，无法判断先后。看到“孤独的人更容易得精神病”，你不知道是孤独导致发病，还是发病导致孤独。

样本小：几十人的研究很容易出现偶然结果。样本越小，结论越不稳定。

效应量小：统计上“显著”不等于“重要”。当效应量很小时，一点点混杂因素就能把结果推翻。

混杂与反向因果：贫困、歧视、物质使用、睡眠紊乱常常同时出现，很难拆开谁的作用更大。

回忆偏倚：让患者回忆童年，记忆本身会被当前的情绪和疾病状态影响。

发表偏倚与可重复性：阳性结果更容易被发表，阴性结果常被搁置。心理学与精神病学近年来经历了“可重复性危机”，一些曾被广泛引用的效应在更大样本中消失了。

样本文化偏差：大量研究来自欧美样本，结论能否套用到中国家庭，需要谨慎。

所以，看到一条研究结论时，可以先问四个问题：样本多大？有没有对照组？是相关还是因果？有没有被独立重复？如果四个问题都答不上来，就先别拿它指导自己的治疗。

六、风险因素不等于责任

这是这一页最想说的一句话。

风险因素是统计学上的概率推手，它不指向某个人的过错。一个人有童年创伤，不代表他“注定”发病；一位母亲脾气急，不代表她“造成”了孩子的病；一个家庭经济困难，也不代表他们“没做好”。

把这三件事分开看，会轻松很多：**因果**（是什么导致了疾病）、**责任**（谁该为疾病负责）、**可控性**（现在还能做什么）。科学能回答一部分因果，但几乎回答不了责任；而可控性，是每天都能动的。

家属可以做的，往往很具体：

- 学习疾病知识，知道哪些是症状、哪些是药物副作用；
- 保持规律的探视、陪伴与服药提醒，但不代替他做所有决定；
- 用“我担心……”代替“你又……”；
- 减少当面的指责与争吵，有分歧留到情绪平稳时再谈；
- 给照护者自己找支持：家属团体、心理咨询、亲友轮班；
- 与医生保持联系，复发早期就调整，而不是等到住院；
- 不隐瞒病情，也不把病情当成家庭的羞耻。

常见问题

“我脾气急，是不是我把孩子逼病的？” 不是。家庭氛围会影响复发与康复，但不在病因的位置上。脾气、沟通方式是可以调整的，调整的目的是让康复更顺，而不是赎罪。

“那家庭因素到底还要不要管？” 要管，但管的是“现在”。减少争吵、稳定作息、及早就医、家属自己寻求支持，这些都会影响复发风险和结局。

“我看了一篇说‘童年创伤导致精神分裂症’的文章，可信吗？” 童年创伤与精神病性体验有关联，但关联不是宿命，也不是单一病因。判断这类文章，先看样本量、有无对照、是相关还是因果、有没有被重复。

“家属是不是应该少见面、少说话，免得‘情感表达’太高？” 不是。目标是减少批评、敌意和过度控制，不是减少关心。稳定的陪伴本身就是保护因素。

> **出现以下情况，请当天联系医生或尽快复诊：**
>
> - 照护者自己出现持续失眠、情绪崩溃、无力照顾的感觉——去精神科或心理门诊求助
> - 家庭冲突反复升级、沟通完全无法进行——联系医生讨论家庭干预

> **出现以下情况，立即去急诊或拨打 120：**
>
> - 出现自杀念头、自伤行为，或已经做出计划——不要独处，联系信任的人陪同，必要时拨打 110
> - 出现命令性幻听让自己做危险的事、坚信被追杀而准备“自卫”——避免争辩与围堵，必要时报警
> - 家庭冲突升级到肢体冲突、打砸、威胁——先离开现场，保证人身安全，不要试图单独制服
> - 出现木僵、缄默、拒食、保持固定姿势不动（警惕紧张症）
> - 出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗（警惕恶性综合征）

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 4：就医与诊断

精神病性症状可能来自精神分裂症，也可能来自双相、抑郁、物质、药物或躯体疾病。诊断需要系统评估。

4.1 就诊渠道与首诊时机

“该去哪个科、现在去还是再看看、要不要叫救护车”——这是家属最常卡住的三件事。这一页把精神科门诊、急诊、社区精防、综合医院精神科的分工讲清楚，也列出哪些情况一秒都不能等。适合第一次面对精神病性症状、不确定该走哪条路的人。读完你能做一个初步判断，并知道首诊时家属具体该做什么、不该做什么。

一、先判断：现在能不能等

就诊渠道的选择，取决于三件事：**有没有危险、症状是不是新出现、能不能配合**。可以先用下面这张表做粗略判断，但拿不准时，按更急的一档处理。

判断	典型情况	该走哪条路
立即处理	自杀计划或行为、命令性幻听、伤人威胁、木僵拒食、高热肌肉僵硬、抽搐、意识不清、噎食	急诊，必要时 120 / 110
几天内就诊	首次出现幻觉妄想、疑心明显加重、失眠多日、拒学拒工、情绪跌到谷底	精神科门诊，尽量约最近的时间
可以预约	症状稳定，只是复诊、调药、副作用咨询、康复咨询	精神科门诊或社区随访

一个有用的经验：**第一次出现精神病性症状，不要等“再看看”。** 首次发作到开始治疗之间的时间越长，恢复往往越费力。等一两个月“自己好”，代价可能是一两年。

二、四条渠道各管什么

渠道	主要职责	适合什么情况	局限
精神专科医院门诊	诊断、开药、调药、复诊、安排住院	大多数需要长期治疗的患者	挂号紧，单次时间短
综合医院精神科 / 心理科	初筛、会诊、处理伴躯体疾病的情况	第一次就诊、合并躯体病、行动不便	部分医院只做轻症，重症需转专科
急诊（精神科急诊或综合医院急诊）	处理危机、评估风险、临时用药、决定是否留观	自杀、伤人、激越、木僵拒食、药物急症	只看当下风险，不做长期方案
社区精防与基层随访	建档、随访、服药管理、康复转介、危机联络	稳定期长期管理、行动不便、经济困难	诊疗能力有限，重症仍需专科

精神科和心理咨询不是一回事

精神科医生有诊断权和处方权；心理咨询师、心理治疗师不能下诊断、不能开药。已经在服药或症状明显的人，只做心理咨询通常不够。反过来，只看医生、完全不谈生活困难，也常常事倍功半，两者可以并行。

社区能帮什么

中国把严重精神障碍纳入社区管理，基层医疗卫生机构会为在册患者提供随访、服药指导和转介；部分地区对门诊服药有补助或免费政策，具体标准和申请方式以当地卫健委、社区精防医生公布的信息为准。社区医生往往是最了解“这家人实际情况”的人，别把他们只当“填表的”。【指南】

三、这些情况不要等门诊

立即去急诊；患者无法配合或拒绝时拨打 120；有伤人风险时拨打 110：

- 说“不想活了”，有具体计划，或已经在准备（囤药、写遗书、站在高处、告别）；
- 已经发生自伤、吞药、割伤、坠楼；
- 命令性幻听，让患者伤害自己或别人，或患者已开始照做；
- 明确的伤人威胁，持械、堵门、追打，家里人已经不敢待在一起；
- 木僵、缄默、拒食超过一两天，或明显脱水（尿少、口干、站起头晕）；
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快——警惕恶性综合征；
- 突然吞咽困难、进食呛咳、呼吸困难——警惕噎食；
- 抽搐、意识不清、剧烈头痛、频繁呕吐；
- 首次出现精神病性症状，同时有发热、头痛、颈硬、意识波动——要先排除脑炎、感染等躯体原因；
- 孕产妇出现严重失眠、言行紊乱、伤害自己或孩子的念头。

判断不了的时候，走急诊。**宁可白跑一趟，不要在家赌一夜。**

四、首诊家属怎么配合

首诊的目标不是“让医生马上确诊”，而是把信息给准、把安全兜住。家属可以做这几件事：

- **谁陪同**：一位最了解情况、情绪相对稳的家属。人太多会让患者紧张，也容易变成集体控诉。
- **提前写时间线**：什么时候开始变化、先出现什么、后来怎么发展、用过什么药、有没有诱因。一页纸就够。
- **先让患者自己说**：哪怕说得乱，也给他十分钟。打断和抢话会让患者觉得“又是你们说了算”。
- **补充而不否定**：用“我观察到的是……”开头，不用“他就是在装”。
- **关键信息必须说**：自杀念头、藏药、停药、饮酒、使用大麻或冰毒、既往住院、既往暴力。隐瞒这些，医生评估会失准。

- **不当着患者讨论“他是不是疯了”**：可以提前把敏感内容写在纸上交给医生，或者请医生单独问。
- **问清楚下一步**：诊断是确定的还是待观察、药怎么吃、多久复诊、出现什么要立刻来。

首诊前一天的准备清单

- ☐ 确认挂的是精神科（或精神心理科），不是只做心理咨询的机构。
- ☐ 把病历、药盒、化验单装进一个袋子。
- ☐ 写一页症状时间线，从最早的变化写起。
- ☐ 和患者说清楚“今天是去聊一聊、做个评估”，不要用“带你去看精神病”这类说法。
- ☐ 想好三个最想问医生的问题，写在纸上。
- ☐ 安排好往返交通和回家后谁陪着。
- ☐ 把家里的危险物品先收好，尤其是大量药物和刀具。

五、第一次去精神科会经历什么

大致流程是：挂号、候诊、医生问诊（现病史、既往史、用药、家族史、生活情况）、精神检查、必要的量表、开化验或心电图、给出初步判断和方案。

有几点心理准备：

- **不一定一次就确诊。** 医生可能需要观察一段时间，或先按“待定”处理，这是负责，不是敷衍。
- **不一定马上住院。** 多数首诊患者可以门诊治疗。是否住院取决于风险、自理能力、有没有人能照看。
- **可能会问得很细。** 包括性生活、月经、饮酒、有没有被打过——这些不是八卦，和诊断、用药安全直接相关。
- **住院实行自愿原则。** 中国精神卫生法规定精神障碍住院治疗实行自愿原则；在特定条件下可实施非自愿住院，有严格的法律条件和程序。相关细节见 11.2 住院指征与自愿非自愿。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即急诊或拨打 120：** 自杀计划或行为；命令性幻听并准备执行；伤人威胁；木僵拒食；高热加肌肉僵硬加意识改变；噎食、抽搐、意识不清。
>
> **尽快联系门诊：** 药物副作用让人无法忍受；漏服药后症状反弹；家属与患者冲突升级；计划怀孕或已经怀孕；出现新的躯体症状。

容易踩的坑

1. **怕“留下记录”不敢就诊。** 精神科就诊记录属于个人隐私，受法律保护；拖延的代价通常更大。
2. **只做心理咨询，不看病。** 有明确精神病性症状时，需要精神科评估。
3. **急诊当门诊用。** 急诊只处理当下风险，长期方案仍要回门诊。
4. **频繁换医生。** 每位医生都要从头了解，治疗容易反复归零。

5. **隐瞒停药和饮酒。** 直接影响诊断和用药安全。
6. **把患者排除在讨论之外。** 当着面讨论他，会强化“我没有发言权”的感觉。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 中国严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）及地方社区管理文件.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.2 初诊准备与病史采集

精神科门诊的时间常常只有十几分钟，说漏一句关键信息，可能就影响判断。这一页告诉你初诊该带什么、症状时间线怎么写、哪些内容必须如实说，以及家属补充信息的边界在哪里。适合第一次带家人就诊、或者自己要去看精神科但不知道从哪说起的人。读完你手上会有一张可以直接照着准备的清单。

一、带什么

把东西装进一个文件袋，出门前对着清单勾一遍：

- ☐ 身份证、医保卡 / 就诊卡。
- ☐ 既往病历、出院小结、门诊记录（尤其是精神科的）。
- ☐ 正在吃的所有药：药盒、药单或处方照片，包括中药、保健品、减肥药、避孕药。
- ☐ 最近的化验单、心电图、脑电图、影像报告。
- ☐ 过敏史清单（药名和反应）。
- ☐ 家族史信息：父母、兄弟姐妹、子女里有没有精神疾病、自杀、住院、长期服药的情况。
- ☐ 女性的月经史、末次月经、是否可能怀孕、是否在哺乳。
- ☐ 一页纸的症状时间线（下面有模板）。
- ☐ 想重点问医生的三个问题。

常被漏掉的东西	为什么重要
保健品和中药	可能影响肝肾功能、与精神科药物相互作用
减肥药、激素、感冒药	某些成分可能引起兴奋、失眠、幻觉
以前的出院小结	能看出既往用药反应、复发模式
饮酒和吸烟情况	影响药物代谢和剂量判断
睡眠和月经记录	常是复发和副作用的最早信号

二、写一条症状时间线

医生最想知道的是“变化的过程”，而不是“现在有多糟”。按时间顺序写，一条一行，不用修饰。

时间线模板

- 什么时候第一次觉得“不对劲”：
- 最早出现的三个变化（睡眠、情绪、说话、社交、成绩 / 工作）：
- 什么时候出现幻觉 / 妄想 / 行为异常：
- 中间有没有好转过，怎么好转的：
- 有没有诱因（熬夜、考试、失恋、失业、搬家、饮酒、使用大麻或冰毒、停药）：

- 用过哪些药，吃了多久，有没有效果，有没有副作用：
- 有没有住过院、有没有自伤自杀行为：
- 现在最影响生活的是什么：

一个写好的例子（示意，非真实个案）

> 去年九月开始睡不好，说班里有人针对他，不愿去上学。十一月起听到有人骂他，说是同学在楼道里装的喇叭。十二月开始不出门，一天只吃一顿。今年一月在门诊看过一次，开了药，吃了两周觉得“没事了”就停了。二月症状加重，说有人要杀他，晚上把门反锁，拿菜刀放在床边。没有饮酒，去年夏天和朋友抽过几次大麻。舅舅年轻时住过精神病院。

这样一段，医生能很快抓到：起病时间、症状演变、治疗史、停药、物质使用、家族史、当前风险。比“他最近很不正常，医生你看看”有用得多。

三、用药与物质使用要如实说

这不是“审问”，而是安全底线。

要说清楚的：

- 现在吃的每一种药，包括精神科药、降压药、降糖药、抗癫痫药、激素、中药、保健品。
- 吃了多久、有没有自己加过减过、有没有漏服。
- 吃了以后有没有效果，有没有手抖、坐不住、发胖、月经紊乱、溢乳、口干、便秘、心慌。
- 有没有对某种药过敏，出现过什么反应。
- 饮酒：多久一次、大概多少、最近有没有停酒。
- 吸烟：每天大概多少支。吸烟会影响部分药物的代谢，医生需要知道。
- 其他物质：大麻、冰毒、摇头丸、笑气、镇静催眠药，用过多长时间、最近一次是什么时候。

为什么必须说：

物质使用可以单独引起精神病性症状，也会加重病情、影响药效、增加复发和暴力风险。隐瞒会让医生把“物质所致”当成“精神分裂症”，或者反过来。医生关心的是怎么治，不是评判你。

如果实在不方便当面说，可以写在纸上递给医生，或者让家属单独说。

四、家族史、孕产史、发育史、躯体史

家族史：直系亲属里有没有精神分裂症、双相障碍、抑郁症、自杀、住院、长期服精神科药物。有也不代表一定会得，只是风险因素之一。

孕产史：对女性很重要。是否怀孕、是否计划怀孕、是否哺乳，直接关系到用药选择。不要因为怕医生“劝停药”就不说，医生需要在“停药复发”和“药物风险”之间做权衡，信息不全就没法权衡。

发育史（儿童青少年尤其重要）：什么时候会说话走路、学习成绩变化、有没有被霸凌、有没有长时间把自己关在房间里、有没有自伤。

躯体史：甲状腺疾病、癫痫、肝病、肾病、心脏病、糖尿病、高血压、头部外伤、感染（包括HIV、梅毒）、自身免疫疾病。这些都可能是精神症状的原因，也会影响用药。

五、家属补充的边界

家属的信息非常关键，尤其是患者自己不觉得有问题的时候。但补充有边界，越界会让患者从此不再开口。

适合说	不适合说
具体的行为和原话：“他这周有三个晚上没睡，说门外有人”	评价和标签：“他就是懒、就是装的”
时间、频率、变化	翻旧账：“他从小就不听话”
用药、饮酒、就医经过	替患者回答所有问题
安全相关信息：自杀念头、藏药、持刀	当着患者面讨论“要不要送走他”
家庭实际困难：没人照看、经济压力	把家庭矛盾当病因控诉

几条实操建议：

- **先说事实，再说担心。** “我怕他晚上出事”比“你们得管管他”更容易被听进去。
- **当着患者的面说。** 除非涉及安全，尽量不搞“背后告状”。可以事先和患者对好：“哪些我可以讲？”
- **留出患者自己说的空间。** 医生问患者时，家属先别抢答，等患者说完再补充。
- **敏感内容写下来。** 自杀念头、藏药、被家暴、性行为，写在纸上比当面说更容易。
- **不隐瞒危险信息。** 这一点没有商量余地：隐瞒可能直接导致评估失误。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 出现自杀计划、自伤行为，或已经吞药、割伤；
- 命令性幻听，或已经按命令行动；
- 明确伤人威胁，或家里已经发生冲突；
- 木僵、缄默、拒食超过一两天；
- 高热、肌肉僵硬、意识改变；
- 首次出现精神症状伴发热、头痛、抽搐、意识波动。

就诊前需要先打电话确认的情况：

- 患者极度抗拒、有暴力风险——先联系医院急诊或社区精防，不要独自强行带人；
- 正在发热或患急性躯体病——先看急诊或内科，精神科评估可以稍后；

> • 涉及未成年人、孕产妇——提前问清楚医院是否有相应门诊。

容易踩的坑

1. **替患者编病史。** 为了“让他住院”夸大，或为了“别留记录”缩小，都会误导治疗。
2. **只说最近一周。** 病程是诊断的核心，几个月甚至几年的变化都要提。
3. **隐瞒停药。** 医生会按“一直在吃药”来判断疗效，结论可能完全相反。
4. **把保健品当“不算药”。** 相互作用是真实存在的。
5. **家属全程代答。** 医生需要观察患者本人的语言和思维。
6. **不带药盒。** 说不清药名，等于让医生猜。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.3 诊断流程与鉴别诊断

“医生凭什么说我是精神分裂症？”这个问题值得认真回答。精神分裂症没有一滴血能验出来，诊断靠的是一套结构化的推理：症状是什么、持续多久、功能掉了多少、有没有别的解释。这一页讲清诊断的四个支点、需要排除的常见情况，以及为什么第一次诊断有时会改。读完你能理解医生的思路，也能判断自己该追问什么。

一、诊断不是一次谈话就定

在门诊，医生做的第一件事往往不是“下诊断”，而是“收集证据”。同一种幻觉，可能来自精神分裂症，也可能来自双相障碍、严重抑郁、大麻、甲状腺功能亢进、脑炎或某些药物。这些情况的治疗完全不同，把可逆的原因漏掉，代价很大。

所以规范的流程通常是：详细病史、精神检查、必要的量表、化验和影像、初步诊断、随访修正。首诊给出的常常是“考虑某病”或“待观察”，这不是医生不负责，而是诊断本身需要时间。

二、诊断的四个支点

支点	具体要求（简化表述）	医生怎么获取
症状	妄想、幻觉、思维紊乱、明显紊乱或紧张症行为、阴性症状中至少两项，且至少一项是妄想、幻觉或思维紊乱	精神检查、家属补充、量表
病程	症状持续一段时间；不同诊断体系要求不同，通常需要至少一个月的活跃期症状，并结合更长的总体病程	病史时间线、既往记录
功能损害	工作、学习、人际、自理能力明显下降	患者叙述、家属观察、功能量表
排除	不能用物质、药物、躯体疾病、心境障碍更好解释	化验、影像、既往史、随访

需要说明：国际上两套主要分类体系对“病程多久”“功能损害怎么算”的具体表述和阈值略有差异。ICD-11 通常要求活跃期症状至少一个月，DSM-5-TR 要求总病程至少六个月；两者都重视功能损害，但条款细节不完全相同。中国临床实践中两者都会参考，具体标准以医生使用的版本为准。【指南】

单一症状不足以诊断

“听到声音”本身不是精神分裂症。诊断看的是症状组合、持续时间、功能变化和排除结果。这也是为什么不能靠一篇科普或一份自评量表给自己下结论。

三、需要鉴别的几类情况

需要排除	常见线索	医生通常会怎么做
双相障碍伴精神病性症状	有过明显躁狂或轻躁狂：精力旺盛、话多、睡得少也不累、花钱大手大脚；症状呈发作性	追问既往发作史、家族史；抗抑郁药诱发躁狂要特别追问
抑郁障碍伴精神病性症状	严重抑郁在前或与妄想同时出现，妄想内容与抑郁主题一致（罪恶、贫穷、躯体腐烂）	评估心境症状的时间关系、严重度
物质或药物所致	大麻、冰毒、致幻剂、酒精戒断；激素、某些感冒药、免疫抑制剂	尿毒物筛查、详细用药史、停药观察
器质性疾病	癫痫、脑肿瘤、卒中、甲状腺疾病、维生素 B12 缺乏、梅毒、HIV、自身免疫性脑炎	化验、脑影像、脑电图，必要时腰穿
分裂情感性障碍	心境发作与精神病性症状长期并存，且心境症状占病程的大部分	纵向梳理时间线，常需随访
妄想障碍	妄想突出但功能相对保留，幻觉不明显，行为不至于明显紊乱	评估妄想以外的症状
短暂精神病性障碍	起病急、持续时间短、常伴明显应激	随访观察是否缓解
孤独症谱系、强迫症、创伤后应激	社交沟通从小就有困难；有反复的强迫观念；有创伤史和闪回	发育史、创伤史、症状性质区分

关于自身免疫性脑炎

这一类需要单独提醒。抗 NMDAR 脑炎等自身免疫性脑炎可以以精神症状起病：年轻患者突然出现幻觉、易激惹、言语紊乱，随后出现癫痫、记忆下降、意识波动、口面部不自主运动、自主神经不稳。它容易被当成“首发精神分裂症”，但也有相当一部分患者最初确实只看精神科。【研究】【临床经验】

所以出现以下组合时，要尽快到急诊或神经科评估，而不是按普通精神科门诊慢慢调药：急性起病（几天到几周）、精神症状加癫痫、记忆明显下降、意识时清时浊、动作怪异、发热、通气不足。是否需要腰穿、查抗体，由神经科医生判断，不是所有首次发作都要做。

四、会做哪些检查

不是每个患者都要全套做，医生会按情况选：

- **化验**：血常规、肝肾功能、电解质、血糖、血脂、甲状腺功能、维生素 B12、感染筛查（如梅毒、HIV，按风险）。
- **尿毒物筛查**：怀疑物质使用时。
- **心电图**：用药前基线，尤其是有心脏病史或需要特定药物时。
- **脑影像**：首次发作、非典型表现、有神经系统体征、治疗反应差、老年首发的患者，更需要。
- **脑电图**：怀疑癫痫、意识波动时。

- **腰穿**：怀疑中枢神经系统感染或自身免疫性脑炎时，由专科医生决定。
- **量表**：PANSS、BPRS、PSP 等，用于评估严重度和追踪变化。

看诊前可以自己先核对

- ☐ 症状是什么时候开始的，最早出现的是哪一项。
- ☐ 有没有一段时间完全正常，最长多久。
- ☐ 有没有发热、头痛、抽搐、意识不清、走路不稳这些“不像精神科”的表现。
- ☐ 有没有饮酒、大麻、冰毒，或最近换过其他科的药。
- ☐ 家族里有没有人患精神病、住过院、自杀过。
- ☐ 有没有既往的出院小结，上面写的是什么诊断。
- ☐ 现在最想解决的一个问题是什么。

检查正常，并不能“证明”就是精神分裂症；检查异常，也不一定排除它。两者要合起来看。

五、诊断会变，随访比一次结论更重要

以下几种情况，诊断被修改是常见的：

- 随访中出现明确的躁狂发作，诊断可能改为双相障碍；
- 停药后症状持续多年不再出现，可能考虑其他诊断；
- 发现物质使用是主因；
- 查出躯体疾病；
- 儿童青少年期诊断本身就不稳定，需要反复评估。

诊断改变不代表之前“被骗了”，而是信息变多了。对患者来说，重要的是治疗有没有效、功能有没有恢复，而不是标签本身。复诊时可以主动问：“现在的诊断依据是什么？有没有需要重新评估的地方？”

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 首次出现精神病性症状，同时有发热、剧烈头痛、颈项僵硬、抽搐、意识时清时浊；
- 精神症状加癫痫发作、记忆骤降、口面部不自主运动——警惕自身免疫性脑炎等器质性原因；
- 自杀计划或自伤行为；
- 命令性幻听并准备执行；
- 木僵、缄默、拒食；高热加肌肉僵硬加意识改变。

尽快联系门诊：

- 诊断不明确，想请第二意见（带上全部资料，不要重新开始）；
- 服药后出现新的神经系统症状；

> - 症状在几周内明显变化，或出现新的发作形式；
> - 对诊断有疑问，但不确定该问什么。

容易踩的坑

1. **把“检查都正常”当成“没病”。** 精神分裂症本来就没有特异性化验指标。
2. **把“一次诊断”当成终审判决。** 诊断会随随访修正。
3. **只做心理测评就下结论。** 量表是辅助，不是诊断。
4. **隐瞒物质使用。** 这会直接改变诊断方向。
5. **频繁换医院重复检查。** 资料不连贯，反而更难判断。
6. **拒绝随访。** 很多鉴别诊断只有在时间里才能看清。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.4 共病筛查与躯体检查

精神分裂症很少“单独出现”。同一个人身上常有抑郁、焦虑、物质使用，也常有体重、血糖、血脂、甲状腺、牙齿的问题。这些共病不但影响生活质量，还直接影响用药安全。这一页讲该筛查什么、抗精神病药治疗前要做哪些基线检查、复查看什么。适合刚确诊、准备开始服药的人，也适合已经吃药多年却从没查过血脂血糖的人。

一、为什么共病要专门筛查

三个原因。

第一，共病很常见，但常被主病掩盖。 一个人话少、不动，可能是阴性症状，也可能是抑郁；心慌手抖，可能是焦虑，也可能是药物副作用或甲亢。不主动筛查，很容易一直归因于“病本身”。

第二，共病影响预后。 抑郁增加自杀风险，物质使用增加复发和暴力风险，睡眠呼吸暂停加重认知损害，代谢问题则慢慢侵蚀心血管健康。

第三，共病影响用药安全。 肝功能、肾功能、心电图、电解质，都会改变医生对药物的选择。抗精神病药本身也可能带来体重、血糖、血脂、催乳素和心脏传导方面的影响，所以基线数据非常关键——没有“用药前”的数字，就判断不了“用药后”的变化。

研究一致显示，精神分裂症患者的预期寿命比一般人群短，心血管疾病是主要原因之一，而这一部分恰恰是可以筛查、可以干预的。【指南】【研究】

二、精神科共病

共病	常见线索	处理方向
抑郁	持续低落、自责、无望、早醒、食欲下降、自杀观念	评估自杀风险；区分阴性症状与药物镇静；由医生调整方案
焦虑	持续紧张、心慌、出汗、回避、反复担心	排除甲亢、咖啡因、静坐不能；心理干预与药物由医生决定
创伤后应激	闪回、噩梦、回避、过度警觉、创伤史	建立安全感；创伤聚焦治疗需在稳定期进行
强迫症	反复出现闯入性的念头、反复检查或洗涤，自己知道不合理	与妄想区分：强迫观念通常被体验为“自己的、不对的”
物质使用	大麻、冰毒、酒精、镇静药；戒断时加重症状	整合治疗；不指责；注意戒断风险
人格问题 / 孤独症谱系	长期的人际模式异常、从小社交沟通困难	需要发育史；影响治疗关系与沟通方式
睡眠障碍	入睡难、早醒、昼夜颠倒、打鼾憋气	睡眠卫生；筛查睡眠呼吸暂停；避免长期自行用安眠药

物质使用为什么必须单独问

大麻和兴奋剂可以诱发精神病性症状，也会加重原有病情、增加复发和冲动行为。反过来，很多患者用物质来缓解焦虑、失眠或药物副作用。这件事需要在不评判的气氛里问，问法可以是：“有没有用什么让自己好受一点？”

突然停酒或停镇静药可能出现戒断，严重时会抽搐、意识混乱，不能在家硬扛，需要医疗处理。

三、躯体共病

- **代谢**：体重、腰围、BMI、血糖、糖化血红蛋白、血脂、血压。抗精神病药相关的体重增加和代谢异常很常见。
- **心血管**：心电图（QT 间期）、心率、血压、有无晕厥史。
- **内分泌**：甲状腺功能、催乳素（月经紊乱、溢乳、性欲下降时可查）。
- **感染**：按风险筛查乙肝、丙肝、梅毒、HIV；是否加做结核筛查，由医生按用药和流行病学情况决定。
- **神经系统**：癫痫史、头部外伤、锥体外系反应的基线（手抖、僵硬、动作慢）。
- **口腔**：龋齿、牙周病、口干导致的龋齿风险；口腔问题会影响进食和自信。
- **眼科**：部分药物可能影响视力调节；青光眼患者用药需特别说明。
- **消化**：便秘很常见，严重时可致肠梗阻，需要主动报告。
- **睡眠**：打鼾、憋气、白天嗜睡，要筛查睡眠呼吸暂停。

四、开始抗精神病药前的基线检查

- ☐ 身高、体重、BMI、腰围。
- ☐ 血压、心率。
- ☐ 空腹血糖或糖化血红蛋白。
- ☐ 血脂四项。
- ☐ 肝功能、肾功能、电解质。
- ☐ 心电图（尤其有心脏病史、家族猝死史、正在用其他影响心电图的药）。
- ☐ 血常规（如计划使用氯氮平，这是必须项）。
- ☐ 催乳素（有月经紊乱、溢乳、性功能问题时）。
- ☐ 育龄女性的妊娠试验与避孕计划。
- ☐ 既往用药、过敏史、物质使用。
- ☐ 神经系统检查与锥体外系反应基线。
- ☐ 家族史：糖尿病、高血脂、心脏病、猝死。

氯氮平要单独强调： 血常规监测是处方的一部分，不是“额外要求”。用药前要查，之后按医生安排定期复查。出现发热、咽痛、口腔溃疡、乏力，要立即查血常规，不能等下次复诊。感觉“还好”不是跳过监测的理由。

五、治疗中复查什么

项目	为什么复查	大致节奏（以医生安排为准）
体重、腰围、血压	早期变化最快，便于及时干预	用药初期较密，稳定后定期
血糖、血脂	代谢异常常无症状	用药后数月复查，之后定期
心电图	QT 延长、心律失常风险	有心脏病史或联合用药时更需
催乳素	月经、性功能、骨密度	有症状时查，不必人人常规
肝肾功能	药物代谢、合并用药	按药物和躯体情况
锥体外系反应	手抖、僵硬、坐不住、迟发性运动障碍	每次复诊都看
血常规（氯氮平）	粒细胞缺乏可致命	严格按处方要求，不能自行拉长
口腔与便秘	影响进食与安全	每次复诊问一句

具体频率由医生根据药物、年龄、体重变化、合并疾病和当地随访安排决定，不要拿别人的复查节奏套自己。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 服用氯氮平后出现发热、咽痛、口腔溃疡、极度乏力（可能粒细胞缺乏）；
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快（可能恶性综合征）；
- 剧烈腹痛、腹胀、停止排便排气（可能肠梗阻）；
- 胸痛、心悸伴晕厥、呼吸困难；
- 抽搐、意识不清；
- 吞咽困难、进食呛咳。

尽快联系门诊：

- 体重在短期内明显增加，或腰围变大；
- 月经紊乱、溢乳、性功能下降；
- 手抖、走路变慢、坐立不安、舌头或嘴唇不自主动作；
- 便秘超过三天、口干严重；
- 打鼾伴白天嗜睡。

容易踩的坑

1. **只查精神科，不查身体。** 代谢和心血管问题往往没有感觉。
2. **觉得“查过就一劳永逸”。** 体重和血糖会变，复查才有意义。

3. **因为怕加药而隐瞒副作用。** 副作用是调整方案的依据，不是“不听话”的证据。
4. **用保健品代替复查。** 没有任何保健品能替代血糖血脂和血常规。
5. **氯氮平“感觉好”就跳过血常规。** 粒细胞缺乏早期可以毫无症状。
6. **便秘硬扛。** 抗精神病药相关的便秘可以很严重。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 5：药物治疗

抗精神病药是治疗的核心，但不是“吃了就完事”。选药、剂量、疗程、副作用监测、氯氮平和长效针剂，都需要具体知识。

5.1 抗精神病药总览：一代与二代

几乎每个刚拿到处方的人都会听到一句话：“这是二代药，副作用小。”这句话对了一半，也误导了一半。抗精神病药确实分成“一代”和“二代”，但这个分法比广告词复杂得多：它既不代表谁更有效，也不代表二代就安全。这一页讲清楚四件事：两类药是怎么分的、疗效差在哪里、副作用谱为什么是选药的主要依据，以及你可以拿哪些问题去和医生讨论。本页不写剂量，具体用法以处方为准。

一、“一代”和“二代”是怎么分的

抗精神病药的核心作用，是阻断大脑里的多巴胺 D2 受体（可以理解为神经细胞表面接收多巴胺信号的接口）。上世纪五十年代，氯丙嗪被发现能让精神病患者的幻觉和躁动减轻，此后一批作用机制相似的药物陆续上市，这类药后来被称为“一代”或“典型”抗精神病药，代表有氯丙嗪、氟哌啶醇、奋乃静、舒必利、五氟利多等。

“二代”或“非典型”抗精神病药从八十年代末开始出现，起点是氯氮平。它们的特点不只是阻断 D2，还同时作用于 5-HT2A 等其他受体，因此锥体外系反应（手抖、僵硬、动作变慢这类药物引起的运动障碍，英文缩写 EPS）相对少一些。常见的二代药包括氯氮平、利培酮、奥氮平、喹硫平、齐拉西酮、阿立哌唑、氨磺必利、帕利哌酮、鲁拉西酮、布南色林等。

这个分法有两个必须知道的局限。第一，它是按**上市年代和受体作用谱**分的，不是按疗效或安全性分的，所以“二代”内部差异极大：氯氮平和阿立哌唑几乎是两个世界，却被放在同一个筐里。第二，有些药的归属本身有争议，比如氨磺必利主要阻断 D2 和 D3，却因为 EPS 较少常被归入二代；舒必利是苯甲酰胺类，通常归在一代。【临床经验】

换句话说，“一代/二代”是一个方便的分类标签，不是一张质量等级表。

二、疗效：总体差距不大，氯氮平是明确的例外

这是最容易被营销话术扭曲的部分。

对于**阳性症状**（幻觉、妄想、思维散乱、激越），一代和二代在群体层面的疗效总体相当。这不是某一个小研究的结论，而是几项大型、贴近真实临床的试验反复得到的结果：在真实世界里，不同药物之间的症状改善差别不大，真正造成差距的是副作用导致的停药。【研究】

对于**阴性症状**（情感平淡、意志缺乏、社交退缩）和**认知损害**，两类药的直接改善都比较有限。有些研究显示二代药略好，但很难排除“阳性症状减轻后，阴性表现跟着好转”以及“EPS 少，人看起来更自然”的影响。这方面的证据并不牢固，不宜过度期待。【研究】

氯氮平是唯一的例外。对于足量足疗程、换过两种以上抗精神病药仍无效的难治性患者，氯氮平在疗效上有其他药物没有的优势，这一点在多个指南里都是明确推荐。代价是它需要严格的血液监测，并且有粒细胞缺乏、心肌炎、癫痫、严重便秘等风险（详见 5.8 氯氮平：难治性精神分裂症与监测）。【指南】

还有一点必须说清：**没有任何一种药被证明“最适合所有人”**。同一种药，有人效果很好、几乎没有副作用，有人却完全不耐受。这种个体差异目前无法靠化验或基因检测提前预测，只能通过试用来确定。

三、副作用谱：这才是选药时最主要的现实依据

如果疗效总体接近，那么选择的重点自然落到副作用上。下表只做类别层面的对比，不构成推荐；具体到某个人，还要看年龄、体重、代谢指标、心脏情况、是否怀孕、是否合并用药。

类别与代表药	常见副作用倾向	特别提醒
一代：氟哌啶醇、氯丙嗪、奋乃静、舒必利、五氟利多	EPS 明显，催乳素升高，氯丙嗪镇静与体位性低血压较明显	长期使用迟发性运动障碍风险较高，需定期观察口面部动作
二代：氯氮平	体重增加、血糖血脂升高、流涎、镇静、便秘；粒细胞缺乏、心肌炎、癫痫	必须定期查血常规；发热、咽痛、口腔溃疡要立即就诊
二代：奥氮平	体重增加与代谢影响在二代中较突出，镇静明显	需要同步管理体重、血糖、血脂
二代：喹硫平	镇静、体位性低血压、代谢影响	老年人、体位性低血压者需注意跌倒
二代：利培酮、帕利哌酮	催乳素升高较明显，EPS 与剂量相关	月经紊乱、溢乳、性功能下降要主动报告
二代：阿立哌唑	静坐不能、失眠、恶心较常见，代谢影响相对小	静坐不能常被误当成“焦虑加重”
二代：齐拉西酮	QT 间期延长、嗜睡；需随餐服用以保证吸收	有心律失常史、合并延长 QT 药物者需评估
二代：氨磺必利	催乳素升高、QT 延长，较高剂量时 EPS	肾功能不全者需调整，须由医生判断

这张表最容易误读的地方，是把“常见”读成“一定会发生”。副作用是概率，不是命运；而且大部分副作用是可以监测、可以处理、可以通过调整方案减轻的。真正危险的不是副作用本身，而是出现了却不说。

两类药还有一个共同的长期风险：**迟发性运动障碍**（TD），表现为口唇、舌头、下颌或四肢的不自主动作，长期用药者都可能出现，一代药风险更高。它早期可能只是“舌头在嘴里动”“嘴角抽一下”，容易被忽略。发现这类动作要尽快告诉医生，不要等到明显影响进食和说话。【指南】

四、剂型：口服、口崩片与长效针剂

同一成分常有不同剂型。普通片剂最常用；口崩片放在舌上很快溶解，适合吞咽困难或拒药的情况；口服液适合需要灵活调整或吞咽困难的人；长效针剂（LAI）把药物做成肌肉注射的缓释制剂，打一次可以维持较长时间，适合依从性差、反复因停药复发的人。剂型的选择不影响药物本身的性质，但会影响血药浓度的平稳程度和生活的便利性。这部分在 5.9 长效针剂、换药、联合与停药 里有更详细的讨论。【指南】

五、和医生讨论选药时，可以问这些

- 以我目前的症状（阳性为主还是阴性为主）、年龄、体重和代谢指标，您为什么选这一类？
- 这个药最常见的副作用是什么？哪些需要我立刻联系您，哪些可以观察？
- 我需要定期查哪些项目？血糖、血脂、催乳素、心电图、体重腰围，分别多久查一次？
- 如果几周后效果不理想，下一步的计划是什么？是加量、换药，还是联合？
- 有没有适合我的长效针剂？我这种情况用针剂和口服，利弊分别是什么？
- 我现在吃的其他药（包括中药、保健品、避孕药、胃药）会不会和它相互作用？
- 如果我打算怀孕或已经怀孕，现在的方案需要调整吗？
- 出现漏服时该怎么处理？——请医生给出具体说明，不要自己补双倍。

六、常见误解与容易踩的坑

“二代一定比一代好。” 不对。二代内部差异很大，氯氮平、奥氮平的代谢风险不低；一代药在急性激越、费用敏感的场景仍有位置。选择取决于人，不取决于标签。

“新药一定更好。” 新药的优势常常是副作用谱不同，而不是疗效更强。上市时间短也意味着长期数据少。

“副作用小说明药效弱。” 没有这个规律。疗效和副作用是两个相对独立的维度。

“症状好了就可以停。” 这是复发最常见的原因。突然停药可能导致失眠、激越、幻觉加重，少数人出现撤药样症状；更重要的是，停药后复发风险显著上升。减量或停药必须由医生计划。【指南】

“吃这个药会成瘾。” 抗精神病药不属于成瘾性物质，不会产生“越吃越想吃”的依赖，但**不能突然停**，因为身体已经适应了它。

“进口的比国产的好。” 通过一致性评价的仿制药在临床上可以替代原研药，具体以医生和药师的意见为准，不要自行换厂牌。

> **出现以下情况，请当天联系医生或尽快复诊：**
>
> - 服用氯氮平后出现发热、咽痛、口腔溃疡、乏力——立即查血常规，警惕粒细胞缺乏
> - 脖子突然歪向一侧、眼睛上翻、舌头不受控、吞咽困难（警惕急性肌张力障碍）

- 坐立不安到无法静坐、来回走动停不下来（警惕静坐不能），不要自行加药
- 口唇、舌头、下颌或四肢的不自主动作（警惕迟发性运动障碍），不要自行停药
- 心悸、晕厥、抽搐，或心电图提示 QT 延长
- 自行停药后出现严重失眠、激越、幻觉加重——不要自行加回原量

出现以下情况，立即去急诊或拨打 120：

- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快、尿少（警惕恶性综合征）
- 自杀念头、自伤行为，或命令性幻听让自己做危险的事——不要独处，必要时拨打 110

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.2 首发、复发与难治性：如何选药

同样是精神分裂症，第一次发病、第二次复发、吃药两年仍不见好，处理思路完全不同。很多患者和家属的困惑也集中在这里：首发是不是要用“最好的药”？复发了一次是不是说明之前的药白吃了？换了两种药都没效，是不是就没希望了？这一页按这三个情境分别讲选药逻辑，并说明“难治性”这个标签到底该在什么时候用。本页不写具体剂量，也不推荐某一种药。

一、首发：先站稳，再谈走远

第一次发病的治疗，是整个病程里最值得认真对待的一次机会。原因很实际：初治阶段对药物的反应通常较好，而这一阶段形成的用药习惯、对治疗的态度、家庭的支持方式，会影响后面很多年。

首发选药通常遵循几条原则。【指南】

单一用药。 先用一种药，而不是一上来就联合。联合用药会让副作用难以归因，也会让后续调整失去参照。

从低剂量开始，缓慢调整。 初治患者对锥体外系反应、镇静、体位性低血压往往更敏感，尤其是年轻、体重偏低的人。起效需要时间，追求“几天内彻底好转”往往换来的是副作用和抵触。

把耐受性放在很靠前的位置。 首发患者大多要长期用药，如果第一段治疗体验是“手抖、发胖、整天昏沉”，后面很难建立信任。医生在疗效相近的药之间，通常会优先考虑患者更能长期接受的方案。这不是“保守”，而是现实。

同步安排心理社会干预。 药物控制症状，心理教育、家庭干预、复原计划帮助人回到生活。首发阶段做这些，比复发多年后再补要容易得多。【指南】

不要过早停药。 症状消失不等于病程结束。首发后过早减停，复发风险明显上升；维持治疗要持续多久，取决于症状缓解程度、既往复发次数、家庭支持与应激水平，由医生判断。

关于长效针剂，首发患者的使用近年有增加趋势，部分研究显示对预防早期复发有帮助，但指南的推荐仍是“有条件考虑”，不是人人适用。【研究】

首发选药的考虑因素	为什么重要
症状以阳性为主，还是阴性、认知问题突出	决定对哪一类药物特点更看重
年龄、体重、代谢指标、心电图	决定代谢与心脏风险的可接受范围
是否能坚持每天服药、有无监督者	影响是否考虑长效针剂
既往用药史与家族用药反应	只能作为参考，不能照搬
学习、工作、哺乳、怀孕计划	影响镇静、催乳素、致畸性等方面的权衡
经济条件与医保	长期治疗必须考虑可持续性

二、复发：先找原因，再谈换药

复发在精神分裂症里并不少见，它不是“意志薄弱”的证据，也不是“这个人没救了”的判决。但复发之后最忌讳的做法，是立刻换药——因为复发的原因常常不在药本身。

复发前最常见的原因有这几类：**自行减量或停药**（包括“感觉好了就停”“怕副作用就停”）、**漏服**、**物质使用**（大麻、酒精、兴奋剂）、**重大生活事件**（丧亲、失业、搬迁、感情破裂）、**睡眠长期紊乱**、**剂量不足或吸收问题**、**合并用药影响了血药浓度**（比如某些抗癫痫药、抗结核药、吸烟量的剧烈变化）、以及**诊断需要重新评估**。

所以合理的顺序是：先核对依从性，再复核诊断，再评估物质使用与躯体状况，然后才是调整方案。如果原来的方案曾经有效、这次是因为停药而复发，恢复原方案往往比换一种新药更合理。

有一个现象值得家属知道：**复发的次数越多，恢复到病前水平的难度往往越大**。这不是吓唬人，而是提醒——把功夫花在预防上，比反复“救火”划算。

三、难治性：一个必须严格定义的标签

“难治性”不是“吃了药还没好”的日常抱怨，它有相对严格的定义。通常要同时满足：**经过两种不同抗精神病药的足量、足疗程治疗，依从性得到确认，症状仍然没有达到可接受的缓解**；同时要有明确的症状严重度与功能损害依据。不同指南在细节上略有差别，但核心是这三条：两种药、足量足疗程、依从。【指南】

在贴这个标签之前，必须先排除“假性难治”。临床上相当一部分“怎么治都不好”的病例，原因是可以纠正的。

排查方向	具体要看什么
诊断是否正确	双相障碍、分裂情感性障碍、抑郁伴精神病性症状、创伤后应激、孤独症谱系、人格障碍、物质所致、器质性疾病
依从性	是否真的每天吃、有没有藏药、家属是否确认、血药浓度是否支持
药物代谢	吸烟量变化、合并用药、肝功能、胃肠道吸收、是否呕吐或腹泻
剂量与疗程	是否真的达到治疗剂量、是否用够时间、是否过早判定无效
物质使用	大麻、酒精、兴奋剂、镇静催眠药
心理社会因素	持续的家庭冲突、居住不稳定、被霸凌、经济崩溃
共病	抑郁、焦虑、强迫、睡眠障碍、甲状腺问题、慢性疼痛

这张表说明一件事：**在考虑“难治”之前，先把可以纠正的问题纠正掉。** 很多患者在这个阶段被重新评估后，发现只是剂量不足、依从性不佳，或者诊断需要修正。

四、氯氮平：难治性治疗里位置最特殊的一种药

如果确实排除了假性难治，接下来最关键的决策通常是一个：**是否使用氯氮平**。

氯氮平是唯一在难治性精神分裂症中被反复证实有优势的抗精神病药，多个指南把它列为这一情境下的推荐选项。它对部分“其他药都没反应”的患者能带来明显改善，包括阳性症状、攻击行为，以及部分患者的整体功能。【指南】

但氯氮平不是“更强的药”，它是一种需要认真管理的药。使用它意味着：

- **血常规监测是处方的一部分**，不是可选项。监测频率由医生根据阶段安排；不能因为“感觉还好”就跳过。
- **发热、咽痛、口腔溃疡、乏力要立即查血常规**，警惕粒细胞缺乏。这是可能危及生命的，不能等下次复诊。
- **早期要警惕心肌炎**，出现胸闷、心悸、气促、发热要尽快就医。
- **癫痫、严重便秘、流涎、镇静、体重与代谢影响**都需要管理。便秘看似小事，严重时可导致肠梗阻。
- **不能自行停药**。突然停用氯氮平可能引起反跳性精神病性症状，还可能出现撤药样不适；任何减量都要医生计划。

为什么这么好的药用得不多？原因很现实：监测麻烦、副作用让人害怕、医生经验不足、患者听说“要抽血”就拒绝。这些顾虑都合理，但它们应该被讨论，而不是让一个可能有效的选项被默默排除。如果医生建议氯氮平，值得认真听完理由；如果医生没提，而你已经换过两种药仍无效，也可以主动问一句：“我这种情况，是否符合氯氮平的适应条件？”【临床经验】

如果氯氮平无效或不耐受，还有别的路：联合另一种药物、合并电休克治疗（对紧张症、严重拒食、高自杀风险尤其有价值）、以及更密集的康复支持。这些都需要在专科医生评估后进行。

五、去门诊前，把这几件事准备好

- 目前吃的药名、剂量、吃了多久、有没有漏服（带药盒或拍照）；
- 最近一次复发前，生活里发生了什么变化；
- 有没有使用大麻、酒精、兴奋剂、镇静药；
- 最近有没有换过其他科的药（抗癫痫药、抗结核药、抗生素、避孕药）；
- 吸烟量有没有明显变化；
- 睡眠、体重、月经、性功能、便秘的情况；
- 之前试过哪些药、各自吃了多久、为什么停；
- 家属观察到的变化，按时间顺序写下来。

六、常见问题

“首发是不是要用最强的新药？” 不是。首发的重点是有效、可耐受、能长期坚持。新不等于更适合。

“复发一次，是不是以后都治不好了？” 不是。多数复发是可以治疗的，但反复复发会让恢复变难。重点是把复发次数降下来。

“两种药都没效，是不是没救了？” 先确认是不是“足量足疗程”和“真的吃了”。排除假性难治后，氯氮平等选项仍然存在。

“氯氮平是不是最后的药，用了就没退路？” 不是“最后”，而是“证据最硬的一个选项”。用了之后仍可调整，只是需要更规范的监测。

> **出现以下情况，请当天联系医生或尽快复诊：**
>
> - 服用氯氮平后出现发热、咽痛、口腔溃疡、乏力——立即查血常规，不能等下次复诊
> - 服用氯氮平后出现胸闷、心悸、气促、发热——警惕心肌炎，尽快就医
> - 准备自行减药或停药——先联系医生，突然停药可能导致复发或撤药样症状

> **出现以下情况，立即去急诊或拨打 120：**
>
> - 出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快（警惕恶性综合征）
> - 出现严重便秘、腹胀、呕吐、停止排便排气（警惕肠梗阻）
> - 出现木僵、缄默、拒食、保持固定姿势不动（警惕紧张症）
> - 出现自杀念头、自伤行为，或命令性幻听让自己做危险的事——不要独处，必要时拨打 110

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.3 剂量、疗程与血药浓度

“为什么他吃那个量，我吃这个量？”“为什么医生不一次加到有效剂量？”“抽血查血药浓度，到底查出了什么？”这三个问题背后，其实是同一件事：抗精神病药的使用有一套“慢慢来”的逻辑，它和吃退烧药、吃抗生素很不一样。这一页讲清楚剂量为什么因人而异、足量足疗程具体指什么、血药浓度在哪些情况下真的有用，以及复诊该盯哪些指标。本页不提供任何具体剂量方案。

一、剂量不是按体重换算出来的

很多人以为药物剂量像买衣服一样按尺码对应，实际上抗精神病药的剂量调整更像调音：先给一个保守的起点，听效果和不良反应，再一点点拧。

原因是药物在每个人体内的“旅程”差别很大。同样一片药，有人吸收得多，有人吸收得少；有人肝脏代谢快，血药浓度上不去，有人代谢慢，常规剂量就出现副作用。影响这件事的因素包括年龄、体重、肝肾功能、是否吸烟（吸烟会诱导某些代谢酶，让部分药物降解更快）、合并用药（很多药会抑制或诱导肝酶）、以及个体间的基因差异。【研究】

所以“治疗剂量”从来不是一个点，而是一个区间。医生在这个区间里找一个对具体的人合适的落点，目标是**最低有效剂量**——既能控制症状，又尽量少带来副作用。这也解释了两个常见困惑：为什么别人用着很好的量，到你身上不够；为什么你用的量看起来比别人小，效果却不错。

起始阶段通常从低剂量开始，缓慢上调。这不是医生保守，而是因为快速加量会放大副作用（尤其是锥体外系反应、镇静、体位性低血压），而副作用一旦出现，患者往往就不愿意再吃了。慢一点，反而更容易走远。【指南】

二、“足量足疗程”到底是什么意思

这两个词在临床沟通里出现频率极高，但很少被解释清楚。

足量，指的是血药浓度或剂量达到了公认的治疗范围，并且维持住了。不是“吃了一点”，也不是“吃吃停停”。

足疗程，指的是在这个剂量上持续足够长的时间，让药物有机会起效。抗精神病药不是当天见效的药：镇静、改善睡眠可能几天内出现，幻觉和妄想的明显减轻通常要数周，阴性症状和认知功能的改善往往要更久。在起效之前就判定“这药没用”，是临床上最常见的误判之一。

但“足疗程”也不等于无限等待。合理的做法是：在治疗剂量下观察一段时间，如果完全没有任何改善的迹象（哪怕只是睡眠、激越、猜疑的程度有一点变化），就需要重新评估；如果有部分改善，通常会继续观察，而不是马上换药。判断“有没有效”，不能只看“还听不听见声音”，还要看频率、强度、对情绪的影响、能不能工作学习、家属观察到什么。【临床经验】

治疗阶段	主要目标	需要关注什么
急性期	控制阳性症状、激越，保证安全	起效速度、副作用耐受、是否需要联合或调整
巩固期	巩固疗效，防止早期复燃	症状是否稳定、睡眠与功能恢复、副作用管理
维持期	预防复发，恢复社会功能	依从性、代谢指标、生活事件、复发预警信号

三、疗程：为什么“好了”还要继续吃

这是患者最不理解、也最容易自作主张的一步。

症状消失，说明药物把当前的症状压住了，不等于背后的易感性消失了。此时如果减停，复发的风险会明显上升；而每一次复发，都可能让下一次缓解变得更难。维持治疗要持续多久，取决于几个因素：首发还是多次复发、上次缓解是否彻底、有没有残留症状、家庭支持与应激水平、有没有物质使用、既往停药后复发的速度。这些都要由医生综合判断，不存在一个人人适用的期限。【指南】

减量也不是“想减就减”。合理的减量通常是有计划的、缓慢的、带着监测的：先评估当前状态是否稳定足够久，再小幅度下调，然后观察一段时间，确认没有复发迹象，再考虑下一步。任何“一下子停掉”的做法，都可能带来失眠、激越、幻觉加重，少数人还会出现头痛、恶心、出汗等撤药样不适。

四、血药浓度：一项被低估、也被滥用的检查

血药浓度检测（治疗药物监测，TDM）就是抽血测一下药在血液里的浓度。它的价值在于：有些药的血药浓度与疗效、副作用的关系比较明确，测出来能帮医生做判断。

目前临床上比较常用、参考范围相对成熟的，包括氯氮平、奥氮平、利培酮及其活性代谢物帕利哌酮、氟哌啶醇、氨磺必利等。另一些药（比如喹硫平）虽然也能测，但浓度与疗效的关系不够稳定，通常不作为常规。【研究】

血药浓度最有用的几种情形：

- **怀疑没吃药**：浓度低到几乎测不到，比反复追问更客观；
- **剂量已经不小，症状却不见好**：可能是代谢快、吸收差，或存在相互作用；
- **副作用明显**：浓度过高可能是原因之一；
- **合并用药变化**：加了或停了一种影响肝酶的药，浓度可能大幅波动；
- **吸烟量剧烈变化**：戒烟或突然大量吸烟，会影响部分药物的代谢；
- **肝肾功能异常**：影响药物清除；
- **氯氮平治疗**：浓度监测与血常规监测一起，是安全管理的一部分。

但它也有明确的局限。第一，不是所有药都值得测。第二，单次结果受采血时间影响很大——是服药前还是服药后、距离上次服药多久，都会改变数值，所以要按照医生交代的时间点去抽血。第三，参

考范围是群体统计的结果，落在范围内不代表一定有效，超出范围也不代表一定中毒，要结合症状、副作用、肝肾功能一起看。第四，浓度正常也可能是“假性难治”，因为问题出在诊断、心理社会因素或物质使用上。

所以，血药浓度是一个**辅助工具**，不是判决书。看到数值异常，第一件事是拿给开药的医生看，而不是自己上网查“超标了怎么办”。

五、复诊节奏与要盯的指标

复诊频率不是固定的。急性期、刚调整方案、刚出院的一段时间，通常需要更密的随访；病情稳定后会逐步拉长间隔。这不是医生“不重视”，而是风险分布本来就不均匀。

每次复诊，除了说症状，建议固定报告这几项：

- 服药情况：有没有漏服、有没有自行减量、有没有把药藏起来；
- 副作用：嗜睡、口干、便秘、体重变化、月经、性功能、手抖、坐立不安、不自主动作；
- 睡眠与情绪：入睡时间、早醒、情绪低落、焦虑、有没有消极念头；
- 物质使用：吸烟量、饮酒、大麻、其他物质；
- 生活事件：换工作、搬家、家庭冲突、经济压力；
- 躯体情况：发热、心悸、晕厥、吞咽困难、腹胀便秘。

需要定期做的检查通常包括体重与腰围、血压、空腹血糖与血脂、催乳素（有月经紊乱、溢乳、性功能问题时）、心电图（尤其使用有 QT 影响的药物时）、肝肾功能；服用氯氮平者还需按计划查血常规。这些不是“额外麻烦”，而是治疗方案的组成部分。【指南】

六、常见误区

“剂量越大，效果越好。” 超过一定范围后，疗效不再增加，副作用却明显上升。剂量调整有天花板。

“血药浓度低，肯定是没吃药。” 也可能是代谢快、吸收差、采血时间不对。要结合情况判断。

“感觉好了就可以减量。” 减量需要计划和监测。自行减量是复发最常见的原因之一。

“漏服一次，下次补双倍。” 不要自行补服双倍剂量，具体怎么处理请问医生或药师。

“中药、保健品可以替代药物。” 不能。部分产品还会影响肝酶，改变血药浓度。

“副作用太大，不如停几天看看。” 突然停药可能引起反跳，正确做法是联系医生调整，而不是自行中断。

> **出现以下情况，请当天联系医生或尽快复诊：**
>
> - 服用氯氮平后出现发热、咽痛、口腔溃疡、乏力——立即查血常规，警惕粒细胞缺乏
> - 脖子歪斜、眼睛上翻、吞咽困难、说话不清（警惕急性肌张力障碍）

- 心悸、晕厥、抽搐，或心电图提示 QT 延长
- 准备自行减量、停药或换药——先联系医生，说明理由

出现以下情况，立即去急诊或拨打 120：

- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快、尿少（警惕恶性综合征）
- 严重便秘、腹胀、呕吐、停止排便排气（警惕肠梗阻）
- 出现木僵、缄默、拒食、保持固定姿势不动（警惕紧张症）
- 自杀念头、自伤行为，或命令性幻听让自己做危险的事——不要独处，必要时拨打 110

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.4 常见副作用与处理

开始吃药以后，身体常会出现一些说不清的变化：白天犯困、嘴巴发干、好几天不上厕所、站起来眼前一黑。这些大多不是“病情变重”，而是药物作用带来的副作用。这一页把最常见的几类副作用讲清楚：哪些会随时间减轻、哪些必须报告、自己能做什么、什么情况要立刻去医院。

副作用从哪里来

抗精神病药的主要作用是挡住大脑里的多巴胺 D2 受体，从而减轻幻觉、妄想等阳性症状。但药物并不会只认一把“锁”，它还会碰到别的受体：碰到组胺 H1 受体，人容易困、食欲增加；碰到乙酰胆碱 M 受体，口水变少、肠道变懒、看近处发花；碰到 α1 肾上腺素受体，血管扩张，起身时血压跟不上；碰到 5-HT2C 受体，饱腹感变迟钝，体重容易上去；多巴胺挡得太多，手会抖、腿会坐不住。

理解这一点有用：副作用不是“身体被吃坏了”，多数是药物作用的附带结果，有办法调整。不同人对同一药物的反应差别很大，别人吃了没事，不代表你也没事；你出现了别人没有的反应，也不代表你“太娇气”。【指南】

七类最常见的副作用

副作用	常见表现	多在什么时候出现	会不会自己减轻
嗜睡、镇静	白天困、反应慢、早上起不来、看东西发木	开始用药或加量后	多数人几周内减轻，少数持续
口干、视力模糊	口水少、说话要喝水、看近处发花	数天到数周	部分减轻，需要主动补水
便秘	排便次数变少、大便干硬、腹胀	数天到数周	不一定减轻，可能逐渐加重
头晕、体位性低血压	起身眼前发黑、站不稳、心慌	加量期、天热、洗澡后	多数减轻，老年人要防跌倒
体重增加	食欲变大、腰围变粗、衣服变紧	数周到数月	通常不会自己停
催乳素升高	月经乱、乳房胀、溢乳、性欲下降	数周到数月	与药物有关，需要评估
性功能变化	性欲下降、勃起或射精困难、润滑减少	数周到数月	常被忽略，但可以处理

这张表只列了最常见的七类。锥体外系反应（手抖、僵硬、坐不住、不自主动作）单独放在 5.5 锥体外系反应与迟发性运动障碍里讲；体重、血糖、血脂放在 5.6 代谢综合征、体重与血糖血脂里讲；催乳素、QT 和低血压放在 5.7 高催乳素、性功能、QT 与低血压里讲。【临床经验】

哪些会自己减轻，哪些不会

会明显减轻的：嗜睡和镇静、起身头晕、口干的一部分、刚开始用药时的胃部不适。身体会在几周内产生耐受，同样的药量带来的困倦感会下降。这也是为什么医生常建议“先忍一忍，别急着停”，但前提是症状没有危险、生活还能维持。【指南】

只会部分减轻的：口干、视力模糊、便秘。耐受有限，更多要靠喝水、加膳食纤维、活动、必要时由医生调整药物或加用对症处理。

通常不会自己好的：体重增加、血糖血脂异常、催乳素升高、迟发性运动障碍。这几类需要主动监测和处理，拖得越久越难逆转。

要分清“副作用”和“复发”：突然变得话多、睡不着、疑心重，可能不是副作用，而是病情波动；突然出现高热、肌肉僵硬、意识不清，可能是恶性综合征。这两类都不要自行加减药，按后文的提示处理。

便秘：最容易被低估的一条

很多人把便秘当成“小毛病”，忍一忍、喝点蜂蜜水就过去了。但抗精神病药引起的便秘不只是“上火”，它是肠道蠕动真的变慢了。轻则腹胀、食欲差、痔疮出血；重则形成粪石、肠梗阻，甚至肠穿孔。服用氯氮平的人风险尤其高，因为氯氮平对肠道蠕动的影响更强。【指南】

可以这样做：每天固定时间喝水，不要等渴了才喝；主食里加粗粮、豆类，每天有蔬菜和水果；饭后走一走，哪怕十分钟；养成固定时间排便的习惯，即使没有便意也坐几分钟。排便情况建议记在本子上，复诊时给医生看。

要警惕的信号：连续三天以上没有排便，同时腹胀、腹痛、恶心、呕吐；完全不放屁；肚子鼓得发硬；呕吐物有粪臭味。这些提示可能已经不只是便秘，而是肠梗阻，需要急诊，不要自己反复用开塞露或灌肠硬扛。

体重、月经和性功能：别忍着不说

这三类副作用有一个共同点：患者常常不说。体重的事，觉得“说了也没用”；月经的事，觉得“不好意思”；性功能的事，觉得“难以启齿”。结果是医生不知道，方案一直不调整，人却越来越难受，最后自己把药停了。【临床经验】

其实这三类都是可以谈的。体重有监测和干预的办法；月经紊乱要查催乳素，多数在换药或调整后能恢复；性功能问题要先分清是药物、情绪还是躯体疾病造成的。复诊时哪怕只说一句“我最近胖了”“月经两个月没来”“这方面不太好”，医生就有机会处理。

可以自己先做的几件事

- ☐ 把副作用记下来：什么时候开始、当时有没有加量、严重程度打几分（0 到 10 分）
- ☐ 困倦明显时，把“白天最困的时间段”告诉医生，由医生决定是否调整服药时间
- ☐ 每天固定喝水，主食里加粗粮，饭后走动，不让便秘拖成习惯
- ☐ 起身分三步：躺着先坐起，坐半分钟，再站稳，尤其夜里上厕所时
- ☐ 复诊主动开口，不因为“怕被换药”或“怕被说矫情”而隐瞒
- ☐ 不吃别人剩下的药，不自行加抗胆碱药，不买宣称“解副作用”的保健品

什么时候需要联系医生 / 去急诊

出现以下情况，当天联系医生或尽快复诊：

- 困到影响上班、上学、走路，或白天几乎都在睡
- 口干到咽不下饭，或一周以上没有好转
- 三天以上没有排便，伴腹胀、腹痛
- 一个月内体重明显增加，或腰围明显变粗
- 月经停止两三个月、出现溢乳，或性功能问题持续存在
- 手抖、走路变慢、坐不住、舌头或嘴唇不自主运动
- 起身头晕频繁，或已经因此摔过跤

出现以下情况，立即去急诊或拨打 120：

- 高热、肌肉僵硬、意识模糊、大汗、心跳很快（警惕恶性综合征）
- 喉咙发紧、舌头不听使唤、眼睛上翻伴呼吸困难（警惕急性肌张力障碍）
- 剧烈腹痛、呕吐、完全不排便不排气（警惕肠梗阻）
- 晕倒、摔伤头部、胸痛、心悸伴眼前发黑
- 进食时突然呛咳、吞咽困难、说不出话（警惕噎食，不要强行喂水）
- 皮肤或眼白发黄、尿色变深（警惕药物性肝损伤）
- 皮疹伴发热、面唇肿胀、呼吸困难（警惕严重过敏）

容易踩的坑

“副作用大，我自己减半吃。” 减量会让血药浓度忽高忽低，症状控制不住，副作用也未必消失，还容易诱发复发。任何调整都应由医生决定。

“口干就少喝水，省得老上厕所。” 口干时更需要补水，尤其在天热、运动后。水喝太少会加重便秘、头晕和肾脏负担。

“便秘是小事，用点泻药就行。” 偶尔用可以，长期自己用刺激性泻药会让肠道更懒。反复便秘要查原因、调方案。

“别人吃这个没事，我也可以。” 同一类药物在不同人身上的副作用谱差别很大，年龄、体重、肝肾功能、合并用药都会影响。

“保健品能解副作用，还没副作用。” 保健品不能替代对症处理，部分产品还可能伤肝，或与抗精神病药相互影响。要不要用，先问医生。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.5 锥体外系反应与迟发性运动障碍

吃完药以后，有人脖子突然歪了，有人眼睛控制不住往上翻，有人腿像装了弹簧一样坐不住，还有人过了几年发现嘴巴总在动。这些表现常被误当成“病情加重”“中邪”或“习惯不好”，其实它们大多属于同一类问题：锥体外系反应。这一页帮你分辨四种常见类型、知道哪种要立刻处理、哪种不能靠自行停药解决。

什么是锥体外系反应

大脑深处有一组叫“基底节”的结构，负责把“想动”的指令调得又稳又顺，让你的手不抖、走路不僵、表情自然。抗精神病药挡住多巴胺 D2 受体后，这套调节系统暂时失衡，就会出现动作过多、过少或不受控制。这一类表现统称锥体外系反应，英文缩写 EPS。【指南】

按出现时间和表现，常分成四种：急性肌张力障碍、静坐不能、类帕金森综合征、迟发性运动障碍。前三种多在用药早期出现，及时处理大多能缓解；迟发性运动障碍出现得晚，处理起来更棘手，重点在早发现。四者可以同时存在，也可以先后出现。

四种类型怎么分辨

类型	典型表现	多在什么时候出现	处理方向
急性肌张力障碍	脖子歪向一侧、牙关咬紧、眼睛上翻、舌头往外顶、喉咙发紧	用药后数小时到数天	需要尽快医疗处理，喉咙受累要急诊
静坐不能	心里发慌、腿非动不可、站坐不安、来回踱步	数天到数周	由医生减量、换药或加对症药物
类帕金森综合征	手抖、四肢发僵、动作变慢、表情少、走路拖步、写字变小	数天到数周	由医生调整方案，多数可缓解
迟发性运动障碍	嘴唇、舌头、下巴不自主运动，咂嘴、皱眉、手指舞动，严重时影响吞咽和呼吸	数月至数年	不自行停药，尽早专科评估

需要提醒：这四种都不是“患者故意做怪动作”。它们不受意志控制，越紧张越明显，睡着后会减轻或消失。家属如果当成“装病”去批评，只会让人更焦虑，动作反而更多。【临床经验】

两种早期反应：急性肌张力障碍与静坐不能

急性肌张力障碍：最像“急症”的一种

典型场景是：加药后一两天，患者突然脖子歪向一边转不回来，或者眼睛不受控制地往上翻、看东西重影，或者嘴巴张不开、说话含糊。严重时喉部肌肉痉挛，会出现声音嘶哑、喘不上气、吞咽困难，这是需要立刻处理的急症。

这种情况看着吓人，但通常是可逆的，医生用抗胆碱能药物或调整方案后，多数在短时间内缓解。家属要做的是：不要用力掰患者的脖子或按压眼球，不要灌水灌药，保持安静，尽快送急诊或联系医生；如果出现呼吸困难、口唇发紫，直接拨打 120。

年轻男性、使用高效价药物、加量较快、肌肉注射给药的人更容易出现。出现一次之后一定要告诉医生，因为再次用药可能复发。【指南】

静坐不能：最容易被误认为“病情加重”

静坐不能的核心不是“多动”，而是一种从身体深处冒出来的烦躁：坐着难受、站着也难受、腿必须动，走来走去也缓解不了。患者常描述“心里像有蚂蚁爬”“腿不是自己的”。旁人看到的是来回走动、抖腿、频繁换姿势，容易以为“又兴奋了”“病情反复”，于是加药，结果越加越重。

这一点很关键：静坐不能会显著增加痛苦，甚至与自杀念头、冲动行为有关，不能当成“小副作用”忍着。如果出现“坐不住到想撞墙”“整夜不能躺”的程度，要当天联系医生。处理通常包括减量、换药或加用对症药物，由医生决定，不要自己加服安眠药或酒。【指南】

也要与焦虑、激越区分：焦虑时人想的是“担心的事”，静坐不能时人想的是“我必须动起来”。这个区别，患者自己最清楚，问一句“你是心里烦，还是腿非动不可”，往往就能分出来。

类帕金森综合征：手抖不等于“脑子坏了”

表现类似帕金森病：双手静止时抖动、胳膊腿发僵、走路起步困难、转身慢、表情变少像“面具脸”、写字越写越小、说话声音变低。它和帕金森病不是一回事，多数在减量、换药或加用抗胆碱能药物后改善。

需要注意的是，这类表现会影响生活：扣扣子、用筷子、走路防跌倒都变难，老年人尤其容易摔跤。出现手抖时，不要自己判断“是药还是病”，也不要自行加安坦（苯海索）——这类药可能加重记忆问题、口干、便秘、尿潴留，长期自行服用还有依赖风险。是否加、加多久，由医生决定。【临床经验】

迟发性运动障碍：为什么不能自己停药

迟发性运动障碍（TD）是长期使用抗精神病药后出现的不自主运动，最典型的是口唇舌的不自主动作：咂嘴、舔唇、舌头在嘴里转、鼓腮、皱眉、眨眼频繁；也可以出现在手指、脚趾、躯干，严重时影响说话、吞咽和呼吸。它在睡着时减轻，紧张时加重，患者常常自己意识不到，反而是家属先发现。

TD 的风险因素包括：用药时间长、年龄大、女性、既往有锥体外系反应、糖尿病、物质使用、频繁调整方案。它可以在用药期间出现，也可以在减量或停药后暴露出来。**部分人停药后能改善，部分人会长期存在**，所以早发现比“以后再说”重要得多。

处理原则有三条。第一，不自行突然停药：突然停可能让不自主运动短期加重，也可能引起复发。第二，尽早告诉医生，医生会评估是否需要调整药物、换用代谢风险不同的药，或考虑专门针对 TD 的治疗。第三，定期评估：高风险人群建议定期做异常不自主运动量表（AIMS）检查，由医生或护士完成。【指南】

有些国家已有专门用于 TD 的药物，国内的可及性和适用人群需要向医生确认。不要自行从非正规渠道购买，也不要相信“排毒针”“营养神经”能治好 TD。

家属可以怎么观察

- ☐ 用手机拍 30 秒视频：平静坐着、双手平举、慢慢走几步、说几句话
- ☐ 记录动作从什么时候开始，和加量、换药、漏服有没有时间关系
- ☐ 问本人感受：“腿是不是非动不可”“心里是不是发慌”，而不是只看动作
- ☐ 观察吃饭有没有呛咳、舌头有没有往外顶、说话是否变含糊
- ☐ 注意有没有脖子歪、眼睛上翻、牙关紧这些急性表现
- ☐ 复诊时带上视频和记录，不要只说“他最近有点怪”
- ☐ 不自行停药、减量、加服安坦或其他“抗震颤”药

什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 喉咙发紧、声音嘶哑、喘不上气、吞咽困难（喉部肌张力障碍）
- 高热、全身肌肉僵硬、意识模糊、大汗（警惕恶性综合征）
- 眼睛上翻固定、脖子歪斜无法回正，伴剧烈疼痛或呕吐
- 突然出现严重的吞咽呛咳、呼吸困难

当天联系医生或尽快复诊：

- 坐不住、来回踱步，已经影响吃饭睡觉
- 手抖、动作变慢、走路拖步，影响穿衣吃饭
- 嘴唇、舌头、下巴、手指出现不自主运动
- 静坐不能伴明显痛苦、失眠，或出现“活着没意思”的念头

不要做： 不要自行停药、减量或加药；不要用力掰脖子、按压眼睛；不要用酒精或安眠药“压一压”。

容易踩的坑

“手抖是病情加重，得加药。” 恰恰相反，类帕金森综合征多与剂量相关，加药常会加重。先让医生判断是副作用、焦虑还是其他原因。

“坐不住就是兴奋，得按住他。” 约束和指责会加重痛苦。静坐不能需要的是评估和调整方案，不是压制。

“TD 停药就好了。” 部分人停药后改善，但突然停药可能诱发复发或让运动症状短期加重，必须在医生计划下调整。

“安坦便宜，自己买来吃。” 抗胆碱能药不是保健品，可能加重记忆和认知问题，也可能被滥用。用不用、用多久，听医生的。

“副作用忍忍就过去了。” 早期的 EPS 往往提示方案需要调整，忍着不说，可能拖成更麻烦的问题。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.6 代谢综合征、体重与血糖血脂

很多患者和家属把“发胖”当成吃精神科药必须付出的代价，忍一忍就过去了。但体重上去的同时，血糖、血脂、血压往往也在变，这些变化早期没有感觉，等到出现糖尿病、脂肪肝、心梗才被发现，代价就大了。这一页讲清楚：要盯哪几个数字、哪些药风险更高、生活方式能做到什么、什么时候该和医生谈换药。

为什么精神科患者要盯代谢

原因有三层。第一层是药物：部分抗精神病药会增加食欲、降低活动量、影响胰岛素敏感性，体重和血糖随之上升。第二层是疾病本身：精神分裂症患者发生代谢异常和心血管疾病的风险本来就高于一般人群，活动少、饮食不规律、吸烟率高都是因素。第三层是就诊习惯：精神科复诊常常只谈睡眠、幻觉、情绪，体重和化验单被跳过。【指南】

代谢问题早期几乎没感觉。等到“三多一少”（喝得多、尿得多、吃得多、体重下降）、视力模糊、伤口不收口，往往已经不只是“偏高”。所以监测不是形式，是治疗的一部分。

五个要盯的数字

指标	怎么测	需要留意的范围	建议频率
体重与 BMI	晨起空腹、同一台秤	BMI 24 及以上为超重，28 及以上为肥胖（中国成人标准）	每次复诊；用药前三个月更密
腰围	站直，肚脐水平绕一圈	男性 90 厘米及以上，女性 85 厘米及以上	每次复诊
空腹血糖	抽血，空腹 8 小时以上	6.1 及以上提示空腹血糖受损，7.0 及以上需评估糖尿病	用药前、约三个月、之后每年
血脂	抽血	以化验单参考范围为准，重点看甘油三酯和低密度脂蛋白	与血糖同步
血压	静坐 5 分钟后测	130/85 及以上需要关注	每次复诊

BMI 是体重（公斤）除以身高（米）的平方。比如 1.70 米、80 公斤，BMI 约 27.7，属于超重。腰围比体重更能反映内脏脂肪，男性肚子大、女性腰粗，风险更高。

这些频率是通行做法，具体由医生根据年龄、基础疾病、用药和化验结果调整。不同学会对代谢综合征的切点略有差异，看到数字“卡在边上”时，不要自己下诊断，交给医生判断。【指南】

代谢综合征：不是“胖”这么简单

代谢综合征是一组同时出现的代谢异常，通常包括：腹型肥胖、甘油三酯升高、高密度脂蛋白偏低、血压升高、空腹血糖升高。五项里符合三项及以上，就提示代谢综合征。它不是一种“病名”，而是一个风险信号：提示糖尿病、脂肪肝、冠心病、脑卒中的风险在上升。

对精神分裂症患者来说，这件事尤其值得重视，因为心血管疾病是这一人群过早死亡的主要原因之一。控制体重、血糖、血脂、血压，本质上是在保护心脏和大脑，而不只是为了外形。

哪些药风险更高

风险层次	常见药物	主要特点
较高	氯氮平、奥氮平	体重、血糖、血脂上升明显，需重点监测
中等	喹硫平、利培酮、帕利哌酮	体重增加常见，血糖血脂影响中等
较低	阿立哌唑、齐拉西酮、氨磺必利、鲁拉西酮	体重影响相对小，但各有其他副作用
一代药	氟哌啶醇、氯丙嗪等	体重影响相对小，锥体外系反应风险高

这张表只能当参考，不能拿来自己选药。原因有三：同一药物在不同人身上的代谢影响差别很大；氯氮平对部分难治性患者是其他药替代不了的；选药还要看症状特点、既往反应、心脏和肝脏情况。医生会在“疗效”和“代谢风险”之间做权衡，这个权衡需要你的体重、化验单和家族史作依据。【临床经验】

生活方式：能做的比想象中多

吃：不用一下子变成“养生餐”。先把含糖饮料换成白水或无糖茶；把白米饭的一部分换成杂粮、豆类；每餐先吃菜和蛋白质，再吃主食；外卖少点油炸和浓汤；零食从“随手吃”改成“定时少量”。如果家里做饭，全家一起调整比单独给患者“开小灶”更容易坚持。

动：目标是每周累计中等强度活动 150 分钟左右，拆成每天 20 到 30 分钟也行。快走、骑车、跳操、做家务都算。刚开始不要定太高，能坚持比强度重要。体重下降 5% 到 10%，血糖和血脂就会有可见的改善。【指南】

睡与烟酒：睡眠不足会让人更想吃高热量食物；吸烟和大量饮酒都会加重代谢和心血管风险。戒烟时要注意，吸烟量的突然变化会影响部分药物（尤其氯氮平）的血药浓度，需要提前告诉医生。

称重：每周固定一天、固定时间称一次，记在手机或本子上。数字不用每天看，但要看趋势。腰围每月量一次即可。

换药、加药与“不能因为胖就停药”

体重增加明显时，医生可能会考虑换用代谢风险更低的药、调整现有方案，或在监测下加用改善代谢的药物。近年研究显示，二甲双胍对药物相关体重增加和血糖异常有一定帮助；GLP-1 受体激动剂等新型药物也在研究中，但是否适合、能否使用，需要医生结合具体情况判断，不属于可以自行购买尝试的范围。【研究】

有一条底线：**不要因为怕胖就自行停药或减量**。停药带来的复发风险，通常比体重问题更紧迫。如果氯氮平是唯一有效的药，正确的做法是一边用、一边积极管理代谢风险，而不是二选一。

也不要相信“排毒”“刮油”“代餐减肥”这类产品。它们既不能替代监测，也可能伤肝、伤肾，或与药物相互作用。

复诊前准备清单

- ☐ 最近三次的体重和腰围记录
- ☐ 最近的血糖、血脂、肝功能化验单
- ☐ 简单记三天吃了什么、动了多少，不用精确到克
- ☐ 家族里有没有糖尿病、高血压、早发心脏病
- ☐ 目前是否吸烟、饮酒，大概多少
- ☐ 想问医生的问题：要不要换药、下次什么时候复查、要不要加做检查

什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 极度口渴、尿量明显增多、恶心呕吐、呼吸深快、口气有烂苹果味、意识模糊（警惕糖尿病酮症酸中毒等急症）
- 胸痛、胸闷持续不缓解，或伴大汗、放射到左肩臂
- 血压很高同时剧烈头痛、视物模糊、说话不清、一侧肢体无力
- 突然看不清、眼前发黑、晕倒

尽快联系医生：

- 三个月内体重明显增加，或腰围增长很快
- 血糖、血脂化验明显超出参考范围
- 月经紊乱、脱发、皮肤变黑变厚（警惕代谢与内分泌问题）
- 伤口久不愈合、反复皮肤感染
- 打鼾严重、白天嗜睡（警惕睡眠呼吸暂停）

容易踩的坑

“胖是药造成的，没办法。” 药物有影响，但饮食、活动、睡眠都能改变结果。完全不干预，才是真的没办法。

“只要不吃饭就能瘦。” 极端节食会带来乏力、低血糖、暴食反弹，也会影响情绪稳定。规律、可持续比“狠”有用。

“血糖正常就不用查。” 奥氮平、氯氮平等药物可能在体重还没明显增加时就引起血糖异常。查一次正常，不等于以后都正常。

“换药就能瘦。” 换药可能改善，也可能带来新的副作用。换药后仍要监测体重和化验，不能换成“低风险药”就放飞。

“保健品能降糖降脂。” 不能替代化验、饮食和医生的处理，部分产品还会伤肝或与药物相互作用。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.7 高催乳素、性功能、QT 与低血压

有三类副作用最容易被“跳过”：月经乱了不说，性功能下降不提，起身头晕忍一忍。它们不像手抖那样显眼，却直接影响生活质量，有的还提示心脏风险。这一页讲清楚催乳素升高、性功能变化、QT 延长和体位性低血压：分别是什么、谁的风险更高、哪些信号要当回事。

催乳素：一条被忽视的激素线

催乳素是垂体分泌的一种激素，正常情况下由多巴胺“压着”，所以不会乱升。抗精神病药挡住多巴胺 D2 受体后，这层压制减弱，催乳素就可能升高。不同药物对催乳素的影响差别很大：利培酮、帕利哌酮、氨磺必利、氟哌啶醇等升高较明显；奥氮平影响较小；氯氮平、喹硫平、阿立哌唑影响更小，阿立哌唑有时还会把偏高的催乳素拉下来。【指南】

催乳素升高不一定有症状，有症状时也不一定升得很高，所以不能只凭感觉判断。比较典型的表现如下：

表现	女性	男性
月经	周期紊乱、经量少、停经	——
乳房	胀痛、溢乳	乳房增大、压痛
性功能	性欲下降、阴道干涩、性交疼痛	性欲下降、勃起困难、射精异常
生育	排卵受抑制，受孕困难	精子质量可能下降
长期影响	骨密度下降、情绪低落	骨密度下降、乏力、贫血样表现

如果月经停了三个月以上、出现溢乳、乳房明显增大，或者性功能问题持续存在，应该查一次催乳素。明显升高时，医生可能会安排进一步检查（包括影像学），目的是排除垂体本身的病变，不是吓人。多数药物相关的高催乳素在换药或调整后可以回落，但要不要调、怎么调，需要医生结合病情决定。

性功能：不是“矫情”，也不是“治不好”

性功能问题在精神分裂症患者中很常见，却常被双方默默忍受。原因不止催乳素：镇静作用会降低性欲和反应；抗胆碱作用会影响润滑和勃起；α 受体阻断可能影响射精；抑郁、焦虑、关系紧张、糖尿病、吸烟也都在起作用。所以不能简单归因于“药”或“心情”。

就诊时可以直接说：“最近性欲下降”“勃起或润滑有问题”“射精和以前不一样”。医生会先排查药物因素，再考虑躯体和其他原因。多数情况下，换用对催乳素影响小的药、调整服药时间、处理抑郁或糖尿病，都能带来改善。**不要因为难以启齿就自行停药**，也不要买来路不明的“壮阳”“调理”产品，它们可能与抗精神病药相互作用，或含有未标注的成分。

QT 延长：少见，但要认真对待

心电图上的 QT 间期反映心脏“充电”的时间。某些药物会让它变长，极端情况下诱发一种危险的心律失常，导致晕厥甚至猝死。这不是说吃药就会出事，而是说有一小部分人风险更高，需要提前识别。

药物方面：部分一代药（如硫利达嗪、匹莫齐特）因 QT 风险已被严格限制；氟哌啶醇在静脉给药时风险较高；齐拉西酮、喹硫平等也有一定程度影响；多种延长 QT 的药合用，风险叠加。

人的方面：本身有心脏病、先天性长 QT、晕厥史；血钾或血镁偏低（呕吐、腹泻、利尿剂、进食差）；同时使用大环内酯类抗生素、氟喹诺酮类、抗真菌药、某些抗抑郁药、美沙酮、部分止吐药；女性、老年人、低体重；肝肾功能不全。这些情况在开药前要主动告诉医生。

需要警惕的症状是：心悸、心跳漏拍感、眼前发黑、晕厥、抽搐。出现晕厥或抽搐，按急症处理，不要等下次复诊。有高危因素的人，医生可能在用药前和调整方案后安排心电图和电解质检查。【指南】

体位性低血压：起身那一下的危险

体位性低血压是指从躺着或坐着站起来时，血压明显下降，出现头晕、眼前发黑、站不稳，严重时会晕倒。抗精神病药阻断 α1 受体、扩张血管，就容易出现这种情况，尤其在开始用药、加量、天热、洗澡后、脱水、饮酒后。

老年人要特别小心，因为一次晕倒可能导致骨折、颅内出血。医生会测量躺着和站起来后的血压来判断，家庭里也可以记录“起身时有没有头晕”。应对办法很朴素：起身慢一点，先坐再站；天热和运动后补水；洗澡水不要太烫、时间不要太长；少饮酒；如果反复头晕，告诉医生调整方案，而不是自己减药。

还要把体位性低血压和静坐不能区分开：前者是“站起来眼前黑、要扶墙”，后者是“坐着也难受、腿必须动”。两者处理完全不同。

哪些人属于高危人群

- 有心脏病、心律失常、长 QT 家族史、晕厥史的人
- 血钾、血镁偏低，或近期频繁呕吐、腹泻、进食很差的人
- 同时服用多种可能延长 QT 间期药物的人
- 老年人、女性、体重偏低的人
- 肝肾功能不全的人
- 有垂体疾病、既往催乳素明显升高、乳腺癌病史的人（需个体化讨论）
- 孕产期、哺乳期女性（需专科共同评估）

这些人群不是“不能用药”，而是需要更仔细的基线检查、更慢的调整和更密的随访。具体怎么做，以面诊医生为准。【临床经验】

可以做的几件事

- ☐ 用药前如果有心脏病、晕厥史、家族史，主动告诉医生
- ☐ 把“起身头晕、眼前发黑、晕倒”记下来，包括发生的时间和当时在做什么
- ☐ 起身分三步，夜里上厕所先开灯、坐一会儿再走
- ☐ 天热、运动、腹泻后注意补水，不空腹喝酒
- ☐ 月经、溢乳、乳房变化、性功能问题，写下来复诊时给医生看
- ☐ 不自行加用其他药物、草药或保健品，尤其是抗生素、止痛药、胃药
- ☐ 医生安排的心电图、电解质、催乳素检查，按时做

什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 晕倒、抽搐、意识丧失
- 心悸伴眼前发黑、胸闷、胸痛、呼吸困难
- 心跳很快且不规律，伴出冷汗、乏力
- 晕倒后摔到头部，或出现呕吐、意识不清

尽快联系医生：

- 起身头晕频繁，或已经因此摔倒
- 月经停止三个月以上、出现溢乳、乳房明显增大
- 性功能问题持续，影响生活
- 心悸、心跳漏拍感反复出现
- 近期频繁呕吐腹泻、进食差，同时还在服药

容易踩的坑

“月经不来是好事，省麻烦。” 停经可能提示催乳素明显升高，长期还会影响骨密度和生育计划，需要评估。

“性功能问题是治不好的，忍吧。” 多数与药物方案有关，调整后可以改善。忍着不说，反而容易导致自行停药和复发。

“心电图做过一次正常，以后不用做了。” 用药方案变化、电解质紊乱、加用其他药物后，风险会变。什么时候复查，听医生的。

“头晕是没睡好，跟药没关系。” 反复起身头晕要测血压，尤其老年人和刚加量的人。

“别人吃这个药没事，我也不用查。” 心脏和代谢风险个体差异很大，别人没事不代表你没事。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.8 氯氮平：难治性精神分裂症与监测

氯氮平是治疗精神分裂症最有效的药物之一，也是监测要求最严的药物之一。它能把一部分对其他药反应不好的患者拉回生活，但也可能带来粒细胞缺乏、心肌炎、癫痫、肠梗阻这些危及生命的问题。这一页讲清楚：什么人适合用、血常规为什么是处方的一部分、哪些症状要当天就医、为什么绝对不能自己停。

氯氮平是什么，什么人适合

氯氮平属于第二代抗精神病药。与其他抗精神病药相比，它对部分“难治性”患者的疗效更好，也能降低反复自杀、自伤的风险，对严重的迟发性运动障碍也可能有帮助。所谓难治性，通常指两种不同的抗精神病药、在剂量和疗程都足够、并且确认按时服药的情况下，仍然没有获得满意效果。【指南】

因为监测麻烦，氯氮平常被拖到很晚才用，甚至被当成“最后的办法”。这是一个常见的误解。对符合条件的人，过早放弃氯氮平可能意味着错过一段本来可以改善的窗口；对不适合的人，贸然使用则可能带来不必要的风险。用不用、什么时候用，需要医生综合评估病情、既往用药、躯体状况和随访条件。

需要说明的是，氯氮平不是“更猛的药”，而是“需要更严密监测的药”。它的许多副作用可以预防和处理，前提是监测到位、患者和家属知道该看什么。

血常规：它不是“附加检查”，是处方的一部分

氯氮平可能引起白细胞和中性粒细胞下降，极少数发展为粒细胞缺乏，使身体失去抵抗感染的能力。这不是罕见到他人都不会遇到的事，所以规范要求所有使用氯氮平的人定期查血常规。**血常规监测是处方的一部分，不是可做可不做的“额外项目”。**

阶段	查什么	目的
开始用药前	血常规、肝肾功能、心电图，部分医院加查心肌酶和炎症指标	留下基线，排除禁忌
开始后的前 18 周	血常规，通常每周一次	捕捉早期白细胞下降
18 周以后	血常规，至少每 4 周一次	长期监测，晚期也可能出现异常
任何发热、咽痛、口腔溃疡时	当天加查血常规	排除粒细胞缺乏，不能等预约

各地规范和各家医院的要求略有差异，有的地方在起始阶段查得更密，具体以处方医院的要求为准。如果因为出差、放假、怕麻烦而漏查，医生可能不得不暂停用药，反而打乱治疗。

粒细胞缺乏：发热、咽痛、口腔溃疡要当天查血

粒细胞缺乏的早期表现很像感冒：发热、咽痛、口腔溃疡、牙龈肿痛、乏力、打寒战。差别在于，普通感冒不会让中性粒细胞掉到危险水平，而氯氮平可以。**出现发热、咽痛、口腔溃疡中的任何一项，当天就要查血常规；查不了就直接去急诊，不要等到下次复诊，也不要自己先吃退烧药把体温压下去。**

如果血常规提示明显下降，医生通常会要求立即停药、抗感染、升白细胞治疗，并密切观察。多数人在及时处理后可以恢复，但延误可能发展为严重感染甚至败血症。用氯氮平的人，家里最好常备体温计，家属要知道“发热不是小事”。

心肌炎、癫痫与其他要盯的风险

心肌炎：开始后的前两个月

氯氮平相关心肌炎多发生在开始用药后的前两个月，尤其是最初几周。早期表现不典型：胸闷、胸痛、心悸、气短、活动后比以前容易累、发热、下肢水肿，很容易被当成感冒或“体质差”。年轻人也可能发生，而且进展可能很快。

用氯氮平的人，如果在前两个月出现上述任何症状，要立即告诉医生，医生可能会安排心电图、心肌损伤标志物和炎症指标检查。**不要自己判断“只是累了”，也不要等到呼吸困难才去。** 心肌炎如果发现得早，处理效果通常较好；拖到心功能受损，风险会明显上升。

癫痫：抽搐不只是“抽一下”

氯氮平可能降低癫痫阈值，剂量越高风险越大；本身有癫痫史、头部外伤史、酗酒、突然停药的人风险更高。发作形式可以是全身抽搐、意识丧失、口吐白沫、尿失禁，也可以是短暂的愣神、局部抽动或行为中断。

遇到抽搐，旁人要做的是：移开周围硬物，保护头部，让患者侧卧，不要往嘴里塞任何东西，不要强行按压肢体，记录发作时间。如果抽搐超过五分钟、反复发作、或发作后长时间不清醒，立即拨打120。首次发作之后要尽快联系医生，评估是否需要调整方案或加用抗癫痫药。

便秘与肠梗阻：最被低估的一条

氯氮平对肠道蠕动的影响很强，便秘发生率很高，严重时可发展为粪石、肠梗阻、肠穿孔，甚至有致死报道。很多患者不好意思说，或者觉得“多喝水就好”，一拖再拖。

建议每周记录排便次数和大便性状。如果出现三天以上不排便，同时腹胀、腹痛、恶心、呕吐、完全不放屁，要按急症处理，去急诊，不要自己反复灌肠或吃泻药硬扛。日常的预防是足量饮水、膳食纤维、规律活动，必要时由医生开具通便药物。

流口水、低血压、镇静与体重

常见问题	表现	可以怎么处理
流口水	夜间枕头湿、白天说话流涎、呛咳	侧卧、垫毛巾、保持口腔清洁；呛咳或呼吸困难要报告
体位性低血压	起身头晕、眼前发黑、晕倒	起身慢、补水、避免过热；晕倒要报告医生
镇静	白天困、反应慢	由医生调整服药时间或方案，不自行减量
体重与血糖	食欲增加、腰围变粗、口渴多尿	按 5.6 的方法监测，必要时调整方案
心动过速	心慌、心跳快	持续或伴胸闷要查心电图

为什么不能自己停

氯氮平不能突然停，原因有四个。第一，精神症状会反跳：幻觉、妄想、激越、失眠可能在几天内明显加重，复发风险很高。第二，会出现胆碱能反跳：恶心、呕吐、腹泻、出汗、流口水、坐立不安、失眠，让人非常难受。第三，可能诱发迟发性运动障碍或其他运动症状。第四，停药一段时间后再次使用，通常需要重新从低剂量开始、缓慢加量，不能直接回到原来的量，否则心肌炎等风险会升高。

所以，“感觉好了就停”“血常规太麻烦就停”“怕副作用就自己减半”都是危险做法。确实需要减量或停药时，医生会制定计划、安排随访，并在停药后持续观察一段时间。这个过程可能需要数周到数月，不能急。

如果漏服了一次，不要在下一次吃双份，按医生事先给的规则处理；如果连续漏服多天，尽快联系医生，不要自己补。吸烟量的突然变化（戒烟或突然抽得更多）、加用某些药物（部分抗生素、抗真菌药、抗抑郁药、中成药）都会影响氯氮平在体内的浓度，变动前要告诉医生。

家属能做的几件事

- ☐ 出现发热、咽痛、口腔溃疡，当天查血常规，不拖延、不先吃退烧药
- ☐ 把验血日期记在日历或手机提醒里，提前预约，别等药快吃完才想起
- ☐ 记录排便情况，三天不排便同时腹痛腹胀，直接去急诊
- ☐ 开始用药的前两个月，留意胸闷、气短、心悸、异常乏力、下肢水肿
- ☐ 不自行加退烧药、抗生素、中成药或保健品，先问医生
- ☐ 药物放在固定位置，用分装盒，防止漏服或重复服用
- ☐ 吸烟量变化、准备怀孕、加用新药，都提前告诉医生
- ☐ 遇到抽搐，侧卧、保护头部、不塞东西、记录时间，超过五分钟打 120

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即去急诊或拨打 120：**

- 发热，同时咽痛、口腔溃疡、乏力（警惕粒细胞缺乏）
- 胸闷、胸痛、心悸、气短、活动耐量明显下降（警惕心肌炎）
- 抽搐、意识丧失，或发作后长时间不清醒
- 剧烈腹痛、呕吐、腹胀、完全不排便不排气（警惕肠梗阻）
- 晕倒、摔伤头部
- 高热、肌肉僵硬、意识模糊、大汗（警惕恶性综合征）
- 吞咽困难、进食呛咳、呼吸困难（警惕噎食或吸入性肺炎）

当天联系医生或尽快复诊：

- 流口水明显加重，影响说话或睡眠
- 便秘超过三天，或需要反复用泻药
- 体重短期内明显增加，或出现口渴、多尿
- 心慌持续，或心跳明显比以前快
- 情绪明显低落、出现“活着没意思”的念头

不要做： 不要自行停药、减量或补双份；不要用退烧药掩盖发热；不要因为“感觉还好”跳过血常规。

常见问题

“血常规一直正常，能不能少查几次？” 不能自行减少。监测频率是按风险设计的，晚期也可能出现异常。确有困难，和医生商量解决办法，而不是不查。

“氯氮平和别的药能一起吃吗？” 有些药会影响氯氮平的浓度或增加副作用，包括部分抗生素、抗真菌药、抗抑郁药、抗癫痫药和某些中成药。加任何药之前，把药名给医生或药师看。

“能不能喝酒？” 不建议。酒精会加重镇静、低血压和肝脏负担，也会影响判断力。

“准备怀孕还能吃吗？” 需要精神科和产科共同评估，不要自行停药。停药复发的风险，对母亲和胎儿都可能是更大的伤害。

“血常规低一点就要停吗？” 由医生判断。轻度下降可能需要加密监测，明显下降需要停药处理。不要自己看数字决定。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.9 长效针剂、换药、联合与停药

治疗精神分裂症，药物只是起点，真正难的是“怎么一直用对”。有人每天吃药却总漏服，有人副作用受不了想换，有人觉得“好了”就自己停，还有人同时吃两种抗精神病药。这一页讲长效针剂适合谁、换药为什么要慢慢来、联合用药的边界、停药和撤药的风险；不写具体剂量和注射间隔，那些必须由医生定。

长效针剂是什么，适合谁

长效针剂（常写作 LAI）是把同一种抗精神病药做成在体内缓慢释放的注射剂，打一次可以维持较长时间。它不是“更猛的药”，也不是“病情严重才用”的最后手段，只是给药方式不同：血药浓度更平稳，不用每天惦记吃药，也不容易因为偷偷吐药而“看起来在吃”。【指南】

对比项	长效针剂	口服药
给药方式	定期到医院注射	每天自行服用
血药浓度	相对平稳，波动小	有峰谷波动
漏服风险	由医护人员跟踪	容易自行漏服或藏药
出问题时的可逆性	一旦注入，无法立即取出	可随时调整
主要负担	需要按时到院、注射部位反应、费用	需要每天记得吃

适合考虑的人：反复因为漏服、停药而复发的人；自己愿意打针的人；每天吃药很难坚持、但能定期到院的人；口服药吸收不稳定的人；家属难以监督、但社区随访可及的人。首发患者如果本人偏好、随访条件好，也可以和医生讨论，不是必须“先用口服很多年”。【临床经验】

不太适合的人：目前处于急性激越、需要快速调整方案的人；对某种针剂成分过敏或既往有严重不良反应的人；完全拒绝注射、一谈就打人的人；近期要做手术或有大面积皮肤感染的人。晕针、怕针的人不必直接放弃，可以和护士商量姿势、环境、止痛方式。

长效针剂也有一些现实问题：注射部位可能红肿、硬结、疼痛；开始阶段可能需要短期口服补充；起效和消退都比口服慢，出现副作用时处理周期更长；需要按时到院，节假日和异地出行要提前安排。这些都要在决定前说清楚。

换药：为什么不能“今天换明天”

换药的原因通常有三类：效果不够（症状残留、功能恢复不理想）、副作用难以忍受（体重、镇静、EPS、催乳素、代谢）、患者偏好或生活安排变化。换药不是“换一种试试”，而是一次有计划的调整。

常见方式有几种：交叉渐换（旧药逐渐减、新药逐渐加，两者有一段重叠）、重叠后渐停（新药先加上，稳定后再减旧药）、以及少数情况下的停药观察（通常只在特定副作用需要澄清时使用）。选哪

种，取决于旧药和新药的副作用谱、半衰期、病情稳定程度、有没有自杀或激越风险。两种药重叠期间，镇静、低血压、QT 延长、EPS、代谢负担可能叠加，需要更密的观察。【指南】

换药期间要特别留意：症状是否加重、睡眠是否变差、有没有新的不自主动作、有没有心悸头晕、情绪是否明显低落。不要因为“新药还没起效”就自己加量，也不要因为“旧药还没减完”就提前停。**不要隔天吃、不要攒药、不要按心情调整。**

还有一点常被忽略：换药后原来的副作用不会立刻消失，新药的副作用也不会立刻出现，需要一个观察窗口。这个窗口有多长，医生会根据药物特点安排复诊。

联合用药：少数情况，不是常规

原则上，精神分裂症的药物治疗以单一抗精神病药为主。原因很实际：两种药叠加，副作用和相互作用都会增加，而疗效未必增加。研究总体上不支持常规联用两种抗精神病药。【指南】

那什么时候会联用？一是单一药物在足够剂量和疗程后只有部分应答，医生可能短期联合另一种药并设定评估时间；二是氯氮平治疗后仍有残留症状，可能加用另一种药作为增效；三是有特定的靶症状需要短期处理。这些都属于“有明确目标、有时间限制、有评估指标”的联合，而不是“多吃一种更保险”。

联合用药的风险包括：镇静和低血压加重、QT 延长叠加、代谢问题加重、EPS 增加、药物相互作用、服药负担变大导致依从性下降。老年人、肝功能不全、心脏病患者尤其要谨慎。联合一段时间后，如果目标没有达到，应该考虑撤掉其中一种，而不是一直加下去。

如果你正在吃两种抗精神病药，可以在复诊时问三个问题：这两种药各自解决什么问题？准备用多久？什么情况下会减掉一种？问清楚，比默默吃着更安全。

停药：最难的决定

停药是患者和家属最常问、也最容易做错的一件事。先说结论：**精神分裂症停药后复发风险很高，停药必须在医生计划下、缓慢进行，并配好随访和应急预案。** 突然停药可能带来四类问题。

第一类是复发：幻觉、妄想、猜疑、激越、失眠可能在数天到数周内回来，而且下一次复发可能比上一次更难治。第二类是撤药样症状：失眠、恶心、头痛、出汗、心慌、坐立不安、焦虑，容易被误当成“病情加重”。第三类是运动症状：迟发性运动障碍可能在停药后暴露或短期加重。第四类是胆碱能反跳，氯氮平突然停时尤其明显，可表现为恶心、呕吐、腹泻、流口水、出汗、激越。

停药的决定通常要考虑：病程长短、复发次数、上次复发的严重程度、目前的功能水平、副作用负担、患者意愿、家庭和随访条件。首发患者一般也需要一年以上的维持治疗，多次复发的人往往需要更长时间，部分人需要长期用药。具体多久，必须个体化，不能照搬别人的经验。【指南】

如果决定减停，医生通常会安排数周至数月的逐渐减量、加密复诊、列出复发预警信号，并约定“出现什么情况就恢复用药或来院”。这个过程里，患者和家属要做的不是说“忍一忍”，而是把睡眠、情绪、疑心、幻觉的变化记下来，及时反馈。

决策前的清单

- ☐ 写清楚这次为什么要换药或停药：是效果不够、副作用、还是生活安排
- ☐ 和医生确认目标：希望改善哪个症状，多久评估一次
- ☐ 记录换药前的基线：体重、睡眠、副作用、月经、情绪
- ☐ 问清楚重叠期要注意什么，出现哪些症状要提前复诊
- ☐ 列出自己的复发早期信号，写下来贴在冰箱上
- ☐ 确认紧急联系人、社区随访电话、最近的急诊怎么走
- ☐ 确认药量够不够撑到下次复诊，避免临时断药
- ☐ 不自行隔天服药、不攒药、不把旧药留给别人

什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 停药或减量后出现严重激越、伤人风险、命令性幻听
- 出现自杀念头、自伤行为或已经做出计划
- 高热、肌肉僵硬、意识模糊、大汗（警惕恶性综合征）
- 注射后出现皮疹、面唇肿胀、呼吸困难（警惕严重过敏）
- 抽搐、晕倒、胸痛、心悸伴眼前发黑

当天联系医生：

- 漏打了一针，或注射部位红肿热痛加重
- 换药后睡眠明显变差、疑心加重、情绪低落
- 出现新的手抖、坐不住、舌头或嘴唇不自主运动
- 停药后恶心、呕吐、腹泻、出汗、心慌持续不缓解

不要做： 不要自己恢复原来的量，不要“补打一针”，不要用酒精或安眠药对付撤药反应。

容易踩的坑

“打针说明病重了。” 长效针剂只是一种给药方式，和病情轻重没有直接对应。对反复漏服的人，它反而可能更安全。

“漏一针没关系，下次补上。” 漏针会让血药浓度下降，复发风险上升。能不能补、怎么补，要问医生，不要自己决定。

“感觉好了就可以停。” 感觉好通常是药物在起作用，不代表病好了。自行停药是复发最常见的原因之一。

“两种药一起吃更保险。” 多数情况下单一用药更安全，联用要有明确目标和期限。

“换药就是今天停旧的、明天吃新的。” 多数换药需要重叠和逐渐调整，突然切换可能引起撤药反应或症状反跳。

“把药攒起来，以防哪天断药。” 攒药容易导致过期、误服、过量，也会让医生误判你的实际用药情况。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 6：心理社会治疗与康复

药物控制症状，康复帮助人重新生活。这个模块讲心理教育、CBTp、家庭干预、技能训练、职业康复和个案管理。

6.1 心理社会干预总览

这一页回答一个很实际的问题：药已经在吃了，为什么还要做心理教育、家庭会谈、社交训练、职业康复？它把模块 6 里的几种干预放到同一张地图上，说明各自管什么、什么时候用、证据有多硬。适合刚进入维持治疗的患者，也适合想帮忙却不知道从哪下手的家属。

药物管症状，康复管生活

抗精神病药的主要任务，是降低幻觉、妄想、思维紊乱的强度，减少复发风险，让大脑从急性紊乱里退出来。它做不到的事情同样清楚：阴性症状（情感平淡、话少、没劲）、认知损害（注意力、记忆、计划能力）、社交退缩、工作能力、关系修复，药物往往只能帮到一部分。很多人症状轻了以后发现，生活并没有自动回来：白天没有安排，朋友断了联系，简历空了好几年，跟父母一说话就吵起来。这些正是康复要处理的部分。【指南】

康复不是“等病好了再说”，也不是“多出去走走、想开点”。它有一整套具体方法：心理教育让人理解疾病和治疗；CBTp 处理幻觉妄想带来的痛苦；家庭干预降低家里的冲突；社交技能训练把“怎么开口”拆成可以练的动作；职业康复帮人重新有一份事做；认知矫正练注意力和记忆力；同伴支持提供希望和榜样；个案管理把散落的服务串起来。这些方法有节奏、有目标，也有做不动的时候。

两条腿的关系要说清楚：心理社会干预不能替代药物。症状还在高位时硬做技能训练，等于让人带着剧痛跑步；反过来，只吃药不康复，症状轻了，日子却可能停在原地。比较现实的做法是：药物负责把地板抬高，康复负责把生活一点点搭回来。

八种干预，各自站在什么位置

干预	主要解决什么	常见形式与长度	证据分量
心理教育	理解疾病与治疗、识别复发、参与决策	个体、家庭或团体，数次到十余次	【指南】【研究】
CBTp	减轻幻觉妄想带来的痛苦、回避与失能	一对一会谈，通常 16 次以上、持续数月	【指南】2020 年后措辞趋谨慎
家庭干预	降低家庭冲突与复发风险、改善沟通	患者与家属共同参加，10 次以上、数月至一年	【指南】【研究】
社交技能训练	开场、倾听、提要求、拒绝、处理冲突	团体或个体，每周一次，数十次	【研究】
职业康复与支持性就业	进入或回到竞争性工作	就业专员加持续支持，不设	【指南】【研究】

干预	主要解决什么	常见形式与长度	证据分量
		固定期限	
认知矫正	注意、工作记忆、执行功能、社会认知	电脑或纸笔练习，每周两三次，数月	【研究】
同伴支持	希望、榜样、减少孤立、提高参与	个体陪伴、团体、同伴辅导员	【研究】结果不一致
个案管理与 ACT	协调服务、减少住院、危机跟进	专人负责；ACT 为多学科小组	【指南】用于复杂病例

表里有三行最容易被误解，值得单独说。

认知矫正不是补脑保健品。 它练的是具体的认知任务，比如记住一串数字、按规则分类卡片、在干扰中保持注意。练过之后，任务本身会进步，但能不能带到买菜、坐车、上班里，取决于有没有人陪着做“迁移”：把练过的策略用在真实场景里。只买一套软件天天点，不讨论怎么用，收益通常有限。【研究】

同伴支持不是随便拉个病友聊天。 受过训练的同伴支持者（自己也是康复者）能提供一种专业人员给不了的东西：这个人真的经历过，而且现在过得还行。但同伴支持有边界，不做诊断、不调药、不替医生拿主意，也需要督导。没有培训、没有边界的“病友互相开导”，有时会互相强化绝望。【研究】【待验证】

个案管理不是居委会登记。 它的核心是有人对你负责：知道你在吃什么药、下一次复诊是哪天、上次危机谁到场、租房和医保卡在哪。对反复住院、生活多个领域都乱成一团的人，这种“有人跟着”的服务比多开一次课有用。【指南】

先看分期，再选项目

阶段	优先做什么	康复重心	暂不建议
急性期	药物、安全、睡眠、家属心理教育	减少刺激、规律作息、建立信任	排满课程、逼着找工作
巩固期	药物维持、识别复发信号、CBTp 起步	恢复日常结构、小步社交	突然加码、试探停药
维持期	药物、家庭、技能、职业支持	复学复工、关系、兴趣	只吃药、不安排生活
长期复杂	ACT、住房支持、持续职业支持	稳定居住、少量但持续的活动	频繁换项目、频繁换医生

分期不是死规定，但顺序有讲究。急性期做康复，第一位是让人感到安全：房间安静一点，探望的人少一点，睡眠先稳住，家属先弄明白这是什么病、药为什么不能停。这时候排满团体课，患者只会觉得被推着走。

巩固期可以开始加内容。CBTp 在这一段起步比较合适：症状还剩一些，人也有精力谈。社交技能和家庭会谈也可以进来，频率不宜高，一周一次已经不少。

维持期才谈复学、复工、谈恋爱、搬出去住。这些目标听起来提气，但需要前面的地基。长期、复杂的病例（反复住院、无家可归、多个服务都用不上）需要 ACT 这类主动上门的小组，以及支持性住房。

选项目时先问一句：现在最影响生活的是哪一件事？只选一件。同时开三四个项目，多数人会在第三周全部停掉。

康复最容易被做错的五件事

- **把康复当成停药的理由。** “我已经能上班了，药可以停了吧”——能上班常是药物在起作用的结果，不是停药的证据。减停必须由医生计划，突然停药可能带来失眠、激越、幻觉加重，少数人出现撤药样不适。
- **把训练当成意志力考试。** 今天没出门、没完成作业，不等于不努力。阴性症状和认知损害会直接削弱启动能力，这时该调的是任务难度和药物方案，不是加批评。
- **一次上太多。** 心理教育、CBTp、技能团体、职业评估同时开始，看起来积极，实际是把人拖垮。一次一个重点，做满八周再加。
- **家属替患者做决定。** 替他把工作找好、把课报好、把朋友约好，短期省事，长期削弱他自己的决定能力。可以一起列选项，决定权尽量留给他。
- **用“忙起来”掩盖症状。** 把日程排得没有空隙，可能让幻觉、猜疑、失眠被忽略。康复计划里要留出观察和复诊的位置。

一个可以照做的起步清单

- ☐ 和医生确认：现在属于急性期、巩固期还是维持期。
- ☐ 写下目前最影响生活的一件事，只写一件。
- ☐ 对照上面的表，选一个和这件事匹配的干预。
- ☐ 问清楚：一周几次、做多久、做到什么算有效。
- ☐ 约定一个“暂停规则”：症状明显加重时先看医生，不加练。
- ☐ 记录两周：睡眠、出门次数、和人说话的次数、情绪。
- ☐ 下次复诊带上记录，和医生一起看有没有变化。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

出现以下情况，先停下康复计划，联系医生；不要用“再坚持一下”硬扛。

- 幻觉变多、出现命令性幻听，或坚信被人监视、迫害，明显影响睡眠和出门：尽快精神科就诊。
- 连续几天几乎不睡、话明显变多、情绪异常高涨或极度兴奋：尽快就诊。
- 出现木僵、缄默、拒食、违拗、保持奇怪姿势不动：可能是紧张症，立即急诊精神科评估，不要当成“不配合”。

- 出现自杀念头、自伤行为或已经做出计划：不要独处，呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 服药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快：可能是恶性综合征，立即停药并急诊。
- 服用氯氮平期间出现发热、咽痛、口腔溃疡、乏力：立即查血常规，不能等下次复诊。
- 进食出现呛咳、吞咽困难、呼吸困难：警惕噎食，立即急诊。
- 在康复项目里被歧视、被劝停药、被要求交出不合理的费用：先停下来，告诉医生或家属，必要时投诉。

常见问题

药效挺好，只吃药行不行？ 对一部分人短期可以。长期看，药物加康复的人在功能和复发后的恢复上通常更好，生活内容也更厚实。康复不必全部做，选一两项能坚持的就够。【指南】

我们这里没有这些项目怎么办？ 很多方法可以“降级使用”：心理教育用门诊时间做，家庭干预靠每月一次的家庭会谈，社交技能从每周一次出门买菜开始，职业支持先问当地残联和社区卫生服务中心。资源少不是不做的理由，做法可以更小。

家属最有用的一件事是什么？ 学会不争辩、不指责地听，并且能识别复发信号。这两件事不需要专业资质，却直接影响复诊是否及时。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- NICE. Rehabilitation for adults with complex psychosis (NG181), 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng181
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.2 心理教育

心理教育是心理社会干预里最基础的一项：把疾病、治疗、复发和权利讲清楚，让患者和家属能听懂、能提问、能参与决定。它听起来简单，做起来却常变成单向说教，或者变成“你到底认不认自己有病”的试探。这一页讲清楚该讲什么、怎么讲、怎么用它提高依从性而不让人反感。

心理教育不是“上课”，也不是“查忠诚”

心理教育（psychoeducation）指的是：用普通人听得懂的话，系统讲解疾病知识、治疗原理、副作用监测、复发信号、应对方法和社会资源。它有四个目标：理解自己的状态、参与治疗决定、更早识别复发、减少自责和病耻感。【指南】

它不是这四件事：

- 不是说服患者承认“我有精神病”。承认诊断不是配合治疗的前提，很多人一边不认同诊断，一边愿意吃药、愿意复诊，这同样可以工作。
- 不是考试。记不住药名、说不清受体，不影响治疗效果。
- 不是只给家属上课。患者本人有知情权，被排除在信息之外，容易产生“你们合起来骗我”的感觉。
- 不是一次性告知。刚被诊断时，人的注意力大概只够记住两三句话，剩下的信息要分次、重复地给。

判断一次心理教育有没有用，不看讲了多少，看对方有没有多问出一个问题、有没有多知道一件可以做的事。它也不能替代药物和复诊：心理教育提高的是理解和参与，不是疗效本身。

该讲什么：一份可以照着讲的内容清单

主题	要讲到的点	常见误解
诊断与症状	阳性、阴性、认知症状分别是什么；诊断是当前状态的归纳，不是判决	“精神分裂就是人格分裂”
病程	多数人需要长期治疗；复发常见；个体差异很大	“吃几个月就能断根”
药物	药物降低复发风险、改善哪些症状；起效需要时间	“药是毒，会吃坏脑子”
副作用	常见副作用、哪些需要报告、怎么监测体重血糖	“忍忍就过去了，不用说”
复发信号	睡眠变少、猜疑变多、幻听变频繁、突然停药	“复发了再治也一样”
应激与物质	熬夜、冲突、大麻与兴奋剂的风险	“大麻能放松，没关系”
功能与目标	复学、复工、社交、独立生活可以分步来	“这辈子不能工作了”
权利与保密	知情同意、隐私、非自愿住院的条件	“住院就出不来了”
危机应对	谁打电话、去哪家急诊、药放在哪	“到时候再说”

这张表不必一次讲完。急性期先讲三件事：这是什么病、药为什么现在不能停、出现什么要马上找医生。其余内容放在复诊和家属会谈里，一次一个主题。

讲副作用时有个平衡要把握：只讲“可能很严重”会让人不敢吃药，只讲“没事”会让人在出现问题时不知所措。可行的说法是：这类药常见的反应是哪些，我们怎么监测，出现哪一种要打电话，出现哪一种要立刻去急诊。把“监测方案”一起给出去，恐惧才会变成可控。

怎么讲才听得进去

先问，再讲。 开口前先问一句：“关于这个病，你目前最想搞清楚的是什么？”对方关心的往往不是发病率，而是“我还能不能上班”“药会不会让我变傻”“会不会遗传给孩子”。从他的问题进入，比从教科书第一章进入有效得多。

用他的词，不用术语。 说“脑子里有声音在评论你”，比说“评论性幻听”更容易接住；说“觉得别人都在针对你”，比说“关系妄想”更接近体验。术语可以后置，作为“医生记录里会写成某某”的补充。

请对方复述。 讲完一段，问“如果我讲得太绕，你用自己的话说一遍，我听听有没有说错”。这叫回述法，能立刻暴露误解，也不会让人感到被考。对方复述错了，先认可他抓住的部分，再补差别。

允许不认同。 “我不觉得自己有病”这句话，可以接：“你可以不同意这个诊断，我们先不谈诊断，谈你想解决的问题——比如晚上睡不着、白天没劲。这些能不能一起想办法？”不和信念硬碰，治疗照样能推进。

分开谈，再合谈。 患者在场时，家属常常抢着补充，患者容易闭嘴。可以先和家属谈一次（讲照护和危机预案），再和患者单独谈一次（讲自主和目标），最后一起谈（讲分工）。三次各二十分钟，比一次讲两小时有用。

给书面材料，并且重复。 人走出诊室就会忘。一页纸的要点、复诊时再问一遍、家属手机里存一份，比一次讲透更可靠。

一次十分钟的对话示例

患者：“我没病，是你们逼我吃药。”

家属常接：“你怎么没病？医生都说了！”——这句话之后，谈话基本结束。

可以换成三段：

1. 接住情绪：“你觉得被逼着吃药，很不舒服，我理解。”
2. 绕开诊断，谈目标：“那我们先不谈病名。你最近睡得怎么样？白天是不是很累？这两件事你想不想改善？”

3. 给出选择：“医生说药对睡眠和紧张有帮助，也可能有副作用。我们可以先试两周，你把不舒服记下来，复诊时我们一起跟医生提。如果完全没帮助，也可以跟医生讨论换方案。”

这不是骗人，也不是承认“没病”。它把“承认诊断”这个高门槛，换成了“愿不愿意试一个可能有用的小步骤”。前提是说法要和医生的解释对得上：可以说“这个药对睡眠和紧张有帮助”，不能编造“这不是治精神病的药”。

提高依从性，而不是“管住他”

依从性差很少是“不听话”，通常有具体原因。找原因，比加监督有效。

常见原因	表现	可以做什么
副作用难受	手抖、发胖、嗜睡、坐立不安	记录具体症状和时间，复诊时提出；由医生调整，不自行减量
觉得自己好了	“我已经正常了，不用吃了”	讲清维持治疗与复发的关系；把停药决定交给医生评估
病耻感	怕同事看见、怕被叫精神病	换包装、固定私密服药时间；讨论是否披露
忘记	作息乱、药多、出门在外	和刷牙、早饭绑定；分装盒、手机提醒；家属只提醒不催逼
费用与取药不便	异地、挂号难、自费压力	问社区随访、门诊慢病政策、长效针剂是否减少取药次数
不信任	觉得医生敷衍、被强制过	换一位能沟通的医生；带上问题清单；家属陪同
认知困难	记不住用法、分不清药盒	简化方案（由医生做）、贴标签、家属代管但保留知情
家庭冲突	吃药变成权力斗争	把“吃不吃”从亲子对抗里拿出来，交给医生和患者谈

真正有效的做法通常是组合：医生做共享决策，患者知道自己在吃什么、为什么吃，家属提供提醒而非监工，复诊时固定检查副作用。单靠“盯着咽下去”，很难撑过一年。

复诊前花五分钟的依从性自查

- ☐ 这一周有没有漏服？漏了几次，当时在做什么？
- ☐ 有没有出现新的不舒服：手抖、发胖、嗜睡、坐立不安、月经变化？
- ☐ 有没有因为“感觉自己好了”而自行减量？
- ☐ 药还够吃到下次复诊吗？
- ☐ 有没有人劝你停药、换药，或者推荐保健品替代？
- ☐ 下一次复诊是哪天，谁陪你去？
- ☐ 如果出现急症，打哪个电话、去哪家医院？

关于“把药藏进饭里”

有些家属会把药磨碎混进食物。这不推荐，原因很具体：患者不知情，等于剥夺知情同意；一旦发现，信任很难修复，之后可能连必要的药也拒绝；剂量和相互作用不可控；有的药味道苦、刺激性强，混在热食里可能影响吸收；还有呛咳和噎食风险。

如果患者持续拒药，且症状加重、有伤人毁物或拒食风险，正确路径是联系医生评估，必要时急诊或住院处理，而不是家庭内部私自给药。紧急情况下怎么做得由医生判断。【指南】

常见问题

要不要告诉患者诊断？ 多数情况下要，但可以分次、用他能接受的说法。完全不说的风险是：他自己上网查、从亲戚口中听到、或者从药盒上看到，反而更崩。说的时候带上“这个诊断意味着什么、不意味着什么”。

他一直否认有病，心理教育还有用吗？ 有用，但目标要改。不追求“承认诊断”，追求“愿意为解决具体问题尝试治疗”。这两件事在临床上可以分开。

讲副作用会不会吓得他不敢吃药？ 会，如果只讲风险不讲监测。把“出现什么、找谁、多久查一次”一起讲，多数人反而更安心。

家属自己听不懂怎么办？ 每次复诊准备三个问题，写在纸上：现在吃的是什么、为什么吃、出现什么要打电话。医生通常愿意回答具体问题，不愿意回答“你说该怎么办”这种开放式提问。

心理教育能代替心理咨询吗？ 不能。心理教育是知识和决策层面的工作；CBTp 处理的是症状带来的痛苦和应对方式；家庭干预处理的是互动模式。三者目标不同，可以叠加。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> 心理教育过程中，如果出现以下情况，停止讲解，先处理安全。

- 患者表达自杀念头、自伤计划，或说“活着没意思”：不要独处，呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现命令性幻听、坚信被追杀、明显激越或伤人风险：不要争辩和围堵，先保证安全，呼叫 120，必要时 110。
- 出现木僵、缄默、拒食、违拗、保持固定姿势：可能是紧张症，立即急诊精神科评估。
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快：可能是恶性综合征，立即停药并急诊。
- 服用氯氮平期间发热、咽痛、口腔溃疡、乏力：立即查血常规。
- 进食呛咳、吞咽困难、呼吸困难：警惕噎食，立即急诊。
- 患者自行突然停药后出现严重失眠、激越、幻觉加重：尽快联系医生，不要自行加回原量。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.3 CBTp：针对精神病性症状的认知行为治疗

CBTp 是“针对精神病性症状的认知行为治疗”的缩写（Cognitive Behavioural Therapy for psychosis）。它常被误会成“劝人承认自己有病的谈话”，其实方向相反：它从这个人正在经历的痛苦出发，一起看这些体验是怎么被解释、怎么影响生活的，再找出能松动的地方。这一页讲它做什么、不做什么、适合谁、大概要做多久，以及证据到底有多硬。

CBTp 做什么、不做什么

做什么

第一，做个案概念化。 治疗师会和患者一起，把症状放回生活里理解：这些体验是什么时候开始的，什么情况下加重，睡眠、压力、冲突、孤独起了什么作用，哪些应对方式短期缓解、长期却让问题更大（比如因为怕被监视而整天拉窗帘，结果越不出门越确信）。概念化不是找谁的错，也不是挖童年，而是画一张“问题怎么维持下去”的地图。地图清楚了，才知道从哪里下手。

第二，正常化。 治疗师会说明：在极度缺觉、长期压力、创伤或药物作用下，人也可能出现听见声音、觉得被针对的体验。正常化的意思不是“你没病”，而是“这种体验有它可以理解的部分”，这能降低羞耻感，也让人更愿意谈细节。

第三，合作检验想法。 不是辩论“你的妄想是错的”，而是一起看：支持这个想法的证据有哪些，有没有别的解释，如果换一种解释，生活会不会好过一点。常用方法是行为实验：把一个“如果……就说明我被监视”的预测，变成一次可以观察的小尝试，再一起看结果。

第四，处理幻听带来的痛苦。 包括记录声音出现的时间、内容、当时的情绪；讨论“这个声音有多大权力”；准备应对卡（听音乐、找人说话、专注做事、离开某个环境）；也包括直接和声音“对话”的练习，前提是患者愿意。

第五，减少回避。 很多痛苦不是症状本身，而是为了躲症状付出的代价：不出门、不上班、不见人、反复检查。CBTp 会把这些回避拆成小步骤，一步步加回来。

第六，谈药物。 不是劝“你必须吃”，而是把吃药放进目标里谈：你想减少复发、想能上班，药在这件事里起什么作用，副作用怎么和医生谈。最终决定权在患者和医生。

不做什么

- **不试图说服患者承认“我有精神病”。** 承认诊断不是治疗的前提。很多有效的 CBTp 会谈里，双方对“这是不是病”意见不同，但仍然能合作处理失眠、回避和痛苦。
- **不和妄想正面辩论。** “你说邻居监视你，证据呢？”“这不可能！”这类对话只会让人更防备。CBTp 问的是“还有没有别的可能”，不是“你错了”。
- **不劝停药、不劝减药。** CBTp 不替代药物，也不能把复发风险降到可以停药的程度。

- **不是“想开点”“积极思维”。** 它要求具体、可观察、可验证，不靠打气。
- **不是一次谈话就见效。** 它是一段有结构、有作业、有回顾的治疗。
- **不是所有人都要谈创伤。** 创伤知情是态度，不等于每个人都必须做创伤加工。

适合谁、什么时候要等一等

情况	是否适合	怎么调整
幻觉妄想还在，但能对话、能出门	适合	以痛苦和回避为目标，不必先消除症状
不认同诊断，但愿意谈困扰	适合	不谈病名，谈睡眠、害怕、吵架
同时有抑郁、焦虑、社交恐惧	适合	可整合处理，先处理最影响生活的一项
急性兴奋、思维极度散乱	暂缓	先药物稳定，改为支持性接触
严重认知损害、注意力维持很短	需调整	缩短会谈、多用图卡、家属参与
正在大量使用大麻或兴奋剂	先处理	物质使用会让会谈效果打折扣
有明确自杀计划	先保安全	先做安全计划与急诊评估，再谈症状
极度偏执、无法建立基本信任	先建关系	从具体事务入手，不急于谈信念

一个常被忽略的适合人群：症状已经不太重，但一直不敢坐公交、不敢去超市、不敢接电话的人。CBTp 对这类“症状后遗的回避”往往比对新发幻觉更有效。

一次会谈大概发生什么

以“觉得邻居在监视自己、不敢开窗”为例，一次会谈可能这样走：

1. **回顾上周。** 哪天最难受，当时在做什么，身体什么反应，后来怎么应对。
2. **选一个具体情境。** 不是笼统谈“被监视”，而是“周三晚上七点，楼下有人说话，你觉得他们在说你”。
3. **记录想法与情绪。** 当时的念头是什么（“他们在记录我”），情绪多强（十分里几分），做了什么（关窗、拉帘、不出声）。
4. **看证据，两栏写。** 支持的一栏、不支持的一栏，都写具体事实，不写“我就是知道”。
5. **找替代解释。** 不必接受，只要能“暂时并列”：也可能是邻居在聊家常，也可能是自己最近睡太少更敏感。
6. **设计一个小实验。** 比如“开窗五分钟，站在离窗两米的地方，记录焦虑从几分降到几分，以及有没有出现‘被记录’的实际后果”。实验要小到能做成，不做“证明你错了”的大测试。
7. **复盘。** 重点不是“你看没人监视你”，而是“即使不完全确定，开窗这件事能不能做到一点”“焦虑有没有从八分降到六分”。
8. **布置作业。** 一周两次，记录表带回来。

一次会谈通常四十五到六十分钟。有效的不只是谈话内容，还有稳定的关系：同一个人、同一时间、不评判，本身就有作用。

疗程与证据

形式与长度。 通常是一对一，每周一次，至少十六次，持续数月；也可以做团体形式。次数不是硬指标，症状持续多年、目标较多的人往往需要更长。【指南】

证据。 多项随机对照试验和系统综述显示，CBTp 对持续存在的阳性症状有小的到中等程度的改善，对症状带来的痛苦、回避和部分功能有帮助；对阴性症状和认知损害的证据较弱；对“减少住院”的结果不一致。【研究】效果通常在治疗结束后一段时间内部分保留，但不是永久。

指南态度。 NICE 的成人精神病与精神分裂症指南推荐把 CBTp 作为可用干预，同时指出总体效应量有限，2020 年更新后的措辞比早期版本更谨慎，更强调针对持续症状和个体需要。【指南】这不等于“没用”，而是说：它不是万能钥匙，也不该被当成必须完成的打卡项目。

期待怎么定。 合理的期待是：更能理解自己的体验、少一点害怕、多做成几件事、和家人的冲突少一点。不合理的期待是：做完就听不到声音、可以停药、从此不再复发。

怎么配合。 患者可以做的：把作业当成治疗的一部分，记录具体情境而不是笼统感受；会谈中觉得被冒犯就直接说；对目标有不同意见就提出来。家属可以做的：不追问会谈内容（隐私归患者），帮忙留出固定时间，不在会谈前后争论“你到底有没有病”。【临床经验】

开始之前，可以准备的清单

- ☐ 写下三个“想改善的具体场景”，比如坐公交、去超市、接电话。
- ☐ 和医生确认：现在的状态能不能坐下来谈四十五分钟。
- ☐ 想清楚哪些事暂时不想说，提前告诉治疗师。
- ☐ 问清楚大概做多少次、什么时候评估有没有效。
- ☐ 准备一个本子，只记情境、想法、情绪强度、做了什么。
- ☐ 和家属说好：会谈内容不追问，时间不被打断。
- ☐ 约定症状加重时找谁、什么情况下暂停会谈。

常见问题

CBTp 会不会给我洗脑？ 不会。它的前提是你有权不同意治疗师的解释，治疗师的工作是提供另一种看法，不是替换你的看法。如果一次会谈让你觉得被强迫承认什么，可以直接说出来，也可以换治疗师。

谈了会不会让症状更重？ 聚焦症状的谈话在少数人身上会短期升高焦虑，正规做法会控制节奏、先建立稳定感，并在症状急性加重时暂停。如果谈完连续几天失眠、猜疑明显加重，应告诉治疗师和医生。

找不到会做 CBTp 的医生怎么办？ 国内受过系统训练的治疗师仍不多。可先问精神科门诊、日间病房、大学心理中心或当地精神卫生中心；也可以先用心理教育、家庭干预、职业支持打底。CBTp 不是康复的必经门槛。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> CBTp 进行中，出现以下情况要先停下治疗，处理安全。

- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 命令性幻听让你去做危险的事，或坚信有人要伤害你而准备“先下手”：远离冲突现场，呼叫 120，必要时 110。
- 连续几天几乎不睡、极度兴奋、话停不下来：尽快精神科就诊。
- 出现木僵、缄默、拒食、违拗、长时间保持怪异姿势：可能是紧张症，立即急诊。
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗：可能是恶性综合征，立即停药并急诊。
- 自行停药后失眠、激越、幻觉明显加重：尽快联系医生，不要自行加回原量。
- 会谈后症状持续加重超过一周，或出现新的自伤冲动：联系治疗师与处方医生，评估是否暂停。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.4 家庭干预

家里有一个人得了精神分裂症，整个家的节奏都会被打乱：谁陪着复诊、谁盯着吃药、半夜起来看有没有出门、亲戚问起来怎么回答。很多家属一边撑着，一边怀疑“是不是我们哪里做错了”。这一页讲家庭干预到底做什么，高情感表达是什么意思，沟通和问题解决可以怎么练，也讲清楚一件事：家庭不是病因，但家庭可以是康复里最有力量的部分。

家庭不是病因，也不是病人

先说历史。上世纪中期曾流行“精神分裂症由母亲造成”的说法，把病因归给“冷漠的母亲”或“混乱的家庭”。这个观点后来被大规模研究否定，今天没有可靠证据支持“某种家庭模式造成了精神分裂症”。精神分裂症是遗传、神经发育、环境风险共同作用的结果，家庭不在病因链的起点上。【指南】

但家庭互动确实会影响病程。家庭情感表达（expressed emotion，简称 EE）研究的是家属在谈到患者时的三种态度：批评（挑毛病、归因于性格）、敌意（拒绝、威胁）、过度卷入（替对方做所有决定、无法放手）。大量研究显示，高 EE 家庭的患者复发风险更高；而结构化的家庭干预可以降低复发风险，尤其是在药物维持的基础上。【研究】【指南】

这里有几个必须说清的边界：

- EE 描述的是“这段时间的互动强度”，不是给家属的人格打分。一个人被反复拒药、夜不归宿、砸东西折腾了三年，说话变冲是人之常情，不是“你有问题”。
- EE 会随病情变化。急性期家里火气大，稳定后自然下降。测一次高，不代表一辈子高。
- 文化会影响判断。中国家庭普遍同住、父母深度参与、独生子女家庭全部照护压在两个人身上。西方量表里算“过度卷入”的行为，在这里可能只是正常的照护。所以更实用的判断标准不是量表分数，而是：这段互动是不是让两个人都越来越累、越来越没有空间。

高情感表达长什么样：三个信号，六句替换

信号	家里常听到的说法	可以换成
批评	“你就是懒，就是不想好。”	“这周你有三天没出门，我有点担心，我们一起看看怎么安排。”
敌意	“你再这样，我就把你送回医院。”	“我现在很累，需要先休息一晚，明天我们再谈这件事。”
过度卷入	“你跟谁打电话？必须告诉我。”	“你愿意说我就听，不想说我也尊重。”
情绪升级	提高音量、哭诉、翻旧账、摔门	“我们先停十分钟，等会儿再说。”

替换句的共同点是：说具体的事，不说人格；给选择，不下命令；表达自己的感受，不替对方定义感受；留一个可以回来的时间。这不是要求家属永远温和，而是把“情绪一下子冲到顶”改成“有台阶可下”。

一个容易踩的坑是把“低 EE”理解成“什么都别说、什么都别管”。恰恰相反，低 EE 的核心是**低敌意、高清晰**：态度不攻击，信息要说清楚，边界要说明白。什么都不说，家里会变成另一种紧张：所有人小心翼翼地绕着走，患者反而感到被当成怪物。

家庭干预不能替代药物。它做的是让药能稳定吃下去、让复发信号更早被看见、让家里的冲突不至于把人推远。把家庭会谈当成“不吃药也能好”的替代方案，是最危险的理解。

沟通训练：四个可以照做的动作

动作一：反映式倾听。 对方说完，先用自己的话复述一遍意思，不加评价。“你的意思是，你觉得我们在背后商量你，所以你不想回家，是吗？”复述对了，对方会松一口气；复述错了，他会纠正你，这比争辩有效。倾听时不要急着给建议，多数时候人先要被听懂，才听得进别的。

动作二：我向表达。 句式是“当……的时候，我感到……，我希望……”。比如“当你半夜开窗抽烟的时候，我担心得睡不着，我希望你能到阳台去，或者提前跟我说一声”。注意三点：说具体行为，不说“你总是”；说自己的感受，不说“你让我”；提一个做得到的小请求，不提“你要懂事”。

动作三：提具体请求。 “你多体谅一下家里”不是请求，是期望。“明天上午十点，你能不能陪我去趟社区医院，大概一小时”才是请求。请求要小、要有时间、要能说“不”。对方拒绝时，问一句“那你觉得什么时候方便”，比追问“你为什么总是不愿意”有用。

动作四：暂停与修复。 吵架升级前约定一个信号，比如举手、说“暂停”、或者离开客厅十分钟。暂停不是冷战，要带一句“我十分钟后回来”。事后修复比当场赢更重要：一句“刚才我声音太大了，对不起”，能把一次冲突的伤害降下来。

问题解决与边界

六步问题解决

- ☐ **把问题写成一句具体的话。** 不写“他不配合”，写“连续两周，早上叫三次还不起床，复诊迟到两次”。
- ☐ **列出所有办法，先不评价。** 包括看起来不靠谱的，先写下来。
- ☐ **评估。** 每个办法对谁有好处、要花多少时间钱、风险是什么。
- ☐ **选一个，只选一个。** 从最可能做到的开始。
- ☐ **分工与时间。** 谁做什么、做到什么时候、怎么知道有没有效。
- ☐ **一周后复盘。** 有效就继续，无效就换下一个办法，不追究“谁的责任”。

用这个方法处理“早上起不来”可能得到这样的方案：晚上十一点收手机、家属只叫一次不反复催、迟到就改约、连续一周记录起床时间。它不解决所有问题，但比每天早上吵一架强。

谁管什么：一张分工表

领域	患者自己决定	家属可以协助	建议写下来
服药	是否按时吃、副作用的感受	提醒、分装、陪同复诊	药名、时间、谁提醒
钱	日常开销、是否工作	大额支出的商量机制	每月预算、谁保管
访客与作息	见谁、几点睡	提前告知、夜间安全	家里几条硬规则
隐私	谁能知道病情	对外统一说法	亲戚怎么回答
危机	愿意联系谁	紧急联系人、送医流程	电话、医院、路线

表格里最重要的是最后两列：写下来。很多冲突不是因为意见不同，而是因为规则从来没说清，每次都临场发挥。

照护者也要有人管

家属的耗竭是真实问题：失眠、焦虑、抑郁、自己生病硬扛、放弃工作。照护者垮了，整个支持系统就垮了。可行的做法包括：固定每周半天完全属于自己的时间；和另一位家属轮班；把自己的就诊也排进日程；参加家属互助小组；允许自己说“我今天不想管”。这不是自私，是维持长期照护的必要条件。【临床经验】

常见问题

我们是不是做错了什么，才让他得病？ 不是。现有证据不支持“父母养育方式造成精神分裂症”。家庭沟通会影响复发和康复，但那是“影响病程”，不是“造成疾病”。把力气放在现在能改变的事上，比反复自责有用。

他骂人、砸东西的时候怎么办？ 先保证安全：不还手、不对骂、不堵在门口，离开现场，把可能伤人的东西收起来。有即时伤人风险就打 110，有自伤或伤人后需要医疗处理就打 120。事后等双方冷静，再谈边界和后果，不在冲突当口讲道理。

要不要住在一起？ 看三件事：他能不能基本自理、家里冲突强度、是否需要有人盯着吃药。可以试住三个月再评估。分开住不等于抛弃，很多家庭是“住得近、各自有门、每天一个电话”，关系反而更好。

家属会谈要不要患者在场？ 通常分开谈一次、一起谈一次。分开谈让家属能说真话（包括愤怒和累），一起谈把分工和规则定下来。全部一起谈，容易出现“当面控诉”；全部分开谈，患者会觉得被排除。

亲戚说“就是你们惯的”，怎么回？ 一句话就够：“医生说这病跟遗传和脑子发育有关，不是惯出来的。”不必说服所有人，也不必向每个人交代病情。对外统一说法，能省掉很多消耗。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> 家庭干预里，安全永远排在沟通技巧前面。

- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现明确伤人意图、正在砸东西或持械：不要正面冲突，撤离并呼叫 110，同时联系医生。
- 出现木僵、缄默、拒食、违拗、长时间保持怪异姿势：可能是紧张症，立即急诊精神科评估，不要当成“赌气”。
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快：可能是恶性综合征，立即停药并急诊。
- 服用氯氮平期间发热、咽痛、口腔溃疡、乏力：立即查血常规。
- 进食呛咳、吞咽困难、呼吸困难：警惕噎食，立即急诊。
- 家属自己出现持续失眠、绝望感、无法支撑：联系医生或心理援助热线，照护者也需要治疗。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- NICE. Rehabilitation for adults with complex psychosis (NG181), 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng181
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.5 社交技能训练

很多患者出院后卡在同一件事上：知道该出门、该复诊、该跟人说话，但一开口就僵住，或者说完更难受，于是干脆不见人。社交技能训练（social skills training，简称 SST）做的，就是把“跟人打交道”拆成一个个可以看、可以练、可以改的小动作。这一页讲它练什么、五个最常用场景怎么做、团体和个体怎么选，以及怎么把训练室里的东西带回生活。

技能不是“会说话”，是可以拆开练的动作

社交技能训练的基本假设很朴素：社交行为是学来的，学过的东西可以再学一遍。它不处理“你为什么变成这样”的深层原因，只处理“下一次遇到这个场面，你能多做哪一步”。

一次完整的社交行为可以拆成四段：

- **接收**：看对方的表情、语气、距离，听清他说了什么。
- **处理**：判断这是什么场合、对方大概什么意思、自己想要什么。
- **表达**：说什么、用什么语气、配什么表情和姿势。
- **反馈**：看对方的反应，随时调整；对方皱眉就收一点，对方点头就继续。

精神分裂症患者在这四段上都可能卡住。阴性症状让人表情少、话少、启动困难；认知损害影响注意力和工作记忆，别人说三句只接住一句；长期退缩让技能生疏；病耻感让人提前放弃。这些都不是“不会做人”，而是症状和处境造成的具体障碍。

训练的目标也不是把人变成外向的人。目标是：能完成他想完成的事——买菜、问路、复诊时把副作用说清楚、拒绝不想借的钱、跟同事打个招呼。一个安静的人不需要变成话多的人，只需要在必要的时候有得选。

多项随机对照试验显示，结构化的社交技能训练能改善训练情境中评定的社交技能；但要把这些技能带到真实生活里，证据就弱得多，通常需要配合现场练习以及职业、家庭方面的支持。【研究】不同指南对它的推荐力度并不一致，多数把它放在综合康复里，而不是当成单独的核心治疗。【指南】它也不能替代药物：幻觉、猜疑还在高位时，先处理症状，技能才练得进去。

五个最常用的场景

场景	关键动作	常见卡点	可以照说的一句
见面与眼神	短暂对视、点头、报名字	盯太久、全程低头	“你好，我是小陈，上次见过。”
倾听	点头、短回应、复述关键词	抢话、走神、急着讲自己	“你刚说的是搬家的事，后来怎么样了？”
表达需求	说情境、说感受、提请求	绕圈子、暗示、最后爆发	“明天复诊，我想请你陪我去，大概一小时。”
拒绝	确认、清楚说不、给替代	过度道歉、编长理由、消失	“这件事我帮不了，我这周

场景	关键动作	常见卡点	可以照说的一句
			要复诊。我可以帮你问问别人。”
冲突	暂停、降音量、只谈一件事	翻旧账、人身攻击、摔门	“我现在很生气，我们先停十分钟，等会儿再说。”

这张表可以贴在冰箱上。练的时候一次只挑一行，不要五个一起上。

拆开练：五个动作的具体做法

眼神与姿态

不需要“一直看着对方的眼睛”，那对多数人都太难。可行的做法是：对视三到五秒，然后自然移开，看对方的鼻梁或眉心也算。紧张时可以看肩膀，再慢慢回到脸。身体侧四十五度站着，比正面对着压迫感小；手不要抱胸，放在身侧或桌上；音量比平时略大一点，语速慢一点，句子短一点。

如果对方是熟人、家人，可以提前说一句“我在练看着人说话，可能有点怪”，把尴尬变成共同任务。

倾听

倾听不是沉默，是三个可以做的动作：点头或“嗯”、复述关键词、问一个开放问题。复述关键词很简单：“你说你最近睡不好？”对方通常会接着讲。开放问题是“后来呢”“你当时怎么想”，不是“是不是”“对不对”。

一个实用的小规则：对方说完后，停两秒再开口。这两秒能避免抢话，也能让自己想清楚要说什么。

表达需求

用三段式：情境、感受、请求。

“明天上午我要去复诊（情境），一个人去我有点紧张（感受），你能陪我去吗，大概一小时（请求）。”

要点：一句只提一件事；请求要具体到时间；给对方说“不”的空间。对方拒绝时，不要立刻解释成“他不在乎我”，可以问“那你哪天方便”。被拒绝是社交的常态，不是关系破裂的证据。

拒绝

四步：

1. **确认**：“我知道你这周急着用钱。”
2. **清楚说不**：“这笔钱我借不了。”
3. **简短理由**：“我这个月的药费和房租已经排好了。”

4. **给替代**：“我可以帮你问问谁有空，或者下周陪你去办手续。”

拒绝最难的是“不解释太多”。理由越长，越像在等对方反驳。也不需要过度道歉，一句“不好意思”足够。拒绝之后不要消失，第二天照常打招呼，关系反而更稳。

冲突

五步：停、降、聚焦、我向、约时间。

- **停**：不立刻回嘴，先深呼吸一次。
- **降**：音量降下来，语速放慢，身体后撤半步。
- **聚焦**：只谈眼前这件事，不翻旧账。
- **我向**：说“我刚才被那样说，很难受”，不说“你就是个混蛋”。
- **约时间**：“这事我们晚上再谈，我现在说不清。”

冲突里最伤人的往往不是分歧，而是威胁：摔门、说“你等着”、提离婚、提断绝关系。这些话说出口，问题没解决，信任先掉一层。

团体还是个体

形式	优点	难点与适合的人
团体训练	有真实观众、可以轮流演练、同伴反馈多、社交焦虑有暴露机会	怕被评价、症状干扰；适合稳定期、愿意开口的人
个体训练	隐私好、节奏可调、可以处理具体难题	缺少真实互动反馈；适合急性期后、社交焦虑重的人
家属陪练	随时可练、贴近生活	容易变成说教；适合愿意配合、能忍住不纠正的家属

多数项目会把三者混着用：团体里学，个体里补，家里练。真正决定效果的往往不是形式，而是有没有“走出训练室”的安排。团体还有一个附带好处：在别人面前练习，本身就是对社交焦虑的暴露；但它不适合症状急性期，也不适合被家属逼着来的人。【临床经验】

泛化到生活：一张练习清单

技能在教室里练会了，不等于在菜市场能用。泛化需要设计。

- ☐ 列出三个最近真正要面对的场面（复诊、取快递、跟邻居打招呼）。
- ☐ 给每个场面定一个“最小动作”，小到几乎不会失败（比如只说一句“你好”）。
- ☐ 按难度排顺序，从最容易的开始，一周只攻一个。
- ☐ 出门前用两分钟预演：第一句说什么、对方可能怎么回、卡住了怎么办。
- ☐ 带上“退路”：难受时可以说“我去下洗手间”，离开不算失败。
- ☐ 回来后记三行：做了什么、对方什么反应、下次改哪里。
- ☐ 每两周和医生或训练师看一次记录，调整难度。

- ☐ 做到三次以上再升一级，不跳级。

常见问题

练的时候像在演戏，很假。 一开始都假。技能先要“能做出来”，再谈“自然”。做十次以后，动作会缩水成自己的样子。

对方不按套路回应怎么办。 训练练的是“多一个可选动作”，不是背台词。准备两句万能句就够：“你再说一遍，我没听清”“我想一下再回答你”。

阴性症状让我根本不想练。 不想动是症状的一部分，不是懒。这时把目标降到“今天就出门五分钟”，并且和医生讨论阴性症状的治疗，不要靠意志硬撑。

被拒绝一次就受不了。 把拒绝当成信息，不当成评价。可以记下来：对方拒绝的是这件事，还是这个人？多数时候是前者。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

社交训练中，出现以下情况要停下来先处理。

- 训练后猜疑明显加重、觉得同学或老师针对自己，持续超过一周：联系医生，评估症状变化。
- 出现自杀念头、自伤行为：不要独处，呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现命令性幻听、明显激越或伤人冲动：先离开现场，呼叫 120，必要时 110。
- 在团体中被嘲笑、被孤立、被要求透露隐私：停止参加，向机构反映，并告诉医生。
- 出现木僵、缄默、拒食、长时间不动：可能是紧张症，立即急诊。
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变：可能是恶性综合征，立即停药并急诊。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- NICE. Rehabilitation for adults with complex psychosis (NG181), 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng181
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.6 职业康复与支持性就业

工作对很多患者不是“锦上添花”，而是收入、身份、作息、社交和尊严的来源。但一提到工作，常见的两条建议都很粗糙：一条是“先把病养好，工作以后再说”，另一条是“随便找个活干，忙起来就好了”。职业康复要处理的正是中间那段：什么工作、什么时候开始、需要什么支持、遇到问题找谁。这一页讲支持性就业和过渡性就业的区别、职业评估怎么做、要不要跟雇主说，以及复学复工的节奏。

先工作还是先培训：两种思路的差别

传统职业康复的思路是“先培训，再就业”（train then place）：先做评估，再上技能课，再去庇护性工场或过渡性岗位，等“准备好了”再进入竞争性就业。这套流程有它的道理，但对精神分裂症患者有两个现实问题：等待期太长，很多人在等待中失去动力；训练内容与真实岗位不匹配，结业后仍然找不到工作。

支持性就业（supported employment）把这个顺序倒过来：“先就业，再支持”（place then train）。先按患者的偏好快速找到一份竞争性工作，再由就业专员在岗位上提供训练和跟进，做多久支持多久。国际上最常被研究的一种模式叫个体安置与支持（IPS，Individual Placement and Support）。【研究】

比较项	先培训再就业	支持性就业
起点	评估、课程、庇护性岗位	直接找有薪的竞争性岗位
时间	数月到数年	通常在数周内开始求职
训练地点	教室、工场	真实岗位，必要时现场陪练
支持期限	结业即结束	不设上限，需要就继续
主要风险	等待中掉队、技能不迁移	岗位不匹配、初期压力大

多项随机对照试验和系统综述显示，支持性就业获得竞争性就业的比例明显高于传统路径，在部分综述中大约翻倍；工作时长和收入也有改善，但长期留任和收入提升的幅度有限，不同国家、不同福利制度下差异很大。它不是一个“找到工作就完事”的方案，而是“找到工作以后还有人管”。【研究】【指南】

NICE 的成人精神病与精神分裂症指南和建议复杂精神病康复的指南，都把支持性就业列为应可获得的干预，尤其是对那些想工作的人。【指南】

支持性就业的七条原则

- **零排除。** 不因为症状还在、住过院、有物质使用史、工作空白期长就把人挡在门外。能不能工作，用尝试回答，不用预测回答。

- **以本人偏好为目标。** 想做什么、能接受多远、愿不愿见人，由本人说。家属觉得“体面”的岗位，不一定是本人愿意干的。
- **快速求职。** 评估不拖成几个月，通常几周内开始投递和面谈。
- **与治疗整合。** 就业专员和医生、个案管理员互通信息（在本人同意的前提下），药物调整、复诊时间、症状波动都能被考虑进去。
- **关注钱和福利。** 工资、医保、残疾补贴、低保会不会受影响，要提前算清楚。收入增加反而失去保障，是很多人不敢工作的真实原因。
- **持续、不限时的支持。** 入职后前三个月最需要人，之后按需减少，但不“结案即失联”。
- **主动联系雇主。** 不是把简历丢出去等消息，而是就业专员去跟雇主谈岗位、谈便利、谈试用安排。

三种“就业支持”不是一回事

- **支持性就业**：竞争性岗位、真实工资、持续支持。
- **过渡性就业**：在康复机构或合作单位做临时岗位，通常有期限，目标是积累经验和建立工作习惯，之后转到竞争性岗位。
- **辅助性就业 / 庇护性工场**：为暂时无法进入竞争性岗位的人提供有保护的环境，收入可能低于最低工资或有补贴。它是选项，不是终点，也不该成为唯一选项。

选择哪一种，看三件事：现在症状稳定程度、能不能承受每天固定出勤、有没有人能在出问题时接手。三者都弱时，从过渡性或辅助性开始不丢人；但要有“往哪走”的计划，不要一待五年。

职业评估评什么

评什么	为什么重要	怎么问
想做什么、讨厌什么	动机决定能坚持多久	“如果不管钱，你最想做什么？”
既往工作与离职原因	找出可复制的经验和真正的卡点	“上一份工作是怎么结束的？”
症状的时间规律	安排班次、避开高压力时段	“一天里什么时候最难受？”
睡眠与服药时间	夜班、早班直接影响复发风险	“几点睡、几点吃药？”
注意力与速度	决定任务复杂度	“同时来三件事会不会乱？”
体力与通勤	决定岗位半径	“单程一小时能接受吗？”
人际压力	决定要不要选人少的岗位	“跟人打交道累，还是一个人累？”
经济与福利	决定“值不值得去”	“现在每个月拿什么钱？”

评估的结论不该是“能不能工作”，而应该是“在什么条件下更能工作”：固定白班、少人多任务、有午休、离家近、可以戴耳机、每周能请半天复诊。这些条件越具体，匹配越准。

和雇主沟通：说还是不说

没有义务主动披露诊断。 大多数岗位的招聘和入职流程不要求你交代精神疾病史。可以不提，也可以只说“我有慢性病，需要定期复诊”。但要注意：隐瞒不等于安全，症状波动时突然请假、频繁出

错，反而更难解释；某些岗位（如高危作业、驾驶、需要体检的岗位）有明确的健康要求，隐瞒可能带来法律和安全风险。

什么时候说。 三种情形比较适合：需要请假复诊或住院；需要具体便利（改班次、减任务、安静工位）；症状已经影响到工作表现，需要解释。不要在面试第一句就说，也不要在被批评时才说。

怎么说。 准备一个三十秒版本，只讲和工作有关的信息：“我有个慢性病，按时吃药，每两个月复诊一次，复诊那天需要请半天假。工作本身我能完成，如果临时状态不好，我会提前说。”不展开细节，不解释病因，不请求同情。找 HR 或直属主管谈，不要在公司群里说。

可以争取的便利。 弹性上下班、固定白班、避免连续夜班、安静或靠边的工位、书面指令代替口头连珠炮、任务拆成步骤、允许每小时短休五分钟、复诊假、试用期适当延长、减少同时进行的任务。这些要求多数不贵，也不影响产出，谈的时候可以说“这样我能稳定出勤”。

如果遇到歧视。 保留招聘记录、聊天记录、考核记录；向 HR 书面反映；必要时咨询当地残联、工会或法律援助。被辞退时不要签“自愿离职”，先问清楚理由。

复学复工的节奏

复工不是“回去就满负荷”。可以用阶梯：

阶段	时间	目标	注意
试水	第 1–2 周	每周几小时或半天	只求到场，不求产出
加量	第 3–6 周	逐步到半职或大半职	每加一次量观察两周
稳定	第 2–3 个月	固定班次、固定任务	睡眠和复诊不能挤掉
调整	三个月后	全职或调整岗位	有波动就退回上一级

夜班、连续加班、频繁出差，对睡眠和服药节律冲击大，尽量避开；如果岗位必须倒班，和医生讨论服药时间怎么安排，不要自行改。

复工前的一张清单

- ☐ 和医生确认：现在的作息、症状和服药时间能不能配合班次。
- ☐ 算清楚收入变化对医保、残疾补贴、低保的影响。
- ☐ 决定要不要披露、对谁说、说到什么程度。
- ☐ 把需要的便利写成一句话，谈的时候能直接说出口。
- ☐ 定好第一阶段的工作量：每周几小时、哪几天。
- ☐ 设一个三个月的评估点，以及“退回上一级”的条件。
- ☐ 留好复诊时间，不靠调药硬撑。

常见坑

- **一上来就全职。** 前两周撑住了，第四周崩掉，之后更难回去。宁可慢一点。

- **为了保住工作自行减药或停药。** 这是复发最常见的诱因之一。工作压力大时应该加复诊频率，不是减药。
- **硬撑到崩溃才说。** 提前说“我最近状态不太好，可能需要调一下任务”，比突然请假一周更容易被接受。
- **家属替本人决定“别去了”。** 一次失败不等于不能工作。可以和本人、医生、就业专员一起评估，而不是替他关门。
- **把工作当成治疗替代。** 工作能提供结构和意义，但不能替代药物和复诊。
- **只盯“体面”岗位。** 先有一份能稳定出勤的工作，再谈往上走，路径会宽得多。
- **被欺负不敢说。** 被克扣工资、被辱骂、被安排危险任务，不是“忍忍就好”，要留证据、找渠道。

常见问题

空白期太长，简历怎么写？ 写事实，不写病情：照顾家人、自学、打零工、做志愿者都算经历。面试被问起，用一句“那段时间身体不太好，现在稳定了，想重新开始”带过，然后把话题转到能做什么。

要不要办残疾人证？ 各地政策不同，证件可能带来就业援助、补贴、税费优惠，也可能在某些岗位体检或背调中被看到。办不办没有标准答案，建议先向当地残联问清楚具体权益和影响，再决定。

家里不同意我工作，怕我累着。 可以把计划摊开：先做每周十小时，设三个月的评估点，出现什么情况就停。用可撤回的方案，比争论“我到底行不行”更容易达成一致。

想考公、考编可以吗？ 部分岗位有体检标准和既往病史要求，以当年招录公告和体检标准为准，不建议隐瞒。拿不准就先咨询招录单位或当地人社部门。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> 工作相关的变化，可能直接影响病情，出现以下情况要及时联系医生。

- 为了工作自行减药、停药，或经常漏服：尽快联系医生，不要自行补服或加量。
- 连续失眠、猜疑加重、幻听变多，仍硬撑着上班：尽快就诊，评估是否需要请假。
- 出现自杀念头、自伤行为，或因工作压力感到“撑不下去”：不要独处，呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现木僵、缄默、拒食、长时间不动：可能是紧张症，立即急诊。
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变：可能是恶性综合征，立即停药并急诊。
- 在工作中遭遇殴打、威胁、非法拘禁：立即报警 110，并告知家属和医生。
- 出现严重焦虑、惊恐发作，无法出门上班：联系医生调整方案，不要靠酒精或自行加药应对。

参考来源

- NICE. Rehabilitation for adults with complex psychosis (NG181), 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng181
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.7 认知矫正、同伴支持与个案管理

有三类服务经常被放在一起讲，因为它们都不直接针对幻觉妄想，却深刻影响一个人能不能把日子过起来：认知矫正练脑子的注意力与记忆力，同伴支持提供“有人走过这条路”的希望，个案管理负责把散落的服务串成一条线。这一页分别讲它们做什么、证据有多硬、局限在哪，也给出一张国内可用的社区资源地图。

认知矫正：练的是哪几种能力

认知矫正（cognitive remediation）针对的是精神分裂症里最容易被忽略的一块：认知损害。它不等于“补脑”，也不是做数独、玩记忆游戏就算。它练的是几种具体能力：

- **注意与警觉**：能不能在嘈杂环境里盯住一件事，能不能持续十分钟不分心。
- **工作记忆**：别人说三件事，能不能记住两件；买菜时能不能心算找零。
- **处理速度**：反应是不是明显慢半拍，排队、点单时会不会卡住。
- **执行功能**：能不能计划顺序、切换任务、遇到变化改方案。
- **社会认知**：能不能看懂对方的表情、语气、言外之意。

常见形式是电脑程序或纸笔练习，也有小组形式，每次三十到六十分钟，每周两到三次，持续几个月。有效的方案通常包含两件事：一是反复练任务本身，二是每次结束前讨论“今天练的这个策略，怎么用到生活里”，这一步叫迁移或桥接（bridging）。只点软件不讨论迁移，收益往往有限。【研究】

证据方面要说实话：多项随机对照试验和系统综述显示，认知矫正对注意力、记忆、执行功能的测验成绩有小的到中等程度的改善；对日常功能的改善较小，而且需要同时有职业或社交康复配合；效果能不能长期维持，研究结果不一致。【研究】它不会让智商变高，也不能替代药物，更不是“练了就能上班”。

认知矫正怎么做才不白练

- ☐ 先定一个生活里的具体目标：记住复诊日期、看懂药品说明书、独立坐一次公交。
- ☐ 让训练师把任务难度调到“努力一下能做成”，成功率保持在七成左右。
- ☐ 每次训练后花五分钟讨论：今天用的什么策略，明天在哪用。
- ☐ 把策略写成一句话贴在桌上，比如“一次只做一件事，做完打勾”。
- ☐ 睡眠、抑郁、药物副作用先处理——这三样都会直接拖垮注意力，不解决就练不动。
- ☐ 急性期不硬练，先稳定症状；练不动不是懒，是状态不允许。
- ☐ 每四周看一次记录：任务成绩有没有进步，生活目标有没有推进。
- ☐ 家属不比较、不催促，只问“今天要不要我陪你练十分钟”。

同伴支持：希望与边界

同伴支持（peer support）指受过训练的康复者，以自己的经历为基础，提供陪伴、经验分享、资源信息和倡导。形式包括一对一陪伴、团体活动、医院或社区里的同伴辅导员，以及家属之间的互助小组。

它最有价值的地方是希望。一个人被告知“这病要终身吃药、可能上不了班”时，专业人员的解释往往显得遥远；而一个同样得过病、现在能自己租房、每周打两天零工的人坐在对面，说服力完全不同。同伴支持还可能减少孤独、提高治疗参与、降低病耻感，在出院后的过渡期尤其有用。【研究】【个人体验】

但证据没有想象中一致。系统综述发现，同伴支持在希望感、赋权、康复态度上有一些积极结果，对住院次数、症状严重度的改善则不稳定，不同项目差别很大，关键在培训质量和督导。【研究】所以它值得尝试，但不该被当成“便宜的替代方案”。

边界必须说清楚：

- **不做诊断、不调药、不劝停药。** 同伴支持者不是医生，“我当年停了药也没事”这句话可能害人。
- **不替代专业治疗。** 它是补充，不是替代。
- **有保密和角色约定。** 私下借钱、频繁越界联系、发展成依赖关系，都是常见问题。
- **同伴自己也可能复发。** 项目要有督导、有替补、有危机转介流程，不能把一个人用到耗竭。

判断一个同伴项目靠不靠谱，可以问四句话：有没有系统培训？有没有督导？角色说明写清楚了吗？出现危机时转给谁？四个都答得上来，基本可以试。

个案管理、ACT 与社区资源

个案管理（case management）听起来抽象，实际做的事很具体：有一个人知道你吃什么药、下一次复诊是哪天、医保卡在哪、上次住院是谁签的字、房租什么时候到期。服务越碎片，这个人越重要。

模式	主要做什么	适合谁	局限
经纪式个案管理	评估后转介到各项服务	需求明确、能自己跑流程	容易变成“给张名单”
临床个案管理	评估、订计划、随访、协调	多数社区患者	个案量大时流于形式
优势模型	围绕本人目标找资源	目标不清、被动的人	对急性风险支撑不足
ACT	多学科小组、上门、低个案量、全天可联系	反复住院、无家可归、服务接不上的人	资源要求高，国内少

ACT（Assertive Community Treatment，主动式社区治疗）的证据相对硬：对反复住院、无家可归、多个服务都用不上的人，它可以减少住院、提高稳定居住的比例；对功能本来较好的人，未必优于常规门诊。【指南】【研究】NICE 关于复杂精神病康复的指南把这类主动、整合、长期的社区支持放在核心位置。【指南】

国内的对应形态主要是社区卫生服务中心的精神卫生防治人员（常被叫作精防医生）：建档、定期随访、评估风险、转诊、协助申请服药补助和救助。各地政策差别很大，有的地方有免费服药或门诊补贴，有的地方只有随访，具体以当地卫健部门和社区通知为准。【指南】

社区资源地图与开口的第一句话

- **社区卫生服务中心 / 乡镇卫生院精防医生**：建档、随访、转诊、服药补助。第一句：“我家人确诊了精神分裂症，想在社区建档，需要带什么材料？”
- **精神卫生中心或专科医院门诊**：调药、复诊、日间康复。第一句：“有没有日间康复或团体活动可以参加？”
- **当地残联**：残疾人证、辅助性就业、职业培训、辅具。第一句：“精神残疾可以申请哪些就业和康复支持？”
- **民政部门 / 街道**：低保、临时救助、庇护性住宿。第一句：“因病致困可以申请什么救助？”
- **12356 心理援助热线**：情绪危机、夜间无人可说的时刻。
- **社工机构与家属互助会**：信息、陪伴、经验。第一句：“你们的活动多久一次，家属能参加吗？”

常见问题

认知矫正能提高智商吗？ 不能。它改善的是特定任务上的表现和策略使用，不改变智力测验的总分，也不保证工作能力提升。

同伴支持者会不会劝我停药？ 正规项目会明确禁止。如果遇到劝停药、推荐保健品、收费“包治”的，立即退出并告诉医生。

ACT 是不是上门监视我？ 不是。ACT 的上门是为了在人不来门诊时仍能接上服务，目标由本人参与制定。如果服务过程让你感到被控制，可以提出，也可以换团队。

社区随访会不会泄露隐私？ 随访记录属于医疗信息，受法律保护。现实中信息保护水平参差不齐，可以问清楚“哪些人会看到我的资料”，并留意社区公示栏是否出现姓名。

这些服务要花很多钱吗？ 社区随访、部分康复活动、热线通常免费或低价；私营机构收费差异大。涉及付费时先问清单价、次数和退费规则，不要一次性交大额费用。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> 康复服务再完整，也替代不了医疗处置。出现以下情况先联系医生或急诊。

- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现命令性幻听、坚信被监视迫害、明显激越：先保证安全，呼叫 120，必要时 110。
- 出现木僵、缄默、拒食、违拗、长时间保持怪异姿势：可能是紧张症，立即急诊精神科评估。
- 服药后高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快：可能是恶性综合征，立即停药并急诊。

- 服用氯氮平期间发热、咽痛、口腔溃疡、乏力：立即查血常规。
- 进食呛咳、吞咽困难、呼吸困难：警惕噎食，立即急诊。
- 在康复机构遭遇辱骂、殴打、非法限制自由或财物侵占：立即离开并报警 110，同时告知家属和医生。

参考来源

- NICE. Rehabilitation for adults with complex psychosis (NG181), 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng181
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- 中国严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）及地方社区管理文件.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 7：物理与其他治疗

物理治疗不是“电击惩罚”。这一模块讲 ECT 的真实适应证、rTMS/tDCS 的证据边界，以及中医/补充剂的定位。

7.1 无抽搐电休克 ECT

提到“电休克”，很多人脑子里会浮现电影里的画面：人被按住，电流通过身体，痛苦地抽搐。现代精神科做的 ECT 完全不是那样：在全麻和肌肉松弛下进行，患者睡着、不抽搐、没有疼痛。这一页讲清楚 ECT 到底治什么、一次怎么做、记忆会受多大影响、同意书意味着什么，以及害怕它的时候可以怎么办。

先澄清三个误解

误解一：ECT 是惩罚或酷刑。 现代 ECT 在全身麻醉和肌肉松弛剂下进行，患者入睡后接受短暂的电刺激，引发一次受控的脑内癫痫发作，全程有麻醉医生和监护设备。它不会让人“被电击”，也不会让人疼得挣扎。

误解二：ECT 是“最后的办法”，做了就没救了。 恰恰相反，对紧张症、严重拒食、高自杀风险这些情况，ECT 常常是起效最快、最应该早用的治疗之一。等到所有药都试遍才考虑，可能已经错过了窗口。【指南】

误解三：ECT 会把人“电傻”。 记忆影响是真实存在的，需要认真对待，但“变傻”是夸张说法。多数人的记忆在数周至数月内改善，少数人会有较长时间的记忆空白。医生会用认知评估和调整治疗方式来降低这种影响。

医生会在什么情况下建议 ECT

情况	为什么考虑 ECT	证据位置
紧张症：木僵、缄默、拒食、违拗、蜡样屈曲	起效快，可挽救生命，药物治疗无效时尤其重要	指南推荐
严重拒食、脱水、营养不良	药物起效慢，患者等不起	指南推荐
高自杀风险，尤其是有明确计划或既往未遂	需要尽快降低风险	指南推荐
难治性精神分裂症，多种药物效果不佳	部分患者可获改善	指南推荐
恶性综合征、恶性紧张症	药物效果有限时的选择	研究支持，需个体化
严重激越、攻击行为，短期难以控制	快速控制，保护患者和他人	指南推荐，需严格评估

可以看到，ECT 的适应证里，很多是“等不起”的情况。它不是用来替代所有药物的，也不是所有精神分裂症患者都需要做。医生会综合病情严重程度、病程、既往治疗反应、躯体状况和患者意愿来判断。

一次 ECT 是怎么做的

治疗前：医生会做病史和体格检查，安排心电图、血液化验，必要时做影像学检查；麻醉医生会评估心肺功能和气道；牙科问题、胃食管反流、近期感染都要提前说明。治疗前需要禁食禁饮，具体时间由医院交代。签署知情同意书是必要环节。

治疗中：患者躺在治疗床上，连接心电、血压、血氧监护，建立静脉通路。麻醉医生给予短效麻醉药，患者入睡；再给肌肉松弛剂，减少肌肉抽动。医生放置电极，给予短暂刺激，引发一次脑内癫痫发作，体表可能只有轻微的手指或脚趾抽动。全程有氧气和气道支持。

治疗后：患者被送到恢复室，几分钟到十几分钟后醒来，可能会有短暂迷糊、头痛、肌肉酸痛、恶心。当天通常需要有人陪同，不能自己开车。一个疗程通常每周两到三次，共数次到十余次，具体次数根据疗效和副作用调整，不是固定套餐。

记忆影响：最需要提前说清楚

ECT 对记忆的影响主要有两种。一种是“顺行性遗忘”：治疗前后一段时间内，新学的东西记不住，比如昨天吃了什么、今天上午做了什么。另一种是“逆行性遗忘”：对治疗前一段时间的事情记忆变模糊，越靠近治疗的时间越明显。多数人的这些影响在治疗结束后数周至数月内逐渐改善，但也有少数人报告较长期的记忆空白，尤其是治疗前就有认知问题、治疗次数多、使用双侧电极的人。

医生会想办法降低影响：使用单侧或超短脉冲刺激、控制治疗次数、治疗前做认知基线评估、治疗中定期复查记忆和注意力。家属可以帮忙记录“治疗前能做到什么、治疗后变化在哪里”，这些信息对判断很有用。

需要区分的是：精神分裂症本身、抑郁、睡眠不足、药物镇静都会影响记忆。不能把所有记忆问题都归给 ECT，也不能因为“别人说没事”就忽视自己的感受。如果治疗后记忆问题持续影响生活，要主动告诉医生，而不是自己忍着。

风险、知情同意与害怕

ECT 的常见不适是头痛、肌肉酸痛、恶心、短暂意识模糊，通常对症处理即可。较少见但需要重视的风险包括：血压剧烈波动、心律失常、吸入性肺炎、牙齿或口腔损伤、癫痫发作时间过长。严重并发症和死亡的风险很低，但并非为零，主要与麻醉和心血管状况有关。

有些情况需要特别评估：颅内压增高、近期心梗或脑卒中、不稳定的动脉瘤、严重肺部疾病、嗜铬细胞瘤。这些不是绝对的禁区，但需要麻醉科、精神科和相关专科共同讨论。

知情同意不是“签个字”。你有权知道为什么建议 ECT、替代方案是什么、预计几次、怎么判断有效、记忆影响如何监测、出现问题时怎么处理。你也可以在治疗前改变主意。如果患者暂时失去判断能力，非自愿治疗需要符合当地法律程序，通常需要第二意见和家属参与，具体以《精神卫生法》和医院流程为准。

害怕是正常的。影视作品里的 ECT 和现实差距很大。可以请医生带你看看治疗室、和麻醉医生聊一次、问问做过的人的感受。恐惧本身不应该成为拒绝必要治疗的理由，但也不应该被忽视。

你可以问的问题

- ☐ 为什么现在建议 ECT，而不是继续调整药物
- ☐ 预计做几次，什么时候评估“有没有效”
- ☐ 麻醉由谁做，治疗前需要哪些检查
- ☐ 记忆影响可能有多大，怎么监测
- ☐ 治疗期间原来的药怎么处理
- ☐ 做完之后怎么维持，会不会很快复发
- ☐ 如果我不想做了，可以随时停吗
- ☐ 非自愿情况下，法律程序是什么

什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 治疗后持续意识模糊、叫不醒，或反复呕吐
- 剧烈头痛、视物模糊、一侧肢体无力、说话不清
- 胸痛、心悸、呼吸困难
- 抽搐持续不停止，或刚做完又连续发作
- 发热、寒战、呼吸急促

尽快联系医生：

- 头痛、肌肉酸痛持续不缓解
- 记忆问题明显影响生活，或情绪明显低落
- 治疗后出现明显的困惑、走错路、认不出熟悉的地方
- 原本控制住的幻觉、妄想又加重

常见问题

“做几次才能好？” 没有统一答案。有人几次就有明显改善，有人需要更多次。医生会在过程中评估，不会机械地做满一个数字。

“做完会忘掉家人吗？” 多数人不会。常见的是治疗前后一段时间的记忆变模糊，远期记忆通常保留。少数人会有较明显的空白，需要提前和医生讨论风险。

“能不能只做 ECT，不吃药？” 不建议。ECT 起效快，但单独使用后复发率较高，通常需要药物或继续 ECT 维持。具体方案由医生制定。

“ECT 疼吗？” 治疗时在麻醉下，不会感到疼痛。醒来后可能有头痛和肌肉酸痛，可以用药缓解。

“ECT 会致癌或损伤大脑吗？” 目前证据不支持 ECT 造成结构性脑损伤，但记忆影响是真实存在的，需要认真监测。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.2 rTMS 与 tDCS

除了药物和 ECT，精神科还有两类“用物理手段调节大脑活动”的治疗：经颅磁刺激（rTMS）和经颅直流电刺激（tDCS）。它们常被宣传成“无痛、无副作用、替代药物”的新方法，实际证据要谨慎得多。这一页讲清楚它们分别是什么、对幻听和阴性症状研究到什么程度、适合谁、哪些情况不能做。

它们分别是什么

rTMS（重复经颅磁刺激）：用一个放在头皮上的线圈产生短暂而强的磁场，磁场穿过颅骨，在局部脑区诱发微弱电流，从而改变该区域神经细胞的兴奋性。治疗时人是清醒的，不需要麻醉，通常坐在治疗椅上，每次几十分钟，一个疗程需要连续多天到数周。最常见的不适是头皮敲击感、头痛，声音较响，需要戴耳塞。

tDCS（经颅直流电刺激）：通过贴在头皮上的电极，施加非常微弱的直流电，改变神经细胞膜的兴奋阈值。治疗时可能有轻微刺痛、发痒或灼热感，同样不需要麻醉。设备看起来简单，市面上甚至有家用版本，但这恰恰是风险所在：参数、电极位置、皮肤保护都需要专业判断，自行使用可能造成皮肤灼伤。

两者都不是“电击治疗”。ECT 是在麻醉下诱发一次癫痫发作，rTMS 和 tDCS 不引起抽搐，也不要求全麻，这是最容易被混淆的地方。具体的刺激部位、频率、强度、电极位置和疗程，由医生和治疗师根据个体情况决定，本页不写这些参数。

对幻听的证据：可能有效，但有限

幻听是 rTMS 研究最多的靶点之一。研究通常把线圈放在与听觉加工相关的颞顶区域，试图降低过度活跃的听觉网络。多项 meta 分析显示，rTMS 对幻听可能有中等程度的改善，部分患者报告声音变小、变少、变得不那么困扰。【研究】

但要注意几个限制。第一，研究样本普遍偏小，不同试验的刺激部位、疗程、入组标准差异很大，结果并不一致。第二，效果往往在治疗结束后一段时间内减弱，长期维持的证据不足。第三，多数研究是在药物基础上加做 rTMS，而不是替代药物；单用 rTMS 治疗精神分裂症的证据很弱。第四，幻听的“改善”有时是主观感受变好，不一定伴随总体症状评分下降。

因此，目前的定位是：对药物控制不理想、幻听持续困扰、愿意配合连续治疗的人，可以在有条件的机构作为辅助治疗尝试；它不是常规首选，也不是“做了就不用吃药”。国内哪些医院开展、是否纳入医保，各地差异很大，需要具体咨询。【指南】

对阴性症状和认知：证据更弱

阴性症状包括情感平淡、言语减少、意志缺乏、社交退缩，往往比幻听更影响长期功能。rTMS 研究常刺激前额叶区域，希望改善前额叶功能。meta 分析结果不一致：有的显示对阴性症状有小到中等改善，有的在控制假刺激后差异消失；tDCS 的研究更少、样本更小，结论更不稳定。【研究】

认知损害方面的研究更初步，多为小样本、短期随访，不能支持“rTMS 能改善记忆和注意力”的普遍结论。对阴性症状，目前更可靠的仍是药物调整、心理社会康复、社交技能训练和有结构的日常活动，物理治疗只能算探索性补充。

tDCS 因为设备便宜、操作相对简单，近些年研究增多，但整体证据等级低于 rTMS。家用 tDCS 设备在监管上参差不齐，已有皮肤灼伤、电极放置错误导致效果相反的报告。**不建议自行购买家用设备在家做**，尤其是同时服用抗精神病药、有癫痫史或头皮皮肤问题的人。

适用、局限与不适合的人

对比项	rTMS	tDCS
是否需要麻醉	不需要，清醒状态	不需要，清醒状态
常见不适	头皮痛、头痛、耳鸣、面部抽动	刺痛、发痒、皮肤发红
少见风险	癫痫发作（很低）、晕厥	皮肤灼伤、电极处皮炎
对幻听的证据	中等偏弱，研究较多	较弱，研究较少
对阴性症状的证据	不一致	更不一致
治疗安排	需连续多天到院	同样需要连续多次

不适合或需要特别评估的情况：头颅内有金属植入物、人工耳蜗、心脏起搏器或其他电子植入设备；有癫痫史或家族史（rTMS 需谨慎评估）；颅内压增高、近期脑卒中或脑外伤；治疗区域有皮肤破损、感染或湿疹；妊娠期（证据有限，需专科讨论）；无法配合保持不动的人。

这些不是绝对的禁区，但需要医生和治疗师逐项评估。做之前要把所有植入物、手术史、用药、癫痫史、妊娠可能都讲清楚，不要觉得“说了会被拒绝”就隐瞒。

还要算一笔现实账：一个疗程往往需要连续多天到院，往返时间和费用都不低；效果因人而异，不能保证一定改善；治疗期间仍然要按医嘱服药、复诊，不能把物理治疗当成“请个假就能解决”的事。把它看成“多一个可选工具”，比看成“最后一根稻草”更稳妥。如果做了几次没有任何变化，也可以和医生讨论是否继续，不必因为“已经开始了”而硬撑。

决定前可以问的问题

- ☐ 我目前的药物治疗是否已经足够剂量和疗程
- ☐ 我想解决的是幻听、阴性症状，还是情绪问题
- ☐ 有没有对照研究支持在这个机构做，疗程多长
- ☐ 效果大概能维持多久，做完之后怎么维持

- ☐ 治疗期间原来的药要不要调整
- ☐ 有没有需要先做的检查（脑电图、影像、皮肤评估）
- ☐ 费用、频次、交通能不能坚持
- ☐ 出现头痛、抽搐、皮肤灼伤时找谁

什么时候联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 治疗中或治疗后出现抽搐、意识丧失
- 剧烈头痛、反复呕吐、视物模糊、一侧肢体无力
- 晕倒、胸痛、呼吸困难
- 头皮或电极处严重灼伤、水疱、破溃

尽快联系医生：

- 治疗后头痛持续不缓解，或耳鸣加重
- 头皮红肿、疼痛、渗液
- 情绪明显变差，出现“活着没意思”的念头
- 幻听或疑心在治疗后反而加重

不要做： 不要自行购买家用设备在家操作；不要因为做 rTMS 就自行减药或停药；不要相信“包治幻听”“做一次就断根”的说法。

容易踩的坑

“物理治疗没有副作用，比吃药安全。” rTMS 和 tDCS 都有不适和少见风险，而且不能替代药物。安全性建立在规范操作和筛选的基础上，不是“天然无害”。

“rTMS 能根治幻听。” 研究显示的是部分改善，且效果可能随时间减弱。把它当成辅助手段，比当成“根治手段”现实。

“家用 tDCS 更便宜，自己在家做就行。” 电极位置、电流、皮肤保护都需要专业判断，自行操作有灼伤和无效的风险。

“做了物理治疗就不用吃药了。” 目前没有证据支持用 rTMS 或 tDCS 替代抗精神病药。擅自停药带来的复发风险，远大于治疗可能带来的收益。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.

- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.3 中医、针灸与补充剂证据

在精神科门诊，最常被问到的几个问题是：“能不能吃中药调理？”“针灸对幻听有用吗？”“omega-3 能不能代替药？”这些方法有人确实在用，也有人因此停了西药、耽误了治疗。这一页不站队，只把证据、风险和边界讲清楚：什么可以辅助、什么不能替代、哪些信号提示肝损伤或药物相互作用。

先说结论

第一，中医、针灸和多数补充剂目前都**不能替代抗精神病药**。它们可能对某些症状或副作用有辅助作用，但没有足够证据支持单独用来治疗精神分裂症。

第二，这类干预的最大风险不是“没用”，而是“用了以后把有效的治疗停了”，以及肝损伤、肾损伤、掺入西药、与处方药相互作用。

第三，任何要尝试的东西，都值得告诉主治医生。隐瞒不会让它更安全，只会让医生在出现问题时少一条线索。

中医：能做什么，不能做什么

中医看精神分裂症，通常按“癫”“狂”“郁”等范畴辨证，用清热化痰、活血化瘀、安神定志等思路组方，也可能使用中成药或针灸。部分患者在规范西药治疗的基础上，报告睡眠、便秘、口干、情绪紧张有所改善。【临床经验】

从研究角度看，问题在于证据质量。多数中药治疗精神分裂症的试验样本小、疗程短、盲法不严、结局指标不统一，难以得出“某方某药有效”的可靠结论。系统综述的总体结论是：某些中药作为辅助可能对症状或副作用有有限益处，但证据等级低，不能支持替代抗精神病药。【研究】

中医真正有价值的地方，可能在于整体关注睡眠、饮食、排便、情绪和体质，这些恰恰是西药治疗中容易被忽略的部分。但它不能替代抗精神病药对阳性症状和复发预防的作用，这一点必须说清楚。

针灸：证据与安全

针灸治疗精神分裂症的研究主要集中在幻听、阴性症状、焦虑、失眠和抗精神病药引起的便秘、流口水。一些小样本试验报告了辅助改善，但样本量小、对照组设置不一，重复性有限，目前只能算“可能有益、证据不足”。【研究】

安全性方面，由受过训练、使用一次性无菌针具的医师操作，针灸总体是安全的。常见不适是针刺处酸胀、轻微出血或淤青、头晕。需要警惕的少见风险包括：气胸（胸背部深刺）、感染、断针、晕针、神经损伤。服用抗凝药、血小板低、针刺部位有感染或皮损、装有心脏起搏器（做电针时）的人，需要提前告知医生。

针灸不能用于控制急性兴奋、拒食、木僵或自杀风险。这些情况需要急诊和精神科处理，不能靠“扎几次看看”。

Omega-3 与其他补充剂

补充剂	研究证据	需要注意
Omega-3（EPA/DHA）	辅助治疗研究结果不一致，对阴性症状可能有小幅益处，早期精神病预防的大型试验未显示明确效果	鱼腥味、腹泻；与抗凝药同用可能增加出血风险
N-乙酰半胱氨酸（NAC）	小样本研究，结果混合，部分显示对症状或副作用有帮助	胃肠不适；缺乏长期数据
肌氨酸（sarcosine）等氨基酸类	小样本，个别显示对阴性症状有益	证据有限，不作为常规推荐
维生素 B 族、叶酸	缺乏时补充有意义；不缺乏时额外补充无明确益处	过量并非无害，尤其脂溶性维生素
大麻二酚（CBD）	处于研究阶段，未获批用于治疗精神分裂症	肝酶影响、药物相互作用、产品质量参差
各类“安神”“排毒”中成药	证据弱，成分复杂	肝损伤、掺西药、重金属、与处方药相互作用

需要特别提醒：omega-3 常被宣传成“天然的抗精神病药”，这是夸大。它在辅助治疗中的证据不稳定，不能替代药物，也不能因为“吃了鱼油”就减少复诊。购买时选择正规渠道、看清成分和剂量标识，不要买“三无”产品。

肝损伤、相互作用与不能替代抗精神病药

肝损伤是中药和补充剂最需要警惕的问题之一。何首乌、土三七（含吡咯里西啶生物碱）、雷公藤、某些“减肥茶”“排毒茶”都有肝损伤报告；朱砂（含汞）、雄黄（含砷）等矿物药有重金属风险。早期表现不典型：乏力、食欲差、恶心、尿色变深、皮肤或眼白发黄。出现这些要立即停用并查肝功能，不要当成“上火”。

相互作用同样重要。部分中药和补充剂会影响肝脏代谢酶的活性，从而改变抗精神病药的血药浓度；有的本身可能延长 QT 间期；与抗凝药、降糖药、抗癫痫药同用也可能出问题。你以为在“调理”，实际可能让血药浓度忽高忽低。

为什么不能替代抗精神病药，理由有四条：一是现有证据不足以支持单用；二是急性期的幻觉、妄想、激越需要快速控制，中药起效速度跟不上；三是停药后复发风险很高，一次复发可能让之前几年的努力归零；四是“替代”往往意味着延误，而延误本身就会造成伤害。

如果要尝试，怎么做相对安全

- ☐ 先告诉主治医生，包括方名、成分、剂量、开始时间
- ☐ 选择正规医院的中医科或有资质的医师，不使用来源不明的“偏方”“秘方”

- ☐ 不同时服用多种成分重叠的中成药，避免重复用药
- ☐ 开始后按医生建议复查肝功能，出现乏力、尿黄、黄疸立即停用
- ☐ 不减少、不停用抗精神病药；不减量“试试看”
- ☐ 记录睡眠、排便、情绪、症状变化，复诊时带上
- ☐ 出现皮疹、发热、呼吸困难，立即停药并就医
- ☐ 不购买宣称“根治精神分裂症”“替代西药”的产品

什么时候联系医生 / 去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 皮肤或眼白发黄、尿色像浓茶、呕吐、右上腹剧痛（警惕肝损伤）
- 意识模糊、嗜睡、行为异常、手抖加重（警惕代谢性脑病或药物相互作用）
- 皮疹伴面唇肿胀、呼吸困难（警惕严重过敏）
- 呕血、黑便、剧烈腹痛
- 心悸、晕厥、抽搐

尽快联系医生：

- 乏力、食欲明显下降、恶心持续几天
- 发热、皮疹、淋巴结肿大
- 加用中药或补充剂后，精神症状明显波动
- 睡眠、排便、月经出现新的变化

不要做： 不要自行停抗精神病药“给中药让路”；不要用“护肝片”抵消可能的肝损伤；不要相信“纯天然所以无毒”。

容易踩的坑

“中药没有副作用。” 中药有明确的肝损伤、肾损伤和过敏风险，矿物药还可能有重金属问题。“天然”不等于“安全”。

“西药伤肝，中药护肝。” 抗精神病药确实需要监测肝功能，但不少中药同样伤肝。正确做法是定期查肝功能，而不是用一种药去抵消另一种药的风险。

“针灸能根治幻听。” 目前证据只支持可能的辅助作用，不能替代药物，也不能用于急性期。

“omega-3 是天然的抗精神病药。” 研究结果不一致，不能替代治疗。把它当成可能的辅助，而不是“天然替代品”。

“别人吃这个方子好了，我也试试。” 中医讲究辨证，同一个方不适合所有人；别人的“有效”也可能是安慰剂、自然波动或同时进行的其他治疗。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 8：特殊人群

儿童青少年、老年、孕产期、躯体疾病患者的治疗重点不同。这一模块讲原则，不替代专科面诊。

8.1 儿童青少年精神分裂症

孩子说“有人在我耳边说话”，家长的第一反应往往是害怕，第二反应是“是不是想多了”。在儿童和青少年身上，精神分裂症确实更难认：症状不典型，孩子自己说不清，还容易和发育中的正常想象、孤独症、多动症、双相障碍、创伤反应混在一起。这一页讲三件事：儿童青少年起病有什么特点、为什么必须由儿童精神科做评估、家庭和学校能做哪些具体的事。读完之后，你至少知道下一步该找谁、该带什么材料、哪些情况一刻都不能等。

一、起病越早，表现越不“标准”

精神分裂症在 18 岁前起病只占全部病例的一小部分，13 岁前起病更少见【指南】。男孩的平均起病年龄通常比女孩早一些。也正因为少见，它最容易被漏掉，也最容易被过度诊断。

在真正出现幻觉、妄想之前，常常有一段“说不上哪里不对”的时期：成绩往下掉、不愿出门、和同学断了联系、说话变少、变得多疑、反复琢磨某些古怪的念头、一个人自言自语、个人卫生明显变差。这些表现单独拿出来，都不指向精神分裂症——青春期本身就可能有情绪起伏和退缩。判断的关键不是“有没有怪”，而是**和这个孩子原来的样子比，变了多少、变了多久、功能掉了多少**。

儿童的症状有几个特点：

- **幻觉以听幻觉为主**，可能是简单的声音，也可能是评论他、命令他的声音。
- **妄想内容往往比较简单、不系统**，因为抽象思维还在发育，孩子不一定能把它讲成一个完整的故事。
- **思维紊乱**可能表现为说话跑题、答非所问、逻辑跳跃，容易被当成“表达能力差”。
- **阴性症状**（情感平淡、意志缺乏、言语贫乏）常被误读成“懒”“叛逆”“内向”，而它恰恰最影响长期功能。
- **功能下降**是最可靠的线索之一：原来能自己上学、能完成作业、能和朋友玩，现在做不到了。

需要说明的是，年龄越小，诊断越要谨慎。儿童期短暂的行为异常、想象性伙伴、对黑暗和鬼怪的恐惧，都是发育中的正常现象。医生不会因为孩子说了句“有人跟着我”就下诊断。

二、最难的一步：先把“像”的排除掉

儿童青少年精神分裂症的鉴别范围比成人更宽。下面这张表列出最常见的几种“看起来像”的情况，以及区分的要点。表格只是帮你理解思路，不能拿来自己对照确诊。

容易混淆的情况	相似的地方	关键的区分点
孤独症谱系障碍（ASD）	社交退缩、语言古怪、兴趣狭窄、有时说“听到声音”	ASD 的核心是自幼就存在的社交沟通困难和重复刻板行为；真正的持续性幻觉、成形妄想相对少见
注意缺陷多动障碍（ADHD）	注意力差、成绩下滑、冲动、坐不住	ADHD 没有幻觉妄想；若出现明确的幻听、被害感，需重新评估
双相障碍	情绪高涨或低落、睡眠减少、言行紊乱、可有精神病性症状	双相的关键是**发作性、有明确的情绪高峰或低谷**，精神病性症状多与情绪同步
创伤与解离	听到声音、片段化记忆、发呆、人格解体、情绪爆发	常有明确的创伤史；声音内容多与创伤相关；解离时“失神”而非木僵
强迫症	反复的念头、仪式化行为、怕被污染	强迫观念通常被体验为“自己的”、令人痛苦的，且常伴抵抗
躯体疾病或药物所致	急性起病、意识波动、抽搐、幻觉	癫痫、脑炎、甲状腺问题、某些药物和物质都可引起精神症状，需先查躯体

还有一类必须单独提醒：**急性起病、伴发热、抽搐、口面部不自主运动、意识时清时浊、行为突然变得很乱**，要警惕自身免疫性脑炎等神经系统急症，而不是先当成“精神病发作”。这类情况要去急诊，做腰穿、脑电图、影像等检查，越早处理越好【临床经验】。

三、评估：为什么必须是儿童精神科

儿童青少年精神分裂症的诊断，不能靠一次门诊、一份量表或一段视频。规范的评估通常包括：

- **儿童青少年精神科医生**（或有明确儿童青少年经验的团队）主导，必要时联合儿科、神经科。
- **多次面谈**，用游戏、绘画、观察等方式降低孩子的防御；青少年更需要单独谈一次，问一些不方便当着父母说的事。
- **多方信息**：父母、主要照护者、班主任或心理老师、既往病历。老师看到的“在学校的样子”常常和家长看到的不一样。
- **发育史**：孕期和生产情况、走路说话的时间、早年社交、学习成绩变化、有没有被霸凌。
- **认知与学业测评**、语言评估，用来区分“能力问题”和“症状问题”。
- **躯体检查**：身高体重、心率血压、血常规、肝肾功能、血糖血脂、甲状腺功能、心电图（用药前必做）。

评估之前，家长可以先准备一份材料，能明显提高面诊效率：

- ☐ 症状时间线：什么时候开始、先出现什么、后来怎么变
- ☐ 孩子的原话：他具体说了什么、对谁说的、什么情境下说的（尽量记原话，不要概括）
- ☐ 学校反馈：老师观察到的变化、缺课情况、同学关系

- ☐ 用药与物质：处方药、保健品、咖啡因饮料、电子烟、大麻
- ☐ 家族史：直系亲属中有没有精神疾病、自杀、住院
- ☐ 已有检查：化验、脑电图、影像、心理测评
- ☐ 生活状态：睡眠、饮食、体重变化、月经（女孩）
- ☐ 风险相关：有没有说过不想活、自伤、想伤害别人
- ☐ 近期躯体情况：发热、抽搐、头痛、意识不清

四、药物：孩子不是缩小版成人

儿童青少年需要药物治疗时，原则和成人一致——控制症状、恢复功能、预防复发——但在执行上有明显差别【指南】。

开始得更慢，监测得更密。 医生通常从更低的剂量起步，加量更谨慎，复诊更频繁。这不是“保守”，而是因为儿童青少年的身体和大脑还在发育，耐受性和成人不同。

副作用谱有差异。 儿童青少年对锥体外系反应（手抖、肌肉僵硬、坐立不安、眼球上翻）更敏感；体重增加、血糖血脂异常、催乳素升高也往往更明显，可能影响月经、乳房发育和身高增长。因此用药期间需要定期测体重、腰围、身高、血糖血脂、催乳素，并观察有没有不自主的口面部动作。

氯氮平要特别小心。 它用于难治性病例，效果确切，但儿童青少年使用时的血常规监测、癫痫风险、体重和代谢问题都需要更严格的随访。服药期间出现发热、咽痛、口腔溃疡，必须立即查血常规，不能等到下次复诊。

不要自行停药或减量。 突然停药可能带来失眠、激越、幻觉加重，也会显著增加复发风险。任何调整都应由医生计划。

关于家长最常问的“药会不会影响大脑发育、会不会影响长高”，目前的研究证据有限，结论并不一致【待验证】。正确的做法是把担心告诉医生，一起权衡“不用药的风险”和“用药的风险”，而不是自己把药停掉。

药物之外，家庭心理教育、调整过的 CBTp、社交技能训练、学业支持、认知矫正，都是治疗的一部分。药物控制症状，这些干预帮助孩子重新回到生活和学习里。

五、家庭与学校：把环境变成治疗的一部分

家庭能做的，比“盯着吃药”多得多。

- **不责怪。** 孩子的病不是父母“教育失败”造成的，也不是孩子“不懂事”。责备只会让孩子更隐瞒症状。
- **不争辩幻听的内容。** 说“我没听见，但我相信你很害怕”比“那都是假的”更有用。
- **不纵容。** 该有的作息、家务、边界还是要保留，这本身就是康复的一部分。

- **降低高情感表达。** 持续的批评、指责、过度干涉，与复发风险升高有关【研究】。具体做法是：说具体的事、说自己的感受、给出可执行的请求，而不是贴标签。
- **照顾自己。** 家长的焦虑和耗竭是真实存在的，需要自己的支持渠道。

学校是最容易被忽略的治疗现场。

- 和班主任、心理老师沟通，只讲必要的信息，明确“哪些情况需要通知家长”。
- 争取合理便利：减少同时多任务、允许课间休息、考试延时、安排靠前或安静的座位、允许暂时减少课程。
- 关注霸凌。被孤立、被嘲笑常常是复发的触发因素。
- 复学要渐进，不要一步到位。先半天、再全天；先少量科目、再全科。
- 不要把“能不能上学”当成唯一的康复指标。

六、发育、学业与长期预期

青春期本身就是一场硬仗：要建立身份、要独立、要被同伴接纳。精神分裂症会打断这个过程，但不等于终止它。

学业可以慢，不必断。 休学、延毕、转去职校，都不是失败，而是换一条节奏。认知损害会影响学习效率，需要的是具体支持——拆小任务、延长时限、减少干扰、有人陪着开始——而不是“再努力一点”。

长期预期要诚实，也要留余地。 总体而言，起病越早，长期结局的平均水平越差，但个体差异非常大，不能用统计数字给某一个孩子下判决【研究】。有人需要长期支持，也有人能完成学业、参加工作。

提前规划转衔。 16 至 18 岁是从儿童青少年服务转到成人服务的节点，很多家庭在这个阶段“断档”。提前半年和医生讨论转诊、病历交接、药物续方，能避免复发。

什么时候需要立即联系医生 / 去急诊

- 孩子说想死、想伤害自己或别人，或有具体计划、开始找工具、送东西
- 命令性幻听让孩子去做危险的事（跳下去、打人、不吃药）
- 突然不说话、不动、不吃不喝、维持一个姿势很久、抗拒被移动（紧张症）
- 高热、全身肌肉僵硬、意识模糊、大汗、心跳很快（恶性综合征）
- 服药后出现发热、咽痛、口腔溃疡、明显乏力（尤其氯氮平）
- 突然抽搐、意识时清时浊、口面部不自主运动（需排除脑炎等急症）
- 叫不醒、吞咽呛咳、呼吸困难、误吸

上述情况不要等到下次复诊，夜间和节假日直接去急诊。拿不准算不算严重时，按严重处理。

容易踩的坑

- 把阴性症状当成“懒”“叛逆”，拖了半年才就诊。
- 把学龄前孩子的想象伙伴和幻听混为一谈；正常想象不影响功能，持续存在且伴功能下降才需要评估。
- 一次面诊没拿到“确诊”就换医院，反复重启评估，反而耽误治疗。
- 只盯成绩，忽略社交退缩和情感平淡。
- 家长怕“贴标签”而向学校完全隐瞒，导致孩子在学校得不到任何支持。
- 看到好转就自行减药，几个月后复发。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in children and young people (CG155), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg155
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

8.2 老年精神分裂症

老年精神分裂症不是一个病，而是两种很不一样的情况：一种是从年轻时病过来、带着几十年的病程进入老年；另一种是到了中晚年才第一次出现幻觉、妄想。前者的难点在共病、多重用药和照护，后者的难点在“先排除躯体原因”。这一页按这两条线讲清楚：老年人对抗精神病药为什么更敏感、跌倒和噎食为什么比幻觉更危险、家属在日常照护里最该盯住什么。读完你能判断哪些变化是“老了”，哪些必须马上就医。

一、早发与晚发：两条完全不同的路

早发（年轻时起病，带病进入老年） 的患者，病程往往已经有二三十年。他们的问题通常不是“幻觉很凶”，而是长期积累的结果：阴性症状和认知损害更明显，社会功能退缩，躯体共病多，长期服药带来的锥体外系反应、迟发性运动障碍、体重和代谢问题也都留了下来。很多人由年迈的父母照顾，而父母本身已经需要被照顾。

晚发（中晚年首次起病） 在临床上常指 40 岁以后第一次出现明确的精神病性症状【临床经验】；60 岁以后首次起病有时被称为极晚发。晚发有一些共同特点：女性更多见，症状以偏执、被害感、听幻觉为主，常伴随听力下降、视力下降、独居、社会隔离。感觉被剥夺的人，更容易把模糊的信息解释成“有人在说我”“有人要害我”。

晚发最重要的一条原则是：**先当成“可能有躯体原因”来处理，而不是先当成精神分裂症。** 以下情况都可能表现为幻觉、妄想、行为紊乱：

可能的原因	线索
谵妄（感染、脱水、电解质紊乱、尿潴留、便秘、疼痛、药物）	急性起病、注意力涣散、昼轻夜重、意识时清时浊
痴呆（阿尔茨海默病、路易体痴呆、血管性痴呆）	记忆和定向力下降、视幻觉、认知波动、走路不稳
脑血管病、癫痫	局灶体征、抽搐、突发起病
药物所致	激素、抗胆碱能药、帕金森病用药、部分止痛药、酒精戒断
感官剥夺	听力、视力明显下降，独居，缺少交流

路易体痴呆要单独记住：它对**抗精神病药极度敏感**，用了之后可能出现严重肌肉僵硬、意识障碍、高热，甚至危及生命。所以老年人出现视幻觉、认知波动、走路不稳时，医生会格外谨慎，家属也要主动告知“有没有走路不稳、有没有看到具体的人和动物”。

二、共病与多重用药：真正的风险在这里

老年患者身上很少只有一种病。高血压、糖尿病、冠心病、慢阻肺、慢性肾病、骨质疏松、便秘、前列腺增生、青光眼，往往同时存在，对应着五种以上的药。

多重用药（同时服用多种药物） 会带来三个问题：

1. **抗胆碱能负担叠加。** 抗精神病药、抗抑郁药、膀胱药、晕车药、部分感冒药都有抗胆碱能作用，加在一起会造成口干、便秘、尿潴留、视力模糊、记忆变差、意识模糊。
2. **镇静叠加。** 抗精神病药加安眠药加止痛药，容易导致白天嗜睡、走路不稳、跌倒。
3. **药物相互作用。** 有些药会影响肝脏代谢酶的活性，让另一种药的血药浓度升高或降低。一个具体例子：吸烟会加快某些抗精神病药的代谢，住院期间被迫戒烟后，同样的剂量可能变得“更猛”，出现嗜睡、僵硬【研究】。

实用的做法是**药物重整**：每次就诊带上所有药盒（包括保健品、中成药、外用药），请医生或药师统一看一遍，问三个问题——这个药还需要吗？能不能减？有没有重复？不要自己停，但一定要问。

三、抗精神病药敏感性：老年人为什么“一点点就够”

同样一片药，在 20 岁和 75 岁的人身上，效果和副作用可以完全不同。原因包括：肝脏代谢变慢、体脂比例改变、血浆蛋白减少、大脑受体对药物更敏感、肾脏排泄下降。结果是**同样的剂量，老年人血里的浓度可能更高，作用更强，副作用也更多**。

因此老年用药的基本原则是：**低剂量起始，缓慢加量，用最小的有效剂量维持**【指南】。这不是“敷衍”，而是安全底线。

老年人需要重点监测的副作用：

- **体位性低血压**：从躺到坐、从坐到站时头晕、眼前发黑，是跌倒和骨折的前奏。
- **过度镇静**：白天叫不醒、走路拖步、反应变慢。
- **锥体外系反应**：手抖、肌肉僵硬、走路前冲、坐立不安；老年人更容易出现，且迟发性运动障碍一旦形成可能长期不恢复。
- **吞咽困难**：药物引起的帕金森样症状会影响吞咽，增加呛咳和吸入性肺炎的风险。
- **QT 间期延长与心律失常**：有心脏病基础的人需要定期查心电图。
- **抗胆碱能作用**：便秘、尿潴留、意识模糊，可能直接诱发谵妄。
- **代谢问题**：体重、血糖、血脂仍需监测，不能因为“年纪大了无所谓”就跳过。

氯氮平在老年人身上要格外小心：除了血常规监测不能省，还要特别注意**便秘和肠梗阻、吸入性肺炎、心肌炎**。服药期间出现发热、咽痛、口腔溃疡，立即查血常规。

四、跌倒、噎食、便秘：三个被低估的杀手

对老年患者来说，幻觉很少直接致命，这三件事会。

跌倒。 一次髋部骨折，可能让一个原本能走路的老人从此卧床，随后是肺炎、血栓、压疮。风险来自药物性低血压、镇静、僵硬、视力下降、地面湿滑、夜间起夜、鞋子不合脚。能改的地方很多，见下面的清单。

噎食与吞咽困难。 抗精神病药可能引起吞咽不协调，迟发性运动障碍会影响咀嚼和吞咽，口干会让食物难以下咽。表现为：吃饭时咳嗽、吃完声音变“湿”、反复肺炎、体重下降。要做的不是“劝他多吃”，而是找医生评估吞咽功能。

便秘与肠梗阻。 抗胆碱能作用加上活动少、喝水少、纤维素少，便秘非常常见。危险信号是：腹胀明显、停止排气排便、呕吐、腹痛加重。氯氮平相关便秘可以很严重，不能只靠“多吃香蕉”。

居家安全与照护清单

- ☐ 起夜路线有夜灯，地面无地毯边角、无电线
- ☐ 卫生间有扶手、防滑垫，洗澡有凳子
- ☐ 测过躺着和站起来时的血压
- ☐ 每半年核对一次全部用药，包括保健品
- ☐ 记录每周排便情况，超过三天未排便要处理
- ☐ 吃饭坐直、慢吃、小口，出现呛咳要记录并告诉医生
- ☐ 每年查视力、听力，该配眼镜配眼镜，该配助听器配助听器
- ☐ 家里有人知道紧急联系人、诊断、用药清单放在哪里
- ☐ 独居老人有每日联络机制（电话、邻居、社区）

五、认知：是精神分裂症，还是别的？

精神分裂症本身就会带来注意、记忆、执行功能的损害，到了老年更明显。但**认知突然变差，永远要先排除谵妄**。谵妄是急症，常见诱因是感染、脱水、便秘、尿潴留、疼痛、电解质紊乱、新加的药。它的特点是起病快、注意力涣散、白天晚上不一样、意识时清时浊。处理方法是找病因，而不是加镇静药。

如果是缓慢进展的记忆下降，需要和痴呆鉴别。精神分裂症患者的痴呆诊断更困难，因为基线功能本来就低，家属和医生都不容易发现“又退了一步”。这时候，**知情人提供的日常功能变化**比量表分数更有价值。

六、照护：家庭、机构与边界

老年精神分裂症的照护者，常常是同样年迈的老伴，或者已经五六十岁的子女。照护负担是真实的，不是“不孝”或“不够爱”。

- **服药管理**：分药盒、固定时间、家人提醒；但也要尊重老人尽可能自主的意愿。
- **日常结构**：固定的起床、吃饭、活动时间，比“多休息”更有保护作用。
- **社会连接**：社区随访、日间照料中心、老年活动室；独居是偏执的放大器。

- **机构养老**：不少养老机构对精神疾病患者有顾虑，需要提前实地了解、如实告知，避免入住后被劝退。
- **法律与财务**：监护、遗嘱、财产管理、预立医疗计划，趁老人还能表达时谈。
- **疼痛与临终**：不要因为“他有精神疾病”就低估他的疼痛，镇痛不足在老年患者中很常见。

什么时候需要立即联系医生 / 去急诊

- 突然意识模糊、嗜睡、胡言乱语、认不出人（警惕谵妄）
- 跌倒后头痛、呕吐、嗜睡、一侧无力（警惕硬膜下血肿，老人轻微跌倒也可能发生）
- 发热、咳嗽、气促、精神突然变差（警惕肺炎）
- 腹胀、停止排便排气、呕吐、腹痛（警惕肠梗阻）
- 进食呛咳、饭后声音湿、反复发热（警惕吸入性肺炎）
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗（警惕恶性综合征）
- 胸痛、晕厥、心跳很快或不规则

老年人病情变化快，上午还“只是有点糊涂”，下午就可能危及生命。不要等到第二天。

容易踩的坑

- 把晚发的幻觉当成“老糊涂”，一拖几年。
- 把谵妄当成“精神病加重”，加药之后更糊涂。
- 心内科、内分泌科、精神科各开各的药，没有人统管。
- 因为“年纪大了”就不治疗抑郁、不处理疼痛。
- 感觉“好多了”就自己减药，几个月后复发。
- 忽略听力和视力问题，让偏执有了土壤。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

8.3 孕产期精神分裂症

怀孕这件事，对任何家庭都是一次重新安排生活的过程；对精神分裂症患者来说，它还多了一层难题——药要不要继续吃、停了会不会复发、产后会不会出事。这一页**不推荐任何具体药物**，因为孕期用药没有“标准答案”，只有在具体的人身上比较两种风险。它想帮你弄清楚：孕前该谈什么、治疗与不治疗各自的风险在哪里、产后为什么是最危险的窗口、哺乳到底能不能谈。所有决定都必须由**精神科和产科联合评估**后作出。

一、孕前规划：最好在怀孕之前就开始谈

最理想的时机，是在计划怀孕之前。这时候医生有时间调整方案、观察稳定性，而不是在已经怀孕之后被动应对。

孕前咨询通常要谈这些：

- **目前病情有多稳定**：过去一年有没有复发、有没有住院、症状控制到什么程度。
- **过去的停药史**：这一点非常关键。如果以前停过药，大概多久复发、复发时是什么样子，是判断“能不能减”的重要依据。
- **目前的用药方案**：哪些药、为什么用、有没有可以替代的选择。调整需要时间，不能临时决定。
- **支持系统**：伴侣、父母、能不能有人帮忙夜间照护、经济条件、住在哪里。
- **产科情况**：年龄、既往孕产史、有没有高血压、糖尿病、甲状腺问题。
- **避孕与计划**：如果暂时不打算怀孕，要和医生讨论可靠的避孕方式；意外怀孕往往让所有决定都变得仓促。

有几件事需要提前说清楚：

1. **不要因为准备怀孕就自行停药。** 突然停药带来的复发风险，往往比药物本身的风险更直接、更严重。
2. **怀孕后要尽快告诉精神科医生**，不要等到下次复诊，更不要因为怕被责怪而隐瞒。
3. **补充叶酸、控制体重、戒烟戒酒**，按产科建议做，这些是所有人都适用的基础措施。

二、治疗与不治疗：两端都有风险

这是全篇最需要说清楚的一点：**不存在“零风险”的选项。** 继续治疗有治疗的风险，不治疗有不治疗的风险，医生能做的是在你这个具体的人身上，比较哪一边更重。

不治疗或突然停药的风险包括：病情复发、幻觉妄想加重、判断力下降、营养不良、不规律产检、脱水、睡眠严重紊乱、自伤自杀风险升高、无法照顾自己，以及复发后不得不使用更高强度治疗（包括住院）。复发本身也与早产、低出生体重等不良产科结局相关【研究】。产后更是复发的高危期。

治疗的风险包括：药物通过胎盘影响胎儿、不同药物在孕期的安全性数据多少不一、分娩后新生儿可能出现短暂的适应反应（易激惹、肌张力变化、喂养困难、呼吸偏快），通常需要儿科观察。不同药物的风险差别很大，有些在孕期积累的数据多，有些很少——**具体选哪一种，必须由医生结合你的病史判断，本页不给药名推荐。**

情形	需要重点讨论的问题	风险主要偏向
病情稳定多年、低剂量维持	能否在医生计划下调整，调整后如何监测	停药复发的风险
近一年有复发或住院	维持现有方案，还是换用数据更多的方案	复发与产科结局
多药联合	能否减到最少必要组合	药物相互作用与新生儿反应
意外怀孕、已自行停药	尽快复诊，评估当前症状与恢复治疗的时机	复发与急性期处理
合并物质使用、吸烟	戒烟戒酒的具体支持，以及代谢监测	早产、低出生体重

需要提醒的是，孕期身体变化很大：血容量增加、肝脏代谢改变、胃肠吸收改变，都可能让同样的剂量在体内的浓度和孕前不一样【待验证】。所以孕期不是“处方开完就不管”，而是要更密切地看症状有没有回来。

三、孕期随访：精神科和产科必须同时在场

孕产期精神分裂症的管理，核心是**联合评估**：精神科、产科，必要时加上临床药师、麻醉科和儿科。任何一方单独做决定都不合适。

孕期需要做的事：

- **产检一次都不能少**，而且要把精神科的诊断和用药如实告诉产科。
- **精神科复诊更密**，重点看睡眠、情绪、幻觉妄想有没有回来、有没有停药念头。
- **监测体重、血压、血糖、血红蛋白**，抗精神病药本身会增加体重和血糖异常的风险，叠加妊娠期糖尿病更要留意。
- **提前做分娩计划**：和产科沟通分娩方式、分娩时谁陪同、产后住在什么样的病房、能不能母婴同室、夜间谁来帮忙。
- **新生儿准备**：提前告知儿科医生母亲用了哪些药，让儿科知道要观察什么。

分娩前后，用药怎么衔接、要不要调整，是医生根据分娩方式和进食情况决定的，不属于患者自己能判断的范围。家属能做的是：把药盒带上、把问题记下来、把医生的交代记清楚。

孕产期就诊准备清单

- ☐ 精神科用药清单：药名、剂量、一天几次、谁开的
- ☐ 最近一次精神科病历或出院小结
- ☐ 过去复发的记录：时间、诱因、当时的表现

- ☐ 产科检查本和最近的化验单
- ☐ 近两周的睡眠与情绪记录（每天睡几小时、有没有异常）
- ☐ 能陪诊的人、能夜间轮班的人，各写两个名字和电话
- ☐ 产后住在哪里、谁来帮忙，提前定好
- ☐ 对哺乳的初步想法，以及想向医生问的问题

四、产后：风险最高的时间窗

如果问孕产期哪个阶段最危险，答案是**产后**。产后精神病（分娩后出现的严重精神障碍，表现为情绪剧烈波动、失眠、言语混乱、幻觉妄想、行为异常）起病往往很急，多数在产后两周内出现，是需要立即处理的精神科急症【指南】。有精神分裂症或双相障碍病史的人，风险明显更高。

产后复发的早期信号常常被当成“当妈妈累的”：

- 连续几晚完全不睡，但看起来还很“精神”
- 话突然变多、想法跳来跳去、别人听不懂
- 情绪在极度兴奋和极度低落之间剧烈摆动
- 出现幻觉、被害感、觉得孩子被掉包或“不是自己的”
- 对孩子表现出异常的想法，或说自己“不配当妈妈”
- 行为混乱：半夜出门、反复清洗、拒绝喂养

这些都不是“矫情”，也不是“不合格的母亲”，而是需要治疗的症状。

保护睡眠是治疗的一部分。 产后睡眠剥夺是复发的重要触发因素。夜间喂奶、换尿布由伴侣或家人轮班，让患者能有一段连续睡眠，这不是“帮忙”，而是防复发措施。

前六周尽量不要让患者长时间独处带婴儿。 家里要有人，能观察、能搭手、能在情况变化时立刻行动。如果出现伤害自己或孩子的念头，要立刻说出来，告诉医生——说出来不会被评判，隐瞒才会让事情变糟。早期干预的效果，远远好过拖到失控。

五、哺乳：可以谈，但不是“全或无”

“吃药就不能喂奶”是一个过于简单的说法。多数药物会少量进入乳汁，但量和影响因药而异；真正需要权衡的，是药物、婴儿情况、母亲的睡眠和支持系统。

可以和医生一起讨论的问题：

- 目前这个方案在哺乳期有多少数据？有没有更合适的选择？
- 宝宝是足月还是早产？有没有特殊情况需要儿科评估？
- 如果哺乳，怎么观察宝宝（嗜睡、吃奶费力、体重增长慢、肌张力异常）？
- 能不能部分哺乳、泵奶和配方奶混合？很多家庭是这样过渡的。

- 如果决定不哺乳，怎样减少涨奶和情绪落差？

  几个原则：

1. **不要为了哺乳自行停药。** 停药复发的代价，往往比哺乳方式的选择大得多。
2. **不要为了“必须全母乳”硬撑。** 混合喂养、配方奶喂养都是合理选择，母亲的状态本身就是婴儿安全的一部分。
3. **决定要由精神科、产科、儿科一起做**，并写进病历，下次复诊能接上。

六、给家属：你能做的具体的事

- **陪诊**：孕产期的复诊次数多，尽量有人陪同，帮忙记医嘱。
- **夜间轮班**：把“让她睡够”当成一项治疗任务来安排。
- **记录**：睡眠时长、情绪变化、异常言语、用药情况，复诊时给医生看。
- **不评判**：产后说“我撑不住了”“我不想活了”“我害怕孩子”，需要的是立刻回应，不是“你想太多了”。
- **留意家暴**：孕期和产后是家庭暴力高发期，如果存在，要先保证安全，寻求外界帮助。
- **接受帮助**：父母、朋友、社区资源，能用就用。照护者的耗竭，会直接影响患者和婴儿。

> **什么时候需要立即联系医生 / 去急诊**
>
> - 产后出现严重失眠、情绪剧烈波动、言语混乱、幻觉、行为异常
> - 出现伤害自己或孩子的念头、计划，哪怕只是一闪而过
> - 孕期出现自杀念头、自伤行为
> - 严重呕吐、完全不能进食、明显脱水、体重快速下降
> - 血压升高伴头痛、视物模糊、水肿（警惕子痫前期）
> - 胎动明显减少、阴道出血、破水、剧烈腹痛
> - 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗（警惕恶性综合征）
> - 新生儿嗜睡叫不醒、吃奶无力、呼吸快、体温异常
>
> 产后精神病的起病可以非常快，几小时内从“有点不对劲”发展到严重混乱。不要观察一晚再说，直接去急诊或拨打 120。

容易踩的坑

- 一发现怀孕就自行停掉所有药，几周后复发。
- 怕被医生责怪，隐瞒怀孕或隐瞒服药。
- 只挂产科，不告诉产科自己在吃精神科药。
- 把产后连续失眠当成“正常的辛苦”。
- 认为“吃药就一定不能喂奶”，或反过来“为了喂奶硬扛不吃药”。
- 产后让患者长时间独自带娃，没有观察者。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

8.4 躯体疾病与物质使用共病

精神分裂症患者的日子，往往不是被幻觉拖垮的，而是被血压、血糖、体重、肝脏和烟酒一点点拖垮。研究一致显示，这一人群的平均寿命比一般人群短约十到二十年，主要死因是心血管疾病，而不是精神疾病本身【研究】。这一页讲四件事：为什么躯体病容易被漏掉、心血管和糖尿病要怎么盯、肝病和物质使用怎么处理、药物相互作用有哪些坑。读完你会知道，下一次复诊该主动说什么。

一、为什么共病是主线，不是附加题

躯体疾病在这一人群里更容易被漏诊，原因很具体：

- **诊断遮蔽。** 一个人说胸闷、乏力、吃不下饭，如果病历上写着“精神分裂症”，很容易被归因为“焦虑”“药物副作用”“想多了”，而不是去查心脏、查血、查肝。
- **症状表达不同。** 阴性症状让人话少、不主动诉说；认知损害让人记不住什么时候开始不舒服；对疼痛的阈值和描述也可能不同。
- **就医延迟。** 怕被贴标签、怕麻烦、经济困难、交通不便、没人陪，都会让“再等等”变成“拖到很重”。
- **生活方式。** 吸烟率高、活动少、饮食结构差、体重增加，这些是长期服药和疾病本身共同造成的，不是“不自律”。
- **医疗碎片化。** 精神科看精神科，内科看内科，两个病历互不相通，没人对整体负责。

所以第一条原则是：**躯体症状要按躯体症状去查。** 不能因为“他有精神分裂症”，就把新出现的心慌、消瘦、腹痛、发热都解释成精神问题。反过来也一样：不能因为“他只是焦虑”，就漏掉真正的心肌梗死。

二、心血管与代谢：最值得盯的一块

抗精神病药，尤其是部分二代药物，会引起体重增加、血糖升高、血脂异常，这是明确的风险【指南】。叠加吸烟、活动少、饮食不规律，代谢综合征非常常见。

问题	为什么容易漏	要盯什么
体重与腹型肥胖	逐渐增加，衣服变紧才被发现	体重、腰围、体重指数，每次复诊记录
糖尿病	多尿、多饮被当成“喝水多”；口渴被当成口干副作用	空腹血糖、糖化血红蛋白，有风险者每年查
血脂异常	完全没有感觉	血脂四项，至少每年一次
高血压	头晕被当成药物副作用	每次测血压，家庭自测更好
心律失常与 QT 延长	心慌、晕厥被忽略	心电图，尤其合并心脏病或多种药物时
吸烟	被当成“他的自由”	吸烟量、戒烟意愿，戒烟时药物浓度会变

吸烟是最大的可干预因素。 它不仅伤血管，还会加快某些抗精神病药的代谢，让血药浓度偏低。反过来说，住院期间被迫戒烟，或者自己突然戒烟，同样的剂量可能变得“更猛”，出现嗜睡、僵硬——这时候需要的是找医生监测，而不是自己减药。

体重和血糖的管理，不是“少吃点”三个字能解决的。需要具体方案：固定三餐、减少含糖饮料、每周有计划的走路、把它变成家庭共同的事。有条件的话，代谢门诊或营养科能帮上忙。

三、肝病与肾病：药物代谢的“底盘”

肝脏负责代谢大多数抗精神病药，肾脏负责排泄。这两个器官出问题，药物的浓度和副作用都会变。

脂肪肝在这一人群里很常见，和体重增加、糖尿病、饮酒有关。多数人没有症状，靠体检的肝功能或腹部超声发现。**病毒性肝炎**（乙肝、丙肝）需要单独筛查，因为它们会悄悄进展。**酒精性肝病**则和饮酒量直接相关。

肝功能不好时，医生可能需要调整方案、减少种类、增加监测。这些都必须由医生判断，患者能做的是**如实告知**：喝了多少酒、有没有肝炎史、在吃什么保健品和中成药。

肾病同样重要。肾功能下降会影响药物排泄，也会影响降糖药、降压药的选择。定期查肌酐、尿常规，是最基本的。

需要警惕的信号：皮肤或眼白发黄、尿色像浓茶、明显乏力、腹胀、下肢水肿、牙龈容易出血。出现这些不要等下次复诊。

四、物质使用：大麻、酒精、兴奋剂

大麻。 它不是“天然就无害”。大麻中的 THC 可以诱发或加重精神病性症状，与复发、起病更早、病情更重相关【研究】。尤其是高浓度产品、青少年期开始使用、有家族史的人，风险更高。有人用大麻“缓解焦虑”或“帮助入睡”，短期可能觉得有效，长期往往让睡眠更乱、动力更差、症状更难控制。戒断时会有烦躁、失眠、食欲下降，通常几天到两周缓解，但需要有人支持。

酒精。 它和抗精神病药叠加会加重镇静、影响平衡、增加跌倒和噎食风险；长期大量饮酒伤肝、伤心肌、升高血压、恶化睡眠，也会显著提高自杀风险。更危险的是**酒精戒断**：突然停酒可能出现手抖、大汗、心跳加快、幻觉、抽搐，严重时危及生命，这是急症，不能在家硬扛。

兴奋剂（冰毒、可卡因等）可以直接引起幻觉、被害感、激越，也会带来胸痛、心律失常、抽搐、高热。用它“提神”或“对抗药物带来的困倦”，往往越用越糟。

处理物质使用的原则有三条：

1. **整合治疗。** 精神科和成瘾治疗在同一个团队、同一份计划里进行，而不是“先戒了再来治精神科”。【指南】

2. **不评判。** 指责会让人隐瞒使用，而隐瞒比使用本身更危险。
3. **减少伤害。** 不一定一次全戒，可以先减量、先换低风险方式、先处理最危险的部分。【临床经验】

五、药物相互作用：你必须主动说的事

很多“药效不对”其实是相互作用造成的。以下几类最常被忽略：

- **圣约翰草**（一种常见的“天然抗抑郁”保健品）：会明显加快多种药物代谢，可能让抗精神病药浓度下降、症状回来。
- **西柚（葡萄柚）汁**：会抑制某些代谢酶，让部分药物浓度升高，副作用加重。
- **吸烟与戒烟**：影响某些药物的代谢速度，变化时症状或副作用可能波动。
- **抗酸药、铁剂、钙剂**：可能影响药物吸收，通常需要错开时间，具体问医生或药师。
- **酒精、镇静催眠药、止痛药**：叠加镇静，增加跌倒、噎食、呼吸抑制风险。
- **多种抗精神病药联用**：不是绝对不行，但需要医生明确理由并加密监测。

最实用的做法是准备一张**用药清单**，随身带着，每次就诊拿出来：

- ☐ 所有处方药：药名、剂量、一天几次、谁开的
- ☐ 所有非处方药：感冒药、止痛药、胃药、安眠药
- ☐ 所有中成药和保健品：名字、成分、吃了多久
- ☐ 咖啡、浓茶、能量饮料每天大概多少
- ☐ 吸烟量、饮酒量、有没有用大麻或其他物质
- ☐ 最近停掉或换掉的药，以及为什么

六、整合治疗：一个人、一个团队、一份计划

共病管理最怕的不是病多，而是“没人负责”。理想的状态是：精神科医生知道你的血压和血糖，内科医生知道你在吃抗精神病药，药师帮你核对相互作用，社区护士或个案管理师帮你约到号、提醒复查。

现实里不一定有这么完整的团队，但可以主动做几件事：

- 固定在一家医院或一个医疗联合体内就诊，让病历能互通。
- 每年做一次完整体检：血压、体重腰围、血糖血脂、肝肾功能、心电图、尿常规。
- 把精神科诊断和用药如实告诉每一位接诊医生，包括牙科和急诊。
- 复诊时带上用药清单和最近的化验单。
- 家属陪着去，帮忙记、帮忙问。

什么时候需要立即联系医生 / 去急诊

- 胸痛、胸闷伴出汗、恶心、左肩或下颌放射痛：立即拨打 120

- 突然一侧肢体无力、口角歪斜、说话不清、视物成双：立即拨打 120（警惕卒中）
- 极度口渴、多尿、恶心呕吐、呼吸有烂苹果味、意识模糊（警惕高血糖酮症）
- 心慌、手抖、出冷汗、意识不清（警惕低血糖）
- 皮肤眼白发黄、呕血、黑便、腹胀明显
- 突然停酒后手抖、大汗、心跳很快、看见不存在的东西、抽搐（酒精戒断，立即急诊）
- 使用兴奋剂后胸痛、高热、抽搐、极度兴奋
- 药物过量或多种药物混合服用

以上情况不要先观察，也不要先联系精神科门诊，直接去急诊或拨打 120。

容易踩的坑

- 把胸闷、气短一律当成“焦虑发作”。
- 把多尿、多饮当成“最近喝水多”，拖到血糖很高才发现。
- 认为大麻“天然、无害、能助眠”。
- 怕被说“不配合”而隐瞒饮酒或吸毒。
- 自行买“护肝片”“保肾丸”，结果影响药效。
- 精神科和内科各看各的，没人统管。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 9：风险管理

精神分裂症的风险不止“暴力”。自杀、紧张症、恶性综合征、噎食和药物急症同样致命。

9.1 自杀风险

自杀是可以被问出来、被说出来、被干预的。很多人以为“不问就没事”“问了反而提醒他”，事实恰恰相反：一个被认真问过、被认真听过的人，往往更容易开口求助。这一页讲五件事：哪些因素会让风险升高、怎么直接把话问出口、风险怎么分级、安全计划怎么写、家里的危险物品怎么处理。它写给患者，也写给想知道“我该怎么接话”的家属。

一、先破除一个误解：问了不会“教坏”他

“直接问会不会给他一个念头？”这是家属最常有的担心。目前的证据是：**平静、直接地询问自杀想法，不会增加自杀风险，反而常常带来缓解**【研究】。因为很多人不是“不想说”，而是“不知道怎么说”“怕吓到别人”“怕被当成威胁”。

真正危险的是另一种沉默：所有人都察觉到不对劲，但没人敢开口，最后在事后说“早知道就问了”。

需要说清楚的是：问出来，不等于你能独自解决。你的任务不是“说服他别死”，而是**知道情况有多严重，然后把他带到能处理的人面前**。

二、风险因素：找那些“可以改”的部分

风险因素不是算命。它的用处是帮你判断“现在该多紧张”，以及哪些环节可以动手改。

类别	具体因素
疾病相关	合并抑郁、绝望感、命令性幻听、严重被害妄想、自知力差、近期复发或刚出院
既往史	曾经自杀未遂（尤其近期、方式致命）、家族中有自杀史
物质使用	大量饮酒、使用大麻或其他物质、混合使用
社会因素	独居、失业、经济困难、亲密关系破裂、丧亲、被歧视或霸凌、刚经历羞辱性事件
治疗相关	刚换药或加药、治疗中断、对治疗失望、缺乏随访

有几个时间点要特别留意：**出院后的头几周、刚被诊断时、复发前后、重要关系破裂后、法律或经济危机中**。这些时候风险会集中升高。

保护因素同样真实：稳定的家庭支持、还愿意看的医生、对孩子的责任感、宗教信仰、还有没完成的事、怕痛苦。它们不能“抵消”风险，但能争取时间。

三、怎么直接问：从轻到重，一层层往下

不要一上来就问“你是不是想自杀”，也不要问“你不会想不开吧”——后者等于给了他一个“应该否认”的台阶。

可以这样开口：

> “我注意到你最近很少说话，晚上也睡不好。我想直接问你一件事，因为我在意你：你有没有觉得，活着没什么意思？”

然后根据回答往下走，一层一层来：

1. **有没有消极念头：**“有没有想过，要是睡过去不醒就好了？”
2. **有没有自杀想法：**“有没有想过结束自己的生命？”
3. **有没有计划：**“有没有想过具体怎么做？”
4. **有没有准备：**“有没有准备东西、选地方、选时间？”
5. **有没有行动：**“最近有没有做过什么，或者开始安排后事？”

问的时候记住几点：

- **平静。** 不要惊呼、不要哭、不要立刻说教。你的表情越稳，他越敢说。
- **具体。** 问“什么时候”“用什么方式”“当时在想什么”，比问“你为什么”更有用。
- **不评判。** 不说“你怎么这么自私”“你还有孩子”“想想你爸妈”。
- **不承诺保密。** 如果涉及生命安全，你需要告诉医生和能帮忙的人。可以提前说：“如果我知道你有危险，我会告诉医生，因为我不想失去你。”
- **记录下来。** 时间、原话、当时的情境，复诊时告诉医生。

四、风险分级：不同级别，不同动作

分级不是为了贴标签，而是为了决定“今晚能不能回家”。

级别	大致表现	该做什么
低	偶尔有“活着没意思”的念头，没有计划，能自我调节，有支持	尽快看门诊，写安全计划，加密随访，处理诱因
中	经常有自杀想法，有模糊计划但没准备，情绪冲动	尽快精神科评估（当天或次日），家属陪伴，限制手段，考虑住院
高	有明确计划、已做准备、近期尝试过、命令性幻听让他去死、极度绝望或激越	立即去急诊或拨打 120，不要独处，不要让他开车
极高	正在实施、已服药、已割伤、已站在高处	立即拨打 120 和 110，现场急救，不要独自搬动

判断时宁可往上靠一级。**“拿不准”本身就是需要专业评估的理由。**

五、安全计划：写下来，比记在心里有用

安全计划不是“保证不自杀”的承诺书，而是一张“当念头来了，我按顺序做什么”的路线图。可以和他一起写，写在一张纸上，放在他看得到的地方。

- ☐ **第一步：我的预警信号**（比如连续两晚睡不着、开始送东西、反复听某个声音）
- ☐ **第二步：我自己能做的事**（洗冷水脸、出门走十分钟、听固定的歌单、写下念头）
- ☐ **第三步：能让我分心的人或地方**（朋友、便利店、公园、宗教场所）
- ☐ **第四步：我可以打电话的人**（写具体名字和号码，至少两个）
- ☐ **第五步：专业帮助**（精神科门诊电话、急诊地址、12356 心理援助热线）
- ☐ **第六步：让环境更安全**（把药、刀、绳索、农药收起来，具体做法见下面的“手段限制”）

这份计划要**定期更新**，复诊时带给医生看。人在急性期写不出来，可以等稍微稳定一点再一起补。

手段限制：最有效、也最容易被跳过的一步

自杀冲动往往不是持续几天，而是几分钟到几小时的“窗口期”。把致命手段挪远一点，就能把这个窗口拖过去。

- **药物**：由家属保管，按次给；家里不留大量存货；过期药及时处理。
- **刀具、剪刀、绳索、皮带**：收进上锁的抽屉。
- **农药、消毒剂、清洁剂**：锁起来，不要放在阳台或厕所。
- **高处**：窗户装限位器，阳台门加锁；不要让他独自去天台、楼顶。
- **煤气、炭**：注意通风和阀门。
- **车钥匙**：高风险期由家人保管。

这些做法可能让他觉得“被监视”“不被信任”。可以这样解释：“这不是因为我不信你，是因为我想让你在难受的那几个小时里，多一点时间。”【临床经验】

六、家属怎么接话：能说的和别说的

可以说	尽量别说
“我不知道该说什么，但我在这儿。”	“你想开点就好了。”
“你现在很难受，我想听你多说一点。”	“你还有孩子、父母，你不能这样。”
“我不会因为这个看不起你。”	“你怎么这么脆弱。”
“我们一起去找医生，我陪你去。”	“你要是敢做，我就……”
“我需要告诉医生，因为我怕失去你。”	“我保证不告诉任何人。”（做不到的承诺）

还有几句是家属自己需要听到的：

- 他自杀，不是因为你不够好。精神疾病会让人产生“没有出路”的感觉，那是症状的一部分。
- 你可以害怕、可以崩溃、可以找人帮忙。照护者也需要支持。
- 你不需要一个人扛。把亲友、社区、医生拉进来。

什么时候需要立即联系医生 / 去急诊

- 明确说想死，或说“我准备好了”“这是最后一次见你”
- 有具体计划、时间、地点、方式
- 正在做危险的事：已服药、已割伤、站在高处、开着煤气
- 开始送东西、写遗书、交代后事、突然异常平静
- 命令性幻听让他去死，或坚信自己该死
- 严重失眠、极度激越、完全不吃不喝
- 刚出院、刚失恋、刚失业后的几天内出现明显变化

出现以上任何一条：不要让他独处，不要让他开车，移除身边的危险物品，立即拨打 120 或去最近医院急诊；现场有危险时拨打 110。也可以拨打 12356 心理援助热线。

容易踩的坑

- 觉得“问了会提醒他”，于是谁都不问。
- 听到“我不想活了”就急着讲道理、举例子、说别人更惨。
- 答应“绝对不告诉别人”，结果自己扛不住。
- 只盯着“有没有说想死”，忽略“开始安排后事”“突然变平静”。
- 家里药箱、农药、刀具完全不设防。
- 出院后觉得“医院都治好了”，随访松懈。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

9.2 暴力风险评估

先说结论：**大多数精神分裂症患者并不暴力，他们更常见的身份是暴力的受害者，而不是加害者。**但也不能走到另一个极端，说“患者绝不会伤人”——在少数具体情境下，风险是真实存在的，而且往往发生在家里，受害者常常是最亲近的家属。这一页把暴力风险拆成“情境”来讲：哪些症状、哪些状态、哪些环境会让风险升高，怎么把它降下来，什么时候必须打 110 或 120。

一、先把事实放回原位

媒体喜欢把精神疾病和暴力绑在一起，这造成两个后果：患者被整体污名化，家属在真正遇到危险时又不敢相信自己的判断。

需要同时成立的两句话是：

- **诊断本身不是暴力预测器。** 仅仅因为一个人有精神分裂症，无法推断他会不会伤人。绝大多数患者终其一生都没有严重的暴力行为【研究】。
- **某些症状和情境确实与风险升高相关。** 命令性幻听、被害妄想、物质使用、治疗中断、急性激越，这些才是需要盯住的东西【指南】。

所以正确的说法不是“他是个危险的人”，而是“**他现在处于一个风险升高的状态**”。状态会变，治疗能改变它，环境也能改变它。这就是为什么这一页讲“风险因素与情境”，而不是给人贴标签。

二、风险升高的情境

下面这张表列的是临床上最需要警觉的组合。单独一条不等于会出事，但几条叠在一起，就要提高警惕。

情境	为什么风险升高	现场能观察到什么
命令性幻听	声音命令他去伤害某个具体的人，他可能认为必须服从	侧耳倾听、自言自语、突然盯着某人、说“我知道了”
被害妄想	坚信某人要害自己或家人，可能“先下手为强”	反复检查门窗、跟踪、收集“证据”、点名某个人
被控制感	觉得身体或想法被别人控制，反抗的冲动强	说“我的手不听我的”“有人在操控我”
急性激越	情绪失控、判断力下降、一点刺激就爆	来回踱步、大声、摔东西、握拳、脸涨红、说话越来越快
物质使用	酒精、冰毒、可卡因直接降低自控、放大冲动	最近大量饮酒、熬夜、瞳孔变化、言语混乱
治疗中断	症状反弹，自知力下降，没人能劝	自己停药、拒诊、躲着家人
既往暴力史	是预测未来暴力最强的因素之一	过去打过人、砸过东西、被报警过
环境压力	拥挤、噪音、被围堵、被强迫、当众羞辱	多人围着、有人拍摄、有人指指点点
武器可得性	冲动时手边有什么，决定后果有多重	家里有刀、棍、工具、枪支

还有两个容易被忽略的点：

风险常常发生在家里。 同住意味着高频接触、日常摩擦、照护疲劳，也意味着对方最了解你的作息和弱点。

风险会随治疗变化。 同一个人，在急性期和稳定期可以是完全不同的状态。所以评估要看“最近几天”，不是看“他这个人”。

三、怎么把风险降下来

先改环境，再谈说服。 人在激越时听不进道理，讲道理往往火上浇油。

- **减少刺激**：关掉电视和音乐，让围观的人散开，把孩子和老人带到另一个房间。
- **保持距离**：至少一臂半的距离，站在门口一侧，不要堵住他的出口，也不要让他觉得被逼到墙角。
- **不要突然靠近、不要从背后接近、不要伸手去抢东西。**
- **说话方式**：低声、慢速、短句，先叫他的名字，承认他的感受——“我知道你现在很害怕，或者很生气”。
- **不争辩妄想内容。** 不说“根本没人害你”，而说“你觉得有人要害你，所以你这么紧张”。
- **给选择，给时间。** “你想先坐下喝口水，还是我陪你去阳台站一会儿？”有选择感，冲动会下降。
- **不要多人围堵。** 三四个人一起上前，几乎一定会激发挣扎，也可能伤到所有人。
- **不要用空头威胁。** “你再这样我就报警”要么别说了，要么真的准备报警。说了不做，只会让他知道威胁没有后果。
- **移除手边的危险物品**：刀、剪刀、玻璃杯、工具、热水。做这件事要在他不注意时、由两个人配合，不要当面抢夺。

长期来看，降低风险靠的是：规律服药、治疗物质使用、家庭干预、减少高情感表达、有稳定随访。这些比任何“临场话术”都管用。

现场降温清单

- ☐ 让无关的人离开，尤其孩子和老人
- ☐ 关掉电视、音乐，降低噪音
- ☐ 自己先深呼吸，语速放慢，音量压低
- ☐ 站在出口附近，保持一臂半的距离
- ☐ 叫他的名字，说一句承认情绪的话
- ☐ 不提“你有病”“你疯了”“你吃药了没”
- ☐ 不争辩幻听和妄想的内容
- ☐ 给两个具体、可执行的选择
- ☐ 手边危险物品已移开，或至少不在他伸手可及处

- ☐ 已经想好：如果升级，谁打电话、打给谁、从哪里撤离

四、什么时候打 110、什么时候打 120

情形	打哪个	电话里说什么
已经动手打人、持械、砸东西，或威胁要伤害具体的人	110	地址、人数、有没有武器、有没有人受伤、他现在的状态
有明确对象、明确方式，正在去找对方	110	同上，并说明他可能有精神疾病、是否在服药
已经受伤、流血、昏迷、抽搐	120（必要时同时 110）	伤情、意识、呼吸、地址
自伤、服毒、高处危险	120（现场有危险时 110）	物品、时间、量、意识状态
木僵、拒食、高热、肌肉僵硬	120	体温、意识、四肢僵硬、多久没吃没喝
只是言语威胁，还能对话，没有武器	先联系精神科医生或社区随访，同时保持警戒	不要独自处理，告诉医生具体说了什么

关于报警，有两件事需要说清楚：

1. **报警不是“毁了他”。** 警察到场可以协助控制局面、协助送医，很多地方有警医联动机制。真正危险的时候，安全优先于“家丑不可外扬”。
2. **报警时如实说明病情。** 是否在服药、最近有没有停药、有没有喝酒、以前有没有打过人。这些信息能帮助现场人员判断，而不是让他被当成“普通闹事者”。

法律上，精神障碍患者的刑事责任能力要由司法鉴定判断，不是家属或警察现场说了算。这一页不展开，具体见11.3 精神卫生法与权益。

五、事后：不羞辱、不“算账”、不装作没发生

风波过去之后，最伤人的往往不是事件本身，而是之后的处理方式。

- **不要在事后反复说“你刚才多可怕”“你差点打死我”。** 羞辱会加重病耻感，也会让他下次更隐瞒症状。
- **记录触发点**：之前发生了什么、他说了什么、有没有喝酒、有没有停药。复诊时带给医生。
- **把安全计划补上**：家里哪些东西要收、紧急时谁打电话、孩子去哪里。
- **该谈的责任要谈**：造成的损失、邻居的投诉、可能的赔偿，可以等稳定后再谈，但不能永远不谈。
- **家属自己的伤也要处理**：被推倒、被掐、被威胁，都是真实的伤害，不是“他病了所以不算”。

六、给家属和邻居：保护自己不是背叛

如果你正和一位有精神分裂症的家人同住，请记住：

- 你有权利保护自己的人身安全，这不叫“抛弃他”。
- 不要独自面对一个持械或明显失控的人。先撤离，再求助。
- 不要因为“他是病人”就长期忍受暴力。长期容忍会让风险累积，也会拖垮整个家庭。

- 邻居如果被卷入，不需要知道诊断细节，只需要知道“现在不安全，请帮忙报警”。

什么时候需要立即联系医生 / 去急诊

- 正在打人、掐人、持械、砸东西，或明确说要杀某个人
- 命令性幻听命令他伤害自己或别人
- 坚信家人要害他，已经开始“反击”或跟踪
- 出现激越升级：摔东西、砸门、脸涨红、说话越来越快、无法对话
- 合并大量饮酒或使用兴奋剂后行为失控
- 有人受伤、流血、昏迷、抽搐
- 木僵、拒食、高热、肌肉僵硬（可能是紧张症或恶性综合征）

现场已经失控时，先撤离到安全位置，再拨打 110；有人受伤或意识不清，同时拨打 120。不要试图独自制服一个成年人，也不要让儿童留在现场。

容易踩的坑

- 为了“反污名”而否认一切风险，结果家属毫无准备。
- 因为一次激越，就给患者贴上“危险分子”的标签，一辈子翻不了身。
- 围观、拍摄、激将、说“你敢吗”，把冲突推向升级。
- 用“报警”当口头威胁，却从不真的行动。
- 认为“病人打人不用负责”，于是不做任何防范。
- 事后羞辱、翻旧账，让他下一次更不敢说自己的症状。

参考来源

- NICE. Violence and aggression: short-term management in mental health, health and community settings (NG10), 2015. https://www.nice.org.uk/guidance/ng10
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

9.3 紧张症与恶性综合征

有两种情况，看起来像“不配合”“闹脾气”“感冒发烧”，实际上都是能在几小时到几天内危及生命的急症：一种是紧张症，人不动、不说、不吃；另一种是恶性综合征，人高热、全身僵硬、意识不清。这一页讲怎么认出它们、家属在现场能做什么、为什么不能强行喂饭、什么时候必须立刻叫救护车。读完请记住一句话：**这两件事都不属于“观察一晚再说”的范围。**

一、紧张症：不是“不想动”，是动不了

紧张症（catatonia）是一组以“精神运动紊乱”为核心的综合征。它不是一种独立的病，可以出现在精神分裂症、双相障碍、严重抑郁里，也可以由躯体疾病、感染、代谢紊乱、药物引起【指南】。它的本质不是“懒”或“赌气”，而是大脑调节动作和言语的系统出了问题。

典型表现有：

- **木僵**：长时间不动、不说话，对外界刺激反应明显减少。
- **缄默**：能发声却不说话，或只说单词。
- **拒食**：不张嘴、含着不咽、把食物吐出来，可能导致脱水和营养不良。
- **蜡样屈曲**：你抬起他的手臂，他会像蜡一样保持这个姿势很久。
- **违拗**：抗拒指令，或者做出完全相反的动作（让他张嘴，他闭得更紧）。
- **刻板动作、作态、模仿言语、模仿动作**：反复做同一个动作，重复别人的话。
- **凝视**：长时间盯着一个点，眼神空洞。
- **兴奋型**：另一种表现是突然极度兴奋、无目的地乱动、喊叫、自伤，同样危险。

紧张症的危险不只是“不吃不喝”。长期不动会增加**下肢静脉血栓**和**肺栓塞**的风险，也会带来压疮、吸入性肺炎、脱水、电解质紊乱。兴奋型则可能造成自伤、伤人、衰竭。所以它需要**急诊精神科评估**，不是“等他有精神了再说”。

二、家属能看到的信号：一张对照表

你看到的现象	可能意味着什么	该怎么做
一天大部分时间不动、不说，叫名字反应很弱	木僵	记录持续时间，尽快联系精神科；伴发热立即急诊
保持一个姿势很久，摆他手臂也不抵抗、不恢复	蜡样屈曲	拍照或录像给医生看，尽快就诊
不张嘴、含饭不咽、体重下降	拒食，有脱水风险	不要强行喂，记录进食量和尿量，尽快就医
让他做什么都反着来，或完全不动	违拗	不要对抗、不要责骂，减少指令，尽快评估
突然极度兴奋、乱抓乱咬、喊叫	兴奋型紧张症	保证安全，移开危险物品，呼叫 120
发热、出汗、心跳很快、四肢僵硬	可能是恶性综合征	立即停药并拨打 120

你看到的现象	可能意味着什么	该怎么做
意识时清时浊、抽搐、口面部不自主运动	可能是脑炎、癫痫等器质性疾病	立即急诊，不要先按精神病处理

送医前，先记下这几件事

- ☐ 从什么时候开始不说话、不动，或者开始拒食
- ☐ 最后一次进食、喝水是什么时候，大概多少
- ☐ 有没有发热，最高多少度，什么时候开始
- ☐ 有没有大汗、心跳很快、呼吸急促
- ☐ 四肢是软的还是硬的，活动时有没有抵抗
- ☐ 有没有抽搐、意识不清、认不出人
- ☐ 最近有没有换药、加量、停药，或者自行吃过什么药
- ☐ 有没有排尿、排便，肚子胀不胀
- ☐ 用手机拍一段短视频，记录姿势、动作和说话情况，给医生看

三、紧张症的紧急处理：家属能做的和不能做的

能做的：

- **记录**：从什么时候开始不动、多久没吃没喝、有没有发热、最近有没有换药或停药、有没有抽搐。这些信息对医生非常有用。
- **尽快送急诊精神科**，或者联系精神科医生安排住院评估。拒食超过一天、完全不喝水、出现发热，直接去急诊。
- **保持安全**：清空床边的尖锐物品，防止跌倒，兴奋型时让儿童离开。
- **基础护理**：协助翻身、活动四肢、保持口腔清洁，观察尿量。
- **如实告知用药**：包括自行加量、停药、喝酒、用其他物质。

不能做的：

- **不要强行喂食、灌水。** 紧张症患者吞咽反射可能很差，强行喂食极易噎食、误吸，造成窒息或吸入性肺炎。
- **不要打骂、羞辱、威胁。** 这不会让他“动起来”，只会加重违拗。
- **不要当成“装病”“赌气”而拖延。**
- **不要自行加用镇静药或抗精神病药。** 药物选择需要医生判断，用错可能加重病情。

治疗上，医生可能会使用苯二氮䓬类药物，或采用无抽搐电休克（ECT）；对紧张症，ECT 往往起效较快，是被指南推荐的手段之一【指南】。具体怎么选、用多少，由医生决定。同时必须查清背后的原因：感染、电解质紊乱、脑炎、药物反应，都可能表现为紧张症。

四、恶性综合征：药物引起的急症

恶性综合征（neuroleptic malignant syndrome，NMS）是抗精神病药相关的一种少见但可能致命的严重不良反应【指南】。它的经典表现是四联征：

1. **高热**：体温明显升高，退烧药往往效果不好。
2. **肌肉僵硬**：全身肌肉发硬，像铅管一样，活动时抵抗明显。
3. **意识改变**：从嗜睡、反应迟钝到昏迷。
4. **自主神经不稳定**：大汗、心跳很快、血压忽高忽低、呼吸急促。

它可以发生在开始用药、加量、换药之后的几天内，也可能发生在长期用药过程中，尤其在脱水、中暑、感染、劳累、合并其他药物时更容易出现。典型化验会发现肌酸激酶（CK）明显升高、白细胞升高，严重时出现肌红蛋白尿和急性肾损伤。

处理原则只有一条：立即停药，立即急诊。 医院会做降温、补液、监测电解质和肾功能、处理并发症，必要时使用特定药物。拖延的后果包括急性肾衰竭、吸入性肺炎、心律失常、弥散性血管内凝血，甚至死亡。

需要提醒的是：**NMS 和紧张症可以同时存在**，临床上称为“恶性紧张症”，两者有时很难区分。家属不需要自己分辨，只要看到“高热 + 僵硬 + 意识改变”，就按最严重的情况处理。

对比项	紧张症	恶性综合征	血清素综合征
常见诱因	精神疾病本身、感染、代谢紊乱	抗精神病药、加量、脱水	多种增加血清素的药物合用
核心表现	木僵、缄默、拒食、蜡样屈曲、违拗	高热、铅管样僵硬、意识改变、大汗	发热、震颤、反射亢进、腹泻、躁动
首要处理	急诊精神科评估，治疗病因	立即停药，急诊支持治疗	立即停药，急诊处理

五、预防：把风险挡在发生之前

- **不自行加量、减量、停药、换药。** 很多 NMS 发生在“自己觉得不够劲，加了一点”之后。
- **脱水、中暑、发热、腹泻时格外小心。** 这些状态会让药物浓度和体温调节更不稳定，要及时告诉医生。
- **换药后的前两周注意观察**：发热、僵硬、意识变化、心跳快。
- **有过 NMS 史的人，一定要主动告诉每一位医生**，包括急诊、牙科、外科。再次使用同类药物需要非常谨慎的评估。
- **记录用药**：药名、时间、剂量变化、谁调的。复诊时带上。
- **紧张症史的人**，在复发早期（话变少、动作变慢、不肯吃饭）就要尽早就诊，不要等到木僵。

什么时候需要立即联系医生 / 去急诊

- 高热，尤其伴肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快：立即拨打 120

- 突然不说话、不动、不吃不喝，或保持一个姿势很久：尽快急诊精神科；伴发热直接 120
- 拒食超过一天、完全不喝水、尿量明显减少
- 全身肌肉发硬、活动时明显抵抗、走路困难
- 意识模糊、叫不醒、抽搐
- 呼吸困难、口唇发紫、进食后呛咳
- 兴奋型紧张症：无目的乱动、自伤、攻击

> 以上任何一条，都不要等“明天再看看”。恶性综合征和紧张症的恶化可以非常快，早一小时处理，结局可能完全不同。

容易踩的坑

- 把木僵当成“赌气”“装病”，拖到脱水才送医。
- 强行喂饭、灌水，造成噎食或吸入性肺炎。
- 把高热当感冒，吃退烧药在家扛。
- 把肌肉僵硬当成“累着了”“抽筋”。
- 看到症状加重就自行加药，反而诱发 NMS。
- 有过 NMS 却不告诉新医生，导致再次用药出事。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

9.4 药物与躯体急症：EPS、NMS、噎食、跌倒

抗精神病药救命，也会带来麻烦。大多数副作用是慢性的、可以管理的，但有一小部分会在几小时到几天内变成急症：眼睛突然翻上去、脖子歪到一边、坐不住到想撞墙、吃饭突然噎住、夜里起夜摔一跤、一个星期没排便肚子胀得像鼓。这一页按“现场怎么认、第一时间做什么”来讲，帮你分清哪些可以等门诊、哪些必须马上走急诊。

一、EPS：四张面孔，从急到慢

锥体外系反应（EPS）是抗精神病药最常见的一类副作用，它其实有四张面孔：急性肌张力障碍、静坐不能、类帕金森综合征、迟发性运动障碍。前两种可能来得很急，后两种更慢，但都会影响生活质量。下面按“从急到慢”的顺序讲。

急性肌张力障碍：最吓人，但通常处理得快

这是 EPS 里最急的一种。它常在开始用药、加量或换药后的几小时到几天内出现，年轻人、男性更容易发生【指南】。

典型表现：

- **动眼危象**：眼球突然向上翻，翻得只剩眼白，眼睛控制不住。
- **斜颈**：脖子突然歪向一侧，转不回来，很痛。
- **牙关紧闭**：嘴张不开，说话、进食困难。
- **舌伸出、舌头扭曲**：舌头不受控制地伸出来或卷曲。
- **角弓反张**：身体向后弓起。
- **喉部痉挛**：声音嘶哑、说话困难、呼吸困难——这一种最危险。

家属第一眼看到，常以为是“中邪”“癫痫”“脑子坏了”。其实它通常不伴意识丧失，人是有意识的，只是身体不听使唤。

处理：立即联系医生或去急诊。医生一般会用抗胆碱能药物注射，多数在几分钟到几十分钟内明显缓解。不要自己加药、不要等着“睡一觉就好”。如果出现呼吸困难、口唇发紫，直接拨打 120。

静坐不能：最容易被误认成“焦虑加重”

静坐不能（akathisia）是一种“心里像有虫子在爬、腿不是自己的、必须动”的感觉。患者常描述为“坐不住”“心里烦躁”，来回踱步、跺脚、反复坐下站起、无法安静看电视。

它最容易被误判成三种情况：焦虑加重、病情加重、患者“不配合”。误判的后果是**加药**，而加药往往让它更严重。

静坐不能本身也很危险：它极度难受，与自杀风险升高相关，也是患者自行停药的主要原因之一【研究】。

处理：把“什么时候开始的、和加药有没有时间关系、是不是一种身体上的‘必须动’”告诉医生。医生可能会调整剂量、换药或加用其他药物。不要自己喝酒、吃安眠药来压，那只会带来新的问题。

类帕金森综合征与迟发性运动障碍

这两类偏慢性，但必须认识，因为它们影响生活质量和长期预后。

类帕金森综合征：手抖、四肢僵硬、动作变慢、走路小碎步、面具脸、写字变小、流口水。它和帕金森病不是一回事，但表现相似，减药或调整方案后多可改善。

迟发性运动障碍（TD）：长期用药后出现的**不自主**动作，最典型在口面部——吐舌、咀嚼、撅嘴、鼓腮，也可能在手指、脚趾、躯干。它在早期可能只在紧张时出现，很容易被忽略。TD 一旦形成，可能长期甚至不可逆，所以**早期发现、尽早告诉医生**非常重要。不要因为“只是小动作”就不说。

这两类都不建议自行停药。突然停药可能诱发更严重的撤药反应，也可能让病情复发。具体怎么调整，见 5.5 锥体外系反应与迟发性运动障碍。

二、恶性综合征：必须背下来的四联征

恶性综合征（NMS）是抗精神病药的严重不良反应，核心是四个字：**热、僵、昏、乱**。

- **热**：高热，退烧药效果差。
- **僵**：全身肌肉发硬，像铅管，活动时明显抵抗。
- **昏**：意识改变，从嗜睡到昏迷。
- **乱**：自主神经不稳定——大汗、心跳很快、血压波动、呼吸急促。

处理只有一条：**立即停药，立即急诊**。不要在家观察，不要等第二天门诊。

三、噎食与吞咽困难：几分钟就能致命

抗精神病药可以从多个环节增加噎食风险：镇静让注意力下降；抗胆碱能作用让口干、食物难以下咽；锥体外系反应影响咀嚼和吞咽的协调；迟发性运动障碍可能让舌头和咽喉动作失控。老年人、有帕金森样症状、有 TD、正在服用多种镇静药的人，风险更高。

噎食的现场表现：进食中突然不说话、用手抓喉咙、面色涨红或发紫、剧烈咳嗽、喘不上气、眼神惊恐。完全阻塞时人无法咳嗽、无法发声。

现场处理：

1. 立即让他弯腰低头，用力咳嗽——能咳就让他自己咳。
2. 不能咳嗽、不能说话时，立即做海姆立克急救（成人在肚脐上方快速向内向上冲击；婴儿用背部拍击加胸部按压，1 岁以下不做腹部冲击）。
3. 同时让人拨打 120。

4. 人失去意识后，立即开始心肺复苏。

预防比抢救更重要：

- 坐直吃饭，不要躺着、半躺着吃。
- 小口、慢吃，把食物切小、煮软。
- 吃饭时不说话、不看电视、不走动。
- 备好温水，口干时先润口。
- 假牙要合适，松动要及时修。
- 有反复呛咳、饭后声音变“湿”、不明原因发热，要告诉医生，评估吞咽功能。

四、跌倒：一次骨折可能改变后半生

跌倒的风险来自药物和环境的叠加：体位性低血压（起身时头晕）、镇静、僵硬、走路不稳、视力下降、地面湿滑、夜间起夜、鞋子不合脚、低血糖、饮酒。

后果在老年人身上尤其严重：髋部骨折后长期卧床，接着是肺炎、血栓、压疮。服用抗凝药的人跌倒后还要警惕颅内出血。

预防清单：

- ☐ 起身分三步：躺 30 秒、坐 30 秒、站 30 秒再走
- ☐ 测过躺着和站起来时的血压
- ☐ 夜灯、扶手、防滑垫、去掉地毯边角
- ☐ 鞋子合脚、防滑，不穿拖鞋走远路
- ☐ 视力、听力定期检查
- ☐ 避免同时服用多种镇静药（由医生评估）
- ☐ 不在酒后、空腹时独自洗澡

跌倒后不要急着扶起来。 先看意识、问哪里痛、看有没有出血、有没有头痛呕吐、能不能动。如果撞到头、出现呕吐、嗜睡、说话不清、一侧无力，立即去急诊——老年人轻微跌倒也可能出现硬膜下血肿，症状可以几小时后才出现。

五、便秘与肠梗阻：最容易被忍过去的一种急症

抗精神病药的抗胆碱能作用会减慢肠蠕动，加上活动少、喝水少、饮食精细，便秘非常常见。**氯氮平相关的便秘尤其需要重视，严重时可以发展为肠梗阻、肠穿孔，甚至危及生命【**指南**】**。

需要警惕的进展：

1. 排便次数明显减少（比如三天以上没有排便）。
2. 腹胀、腹痛、恶心、食欲下降。

3. 停止排气、呕吐（呕吐物可能有粪臭味）。
4. 腹部胀硬、按压疼痛。

到了第 3、4 步，就不是“多吃点香蕉”能解决的了，必须急诊。

日常管理：

- 主动记录排便频率，不要等患者自己说。
- 保证饮水，增加膳食纤维，适度活动。
- 不要长期自行使用刺激性泻药，也不要自己灌肠。
- 正在服用氯氮平的人，每次复诊都要主动说排便情况。
- 出现腹胀、呕吐、停止排气，立即急诊。

六、急症速查表与常见误区

情况	关键表现	第一时间做什么
急性肌张力障碍	眼睛上翻、脖子歪、牙关紧闭、舌伸出	联系医生或去急诊；呼吸困难拨 120
静坐不能	坐不住、来回走、内心极度烦躁	记录出现时间，尽快告诉医生，不要自行加药
恶性综合征	高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗	立即停药，拨打 120
噎食	不能说话、抓喉咙、面色发紫	海姆立克急救，同时拨 120
跌倒	头痛、呕吐、意识改变、一侧无力	不急于扶起，头面部着地或服抗凝药者去急诊
便秘转肠梗阻	腹胀、腹痛、停止排气、呕吐	立即急诊，不要自行灌肠

什么时候需要立即联系医生 / 去急诊

- 眼睛突然翻上去、脖子歪、牙关紧闭、舌头伸出、呼吸困难
- 高热、全身僵硬、意识改变、大汗（恶性综合征）
- 进食中突然不能说话、抓喉咙、面色发紫（噎食）
- 跌倒撞到头，之后出现呕吐、嗜睡、说话不清、一侧无力
- 腹胀明显、停止排便排气、呕吐、腹痛加重
- 静坐不能严重到无法忍受，出现自伤或自杀念头
- 口面部出现不自主动作，且越来越明显

拿不准的时候，按严重处理。副作用不会因为“忍一忍”而消失，急症也不会因为“再观察一晚”而变轻。

容易踩的坑

- 把动眼危象当成“癫痫”或“中邪”，耽误处理。
- 把静坐不能当成“焦虑加重”，反而加药。
- 觉得“小动作”无所谓，错过迟发性运动障碍的早期窗口。
- 强行给噎食的人喝水、拍背、用手指乱掏。

- 跌倒后立刻把人架起来，加重损伤。
- 便秘长期靠刺激性泻药，直到肠梗阻才就医。
- 出现副作用就自行停药，导致复发。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 10：复发预防与长期管理

精神分裂症容易复发。这一模块讲预警信号、维持治疗、依从性、社区随访和生活质量。

10.1 复发预警信号

复发很少是“某天早上突然就变了一个人”。在幻觉和妄想明显回来之前，多数人已经有一段时间睡得越来越少、越来越防备，或者悄悄把药停了。这一页讲怎么认出这些前兆，怎么把它整理成一份属于自己的预警清单，以及家属在边上能观察到什么、第一句话该怎么说。读完可以带走一张能贴在冰箱门上的表。

一、复发多半有“前奏”

先解释三个词。**缓解**指症状轻到基本不影响生活，并且维持了一段时间；**复发**指缓解之后症状又回到需要治疗的程度；**前驱症状**指复发真正发生之前那段“不太对劲”的时期。

前驱期通常持续几天到几周，表现往往不典型：睡不好、烦躁、觉得别人在议论自己、不想出门。它不像幻觉那样一眼能认出来，所以最容易被当成“最近压力大”“脾气变差”“人变懒了”。但对治疗来说，这恰恰是最有价值的窗口——这时候核对服药情况、加密随访、处理生活里的应激，有可能把一次住院挡在门外【指南】。

需要说清的是：有前驱症状不等于一定复发，没有前驱症状也不等于不会复发。它是一个提示你去核对、去联系医生的信号，不是一个可以自己下结论的诊断。

二、六类最值得盯住的信号

类别	具体表现（举例）	为什么值得注意
睡眠	入睡困难、凌晨醒来睡不着、总睡眠明显缩短却不困、昼夜颠倒	往往出现得最早，比幻觉早好几天
情绪	无故紧张害怕、坐立不安、易怒、突然低落哭泣	焦虑和抑郁常与复发同时出现
感知	声音变大变清楚、余光看到人影、觉得周围不真实	“将信将疑”阶段比明确幻听更好沟通
猜疑与思维	觉得被针对、被议论、被监视；说话跳跃、别人听不懂	常先表现为对家人的盘问和防备
社交与功能	不出门、不接电话、卫生变差、工作学习明显掉	与阴性症状、药物副作用容易混淆
服药与复诊	自行减量、藏药、说“我好了不用吃”、拒绝复诊	停药是最强的复发预测因素之一

睡眠是最值得盯的一项。不是“睡得少”本身，而是“睡得少还不觉得困”。家属常描述为“他这几天精神特别好，半夜还在收拾东西”。这种状态如果持续两三个晚上，就该联系医生，而不是等它自己过去。

情绪的变化有两个方向。一个是往上走：紧张、烦躁、一点就着、坐不住。另一个是往下走：突然沉默、哭泣、说“活着没意思”。后者更危险，因为抑郁和自杀风险常常同时升高。

感知的早期变化很轻微：声音好像变大了，或者开始能“听出”是哪个熟人在说；眼角扫到人影；觉得世界像隔了一层玻璃。这些体验本人往往也半信半疑，这时候问“你最近有没有听到什么”，比等他开始跟声音对话要容易得多。

猜疑常从具体的人开始：邻居在议论、同事在针对、家里被装了东西。表现是反复检查门窗、盘问家人行踪、把窗帘拉上。争辩“没人议论你”通常无效，甚至会让对方把你也算进“他们”里。

社交与功能的退步需要和阴性症状、药物镇静区分。判断的办法是看“变化速度”：几周内明显下滑，更像复发前驱；长期稳定地不爱说话、表情少，更像阴性症状。

服药与复诊的变化最直接。藏药、吐药、把药换成保健品、频繁换医生、拒绝查血，都是明确的警报。尤其是“我感觉好了，不用吃了”这句话——它常常出现在复发前的几周。

三、做一份属于自己的预警清单

每个人的前驱表现相对固定，第二次、第三次复发往往沿着相似的路径走。所以清单要个人化，不能照抄别人的。

做法可以分五步：

1. **回忆上一次复发前两到四周**。问家属、翻聊天记录、看就诊记录，把当时发生的具体事情写下来。
2. **只留五条**。选最具体、最容易被外人观察到的，不要写“情绪不稳”这种谁也说不清的话。
3. **写成行为句**。不写“睡眠变差”，写“连续两晚只睡三小时，白天还在擦地板”。
4. **分三级**：黄色是出现了但还能上班上学；橙色是已经影响日常、持续三天以上；红色是出现危险信号。
5. **每条配一个动作和一个联系人**，然后拿给医生看，请医生补充和修正。

级别	大致表现	当天该做什么
黄色	睡眠或情绪有变化，日常基本维持	记录、核对服药、减少熬夜和应酬，下次复诊时提出来
橙色	持续三天以上，明显影响工作学习，开始回避人	一天内联系医生，商量是否提前复诊或调整随访
红色	命令性幻听、明确的自伤伤人念头、拒食、失联、打砸	立即急诊或拨打 120，有即时危险时拨打 110

可以照着勾选：

- ☐ 我写下了自己最常见的五个早期信号
- ☐ 每个信号都配了具体动作，而不是“注意观察”
- ☐ 清单上有医生、社区精防医生、一位家属的电话
- ☐ 家里有一个固定放清单的地方，家里人都知道
- ☐ 我和至少一个人对过这份清单，确认写得看得懂
- ☐ 我知道红色信号出现时去哪个医院、走哪条路
- ☐ 清单每半年和医生一起更新一次

四、家属能观察什么、怎么开口

观察的原则是：**描述行为，不评价人格；提供信息，不下诊断。** “他今天把窗帘拉了一天”是信息，“他又犯病了”是判决。前者医生能用，后者只会让对话结束。

值得记的几项很具体：几点睡、几点起、夜里有没有起来；吃了几顿；出门几次；有没有洗漱；手机用到几点；有没有自言自语或无故发笑；有没有反复检查门窗；药盒里还剩几粒。

记录不用复杂，手机备忘录一天一行就够。复诊时给医生看五行字，比“他最近不太好”有用得多。

开口的句式可以练：

- “我注意到你这三天都是凌晨四点还亮着灯，是睡不着，还是心里有事？”
- “你最近好像不太想接电话。是懒得说话，还是他们说的话让你不舒服？”
- “我不跟你争那个声音是不是真的。我只想知道，它有没有让你想去做伤害自己的事？”

三件最好别做：

- **不偷看手机、不翻抽屉当侦探。** 被抓到一次，之后他就什么都不跟你说了。
- **不说“你又犯病了”“你就是不吃药”。** 这两句话会把对方推到防守位置。
- **不在情绪最高的时候讲道理。** 等半小时，效果常常比讲一小时好。

五、容易踩的坑

把阴性症状当成懒。 不想动、不说话、面无表情，可能是阴性症状，也可能是药物镇静。骂一顿通常只会让退缩更严重，正确做法是记下来告诉医生。

只盯幻觉，忽略睡眠。 睡眠变浅变短，往往比幻听早出现好几天，而且更容易被家属发现。

把副作用当成复发。 静坐不能（坐着也停不下来、来回踱步）、手抖、嗜睡、坐立不安，可能是药物反应，需要医生调整，不是病情加重。两者的处理方向完全相反。

一次复发就换医生、换医院、换药。 复发后最需要的是稳定评估和足量足疗程，频繁更换会让医生看不到完整病程，也容易在换药空档里出问题。

家属自己扛。 长期盯着一个人，先垮的往往是照护者。轮班、找人替手、自己去看医生，都不是自私。

把“能上班”当成没事。 很多人是硬撑着上班，回家才崩。功能维持是好事，但不能替代睡眠、服药和复诊这三项硬指标。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> - 连续两三个晚上几乎不睡，白天仍然兴奋、话多、停不下来。
> - 出现命令性幻听（声音叫他去做危险的事），或明确说“有人要我死”。
> - 出现自杀念头、自伤行为、写遗书、把东西送人、突然交代后事。
> - 拒绝进食饮水超过一天，或出现木僵、缄默、蜡样屈曲（肢体被摆成什么姿势就保持什么姿势）。
> - 打砸、威胁他人、携带刀具，或已经离家失联。
> - 服药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快——按恶性综合征处理，立即急诊。
>
> 以上情况不要等下次复诊。拨打 120；有即时人身危险时拨打 110；也可以拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

10.2 维持治疗与依从性

症状消失之后的那几个月，才是最容易出问题的时候。很多人正是在这里停了药，然后在半年后回到急诊。这一页讲维持治疗大概要多久、为什么不能自己停、依从性差通常不是“不听话”，以及有哪些具体工具、家属可以怎么帮而不至于变成监视。

一、先分清三个阶段

治疗不是“吃到症状没了就结束”。临床上通常把它分成三段，每段的目标不一样。

阶段	主要目标	大致时长	这一段的重点
急性期	控制阳性症状、保证安全	数周	找到有效方案，处理激越、拒食、失眠
巩固期	巩固疗效，防止反弹	一般数月	剂量通常维持不变，不急着减
维持期	预防复发，恢复功能	首发常需一到两年，多次复发更久	最低有效剂量、副作用监测、康复

要说明的是，表里的时长是群体经验，个体差异很大。首发还是多次复发、有没有自杀史、停药后复发得多快、家庭环境稳不稳定，都会影响医生对疗程的判断。有人需要长期甚至终身用药，这不等于“病得重”，只等于“这个方案对他有效且必要”【指南】。

还有一个常见误解：维持期等于“什么都不做，只吃药”。实际上这一段时间要做的恰恰最多——副作用监测、体重和代谢管理、睡眠和作息、复学复工、家庭沟通，都是在维持期完成的。

二、为什么不能“感觉好了就停”

第一，症状消失不等于疾病消失。 药物压制的是症状的表达，不是病因本身。很多人停药后一两周内一切正常，于是认为“果然好了”，但真正的考验在后面几个月。

第二，停药后复发风险明显上升。 研究综述里，停用抗精神病药的人一年内复发的比例远高于继续用药的人，而且不少就发生在停药后的几个月内【研究】。复发不是运气问题，是概率问题。

第三，每一次复发都有代价。 不只是住一次院。复发之后，功能恢复往往比上一次更慢，对治疗的反应可能变差，工作、学业、关系都可能断掉一截，自杀风险也会升高。有研究提示，复发次数越多，达到缓解所需的时间越长【研究】。

第四，突然停药本身会难受。 可能出现失眠、焦虑、坐立不安、恶心、头痛、出汗、幻觉加重，少数人还会出现运动方面的撤药反应。这些症状容易被误读成“病又重了”，于是有人自己加药，有人干脆放弃【指南】。

第五，停药可以，但要有计划。 医生在患者稳定足够久之后，会用几个月甚至更长时间缓慢减量，同时加密随访、写好复发预案。这和“自己把药停了”是两件完全不同的事。

有两个特别要提醒的地方：

- **氯氮平不能自行停。** 突然停用可能引起症状明显反跳，也可能出现撤药相关的运动症状。而且氯氮平的血常规监测是处方的一部分，不能因为“感觉还好”就跳过；出现发热、咽痛、口腔溃疡、乏力，要立即查血常规。
- **长效针剂同样不能自行中断。** 它只是把每天吃药改成定期注射，停药后的反跳一样会发生。

三、依从性差，通常不是“不听话”

“不依从”是医生的说法，翻成日常语言就是：没按商量好的方式吃药。它的原因很具体，解决办法也不同。把它当成态度问题去批评，基本不会有效。

常见原因	患者常说的话	背后是什么	可以怎么处理
副作用	“吃了像木头人”“手抖得拿不住筷子”	镇静、锥体外系反应、体重增加、性功能受影响	记录下来找医生调整，而不是硬扛或自行减量
病耻感	“吃药就等于承认自己是精神病”	怕被贴标签、怕被同事看见	保护隐私、把吃药当成治疗而不是身份
自知力不足	“我没病，是你们有病”	疾病本身影响了判断能力	不硬碰，先建立信任，从具体目标切入
费用与获取	“一盒好几百”“挂号根本挂不上”	经济压力、异地、交通不便	问门诊慢特病、社区免费服药、长效针剂减少频次
忘记与作息乱	“想起来就吃”	注意力差、昼夜颠倒、生活没结构	提醒工具、把药放在必经之处
沟通不畅	“医生根本不听我说”	没被解释清楚，或换医生太频繁	带问题清单去复诊，固定一位医生
家属方式	“他们天天盯着我”	被控制感、被当犯人	从监视改成合作，先问需要什么帮助
物质使用	“喝点酒没事”	酒精、大麻、兴奋剂干扰治疗	整合治疗，不要只谈戒断不谈症状

值得单独说的是**副作用**。它是依从性差最常见、也最容易被解决的原因。很多人不是不想吃，是吃了太难受又不知道怎么开口。把“手抖”“坐不住”“胖了”“月经不来”“同房没感觉”这些具体困扰写下来带去复诊，比一句“副作用太大”有用得多。医生有调整方案的空间，但前提是知道发生了什么。

四、工具与家属的角色

先说工具。它们的共同点是：**把“记得吃药”从意志力问题变成环境问题。**

- ☐ 手机闹钟，铃声和普通通知区分开
- ☐ 分格药盒，一格一天或一格一次
- ☐ 把药盒放在牙刷旁、饭桌边、玄关——每天必经的地方
- ☐ 把吃药绑定在固定动作后：刷牙后、早饭后、睡前关灯前

- ☐ 每周固定一天补药盒，同时清点还剩多少
- ☐ 设一个“补药预警”：剩下七天量的时候就去开药，不要等吃完
- ☐ 复诊前一天写三行：这周睡眠怎么样、有什么副作用、想问什么
- ☐ 和医生讨论长效针剂是否适合自己
- ☐ 把复诊日期写进日历，并设提前一天的提醒
- ☐ 让一位家人知道药放在哪、什么时候该补

再说家属的角色。核心是一句话：**提醒可以，接管不行。**

先问“你希望我怎么帮”，而不是直接安排。有人希望被叫一声，有人希望药盒被补好，有人什么都不想被碰。问过再动手，摩擦会少很多。

不要做的事很具体：不要把药藏进饭里，不要偷偷加药或减药，不要用“不吃药就送你住院”来威胁，不要在孩子面前说“你爸有病”。这些做法短期可能“有效”，但会把治疗变成一场对抗，而对抗里的人通常会偷偷停药。

可以做的事也很具体：承认副作用是真的。“你手抖得难受，我们去找医生看看能不能换”比“忍一忍就好了”有用得多。允许对方抱怨，抱怨不等于拒绝治疗。把“你怎么又忘了”换成“到点了，水给你倒好了”。

最后是边界。家属可以提醒、可以陪同、可以帮忙付钱，但不能替对方承担全部后果，也不能因为对方拒绝就彻底放弃。比较可持续的姿态是：我一直在，但决定权在你；出现危险信号时，我会按事先说好的方式处理。

五、常见问题与容易踩的坑

“症状好了，能不能减一半？” 减量是医生根据病程、既往复发次数、副作用耐受情况决定的，不是按感觉打折。自行减半常常在几周后显出后果，而那时候已经很难挽回。

“中药或保健品能不能替代？” 不能。它们可能帮忙改善睡眠或焦虑，但没有证据能替代抗精神病药预防复发，还可能带来相互作用。要加任何补充剂，先告诉医生。

“准备怀孕，是不是得先停药？” 这是需要提前规划的事，不是发现怀孕后临时决定。停与不停都有风险，要精神科和产科一起评估，具体见8.3 孕产期精神分裂症。

“长效针剂是不是给不听话的人用的？” 不是。它适合的人包括：觉得每天吃药麻烦的、胃肠吸收不稳定的、反复忘记的、希望减少服药被家人看见的。是否适合要医生评估。

“漏了一次怎么办？” 不要自己加倍补服，也不要连着停几天。看距离下次服药还有多久，问医生或药师。这个问题的答案和具体药物有关，不适合套用。

最容易踩的坑是把“吃药”当成治疗的全部，或者反过来把“康复”当成停药的许可证。两者都偏了：药物是底盘，康复是内容，减停是医生的事。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 已经自行停药或减药，且出现失眠、烦躁、多疑、幻觉加重。
- 停药后出现明显的心慌、出汗、恶心、坐立不安，影响进食和睡眠。
- 服用氯氮平期间出现发热、咽痛、口腔溃疡、乏力——立即查血常规。
- 出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗，可能是恶性综合征，立即急诊。
- 出现自杀念头、自伤行为，或命令性幻听。
- 因费用问题准备断药——先联系医生或社区精防医生，通常有比断药更好的办法。

拨打 **120**；有即时人身危险时拨打 **110**；也可拨打 **12356** 心理援助热线。

参考来源

- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

10.3 社区随访与个案管理

出院并不等于治疗结束，恰恰相反，真正的长期管理大部分发生在社区里。很多人不知道社区能做什么、随访是谁来、被“建档”是不是被监视。这一页把社区精神卫生服务、随访、个案管理和危机预案讲清楚，也说明家属可以怎么配合。各地具体做法差别很大，涉及政策的部分以当地为准。

一、社区能提供什么

在中国，精神卫生服务不是只有专科医院。社区卫生服务中心、乡镇卫生院一般配有精防人员（有的地方叫精防医生、社区医生），负责辖区内严重精神障碍患者的登记、随访、服药指导和转诊。综合医院精神科、精神专科医院、疾控和残联也各有一部分职能。

服务	谁提供	能解决什么	怎么找
建档与随访	社区卫生服务中心、乡镇卫生院	定期了解病情、服药、副作用，发现恶化及时转诊	出院时由医院转介，或带诊断材料自行去登记
服药指导与免费服药	社区精防人员、部分地区的定点医院	领药、核对用法、提醒复查	问社区有没有当地的项目
年度体检	社区或指定机构	血常规、肝肾功能、血糖血脂、心电图、体重血压	按社区通知参加，别当成可有可无
应急处置	社区、公安、民政、医院联动	出现伤人、自伤、失联时的快速处理	先打 120/110，再联系社区医生
康复与日间活动	社区康复站、阳光心园一类的机构	社交、手工、职业训练、同伴活动	问社区或区残联
政策与补助	民政、残联、医保部门	低保、两项补贴、医疗救助、残疾评定	见 11.4 监护、残疾、病假与医保

需要说明的是，各地项目名称、覆盖范围、免费药品目录、随访频次都不一样，同一个省的不同城市都可能有差别。看到网上说“国家免费发药”，先确认本地有没有这个项目，不要按网上的说法去要求。

二、随访是怎么进行的

随访的核心是四件事：**症状有没有变化、药有没有按商量好的吃、副作用有没有出现、有没有危险行为的苗头。**

形式上，可能是到社区面访，也可能是电话；有的地方会提前约在门诊。频次按病情稳定程度分档：稳定的人间隔较长，不稳定的人会明显加密，出现明显症状变化或风险时，要求在一两周内面访。具体档位由当地规范和社区医生判断，不必记数字，只要知道“越不稳定，来得越勤”。

随访时通常会做一次**危险性评估**，从 0 级到 5 级。简单理解：

- 0 级：没有攻击、打砸、威胁这类行为。
- 1 到 2 级：以口头威胁、喊叫为主，或者只在家里打砸财物、能被劝住。

- 3 级及以上：打砸不分场合、劝不住，或者针对人、持械、纵火等。

这个分级不是给患者贴标签，而是决定“要不要马上转诊、要不要请公安协助”的操作工具。

年度体检常被忽略，但它很关键。抗精神病药会影响体重、血糖、血脂、心电图和催乳素，这些变化早期没有感觉，只能靠检查发现。把体检当成治疗的一部分，而不是“社区的任务”。

关于建档，有两点需要说清楚。第一，登记和随访通常需要患者或监护人知情同意，具体程序按当地规定。第二，建档的目的是让社区知道“辖区里有这样一个人，需要定期看看”，不是监视。信息属于敏感个人信息，医疗机构和社区有保密义务。如果担心信息被单位、邻居知道，可以主动问清楚“哪些人会看到、会不会通知单位”。

三、个案管理：有一个固定的人

碎片化的服务很容易掉链子：医院管开药，社区管随访，残联管评定，谁都管一段，谁都不管全部。个案管理（case management）就是指定一个人做“总协调”，通常由社区精防人员、社工或精神科护士担任。

这个人做的事包括：评估需求（不只是症状，还有住房、收入、工作、照护、法律问题）、制定一份写下来的服务计划、把医院、社区、残联、民政的资源串起来、定期复盘、在危机时第一个被联系。

对反复住院、独居、家庭支持薄弱、合并物质使用的人，有些地区会提供强度更高的模式，比如多学科团队主动上门（常被称为 ACT，主动式社区治疗）。研究显示这类模式能减少住院天数、提高留治率，但对团队和经费要求高，不是每个地方都有【研究】。

对患者和家属来说，个案管理最实际的价值是：**遇到事情知道打给谁。** 这比任何一份方案都重要。第一次见面时可以问三个问题：你负责什么、出问题什么时候能找到你、如果找不到你打哪个电话。

四、危机预案：写下来才有用

危机预案不是“万一出事再说”，而是提前把决定做好，免得在慌乱中做错。一张纸就够，写清楚下面这些，家里人手一份，社区医生那里也留一份。

- ☐ 出现哪些信号算“这次不一样”（对照自己的预警清单）
- ☐ 第一个电话打给谁，第二个打给谁，号码写全
- ☐ 去哪个医院、走哪条路、急诊在几楼
- ☐ 谁陪同、谁开车或叫车、谁留下来看家
- ☐ 医保卡、就诊卡、病历、正在吃的药放在哪个袋子
- ☐ 大概需要多少钱，谁先垫
- ☐ 家里老人、孩子、宠物临时谁照顾

- ☐ 单位或学校怎么请假，找谁说
- ☐ 如果患者拒绝去医院，按什么步骤处理，什么时候打 110
- ☐ 事后由谁负责复盘和更新预案

预案里最容易被漏掉的是“拒绝就医怎么办”。比较稳妥的顺序是：先联系社区医生或门诊医生，请他们电话沟通；仍拒绝且风险升高时，联系当地精神卫生防治机构或拨打 120；出现即时伤人、自伤、打砸，拨打 110。不要几个家属一起硬抬，抬的过程本身就容易受伤。

预案还要定期更新。搬了家、换了医生、换了药、家里添了孩子，都要改一遍，否则真到用的时候会发现号码是空的。

五、家庭协作与常见问题

家属怎么和社区配合。 最有用的是三件事：如实说、及时说、留着记录。如实说包括“他其实没怎么吃药”“晚上基本不睡”这些不太好看的部分；及时说是指变化发生的那几天就说，不要攒到下次随访；留记录是指睡眠、服药、副作用、情绪变化，一天一行，随访时直接给对方看。

信息授权。 成年患者的病情属于个人隐私，医生和社区原则上不能随便告诉家属。如果希望家属参与，比较可行的办法是患者本人在场时签署授权，或者由患者主动指定一位联系人。患者不愿意授权时，家属能做的是提供信息、表达担心，而不是要求医生“必须告诉我”。

常见误解。

- “建档就是被监控。” 建档是服务登记，不是监控；但信息确实敏感，值得问清楚使用范围。
- “社区医生不懂，还是专科医院靠谱。” 社区负责的是长期、就近、连续，专科负责的是诊断和方案调整，两者是接力关系。
- “搬家了不用管。” 跨地区居住要办理转档或重新登记，否则随访会断，下一次出事时当地社区完全不了解情况。
- “随访就是走形式。” 随访最有价值的部分是“变化”被发现得早，这恰恰需要连续性。
- “签了字就再也出不来。” 自愿住院和社区建档是两件事，不要混为一谈。

一个容易被忽略的点： 社区服务再好，也替代不了门诊复诊和处方调整。社区医生通常不负责选药和调剂量，遇到治疗方案的问题，仍然要找精神科医生。反过来，门诊医生也看不到患者在家里每天的样子，这部分信息只有家属和社区能提供。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 随访中发现症状明显加重、服药完全中断、连续多日不睡。
- 出现命令性幻听、明确的自伤伤人念头或计划。
- 拒绝进食饮水、木僵不动、缄默不语。
- 打砸、威胁他人、携带刀具、离家失联。

> - 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗——立即急诊。
> - 社区医生建议转诊而暂时挂不上号时，直接去精神专科医院急诊，不要等。

> 拨打 120；有即时人身危险时拨打 110；也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- 中国严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）及地方社区管理文件.
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- NICE. Rehabilitation for adults with complex psychosis (NG181), 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng181

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。社区服务与政策以当地卫生健康部门、医保部门和残联的最新规定为准。

10.4 康复目标与生活质量

“康复”这个词很容易被理解成“病好了，回到从前”。对精神分裂症来说，这个标准既太高，也太窄。这一页讲康复到底包含什么、为什么不必以“回到病前”为唯一目标，以及目标该由谁来定、怎么定才不至于变成新的压力。

一、康复不只是“症状没了”

临床上说的康复，通常指症状缓解、功能恢复、能独立生活。这是“临床康复”，医生用症状量表和社会功能量表来评估。

但还有另一个概念，叫“个人康复”（personal recovery）：即使还有一些症状，也能过上自己认为有意义的生活。国际上常用五个词来概括它的内容——联结（有人可以依靠）、希望（相信未来会变好）、身份（不只是“一个病人”）、意义（每天有事值得做）、赋权（对自己的生活有发言权）【研究】。

这两个概念不冲突，但重心不同。临床康复问的是“症状还剩多少”，个人康复问的是“日子过得怎么样”。只看前者，容易把治疗变成一场永无止境的打分；只看后者，又可能忽略该处理的症状。比较实在的做法是两条线一起看。

需要提前说明的是，个人康复这个概念来自康复者群体的经验总结，研究上更多是质性研究和共识框架，不是“照着做就能好”的处方【待验证】。它的价值在于提醒：康复的终点不止一个。

二、四个维度

把康复拆成四块，比笼统地说“变好”更容易操作。

维度	具体指什么	可以观察到的变化	谁最有发言权
症状	幻觉、妄想、情绪、睡眠、焦虑	声音出现的频率和干扰程度、睡眠是否稳定	患者本人，其次才是量表
功能	自理、家务、学习、工作、理财、就医	能不能自己挂号、按时吃饭洗澡、独立出门	患者和日常接触的人
关系	家人、朋友、伴侣、同事	有没有可以说话的人、冲突是否减少	患者本人
意义感	每天有没有想做的事、觉得自己有用	有没有持续的兴趣、是否愿意计划下周	只有患者本人

四个维度的重要程度因人而异。有人最想恢复的是工作，有人最想的是不再和父母吵架，有人只想每天能睡好。没有哪一种更“高级”。把别人的目标当成自己的目标，通常坚持不了多久。

还要注意，四个维度不总是同步。症状减轻了，功能可能还没跟上；工作恢复了，关系可能仍然紧张。这种不同步是正常的，不代表治疗失败。

三、康复不是“回到病前”一条路

“回到病前”这个目标有几个现实困难。

第一，病前的那个“自己”可能本来就在变化中。 很多人在青少年晚期或二十岁出头起病，那正是学业、交友、独立的阶段。病前的状态本身就不是一个稳定的参照点。

第二，时间不会倒流。 中断的学业、丢掉的工作、断掉的关系，很难原样复原。这不是患者的错，也不代表以后不能有新的学业、工作和关系。

第三，有些改变是永久的，但不等于更差。 有人需要长期服药，有人不能熬夜，有人对压力更敏感。这些是新的条件，不是失败。学会在这些条件下安排生活，本身就是康复的一部分。

比较现实的说法是“建立一个新的常态”：可能工作量比以前少，但睡得着；可能朋友不多，但有两三个能说真话的；可能还在吃药，但能自己管好药和复诊。这种生活不戏剧化，但可持续。

也要承认另一面：确实有人恢复得很好，回到原来的岗位，甚至比病前更稳定。这样的例子存在，但不该被当成标准去要求所有人。把少数人的结果当成普遍期待，对多数人是一种伤害。

四、目标由谁定、怎么定

原则很简单：**目标由患者主导，家属和医生做参谋。** 这不是客套话。一个人只有对自己定的目标才有持续的动力，别人塞过来的目标，通常在执行阶段就会崩。

具体做法可以参考下面几步。

1. **先问“你希望半年后的一天是什么样子”**，而不是“你打算什么时候上班”。前者能问出生活细节，后者只会得到防御。
2. **把目标拆到能看见的程度。** “恢复社交”太虚，“每周三和表哥打一次球”才是能做的。
3. **一次只动一件。** 同时改作息、找工作、谈恋爱，几乎一定失败。
4. **设一个复查点。** 比如一个月后回看：做到了多少、哪里卡住、要不要改。
5. **允许放弃。** 试过不合适的目标可以换，这不叫没毅力。
6. **写下来，放在看得见的地方。** 但不要做成打卡表去考核对方。

家属最常犯的错，是把“我为你好”的目标当成患者的目标。比如希望孩子考回原来的大学、希望配偶回到原来的岗位。这些愿望可以理解，但需要先问一句“这是你想要，还是我想要”。

另一个错是过度保护。什么都替对方做好，看起来是照顾，实际上把“我还能做什么”一点点拿走。比较合适的做法是：能做的一起做，做不了的帮忙补位，而不是全部代劳。

如果一时想不出“大目标”，可以先勾掉几件小事：

- ☐ 这周有三个晚上在十二点前上床
- ☐ 这周自己去开一次药，或者把药盒补满

- ☐ 这周和一个能说真话的人聊十分钟
- ☐ 这周出门一次，哪怕只是买菜、取快递
- ☐ 这周记下三件“我做到了”的事，不用是什么大事

五、生活质量和容易踩的坑

生活质量不是一个虚词，它可以拆成很具体的几项：睡得怎么样、住得稳不稳、有没有钱花、一周和几个人说过话、有没有被当人尊重、身体有没有难受的地方。这些比“症状评分降了几分”更贴近每天的感受。

临床上也会用一些量表，比如个人与社会功能量表（PSP）、生活质量量表（QLS）。它们的作用是让医生和研究者有一个共同的参照，不是给患者打分的考试。分数低不代表这个人过得不好，分数高也不代表没有困难。

容易踩的坑：

把停药当成康复目标。 康复的目标是生活，不是停药。是否减停由医生根据病程决定，把它当成“痊愈的证据”，往往会用复发来换。

把上班当成唯一的成功标准。 能工作当然好，但工作不是衡量人的唯一尺子。有人先恢复的是做饭、养花、遛狗、和朋友吃饭，这些同样算康复。

用“正常人”做比较对象。 和同龄人比收入、比婚育、比职位，几乎必然失望。比较对象换成“半年前的自己”，才有意义。

一次退步就否定全部。 康复不是直线，遇到换药、搬家、失业、失恋，退一步很常见。退步之后能回到原来的轨道，本身就是能力。

忽略身体健康。 体重、血糖、血脂、牙齿、睡眠呼吸问题，都会直接影响情绪和精力。康复计划里应该有这一块。

忽略抑郁。 康复期的无望感、兴趣丧失、反复说“没意思”，不一定是“懒”或“想不开”，可能是抑郁，需要评估。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现持续两周以上的情绪低落、兴趣丧失、觉得自己是负担。
- 出现自杀念头、自伤行为、写遗书、把东西送人。
- 出现命令性幻听，或坚信自己得了不治之症。
- 连续多日不睡、话多、冲动消费、行为失控。
- 拒绝进食饮水、木僵不动。
- 康复计划推进中反复卡在同一处，且伴随明显的痛苦——这不是毅力问题，值得和医生或心理治疗师讨论。

> 有自杀或伤人风险时，不要独处，立即拨打 120（必要时 110），或前往最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Rehabilitation for adults with complex psychosis (NG181), 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng181
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 11：危机、住院与法律

急性激越、拒食、自伤/伤人风险，可能需要住院。这一模块讲现场处理、住院指征和法律权益。

11.1 急性兴奋激越的现场处理

家里有人突然大声喊叫、砸东西、来回走、说有人要害他，那几分钟往往决定后面几周怎么过。这一页讲的是现场能做什么：先保证安全、怎么减少刺激、第一句话怎么说、什么时候该打 120 或 110、以及哪些做法看起来有用其实很危险。它不鼓励任何形式的强行制服。

一、先保证安全，再谈别的

激越（agitation）是一个描述性说法，指明显的坐立不安、情绪高涨、言语增多、动作不断，可能伴随威胁、打砸或攻击。它不是一种诊断，背后可能是幻觉或妄想的驱动，可能是极度恐惧，可能是疼痛、感染、低血糖等躯体问题，也可能是药物副作用（比如静坐不能）或酒精、兴奋剂的作用。

现场第一件事不是讲道理，是判断“现在有没有人可能受伤”。

几个具体动作，越快做越好：

- **拉开距离。** 保持大约两臂的距离，不要贴脸说话，不要站在对方正前方堵住去路。
- **站在出口一侧。** 让自己有一条退路，也让对方知道“你可以走”。堵住门会显著增加恐慌。
- **清掉危险物。** 刀具、剪刀、玻璃杯、热水壶、打火机、酒瓶、可投掷的重物，能拿走就拿走；拿不走就把人引开。药盒和农药、清洁剂也要注意。
- **减少在场的人。** 围观的人越多，越容易被理解成“他们要对付我”。指定一个人主谈，其他人退到另一个房间。
- **让孩子离开。** 不管孩子多大，都不要让他在现场“帮忙劝”。
- **关掉刺激源。** 电视、音响、刺眼的灯、一直响的手机。

如果对方已经持械、正在打人、或者把门反锁，不要试图自己解决，直接进入下面“什么时候打 110”的部分。

二、减少刺激：环境、距离、姿态

激越的人对外界刺激非常敏感。声音、光线、人数、目光，都会被放大。

声音：说话音量降到比平时低一点，速度放慢。不要几个人同时说，也不要隔着房间喊。安静本身就有降温作用。

光线：把大灯调暗或关掉一部分，但不要全黑——黑暗会加重不安和猜疑。

距离与姿态：侧身站，不要正面对峙；手放在看得见的地方，不要插兜、不要背手；不要俯视，能坐下就坐下，让双方视线高度接近。

时间感：给对方留出回应的空档。问完一句，等十秒。急于填满沉默，会让人觉得被逼。

身体接触：除非对方正在伤害自己或别人，否则不要主动触碰。突然的接触是激越现场最常见的升级点。

还有一点常被忽略：**先处理身体需求。** 渴、饿、憋尿、疼痛、太热、失眠好几天，都会让情绪更容易爆。递一杯水、问一句“要不要先去趟厕所”，有时比任何劝说都有效。

三、怎么说话

说话的目标不是“让他承认自己有病”，而是**让他感到安全一点点，愿意接受帮助**。这两件事差别很大。

不建议说	为什么	可以换成
“你冷静点”	否定了他此刻真实的恐惧	“我在这儿，我们不着急，慢慢说。”
“没人害你，那是假的”	直接争辩妄想，会把你也划进“他们”	“你觉得有人要害你，这一定很害怕。”
“你再这样我就报警”	威胁会加速升级	“我需要保证大家都安全，所以我们先坐下来。”
“你是不是又没吃药”	一开口就审问，容易触发对抗	“这几天是不是没睡好？”
“我是为你好”	把决定权拿走	“你想先做什么？喝水，还是坐一会儿？”

几条通用的做法：

- **自我介绍，叫名字。** “我是你姐，我在。”比“你听我说”有效。
- **说清楚你要做什么。** “我想把电视关了，太吵了。”提前说，不要突然动手。
- **短句，一次一个信息。** 激越时处理长句的能力会下降。
- **给两个选项，不给开放题。** “去客厅坐，还是去阳台站一会儿？”
- **承认情绪，不确认内容。** 可以承认“你很害怕”“你很生气”，不必承认“他们真的在监视你”。
- **重复。** 同一句话平静地说三遍，比换三种说法更稳。
- **允许沉默。** 不说话不等于失败。

如果对方开始能对话，可以慢慢转向具体的事：“要不要我陪你走一圈”“我们先吃饭，别的事待会儿说”。不要在这个时候讨论“你到底有没有病”，那是之后门诊的事。

四、什么时候打 120、什么时候打 110

这两个号码的分工，很多人搞不清。简单说：**120 管医疗，110 管人身安全和制止危害行为。** 很多时候两个都要打。

情况	打哪个	说明
意识不清、抽搐、高热、大汗、肌肉僵硬	120	可能是恶性综合征、感染、脑部问题
胸痛、呼吸困难、严重外伤、出血	120	先救命，精神问题随后处理
疑似服药过量、饮酒后昏迷、低血糖	120	带上药盒和空瓶，告诉急救人员吃了什么
木僵、缄默、拒食拒水超过一天	120 或急诊	可能是紧张症，需要精神科急诊评估
正在打人、砸东西、持械、纵火	110，同时 120	先制止危害，再送医
把自己反锁、站在窗台或楼顶	110，同时 120	不要自己冲上去拉
离家失联、可能自伤	110	报失联，提供照片、衣着、常去地点

打 110 时说清楚四件事：**具体地址（门牌、楼层、单元）、现场有几个人、有没有武器、有没有人受伤。** 不要只说“我家人情绪失控了”，这会让出警的人无法判断该带什么、该不该带约束工具。

打 120 时除了地址，还要说：**现在是不是清醒、有没有呼吸问题、有没有吃药、吃的什么药、有没有喝酒。** 把药盒、病历、医保卡放在门口，急救人员到了直接拿。

还要提醒一句：**报警不是“把家人送进派出所”。** 在多数情况下，110 的角色是制止正在发生的危险行为、协助送医，后续的评估和治疗仍然由医疗机构完成。提前把这句话跟家人说清楚，可以减少“被背叛”的感觉。

五、不要做什么

不要强行制服。 几个人一起按倒、压住胸口和背部，是现场最危险的动作。体位性窒息、横纹肌溶解、骨折、吸入呕吐物，都可能在这几分钟里发生。已经在用抗精神病药的人，体温调节和运动系统本来就可能不稳定，剧烈挣扎加高温，是恶性综合征的诱因之一。

不要自行捆绑。 用绳子、胶带、床单固定四肢，可能导致神经压迫、血液循环障碍、皮肤损伤，也可能被认定为非法限制人身自由。约束是在医疗机构里、没有其他替代办法时、由受过训练的人按规范实施的保护性医疗措施，需要记录和观察，不是家属可以自行采取的“土办法”。

不要围堵。 把人围在墙角、堵住门、几个人同时逼近，只会让“被攻击”的预期变成现实。

不要抢东西、不要突然从背后靠近。 除非对方正要伤害自己或他人。

不要灌药、不要往水里加药。 呛咳、误吸、剂量不可控，都可能致命。

不要激将。 “你打啊”“你敢吗”这类话，在激越现场是把火往上浇。

不要拍照录像发群。 事后传播会造成二次伤害，也可能涉及隐私侵权。

不要用“精神病”“疯子”当骂人的词。 尤其是当着本人的面。

不要在孩子面前复盘细节。 孩子需要的是“现在安全了”，不是全过程。

如果情况已经超出能力范围，正确的选择是退出来、锁好门、打 120 和 110，而不是“再试一次”。退出来不丢人。

现场平息之后，还有几件事要做。激越过后，家属常常会抖、会哭、会自责，这些都需要被看见，也需要被处理。

- [ ] 检查所有人有没有受伤，包括自己
- [ ] 把经过和时间点简单写下来，越具体越好
- [ ] 当天或第二天联系医生，说明这次发作
- [ ] 更新危机预案里的电话、医院和步骤
- [ ] 把危险物品收好，药交给一个人统一保管
- [ ] 让参与的人先睡一觉，复盘可以放到明天

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现意识不清、抽搐、高热、大汗、肌肉僵硬、心跳很快。
- 出现胸痛、呼吸困难、严重外伤或出血。
- 木僵不动、缄默不语、拒绝进食饮水超过一天。
- 明确说“有人要我死”，或出现命令性幻听。
- 已经发生打人、砸东西、持械、纵火，或站在高处、反锁房间。
- 疑似服药过量、饮酒后昏迷。

立即拨打 120；有即时人身危险时拨打 110；也可拨打 12356 心理援助热线。不要等“他自己冷静下来”。

参考来源

- NICE. Violence and aggression: short-term management in mental health, health and community settings (NG10), 2015. https://www.nice.org.uk/guidance/ng10
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体处置以现场专业人员判断和现行法律为准。

11.2 住院指征与自愿非自愿

住院是精神分裂症治疗里最让人紧张的一件事。有人担心“进去就出不来”，有人拖到出事才送。这一页讲什么情况需要住院、自愿和非自愿在法律上分别是什么条件、病房里大概会发生什么、出院前要准备什么。法律部分只讲原则，具体个案以现行法律和当地规定为准。

一、什么情况需要住院

住院不是“病重到某个分数”就自动触发，而是看**门诊能不能保证安全、能不能完成必要的治疗**。下面这些情形，通常是医生建议住院的理由。

情形	为什么门诊难以替代	常见处理
自杀念头明确、有计划或已有自伤行为	门诊无法做到全天看护	住院评估、环境安全管理、调整治疗
明确威胁他人、持械、打砸，或命令性幻听	需要安全环境和快速起效的处理	住院，必要时联合公安送诊
拒食拒水、木僵、缄默、蜡样屈曲	可能是紧张症，有脱水、衰竭风险	急诊评估，常需住院甚至物理治疗
严重药物不良反应	需要停药、观察、处理合并问题	住院监测
诊断不明确、需要连续观察	门诊每次只有十几分钟	住院观察、完善检查
合并严重躯体疾病或外伤	需要多科协作	综合医院或专科病房
门诊调整多次仍反复恶化	需要结构化治疗与护理	住院重新评估方案
家中无人照护、环境本身有风险	出院后无法保证服药与安全	住院同时联系社区资源

反过来说，也有一些情况**不一定需要住院**：症状存在但能配合门诊、有家属陪同、没有自伤伤人风险、调整方案可以在门诊完成。住院本身也有代价——脱离工作和社交、环境陌生、可能带来病耻感，这些都要一起权衡。

二、住院能做什么、不能做什么

能做的：

- 提供相对安全的环境，把刀具、窗户、危险物品管理起来。
- 24 小时护理观察，及时发现问题。
- 系统评估：精神检查、病史、体格检查、化验、心电图、必要的影像。
- 在可控条件下调整治疗，观察反应和副作用。
- 处理合并的躯体问题、物质戒断、拒食脱水。
- 让家属喘一口气，同时接受心理教育和沟通训练。
- 为出院后的社区随访、康复、复学复工做准备。

不能做的：

- 不能“关起来就没事”。住院只是把风险暂时降下来，真正的长期管理在出院之后。
- 不能保证“一次治好”。住院的目标是度过急性期、把方案稳定下来，不是根治。

- 不能替代知情同意。多数治疗仍然需要患者理解和同意，非自愿住院也不等于所有治疗都可以强制。
- 不能消除病耻感。住院记录属于敏感信息，隐私保护是另一个要单独处理的问题。

三、自愿住院

中国精神障碍的住院治疗实行**自愿原则**。也就是说，默认情况下，住院需要患者本人同意。

自愿住院的人，通常是自己觉得需要帮助，或者在家属劝说下同意。住院期间，患者提出出院，医疗机构应当按规定办理；如果医生评估认为病情仍需要继续住院，且符合法律规定的非自愿条件，需要走相应的法定程序，不能靠“拖着不办”或者“口头劝住”来解决。反过来，也不能因为家属不同意就强行留住一个不符合条件的患者。

自愿住院有一个常被忽略的好处：患者对治疗的参与度更高，出院后更容易接着吃药、接着复诊。所以如果能在自愿的前提下入院，通常比拖到非自愿要好。

四、非自愿住院：法律上的两类情形

非自愿住院是例外，不是常规。按照《中华人民共和国精神卫生法》的原则，对严重精神障碍患者实施非自愿住院，需要同时满足“诊断结论和病情评估表明需要住院”，并且属于法律规定的两类情形之一：

第一类：已经发生伤害自身的行为，或者有伤害自身的危险。 比如自杀未遂、明确的自伤计划、拒食到危及生命。

第二类：已经发生危害他人安全的行为，或者有危害他人安全的危险。 比如打伤他人、持械威胁、纵火。

几个要点需要说清楚：

- **前提是“严重精神障碍患者”**，并且经过诊断和病情评估。不是家属觉得“该住院”就能住院，也不是医院单方面决定。
- **诊断结论由精神科执业医师作出。** 疑似患者被送诊时，医疗机构不得拒绝为其作出诊断。
- **送诊的主体**通常包括近亲属、所在单位、公安机关等。出现正在发生的伤害行为时，公安机关会介入制止并协助送医。
- **患者和监护人有救济权利。** 对需要住院治疗的诊断结论有异议、不同意住院的，可以要求再次诊断和鉴定；再次诊断或鉴定认为不需要住院的，医疗机构不得对其实施住院治疗。
- **非自愿住院不是处罚。** 它不设“刑期”，住多久取决于病情评估和治疗需要，而不是“关够多少天”。
- **非自愿住院不等于强制一切治疗。** 用药、检查等仍然要按知情同意和诊疗规范处理；紧急情况下如何处置，法律和诊疗规范有具体规定。

还要提醒：非自愿住院的决定权在医疗机构和法定程序，不在家属。家属能做的是提供病史、表达观察、配合送诊，而不是“签字把人送进去”。反过来说，如果家属认为患者被不当收治，也有投诉和申请再次诊断的渠道，具体见 11.3 精神卫生法与权益。

五、病房流程与出院计划

入院当天通常会做这些事：医生问病史、做精神检查；护士做安全检查和物品登记；测体温、血压、体重；抽血、做心电图；告知病房制度、探视时间、通讯方式。

随身物品有讲究。刀具、打火机、火柴、玻璃器皿、绳子、皮带、大量现金、可能被用来伤害自己的物品，通常由病房代为保管。手机、充电器、眼镜、换洗衣物一般可以带，具体按病房规定。不同医院差别很大，入院前问清楚，比到了门口争执要好。

住院期间，治疗由医生、护士、心理治疗师、社工、康复师共同参与。家属可以做的是：按探视时间去、带对方习惯的东西、听护士说注意事项、参加家属课堂、把家里的情况如实告诉医生。

出院不是“办个手续”。 比较理想的出院准备，在出院前一两周就开始：

- ☐ 出院后的药名、用法、复诊时间已经写清楚
- ☐ 已经预约到具体的复诊号，而不是“回头再挂”
- ☐ 社区精防人员已知情，转介材料已提交
- ☐ 家里已经收好危险物品，窗户、阳台有防护
- ☐ 家属知道复发预警信号和危机时的联系电话
- ☐ 有书面的危机预案，家里人手一份
- ☐ 病假、复学、复工的手续已经开始办
- ☐ 知道出现什么情况要立刻回医院
- ☐ 出院后头两周由谁陪着，已经安排好

出院后的头几个月是复发的高峰期。药物、复诊、社区随访、家庭支持这四件事，任何一件掉链子，都可能把住院的成果还回去。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或明确说“不想活了”。
- 出现命令性幻听，或坚信有人要伤害自己或家人。
- 拒食拒水超过一天、木僵不动、缄默不语。
- 打人、砸东西、持械、纵火，或离家失联。
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗——立即急诊。
- 出院后药物断了、复诊没约上、社区联系不上——尽快联系医生，不要拖到下次。

拨打 120；有即时人身危险时拨打 110；也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议，也不构成法律意见。住院与收治的具体条件、程序以现行法律、司法解释和当地卫生健康部门规定为准。

11.3 精神卫生法与权益

很多人第一次接触《精神卫生法》，是在被送诊或被建议住院的时候。那一刻最需要的不是背法条，而是知道：默认规则是什么、例外在什么条件下成立、自己有哪些权利、被侵犯时找谁。这一页按这个顺序讲。它只讲原则，不构成法律意见；具体个案请咨询律师或当地法律援助机构。

一、自愿原则是起点

《中华人民共和国精神卫生法》2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行。它的核心取向可以概括成几句话：精神障碍的住院治疗实行**自愿原则**；精神障碍患者的人格尊严、人身和财产安全不受侵犯；患者享有教育、劳动、医疗、从国家和社会获得物质帮助等权利。

“自愿”不是一句口号，它意味着几件事：

- 默认情况下，住院要本人同意。
- 门诊、社区随访、康复服务，也应当尊重本人意愿。
- 不能因为“家里管不了”“怕丢人”“想让他戒酒”就把人送去住院。
- 不能因为一个人有精神障碍诊断，就默认他不能做决定、不能签字、不能工作、不能结婚。

同时，法律也承认现实：少数情况下，患者由于疾病本身的影响，无法做出对自己有利的判断，或者存在明确的伤害风险。这时才有例外。**例外需要严格的条件和程序，不是谁觉得危险就能用。**

二、非自愿住院的两类情形

按照法律的原则，对**严重精神障碍患者**实施非自愿住院，需要诊断结论和病情评估都表明“需要住院治疗”，并且属于以下两类情形之一：

情形	具体含义	常见例子
伤害自身	已经发生伤害自身的行为，或者有伤害自身的危险	自杀未遂、明确的自伤计划、拒食到危及生命
危害他人安全	已经发生危害他人安全的行为，或者有危害他人安全的危险	打伤他人、持械威胁、纵火、开车冲撞

程序上还有几个关键点：

诊断主体。 精神障碍的诊断应当由精神科执业医师作出。疑似患者被送诊时，医疗机构不得拒绝为其作出诊断。

送诊主体。 出现正在发生的伤害行为时，近亲属、所在单位、当地公安机关等可以采取措施制止并送诊。公安机关在协助送医、制止危害行为方面的角色，是法律明确规定的。

异议与救济。 患者或者其监护人对“需要住院治疗”的诊断结论有异议、不同意住院的，可以要求**再次诊断**；对再次诊断结论仍有异议的，可以依法委托**鉴定**。再次诊断结论或者鉴定报告表明患者不需要住院治疗的，医疗机构不得对其实施住院治疗。

期限与评估。 非自愿住院不是“关够多少天”。住院时间取决于病情评估和治疗需要，医疗机构应当定期评估，病情允许时应当及时办理出院或转为自愿。

不等于强制一切。 非自愿住院解决的是“留在医院接受治疗”的问题，不等于所有检查、所有用药都可以不顾患者意愿。具体到某一项治疗怎么处理，法律、诊疗规范和医院制度都有规定。

要特别说清楚：**家属没有“送人住院”的决定权。** 家属能做的是提供病史、表达观察、配合送诊、参与后续照护。最终是否收治，由医疗机构按法定条件和程序判断。如果家属认为患者被不当收治，同样有投诉和申请再次诊断的渠道。

三、知情同意

知情同意不是“签个字”，而是**在理解的基础上做决定**。它通常包含四件事：

1. 医生说明诊断、病情、建议的治疗方案。
2. 说明治疗的可能收益、风险和不良反应。
3. 说明有没有替代方案，以及不接受治疗可能有什么后果。
4. 患者在理解的基础上自愿同意，必要时签署书面同意。

几个容易混淆的地方：

- **同意可以撤回。** 签了字不等于永远有效，患者可以在任何时候改变主意，但改变主意后的处理要按规范来，不能简单“随他”。
- **紧急情况有例外。** 出现危及生命的情况时，医疗机构可以先行救治，事后再补记和告知。这不是“可以不告诉家属”，而是顺序不同。
- **科研和试验另有一套。** 涉及研究、试验性治疗时，需要伦理审查和单独的知情同意，不能用普通治疗同意书代替。
- **监护人签字不等于患者没有发言权。** 患者有能力表达意愿时，应当尊重其意愿；认为患者不具备决定能力，需要有依据和程序，不能由家属单方面宣布。

实际操作中，最有用的一句话是：“医生，我想知道这个治疗的收益和风险，还有别的选择吗？”这句话不冒犯，也不外行。

四、隐私、约束与隔离

隐私。 患者的姓名、肖像、住址、工作单位、病历资料，以及其他可能推断出身份的信息，都属于需要保密的范围。医疗机构、社区、用人单位、学校都有保密义务，法律另有规定的除外。

现实中常见的泄露方式很具体：病历随手放在护士站台面上、医生在走廊里讨论病情、单位人事部门收到诊断证明后到处传、家属在群里发照片。遇到这些情况，可以要求更正、要求停止传播，情节严重的可以投诉。

患者本人有权复印病历资料中的客观部分（如化验单、检查报告、出院记录），具体范围和流程按医院规定。出院时顺手复印一份，后面办残疾评定、医保、病假、复诊都用得上。

约束与隔离。 法律允许在特定条件下实施约束、隔离等**保护性医疗措施**，但条件很严：

- 必须是患者正在或将要发生伤害自身、危害他人安全、扰乱医疗秩序的行为；
- 必须是没有其他可替代措施；
- 必须遵循诊断标准和治疗规范；
- 必须记录在病历中；
- **禁止利用约束、隔离惩罚患者。**

约束的时长、观察频率、解除条件，由诊疗规范和医院制度规定。家属可以问三个问题：为什么用、用了多久、什么时候解除。如果发现被约束期间无人看护、被反绑、被长时间不解除，应当立即向护士站、医务科反映，必要时投诉。

歧视。 法律禁止歧视、侮辱、虐待、遗弃精神障碍患者。用人单位、学校在招录、入学、晋升中，不能仅因精神障碍诊断就拒绝或辞退；具体条款和举证方式，要看劳动、教育方面的法律和当地规定。

五、遇到问题找谁

维权的路径是有顺序的，从近到远、从快到慢。多数问题在第一步就能解决。

遇到的问题	先找谁	还可以找谁
对诊断或收治有异议	主诊医生、科主任	申请再次诊断、鉴定
治疗未告知、被强迫签字	医务科、医患沟通办公室	卫生健康行政部门投诉
病历、隐私被泄露	医院医务科、隐私保护负责人	12345、卫生健康行政部门
被不当约束、被虐待	护士站、医务科，立即	110 报警、12345
被单位辞退、被学校拒收	单位人事、学校相关部门	劳动仲裁、12348 法律援助
医保报销、救助申请被拒	医保经办机构	12345、上级医保部门
不确定自己有什么权利	12348 法律援助热线	当地残联、精神卫生社会组织

可以保留的材料，越早准备越好：

- ☐ 诊断证明、出院记录、门诊病历
- ☐ 知情同意书、治疗方案告知书
- ☐ 约束、隔离的记录（可要求复印）
- ☐ 收费清单、发票

- ☐ 与医院、单位沟通的书面记录或聊天截图
- ☐ 目击者姓名和联系方式

需要强调：**本页不是法律意见。** 每个案子的证据、程序、时效都不一样，是否起诉、怎么起诉，需要律师看材料后判断。法律援助对经济困难人群通常免费，可以拨打 12348 咨询。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> - 被非法限制人身自由、被殴打、被虐待——立即拨打 110。
> - 出现自杀念头、自伤行为，或命令性幻听。
> - 被拒绝提供必要的医疗救治，或治疗被无故中断。
> - 出现高热、肌肉僵硬、意识改变、拒食脱水。
> - 因维权、投诉导致情绪崩溃、失眠多日。
>
> 医疗急症拨打 120；人身安全受威胁拨打 110；法律咨询拨打 12348；心理支持可拨打 12356。

参考来源

- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议，也不构成法律意见。具体权利主张、投诉与诉讼，请咨询执业律师或当地法律援助机构，并以现行法律和当地规定为准。

11.4 监护、残疾、病假与医保

治疗之外，还有一堆“办事”的事：谁能在同意书上签字、能不能办残疾证、上班怎么请假、药费能报多少、社区有没有补助。这些事没人天生会，办错一次往往要重跑好几趟。这一页按事项拆开讲，只讲原则和路径，不写具体比例——因为各地标准差别很大，以当地政策为准。

一、监护人：谁当、做什么、怎么监督

监护人不是“管着这个人”的人，而是在法律上替他做决定、保护他权益的人。精神障碍患者不一定都需要监护人；只有在不能辨认或者不能完全辨认自己行为时，才涉及监护问题。

谁可以当。 成年人监护通常按顺序确定：配偶；父母、子女；其他近亲属；其他愿意担任监护人的个人或者组织（需经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意）。没有依法具有监护资格的人时，由民政部门担任，或者由具备条件的组织担任。

意定监护。 具有完全民事行为能力的成年人，可以事先以书面形式确定自己的监护人，约定在自己将来丧失或部分丧失民事行为能力时由谁监护。这种做法在病情稳定期特别值得考虑：趁自己还能决定，把决定权交给自己信任的人，比事后由亲属争执要好。做意定监护建议办理公证，减少后续争议。

职责范围。 主要包括：保护人身权利和财产安全；代理民事活动；在医疗场景中参与知情同意；管理财产时以被监护人利益为原则；尊重被监护人的真实意愿，最有利于被监护人。

几条边界。

- 监护不是限制人身自由。把患者锁在家里、不让出门，可能构成非法限制人身自由。
- 监护不是替对方做所有决定。患者有能力表达意愿时，应当尊重。
- 不得虐待、遗弃，不得随意处分其财产，不得放弃其应得的医疗。
- 不履行职责、侵害权益的，有关个人或组织可以向法院申请撤销监护人资格，并依法另行指定。

监督与变更。 居委会、村委会、民政部门、残联、其他近亲属，都可以对监护进行监督。认为监护人严重失职的，可以申请变更。现实中很多家庭没人愿意“撕破脸”，但财产被侵占、治疗被拖延这类事，越早介入越好。

二、精神残疾评定：有什么用、怎么办

什么是精神残疾。 指各类精神障碍持续一年以上未痊愈，存在认知、情感和行为障碍，影响日常生活和社会参与。精神分裂症是最常见的原因之一。

分级。 精神残疾通常分为一至四级，一级最重，评定依据包括社会功能损害程度、生活自理能力、是否需要持续监护等，由指定医疗机构按国家标准评定。分级不是“贴标签”，而是决定能享受哪些服务的依据。

有什么用。

- 申请困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。
- 参加城乡居民医保时可能获得资助。
- 享受社区康复、日间照料、辅助性就业等服务。
- 在就业、税收、法律援助等方面可能有相应政策。
- 办理提前退休、劳动能力鉴定时作为材料之一。

怎么办。 一般流程是：向户籍地或居住地的残联（或社区受理窗口）提出申请，提交诊断证明、病历、身份证明等；残联受理后安排到指定医疗机构评定；评定结论经审核后制证发放。不同地方的具体窗口和材料清单不一样，先打当地残联电话问清楚，能少跑很多路。

要权衡的地方。 残疾评定会形成正式记录，进入残疾人数据库。多数情况下这带来的是服务和补贴，但也可能在某些商业保险投保、部分职业准入时被问到。法律禁止基于残疾的歧视，现实中的摩擦仍然存在。是否申请，取决于你更需要哪一头。这个问题没有标准答案，可以和家人、医生、残联工作人员分别聊一聊。

复评。 病情或功能发生明显变化时，可以申请重新评定。不是“评一次定终身”。

三、病假、医疗期与工作

病假。 需要停工治疗时，凭医疗机构出具的病假证明向单位请假。病假证明通常只需写明建议休息的时间，是否披露具体诊断由本人决定；单位要求提供诊断材料的，注意控制知悉范围，避免被随意传播。

医疗期。 企业职工患病或非因工负伤需要停工医疗时，享有一定的医疗期。医疗期的长短与实际工作年限、在本单位工作年限有关，从几个月到两年左右不等，具体按国家和当地规定执行。医疗期内，单位一般不能随意解除劳动合同；病假工资的标准各地不同，但通常有下限。

医疗期满之后。 如果不能从事原工作，也不能从事单位另行安排的工作，单位可以依法解除劳动合同，但需要支付经济补偿，并可能涉及医疗补助费。这类情况建议先咨询当地劳动保障部门或法律援助，不要口头答应“自己辞职”。

劳动能力鉴定。 病情长期影响劳动能力时，可以申请劳动能力鉴定，用于病退、退职或工伤保险等程序。鉴定需要病历、诊断证明、检查报告，流程由当地人社部门安排。

复工。 复工不一定一步到位。可以先半天、先轻岗、先居家，和单位协商“合理便利”，比如避开夜班、减少连续加班、允许定期复诊。这些安排不丢人，很多慢性病都是这样管理的。

被辞退、被拒录怎么办。 法律禁止因残疾歧视劳动者。遇到明显不合理的辞退或拒录，先保留证据（通知、聊天记录、录音），再走劳动仲裁或拨打 12348 咨询。不要因为“怕麻烦”就签下“自愿离职”。

四、医保与费用

基本医保。 职工医保和城乡居民医保是两条主线。精神分裂症的门诊和住院费用，按参保地政策报销。具体比例、起付线、封顶线各地不同，不要按网上的数字估算自己的花费。

门诊慢特病。 许多地区把精神分裂症等严重精神障碍纳入门诊慢性病或特殊病种保障，办理备案后，门诊开药可以按更高比例报销。病种名称、认定标准、办理材料各地不同，向参保地医保经办机构或医院医保办咨询。这是最值得花半天去办的一件事。

大病保险与医疗救助。 个人负担较重时，大病保险会在基本医保之后再次报销；符合条件的困难人群还可以申请医疗救助。这两项通常需要提交材料审核，不会自动到账。

免费服药项目。 部分地区的严重精神障碍管理治疗项目会为困难患者提供基本抗精神病药物，由社区精防人员管理。有没有、覆盖哪些药，取决于当地，直接问社区。

异地就医。 长期在外地居住的，办理异地就医备案后可以直接结算，否则要先垫付再回参保地报销。备案可以在国家医保服务平台或当地医保窗口办理。

药费之外的钱。 交通、陪护、误工、营养，往往比药费更高。算家庭预算时要把这些算进去，别只盯着药价。

五、社区补助与办事清单

常见补助。

- 困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴（通常合称“两项补贴”）。
- 最低生活保障、特困人员救助、临时救助。
- 精神障碍社区康复服务：康复站、日间照料、阳光心园一类的机构，多数免费或低价。
- 住房、取暖、子女教育等方面的专项救助。

这些项目的名称、金额、条件由地方确定，且会调整。最可靠的问法是：“我这种情况，在本地能申请哪些？”——问社区民政窗口、残联和医保经办机构各一遍，答案往往不一样。

事项	找谁	大致需要什么	注意什么
监护确定或变更	居委会/村委会、民政、法院	身份证明、诊断材料、亲属关系证明	意定监护建议公证
精神残疾评定	当地残联、指定医院	诊断证明、病历、身份证明、照片	先电话确认材料和窗口
门诊慢特病备案	医保经办机构、医院医保办	诊断证明、病历、申请表	办完再开药，能省不少
病假与医疗期	单位人事、劳动保障部门	病假证明、诊断材料	控制诊断信息知悉范围
劳动能力鉴定	当地人社部门	病历、检查报告、申请材料	用于病退、退职
两项补贴	街道/乡镇民政窗口、残联	残疾证、收入证明、银行账户	每年可能需要复核

可以提前备好的材料：

- ☐ 身份证、户口本、居住证
- ☐ 诊断证明、出院记录、门诊病历
- ☐ 近一年的化验和检查报告
- ☐ 残疾人证（如已办理）
- ☐ 医保卡、银行卡
- ☐ 收入证明、低保证明（如申请救助）
- ☐ 监护关系证明（如由家属代办）
- ☐ 一份写清楚“谁在吃什么药、看哪个医生”的便条

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 因为费用、报销、办事受阻而准备停药——先联系医生或社区精防医生，通常有比断药更好的办法。
- 出现自杀念头、自伤行为，或命令性幻听。
- 被辞退、被拒保、被要求“签字放弃”后出现严重失眠、崩溃。
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、拒食脱水。

医疗急症拨打 **120**；人身安全受威胁拨打 **110**；法律与劳动纠纷咨询 **12348**；政策咨询可拨 **12345**；心理支持可拨 **12356**。

参考来源

- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 中国严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）及地方社区管理文件.
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议，也不构成法律意见。监护、残疾评定、病假、医保与补助的具体条件、材料和标准，以现行法律和当地政策为准。

模块 12：家庭、社会与污名

家庭不是病因，但可以是重要的支持系统。这一模块讲照护、沟通、边界、病耻感和社会融入。

12.1 家属照护手册

家人得了精神分裂症，最先被改变的往往不是“治疗方案”，而是每天的作息、饭桌、睡眠和钱。这一页把“照护”拆成可以照做的动作：怎么提醒吃药、怎么看出复发苗头、家里要提前准备什么、你自己快撑不住时怎么办。适合与患者同住或经常联系的家属读，读完可以照着做一张属于你们家的照护清单。

先把位置摆正：你是照护者，不是医生，也不是病因

二十世纪中期曾有“精神分裂症源性母亲”的说法，把发病归咎于母亲冷淡、控制。这个观点后来被研究反复否定：家庭沟通会影响病情走向，但不是致病原因。【指南】今天的共识是，家庭既不是病因，也不是旁观者，而是治疗的一部分。

照护者最容易掉进两个坑。第一个是**替医生干活**：自己判断该加药还是减药、把别人的处方拿来试、觉得“这次看起来好了”就停。第二个是**替患者承担一切**：把所有家务、钱、社交、复诊都接过手，患者只剩下吃饭和睡觉。前者危险，后者会让功能退化得更快。

可以记住三条边界：

- 药物、诊断、住院、法律相关决定，交给医生和专业人员，你负责提供信息和陪同。
- 你能做的是三件事：**稳定日常、观察记录、在需要时把人送到医生面前**。
- 照护是以年计的长期项目，不是冲刺。今天没做好，明天还能接着做。

日常照护：把“过日子”拆成能做的事

急性期过后，很多家庭会陷入“什么都不敢让他做”的状态。更稳妥的做法是分层：先守住底线，再一点点加回生活内容。

层次	具体做什么	谁主导	常见误区
底线：先稳住	规律起床与入睡、按点吃饭、每天出门十分钟、按时服药	家属主导，患者参与	怕冲突就完全随他作息
恢复：加回内容	自己洗碗、买菜、做饭中的一小步、固定一项活动	一起商量，患者做决定	一次加太多，失败后全撤
维持：接近平常	上班或上学、自己管一部分钱、维持两三个朋友	患者主导，家属后退	家属不肯放手

睡眠是第一块基石。 连续几天睡得很少、白天也不困，常常是复发的前哨，而不是“精神变好了”。可以做一个简单的睡眠记录：几点上床、大约几点睡着、夜里醒几次、白天睡多久。记录本身不治病，但它能让医生在几分钟内看到趋势。

吃饭和体重需要盯着。 二代抗精神病药容易带来体重增加、血糖血脂变化，这不是“嘴馋”。【指南】如果家里能统一饭菜结构、减少含糖饮料、每周固定称一次体重，比事后责怪有用得多。

活动要具体到动作。 “多出去走走”几乎不会被执行；“每天晚饭后和我走到小区门口再回来”才可能被执行。从五分钟开始，稳定两周再延长。

环境和刺激要降下来。 急性期家里人多、声音大、争论多，症状往往更乱。可以约定：客厅电视音量固定、不在他面前讨论病情、来客提前说、给他一个可以关门的角落。

隐私和尊重不能省。 不翻手机、不偷看日记、不在亲戚群里直播病情。被监视感本身就是很多患者的症状之一，翻找会直接把它坐实。

服药提醒：不靠唠叨，靠流程

提醒吃药最容易变成每天三次的拉锯。有效的方式通常不是“更有说服力地说”，而是把决定变成流程，减少每次都要重新谈判的次数。

方式	优点	局限	适合谁
口头提醒	灵活、有人情味	容易变成唠叨和争吵	关系尚可、记性尚可
手机闹钟或提醒应用	不依赖家属情绪	需要患者愿意配合设置	有手机、愿用工具
分装药盒	一眼看出漏没漏	需要每周分装一次	多种药、易忘
家属保管、当面服用	漏服最少	容易引发控制感冲突	急性期、自知力差
长效针剂	不用每天想着	需医生评估、要按时去打	反复漏服、胃肠吸收差

> 长效针剂是不是选项，要和医生讨论，不要自己觉得“打一针就省事”就当成方案。

每周花五分钟做一次“药事检查”：

- ☐ 药盒里的药和处方是否一致，有没有过期或混装
- ☐ 这周漏了几次，漏在什么时间、什么情境
- ☐ 有没有新出现的手抖、僵硬、坐不住、流口水、月经变化、体重变化
- ☐ 有没有自行加量、减量、用保健品或中成药替代
- ☐ 下次复诊是哪天，需不需要提前

有三件事不要做：**不要把药碾碎混进饭里**，这会让患者发现后彻底不信任你，也可能改变药物吸收；**不要用“不吃药就送你去医院”来威胁**；**不要因为“最近挺好”就自己减量**。突然停药可能带来失眠、激越、幻觉加重，也会明显抬高复发风险。【指南】患者拒药时，正确动作是记下拒药的时间和理由，联系医生调整方案，而不是把冲突升级成权力斗争。

复发观察：记什么、多久看一次

复发很少毫无征兆。多数人在症状明显之前，会先出现睡眠、情绪、说话方式的变化。这些变化单独看都不像“病”，连起来才有意义。

信号类别	具体表现	记录方式
睡眠	入睡变难、总时长缩短、白天不困	每天一行
情绪	莫名紧张、易怒、低落、坐立不安	每周打分零到十分
想法	觉得被针对、被议论、被监视，开始查门锁、拉窗帘	记原话，不评价
言语与行为	说话跳跃、自言自语、突然不出门、卫生明显下降	记频率
用药	漏服增多、主动说“我没病”、藏药	记次数

建议固定**每周一次、十分钟**的家庭复盘：这周睡得好不好、有没有出现上面任何一条、下周需要谁做什么。记录用手机备忘录就够，复诊时给医生看，比临场回忆可靠得多。

需要提醒的是：阴性症状（少说话、没劲、表情少）和药物镇静、抑郁，看起来很像，家属很难分清。**不要自己判断“他是懒”还是“他病了”**，把观察写下来交给医生。【临床经验】

危机准备：平时做好，出事不慌

危机处理的成败，常常取决于事前有没有准备。趁平静的时候，和患者一起把下面几件事做完。

- ☐ 写一张**应急卡**：诊断、目前用药与剂量、药物过敏史、主诊医生与医院电话、监护人及紧急联系人、医保卡放哪
- ☐ 定好**去哪家医院**：最近的能看精神科急诊的医院，白天和夜间分别怎么走，谁陪同
- ☐ 写一份**危机预案**：出现哪些情况要联系医生、哪些要直接去急诊、谁负责打电话、谁负责陪着
- ☐ 处理**家里的危险物品**：不是全部没收，而是减少随手可及——药物由家属保管、刀具与农药集中上锁、阳台窗户加限位
- ☐ 准备**钱与证件**的备用方案：住院押金、身份证、医保卡放在固定位置
- ☐ 记下**社区资源**：社区精防医生、个案管理员、当地心理援助热线；地方号码以当地卫健委公布为准

危机预案最好由患者本人参与制定，哪怕他只同意其中一部分。他参与过的计划，执行起来阻力小得多。【临床经验】

照护者自我照顾：这不是自私

长期照护的家属，抑郁、焦虑、失眠和躯体不适都很常见。你倒下，整个支持系统就断了，所以自我照顾是照护工作的一部分，不是额外的奢侈。

- **排班，而不是硬扛。** 一位家属主责、另一位备份，每周至少留半天完全交出去。
- **允许自己做不到。** 你不可能二十四小时监测，也不可能保证不复发。

- **找同类。** 家属互助团体、社区心理教育课程，比独自消化有效。【研究】
- **保留一件与病无关的事。** 一份工作、一个爱好、一段朋友关系，都是你的锚。
- **必要时自己就诊。** 持续两周以上的失眠、食欲改变、提不起劲、什么都不想做，值得看医生。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

尽快联系医生（当天或次日）

- 连续几天睡眠明显减少，或整天卧床不起
- 出现新的猜疑、被监视感，或开始自言自语、对着空气说话
- 漏服明显增多，或明确表示要停药
- 出现手抖、僵硬、坐不住、走路不稳、吞咽呛咳、月经紊乱、体重快速变化
- 情绪持续低落、说“没意思”“拖累你们”

立即去急诊或拨打 120（必要时 110）

- 有自杀念头、计划或自伤行为
- 出现命令性幻听，或明确威胁要伤害他人
- 木僵、缄默、拒食、拒水、违拗、蜡样屈曲（可能是紧张症）
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快（可能是恶性综合征）
- 服用氯氮平后发热、咽痛、口腔溃疡、极度乏力（需立即查血常规）
- 进食呛咳、呼吸困难、意识不清、抽搐、胸痛、晕厥

常见问题

“他不肯吃药，我能不能把药藏在饭里？”不建议。藏药一旦被发现，信任很难修复，还可能影响吸收和剂量准确性。更稳妥的做法是记录拒药情况、联系医生，讨论换药、简化方案或长效针剂。

“他整天躺着，是不是懒？”阴性症状、药物镇静、抑郁、睡眠紊乱都会表现成“躺着”。这个判断交给医生，你负责记录持续多久、有没有伴随其他变化。

“要不要让他搬出去独立住？”看功能，不看诊断。能自己管理药物、做饭、处理钱和突发情况，就可以逐步尝试；可以先用“半独立”过渡，比如一周住几天，保留随时回头的选项。

“亲戚问起来，我该怎么说？”你有权不说。可以准备一句固定回答：“他在调理身体，需要安静。”是否公开，是患者和自己的选择，不是义务。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178

- NICE. Rehabilitation for adults with complex psychosis (NG181), 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng181
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

12.2 沟通与边界

和患精神分裂症的家人说话，难的地方往往不是“没话说”，而是每句话都可能变成争论：他说有人在监视，你说没有；他说药是毒，你说必须吃。这一页讲三件事：怎么谈幻觉和妄想而不吵起来，怎么在不争辩的同时不纵容，怎么把边界设在行为上而不是人身上。适合每天要和患者打交道的家属读。

为什么争辩没有用

妄想的定义就是“即使有相反证据也坚持的信念”。它不像误会，靠摆事实就能纠正。你越举证，他越可能把你也归进“他们那一伙”，沟通的门就此关上。【指南】

争辩还有三个副作用：一是把注意力从“怎么过日子”转移到“谁对谁错”；二是让家里充满敌意，而敌意和批评恰恰与更高的复发风险相关；三是让他学会不再跟你讲真实体验，症状转入地下，你反而更晚发现变化。【研究】

所以目标不是“说服他承认自己有病”，而是：**让他愿意继续跟你说话，让危险行为不发生，让治疗能继续。**

谈幻觉：把它当成一种真实发生的体验

幻听对患者来说是“真的听见了”，不是想象。你否认声音存在，等于否认他的感官；但你附和“是有人在骂你”，又会加固他的解释。

可以走中间那条路：**承认体验，不确认解释。**

- “你听到的那个声音，现在还在说吗？说的什么？”
- “听起来很难受。它一直在，还是有时候没有？”
- “我没听见，但我相信你听见了。”
- “那个声音让你想做什么吗？”

最后这句是安全评估的关键。幻听本身不可怕，可怕的是**命令性幻听**——声音叫他去伤害自己或别人。一旦出现，不要辩论声音真假，先处理安全。

谈妄想：不背书、不揭穿、不辩论

三种常见回应各有代价：

回应方式	说法示例	短期效果	长期代价
直接否定	“根本没人跟踪你，你想多了”	终止话题	他觉得你不懂、不可信，转为隐瞒
附和	“对，他们就是在监视你”	他当下安心	加固妄想，日后你纠正会更难
承认感受、不下结论	“你觉得被盯着，这让你很紧张，是吗”	他愿意继续说	需要反复练习，短期看不到效果

第三种最费力，但最稳。具体可以说：

- “我不怀疑你有这种感觉。我这边没看到那个人，但我想知道你是怎么发现的。”
- “如果真有人在盯你，你会希望我做什么？”
- “这件事我们先记下来，下次问医生。”

不要做的：偷查他的手机来“证明”他没被监视，然后拿结果去对质；不要在亲戚面前复述他的原话当笑话；不要用“你再这样我就……”来换他放弃某个想法。

不争辩，也不纵容：把“体验”和“行为”分开

这是整套沟通里最有用的一条线：

- **体验**：他听到什么、相信什么，你不评判，也不需要同意。
- **行为**：他做什么、说什么、对谁做什么，需要有规矩。

举例：

情境	可以接受	不能接受
听到骂人的声音	告诉你、戴耳机、回房间	因声音而砸东西、打人
觉得邻居针对他	拉窗帘、跟你讨论、找医生谈	半夜去敲邻居门对质
不想吃药	说出顾虑、和医生讨论换方案	把药藏起来、假装吃了

最后那一栏不是“道德问题”，是安全问题。你要传递的信息是：“你的感受我接住了，但伤人、砸东西、半夜出门这几件事，我们家不做。”

设定边界：对行为，不对人

边界不是惩罚，是把“我能做什么、不能做什么”说清楚。有效的边界有三个特点：**具体、可执行、事先说**。

- **具体**：“你半夜两点在客厅大声说话，我会睡不着”比“你要考虑别人”有用。
- **可执行**：说“再这样就送你住院”，如果你做不到，边界就作废了。
- **事先说**：在平静时商量，而不是在冲突最高点宣布。

一个可用的句式：**当（具体行为）发生时，我会（具体动作），因为（影响）。**

> “当你凌晨在客厅开灯说话，我会请你去房间，因为孩子第二天要上学。”
>
> “当你对我说难听的话，我会离开房间十分钟，等你平静再谈。”

说完要真的做。做不到的边界比没有边界更伤信任。

同时要留出**可以商量的空间**。边界不是把生活切成“听话”和“不听话”。比如他坚持不去日间康复站，可以退一步：一周去一次，或者先只参加半天。

降低“高情感表达”：少一点批评、敌意和过度卷入

“高情感表达”是研究里的一个概念，指家属的三种状态：**批评多**（总指出他哪里不对）、**敌意明显**（把人整体否定）、**过度卷入**（替他做所有决定、自己的情绪完全绑在他的病情上）。这类家庭氛围与更高的复发风险相关，而结构化的家庭干预能降低复发。【指南】【研究】

降低它不需要“忍着不说话”，而是换几种说法：

高情感表达的说法	换成	为什么
“你就是懒，整天躺着”	“你今天躺了一整天，是没力气，还是没事做？”	从评判人变成描述事
“你再不吃药就完了”	“我担心你不吃药会难受，我们一起跟医生说”	从威胁变成同盟
“我为你牺牲了一辈子”	“我需要休息一下，今晚你洗碗”	从道德债变成具体请求
“你什么都别管，我来”	“这两件事你选一件做”	从替代变成给回控制感

还有几个通用技巧，做起来比听起来难：

- **一次只说一件事。** 症状本身会损害工作记忆，五件事一起说，等于什么都没说。
- **短句、慢一点、留停顿。** 说完停三秒，等回应。
- **写在纸上。** 复诊安排、吃药时间、家里的约定，写下来贴在冰箱上，比重复十遍有效。
- **先问再给建议。** “你想听我的想法吗？”这句话能省掉一半冲突。
- **不要用反问句。** “你觉得这样对吗？”在症状活跃时会被听成攻击。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

尽快联系医生（当天或次日）

- 沟通明显变难：说话跳跃、答非所问、突然不说话
- 出现新的被监视、被控制、被替换的想法
- 明确表示要停药，或已经连续漏服
- 情绪持续低落、说自己“拖累家里”
- 家里冲突频次明显上升，你已经开始害怕回家

立即去急诊或拨打 120（必要时 110）

- 命令性幻听，声音让他去伤害自己或别人
- 明确说出要伤害某人，或有具体计划
- 已经发生打人、砸东西、持械、堵门等行为
- 木僵、缄默、拒食、违拗（可能是紧张症）
- 出现高热、肌肉僵硬、意识改变

容易踩的坑

坑一：把“不争辩”理解成“什么都顺着”。 不争辩是不争论真假，不是取消规矩。该说的“不能打人”必须说。

坑二：在症状最重的时候讲道理。 急性期做心理教育、谈人生规划，基本无效。先把症状压下来，再谈这些。

坑三：全家口径不一致。 一个人说“必须吃药”，另一个人偷偷说“不想吃就算了”，患者会立刻找到缺口。大人之间先对齐，再跟患者谈。

坑四：把沟通当成一次性任务。 谈一次没谈通很正常。这类对话是长期的、反复的，进展常以月计。

坑五：自己憋着。 长期压着情绪，最后往往以一次大爆发收场。家属也需要有人听自己说话，家属互助团体或心理咨询都可以。【临床经验】

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- NICE. Violence and aggression: short-term management in mental health, health and community settings (NG10), 2015. https://www.nice.org.uk/guidance/ng10
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

12.3 病耻感与社交

比症状更难摆脱的，常常是“别人会怎么看”。有人不敢去社区医院拿药，有人把药盒撕掉标签，有人在同学问起时说自己“在休学养病”。这一页讲病耻感从哪里来、它怎么一点点缩小一个人的生活，以及要不要告诉别人、怎么重新交朋友。不劝你“勇敢公开”，也不劝你“永远藏着”。

病耻感从哪里来：四种，不是一种

“病耻感”不是一个模糊的情绪，它至少有四层，搅在一起时才最难对付。

类型	谁持有	典型表现	能做什么
公众污名	社会大众	觉得“精神病”等于危险、不可预测、治不好	接触真实的人、准确的信息
结构污名	制度与机构	就业体检、保险、入职问询、租房被拒	依法主张权益、找专业支持
内化污名	患者本人	“我是废人”“我不配”“我这辈子完了”	认知工作、同伴支持、被看见
连带污名	家属与身边人	不敢跟亲戚说、觉得抬不起头	家属自己的支持团体

分清这四层很有用：**内化污名不是性格软弱，是社会态度被搬进了心里。** 你不需要先“想开”，才能开始生活；很多人的顺序是反过来的——先恢复一点点生活，想法才慢慢松动。

病耻感怎么起作用：一条下滑的链条

它的伤害通常不是一次打击，而是一个循环：

1. **预期被拒绝** → 不敢约朋友、不敢投简历、不敢去社区活动。
2. **回避** → 社交圈缩小，工作与学习机会减少，生活只剩家和医院。
3. **技能与信心退化** → 更确信“我确实不行”。
4. **更深的回避** → 症状与抑郁加重，复发风险上升。

这条链条上，最容易被忽略的是第二步。很多人以为“等病好了再去社交”，但社交本身是康复的一部分，长期隔离会让阴性症状和认知损害显得更重。【研究】

还有一个常见误会值得说清：媒体常把精神分裂症与暴力绑在一起，这让公众高估了危险。实际上大多数患者并不暴力，暴力风险与具体症状、物质使用、治疗中断等情境因素相关，不能用来给一个群体贴标签。【指南】理解这一点，不是为了替谁辩护，而是为了让你在听到歧视性言论时，知道那不是事实。

要不要告诉别人：没有统一答案，只有分层决定

“公开还是不公开”是个伪选择。真实的选择是：**对谁、说多少、什么时候说、说到什么程度。**你可以对家人说全部，对好朋友说一部分，对同事什么都不说。这三种都不丢人。

做决定前，可以问自己四个问题：

1. 这个人**需要知道**吗？（需要为我调整工作、需要在我状态差时搭把手）
2. 说出来可能得到什么？（理解、便利、陪伴）
3. 说出来可能要承担什么？（被议论、丢机会、关系变化）
4. 如果结果是坏的，我有没有退路？

对象	通常建议	说明
主诊医生、心理咨询师	全部说	信息不全，判断就会偏
同住家人	大部分说	他们需要知道如何识别复发、如何应急
极亲近的朋友	可选择部分说	说“我在治疗一个会反复的病”通常够用
同事、同学、邻居	默认不说，按需说	需要请假或调整任务时，可只对直属上级说
雇主、人事部门	视权益需要	涉及合理便利时再谈，先了解自己的权利
公开社交平台	建议谨慎	一旦发布难以收回，可先观望

如果决定说，可以准备一句“标准答案”，避免临场解释：

> “我之前有一段时间生病了，是精神方面的，现在在治疗、在恢复。有些事可能需要你配合一下。”

这句话的好处是：给了信息，没给细节，也没把自己放在需要被同情的位置上。

不要被“公开能减少污名”绑架。 公开确实能帮助公众认识这个病，但那是**愿意公开的人**做的事。不愿意公开是正当选择，不是懦弱，更不是“不够努力”。【个人体验】

应对内化污名：几个具体动作

内化污名最难的地方，是它听起来像“事实”而不是“看法”。下面这些做法不是让你自我安慰，而是让那些“事实”接受检验。

- **把句子写下来，再改写。** “我这辈子完了”可以改成“我现在不能上班，但我还能做饭、能遛狗、能每周见一次朋友”。不是硬拗成正面，而是把绝对句改成有范围的句子。
- **区分“病”和“我”。** “我有精神分裂症”和“我是精神分裂症患者”是两句话，前者把一个病放在生活的一部分，后者把整个人交给它。
- **收集反例。** 每当你做成一件小事——按时复诊、坐公交去一趟超市、给朋友回一条消息——记下来。内化污名靠记忆筛选维持，反例要主动积累。
- **减少“解释的义务”。** 你不需要向每个人证明自己正常。别人问起，你有权说“这个我不太想聊”。

- **找“见过世面”的人。** 同伴支持团体里那些已经工作、已经当父母、已经稳定多年的人，能提供一种很难从别处得到的信息：这条路有人走过。【研究】

重建社交：从最小的一步开始

社交不是“变得外向”，是“恢复和人打交道的机会”。分级来做，比一步到位稳。

- ☐ **第一级（第一到第二周）**：每天出门一次，买一样东西、走十分钟；给一个熟人回一条消息
- ☐ **第二级（第三到第六周）**：固定一项有结构的活动——兴趣班、社区活动室、志愿服务、宗教场所活动
- ☐ **第三级（第二到第三个月）**：和一个人单独见面，一小时以内，地点选安静的公共场所
- ☐ **第四级（第三到第六个月）**：参加小团体（三到六人），有共同任务，比如一起做饭、打球、做手工
- ☐ **第五级**：恢复一两个可以长期维持的关系，允许对方知道自己的一部分情况

选择活动时，优先看三个条件：**有固定时间**（不用每次决定去不去）、**有具体任务**（不必一直找话题）、**可以随时离开**（不至于被困住）。有结构的活动比纯聊天更容易进入。

社交技能训练对“不知道说什么”“容易冷场”“不敢拒绝”这类困难有帮助，通常是团体形式，可以问医生或康复机构有没有。【研究】

要接受一件事：社交恢复会有反复。这周能去，下周不想去，不代表前功尽弃。把“去了几次”而不是“表现好不好”当作指标，压力会小很多。

家属自己的病耻感

家属的病耻感常被忽略，但它真实存在：不敢跟亲戚说、在单位回避“家里怎么样”的话题、觉得是自己没教好。

几点提醒：

- **你不是病因。** “父母教育不当导致精神分裂症”的旧说法已被否定，家庭氛围影响病程，但不是致病原因。【指南】
- **你可以有自己的边界。** 不需要向所有亲戚交代病情。准备一句固定回答即可：“他在调理，需要安静。”
- **找一个能说真话的人。** 家属互助团体、心理咨询、一位嘴严的朋友，都比独自消化好。
- **别把孩子拉进“保密同盟”。** 让未成年子女一起承担秘密，负担往往超出他们的能力。可以用他们能懂的话说一部分。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **尽快联系医生（当天或次日）**

- 因为怕被看见而停药、不去复诊、拒绝出门超过两周
- 情绪持续低落、自责加重、说“我是个负担”
- 遭遇歧视或羞辱后，出现明显失眠、惊恐、回避
- 社交退缩伴随卫生下降、说话变少、昼夜颠倒

立即去急诊或拨打 120（必要时 110）

- 出现自杀念头、计划或自伤行为
- 说“我消失了对大家都好”这类告别性表达
- 因被歧视而出现激越、威胁他人或报复性言语
- 出现命令性幻听、木僵拒食、意识改变

常见问题

“单位要求填精神疾病史，必须写吗？”这涉及法律和具体情境，本页不提供法律意见。一般原则是先了解当地规定和自身权益，必要时咨询专业法律渠道；以现行法律和当地政策为准。

“我在网上看到有人说这病治不好，是真的吗？”精神分裂症的病程差异很大，有人一次发作后长期稳定，有人需要长期治疗。把它说成“都治不好”既不准确，也会直接喂养内化污名。具体预后要和自己的医生谈。【指南】

“孩子在学校被议论，要不要转学？”先评估：议论是偶发还是持续、学校是否愿意处理、孩子自己的意愿。转学能解决一时，但若沟通与支持没建立，问题常会重演。

“我不想让邻居知道，是不是很没出息？”不是。隐私是权利，不是羞耻。愿意公开的人有他们的理由，不愿意公开的人也有充分理由。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- NIMH. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

12.4 工作、学习与社区融入

“还能不能上班”“还能不能上学”是很多家庭在急性期过后最先问的问题。这一页讲的是：怎么分阶段回去、有哪些支持可以借力、权益和合理便利大致包括什么。它不是“励志复出指南”，也不承诺回到病前状态；目标是把“参与”一点点加回来，同时不把已经稳定的东西赌进去。

先看阶段，而不是先看“能不能”

“能不能工作”这个问法太粗。更有用的问题是：**现在能稳定承担多少？** 判断依据不是诊断，而是下面几项的实际表现：

- 睡眠是否连续两周以上基本规律
- 阳性症状是否已明显减轻、是否还受幻听干扰
- 注意力能否连续集中三十分钟以上
- 能否独立完成出门、吃饭、按时服药
- 遇到压力时有没有可用的应对方式

如果这五项里多数还不稳，直接全职复工往往以复发收场。可以先做“低强度参与”：志愿服务、半天的课程、家里的固定任务。这些不算“正式工作”，但能保住作息、社会角色和自我效能感。

复工：分阶段走，比一次到位稳

阶段	做什么	谁参与	注意
准备期	稳定作息与服药，试做每天两小时的任务	患者、家属、医生	先证明能连续做，再谈岗位
试水期	志愿服务、兼职、原岗位的半日班	患者、康复机构	允许失败，不把一次缺勤当结论
返岗期	分阶段返岗：先半天、再全天；先少任务、再加量	患者、直属上级、人事部门	复诊日提前排开，避免频繁请假
稳定期	固定班次，建立“状态不好时怎么办”的预案	患者、同事中的一两位	预案要写下来，别只放在脑子里
维持期	定期复诊，压力高峰期主动减量	患者、医生	升职、换岗、加班都是压力事件

几个实操要点：

- **先和医生对时间表。** 返岗时间、能承受的强度、复诊安排，最好有医生的一句话支持，跟单位沟通时也更具体。
- **只让必要的人知道。** 直属上级通常需要知道“我需要阶段性减量”，不必向全组解释诊断。是否告知同事，是你的选择。
- **把“状态差”预案写下来。** 比如“如果连续三天睡不着，我就先请两天假、联系医生”，比临场硬撑好。

- **别把返岗当考试。** 退一步回到半天班，不是失败，是调整强度。

复学：和学校谈什么、怎么谈

学生复学的难点常在“信息不对称”：学校怕担责，家长怕被劝退，学生怕被议论。比较有效的做法是三方各让一步，把问题具体化。

谈之前准备好：

- ☐ 医生出具的复学建议（能否上课、体育课与实验课的限制、需要服药的说明）
- ☐ 一份简短的情况说明，只写学校需要知道的：可能请假、可能注意力下降、压力大时需要休息
- ☐ 明确的联系人：家长、班主任、学校心理老师
- ☐ 复学节奏建议：先上半天、先不上晚自习、先减一门课
- ☐ 遇到症状波动时的处理流程：联系谁、去哪里、是否需要临时休息

和学校谈的时候，尽量把话题从“病情”转到“安排”：

别说	可以说
“他有精神病，请学校多照顾”	“他在治疗中，医生建议前两个月先上半日课”
“千万别让同学知道”	“我们希望由班主任掌握情况，不向全班说明”
“出问题学校负责”	“出现情况请第一时间联系我，我们有医生和预案”

如果学校要求提供诊断证明，属于常见流程；但**病情细节的传播范围应当可控**，学校不宜在班级、宿舍范围内公开。具体做法以学校规定和现行法律为准。

职业支持：四种常见形式

不是所有人都能直接进入竞争性岗位。下面几种支持方式目标不同，可以组合使用。

形式	做法	适合谁	证据
支持性就业	先上岗再训练，快速匹配竞争性岗位，就业专员长期跟进	想工作、但不确定自己准备好没的人	研究支持较强，被多国指南推荐
过渡性就业	先在合作单位做临时岗位，逐步过渡到正式岗	长期脱离工作、需要重建节奏的人	有一定证据，效果差异较大
职业康复训练	评估、简历、面试、工作技能训练，再推荐岗位	需要系统补技能的人	有效，但单独使用不如边做边支持
庇护性工场	在保护性环境中工作，压力较低	功能受损明显、暂不能进入竞争性岗位的人	提供参与机会，转入普通岗位的比例有限

支持性就业的核心不是“先训练好再上班”，而是“先上班，边做边支持”。 它不要求你通过“工作准备度”评估，也不排斥病程长的人。国内部分城市的精神卫生中心、残联系统和社会组织提供类似服务，可以向社区精防医生或当地残联询问。【指南】【研究】

找工作时，学历断档、空窗期是常见障碍。可以准备一个不涉及诊断的说法：“这几年因为身体原因在治疗和恢复，现在稳定了，想重新开始。”多数雇主能接受这个程度的信息。

社区融入：从“参加”到“参与”

“融入”不等于热闹。有人喜欢每周一次的书法班，有人只愿意每天去楼下坐半小时，两者都算数。

可以按“参与深度”分三层：

1. **到场**：去社区活动室坐一会儿、参加一次讲座、在小区散步。目标是“出现过”。
2. **参与**：有固定时间、有具体任务，比如值日、领操、帮忙分饭、做手工义卖。
3. **承担角色**：成为小组里被需要的人——带新成员、负责器材、教别人一项技能。

第三层对自我认同的帮助最大，但要从第一层慢慢走。有结构的活动（固定时间、明确任务、可随时离开）比自由聊天更容易进入。

国内可用的资源包括：社区卫生服务中心的精防随访、日间康复站、残联系统的托养与康复服务、精神卫生中心开设的康复科、社会组织办的同伴支持小组。具体名称和准入条件各地不同，**以当地卫健委、残联公布的信息为准**。

权益与合理便利：能争取什么

“合理便利”指的是在不造成过度负担的前提下，为单位或学校做的调整。常见的包括：

- 弹性上下班、错峰通勤，避开人流高峰
- 减少加班、暂缓出差、阶段性降低任务量
- 安静一些的工位、允许戴耳机
- 复诊与治疗时间的请假安排
- 考试延时、分散考场、免修部分课程
- 分阶段返岗、先试岗再定岗

争取这些，一般需要：诊断或治疗证明、具体的调整清单、一个愿意配合的对接人。**沟通时提“具体请求”比提“诊断”有效**——“我每周三下午需要请假两小时复诊”比“我有精神疾病”更容易被回应。

法律层面只能讲原则：我国法律原则上禁止基于精神障碍的歧视，保障平等就业与受教育权利，并规定对精神障碍患者的隐私保护；具体条文、认定标准和救济渠道，**以现行法律和当地政策为准**，本页不提供法律意见。涉及劳动争议、退学处分、残疾评定时，建议咨询专业法律渠道或当地残联。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

尽快联系医生（当天或次日）

- 复工复学后连续失眠、焦虑明显加重、出现回避上班上学
- 幻听或猜疑重新出现，或比之前更频繁
- 为了“撑住”而自行加量、减量或停药
- 被单位或学校要求“先休学”“先离职”，情绪明显低落
- 出现“我拖累大家”“我不该回来”这类想法

立即去急诊或拨打 120（必要时 110）

- 出现自杀念头、计划或自伤行为
- 命令性幻听，声音让他做危险的事
- 在校或在岗出现明显激越、威胁他人、无法自控
- 木僵、拒食、意识改变，或高热伴肌肉僵硬

常见问题

“简历上空窗三年，怎么解释？”准备一句稳定的说法，不要每次编不同的理由：“这几年身体原因在治疗，现在稳定了。”如果对方追问细节，可以说“这个我不太方便展开”。

“要不要考公务员、当老师？”部分岗位有体检和病史申报要求，标准因岗位和地区而异。这类问题需要查当年招录公告，并以现行法律和当地政策为准，不要凭传言决定。

“一直找不到工作，是不是说明我不行？”就业市场本身就有结构性困难，加上学历断档、歧视，失败的原因很少只有一个。把“找到工作”拆成“投三份简历”“参加一次面试”，比用结果评价自己更可持续。

“社区活动都是老人，我不想去。”可以先找同类：同伴支持小组、青年康复活动、兴趣类社团。找不到就先从“每天出门一次”开始，不必强迫自己融入一个不合适的群体。

参考来源

- NICE. Rehabilitation for adults with complex psychosis (NG181), 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng181
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 13：误区、问答与工具

这一模块是可以直接打印/照抄的工具页，也集中拆掉最常见的误解。

13.1 症状日记与复发预警表

出院时医生常说“注意观察，有变化就来”，可“变化”到底是什么，很多人回家就忘了。这一页给出一份可以直接照抄的记录方法：每天记五个格子，每周填一张预警表，复诊时三分钟讲清楚。它不要求你写得漂亮，也不要求天天满分，能坚持记下三四成，就已经比“全凭印象”有用得多。

一、为什么值得记：三个很实际的作用

第一，对抗记忆偏差。 人对最近两三天的感受记得最清楚，对两周前的情况只剩一个模糊的结论：“好像还行”或者“一直不好”。医生调药偏偏需要看趋势，而不是看今天的心情。

第二，发现自己的模式。 很多复发不是毫无征兆的。有人是先连续几天只睡三四个小时，然后开始多疑；有人是先不愿出门、话变少，过一阵才出现幻听。记上一个月，模式往往自己会浮出来。

第三，让复诊更有效率。 一次门诊常常只有十几分钟。带着记录去，你可以直接说“这周幻听从每天一两次变成五六次，晚上明显，睡眠从七小时掉到四小时”，医生马上能抓住重点。空手去，往往只能说出“还行吧”。

要强调的是：记录是工具，不是考核。漏了几天不用补，也不用因为“记得不好”而自责。它的目的是帮你和医生，不是给谁打分。

二、每天记什么：五个格子

不用写日记，五个格子就够。每个格子一两句话，或者直接打勾、写数字。

格子	记什么	例子
睡眠	几点上床、大概多久睡着、夜里醒几次、总共睡多久、白天困不困	23:30 上床，1 点才睡着，醒 2 次，共 5 小时，白天很困
服药	有没有漏、有没有自己加减、有没有不舒服	早上的漏了，晚上按时；吃完手有点抖
症状	幻听有没有、几次、说什么；有没有多疑、被针对感；情绪打几分	幻听 2 次，说“他们在看你”；下午觉得同事在议论我
副作用	手抖、僵硬、坐不住、口干、便秘、心慌、体重、月经、性功能	便秘第 3 天；坐不住，下午走了很久
活动	出门了吗、做了什么、和谁说过话	上午买菜，下午没出门，和妈妈说了几句话

几个写法上的建议：

- **能用数字就用数字。** “幻听 3 次”比“幻听很多”有用；“睡了 4 小时”比“没睡好”有用。
- **记事实，不急着解释。** 写“今天觉得邻居在敲墙针对我”，不必写“因为我不好所以被针对”。解释留给复诊时和医生一起做。
- **情绪用 0 到 10 打分。** 0 是最低，10 是最好。不用精确，凭感觉给一个数就行。
- **副作用要具体。** “难受”医生没法处理，“手抖到拿不稳筷子”“三天没排便”就能处理。

三、症状清单：打勾就行

如果不想写字，每天睡前花一分钟，把当天有的情况打勾。建议固定放在床头或手机备忘录里。

- ☐ 今天听到别人听不到的声音
- ☐ 声音在评论我，或命令我做什么
- ☐ 觉得有人在监视、跟踪或针对我
- ☐ 觉得别人能知道我的想法，或我的想法被拿走了
- ☐ 说话跳跃，别人说听不懂
- ☐ 什么都不想做，躺着也不觉得休息
- ☐ 对以前喜欢的事提不起兴趣
- ☐ 不想见人，回避电话和消息
- ☐ 入睡困难、早醒，或睡得明显比平时多
- ☐ 情绪低落到影响吃饭、洗漱、出门
- ☐ 特别烦躁，坐不住，容易发火
- ☐ 注意力散，记不住刚发生的事
- ☐ 手抖、肌肉僵硬、走路不稳、脖子转不动
- ☐ 口干、便秘、排尿困难、心慌
- ☐ 今天漏服或自行调整了药

勾选本身不说明病情好坏，它只是把“感觉”变成“可以数的东西”。连续几天勾选项目变多，就是值得和医生说的信号。

四、一周一次：复发预警表

每天记完，周末花五分钟做一次汇总。这张表比日记更能看出趋势，也最适合复诊时给医生看。

预警信号	上周	本周	变化
睡眠明显减少（比自己平时少很多）			
多疑、觉得被针对			
幻听变频繁或内容变凶			

预警信号	上周	本周	变化
说话变乱、别人听不懂			
明显退缩、不出门、不说话			
情绪异常高涨或异常低落			
烦躁、坐立不安、容易冲突			
漏服、自行减药或停药			
工作学习能力突然下降			
出现新的躯体不适			

填法很简单：有就写“有”或打勾，没有就写“无”，比上周好写“↓”，比上周差写“↑”，差不多写“→”。

除了通用信号，每个人还有自己的“专属前兆”。有的人是突然特别爱整理东西，有的人是开始反复检查门锁，有的人是说话突然变得很正式。花十分钟和家人一起回想：**上一次复发前一两周，最早出现的三个变化是什么？** 写下来，贴在冰箱上。

- ☐ 我的第一个前兆：_____
- ☐ 我的第二个前兆：_____
- ☐ 我的第三个前兆：_____

【临床经验】

五、副作用与躯体指标：单独留一页

有些问题进展慢，不记就发现不了。建议每周固定一天（比如周日早上）测一次，记在同一张纸上。

项目	多久记一次	怎么记
体重	每周	同一时间、同一件衣服、同一台秤
腰围	每月	肚脐水平绕一圈
血压	每周	静坐五分钟后测
血糖、血脂	按医生安排	把化验单拍照存好
月经	每月	日期、是否规律、量多量少
性功能	有变化时	简短描述，不必详细
排便	每周	几天一次、是否干结
手抖、僵硬、坐不住	每周	轻、中、重三档即可

如果服用氯氮平，血常规的日期和结果要单独记，见 13.3 的用药记录页。发热、咽痛、口腔溃疡要立即查血，不能等到下周。

六、复诊怎么用这份记录

门诊时间有限，记录不是念给医生听，而是帮你挑重点。可以按这个顺序讲：

1. **先说变化**：“这两周幻听变多了，晚上尤其明显。”
2. **再说影响**：“因为这个，我三天没去上班，晚上只睡四小时。”
3. **再说药**：“药一直按时吃，就是吃完手抖，拿筷子不稳。”
4. **最后说担心**：“我怕是不是又要复发了。”

如果医生时间紧，直接把预警表递过去，比你组织语言更快。

- ☐ 复诊前把记录本、药盒、化验单装进同一个袋子
- ☐ 用一句话写下这次最想解决的问题
- ☐ 把最严重的三个变化圈出来
- ☐ 想好一个必须问医生的问题
- ☐ 记下医生这次的调整和下次复诊时间

七、可照抄的模板

下面是每天一行的简版，抄在笔记本上或做成手机表格都行。

```
日期：
睡眠：上床___ 入睡约___分钟 夜醒___次 共___小时 白天困（无/轻/重）
服药：早（按时/漏/自减） 中（ ） 晚（ ） 不适：
症状：幻听___次，内容：_____ 多疑（无/轻/中/重） 情绪__/10
副作用：_____
活动：出门（是/否） 做了：_____ 和人说话（是/否）
备注：
```

一周汇总时，只回答三个问题：

- 这周比上周，最明显的变化是什么？
- 有没有出现我的“专属前兆”？
- 有没有需要下次复诊一定要说的事？

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经在准备方法：不要独处，联系信任的人陪着，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现命令性幻听，声音让你伤害自己或别人：先保证安全，远离危险物品，拨打 120，必要时 110。
- 连续多天几乎不睡、明显兴奋话多、行为失控：尽快精神科急诊评估。
- 出现木僵、拒食、缄默、长时间不动：警惕紧张症，立即急诊。
- 出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗：警惕恶性综合征，立即急诊。
- 服用氯氮平期间发热、咽痛、口腔溃疡：立即查血常规。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- 中国严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

13.2 常用量表：PANSS、BPRS、SAPS、SANS、PSP

复诊时医生可能在病历上写“PANSS 78 分”“PSP 55 分”，或者让你做一份长长的访谈。这些字母和数字是什么意思？分数高是不是就更严重？能不能自己在网上找一份量表测一测？这一页讲清五个最常用的量表各自测什么、谁来评、能用来做什么、不能用来做什么。读完你能看懂报告上的关键信息，也知道该向医生问什么。

一、量表是什么、不是什么

量表是一种**结构化的评估工具**：把“幻听多不多”“情感平淡不平淡”这类描述，转换成可以比较的分数。它的价值在于“可比”——同一个患者这个月和上个月比，或者一群患者和另一群患者比。

它有几个明确的边界：

- **不是诊断工具。** 量表测的是症状严重度或功能水平，不负责回答“是不是精神分裂症”。诊断要靠病史、精神检查、病程、功能损害和排除其他原因。
- **不能替代面诊。** 量表是医生访谈的补充，不是替代。同样 78 分，两个人的实际困难可能完全不同。
- **分数受评分者影响。** 不同医生对同一条目的理解可能有差异，所以趋势比单次分数更可靠。
- **不能自测确诊。** 网上流传的“精神病测试”多为筛查或娱乐性质，不能用来给自己或家人下诊断。

量表分两类：**他评**（由受过训练的医生或心理师评定）和**自评**（本人填答）。这一页讲的五个都是他评量表，需要专业人员操作。

【指南】

二、五个常用量表一览

量表	测什么	谁评	用途与主要局限
PANSS	阳性、阴性、一般精神病理的严重度	精神科医生或受训评估员	疗效评估与症状追踪；访谈较长，需培训
BPRS	精神病性症状的快速评定	精神科医生或受训评估员	急性期与病房追踪；条目较粗，阴性症状覆盖不足
SAPS	幻觉、妄想、怪异行为、思维形式障碍	受训评估员	阳性症状细化评估；不覆盖阴性症状
SANS	情感平淡、言语贫乏、意志缺乏等	受训评估员	阴性症状评估；与抑郁、锥体外系反应难区分
PSP	工作学习、关系、自理、行为控制	医生或受训评估员	功能评估与康复目标；受环境与机会影响

三、PANSS 与 BPRS：症状严重度

PANSS（阳性与阴性症状量表） 是目前研究和临床追踪里最常用的一个。常见版本为 30 个条目，分成三个部分：阳性症状、阴性症状、一般精神病理。每个条目按 1 到 7 分评定，分数越高表示越严重。

它的好处是“全面”：既有幻听、妄想这类阳性症状，也有情感平淡、社交退缩这类阴性症状，还包含焦虑、抑郁、紧张等一般症状。总分的变化，常被用来判断治疗有没有起效。研究中常用的“应答”定义，通常是“总分较治疗前下降一定幅度”，但具体阈值在不同研究里并不统一，所以看到“应答率”时要留意它用的是什么标准。【研究】

它也有明显的局限：访谈需要时间，评分需要训练；阴性症状和抑郁症状、药物引起的表情减少容易混在一起；总分把不同性质的症状加在一起，可能掩盖结构上的变化。所以看 PANSS，不能只看总分，要看他三个部分各自怎么变。

BPRS（简明精神病评定量表） 更短、更快，适合急性期或病房里反复评估。经典的 18 项版本覆盖幻觉、妄想、概念紊乱、焦虑、抑郁、敌意、激越等，按 1 到 7 分评定；也有扩展版本，条目更多。它的优点是省时、对急性症状敏感；缺点是条目较粗，对阴性症状和认知损害的覆盖不够。

两者怎么选？急性期、需要频繁评估时，BPRS 更实用；需要细致追踪阳性和阴性症状时，PANSS 更合适。这不是“谁更高级”的问题，而是场景问题。

四、SAPS 与 SANS：把阳性和阴性分开看

阳性症状和阴性症状对治疗的反应不一样，混在一起评容易看不清，所以有了这两个专门的量表。

SAPS（阳性症状量表） 把阳性症状拆成几个部分：幻觉、妄想、怪异行为、阳性思维形式障碍，每个部分下有若干条目，最后给出各部分的总体评分。它适合在研究或复杂病例中，细致描述“阳性症状到底以什么形式为主”。它的局限是只管阳性症状，不评阴性、抑郁和功能。

SANS（阴性症状量表） 把阴性症状拆成情感平淡、言语贫乏、意志缺乏、快感缺失、注意障碍等部分，同样有分量表和总体评分。它的价值在于让“阴性症状”变得可描述、可追踪，而不是一句“他就是懒”。

SANS 有一个绕不开的难点：**阴性症状和抑郁、锥体外系反应长得很像。** 表情少、说话慢、动作少，可能是阴性症状，也可能是药物引起的类帕金森表现，还可能是抑郁。区分它们需要医生结合用药时间、情绪评估和神经系统检查来判断，单靠一份量表不够。【临床经验】

需要说明的是，这几个量表的条目数和具体结构在不同版本、不同翻译中存在差异，本文不写死条目数。看到报告上的“总分”，最好问一句：用的是哪个版本、哪个分量表。

五、PSP：功能水平

前面四个量表测的是症状，PSP 测的是**功能**——一个人在实际生活里过得怎么样。

PSP（个人与社会功能量表）通常给一个 0 到 100 的分数，分数越高功能越好，评估四个领域：

- 社会上有用的活动（工作、学习、家务、志愿活动）；
- 个人与社会关系（朋友、伴侣、家庭互动）；
- 自我照料（洗漱、穿衣、吃饭、理财）；
- 干扰与攻击行为（情绪失控、冲突、扰乱他人）。

评定时，医生先看四个领域里最差的那个，再结合整体印象给分。分数通常被划成几个功能带，从“功能优秀”到“功能极差”，但具体分界在不同版本和研究中略有差别。

PSP 的用处很实在：它能把“恢复得怎么样”从模糊的感受变成可讨论的目标。比如一个人幻听少了，但 PSP 没变，说明功能还没回来，接下来该做的是康复训练、社交练习、逐步复工，而不只是继续加药。

它的局限也要知道：功能受环境影响很大。一个找不到工作的人，PSP 可能很低，但这不完全是他的能力问题；一个被家人过度照顾的人，PSP 可能虚高。所以 PSP 要结合生活环境来读，不能当成“能力评分”。

六、怎么读一份量表报告

拿到报告，先看四件事：

1. **看是什么量表、什么版本。** PANSS 和 BPRS 的分数不能互相换算，SAPS 和 SANS 也不能简单相加。
2. **看分量表，不只看总分。** 总分不变，阳性降了、阴性升了，是完全不同的故事。
3. **看时间点。** 单次分数意义有限，和上一次比、和基线比才有意义。
4. **看是谁评的。** 不同评估者之间的差异，可能比病情变化还大。

还有几个常见误解：

- **“分数高就是病重。”** 部分对，但不完全。量表分数高说明症状多或重，不等于功能差、不等于预后差。
- **“分数降了就是好了。”** 症状分数下降是好事，但功能、生活质量、副作用负担要一起看。
- **“量表分数能评残疾。”** 残疾评定有专门的标准和流程，量表分数只是参考之一。
- **“我自己测一下就知道有没有病。”** 不行。自测量表最多用于筛查提示，不能诊断。

复诊时如果想问得更清楚，可以照着这份清单问：

- ☐ 这次用的是哪个量表、哪个版本？
- ☐ 和上次比，哪个分量表变化最大？

- ☐ 这个变化，你觉得和药物、生活事件还是季节有关？
- ☐ 功能方面（PSP）这半年有变化吗？
- ☐ 量表分数会不会影响后面的治疗计划？
- ☐ 我需要自己记录哪些指标，下次带来？

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 量表提示自杀意念，或本人出现自杀念头、自伤行为：不要独处，拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 评估中出现明显激越、冲动、伤人风险：先保证安全，拨打 120，必要时 110。
- 出现木僵、拒食、缄默、长时间不动：警惕紧张症，急诊精神科评估。
- 出现高热、肌肉僵硬、意识改变：警惕恶性综合征，立即急诊。
- 服用氯氮平期间发热、咽痛、口腔溃疡：立即查血常规。

参考来源

- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- APA. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Schizophrenia, 3rd ed., 2020.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

13.3 复诊沟通单与用药记录

很多人复诊时的真实状态是：排队两小时，进门五分钟，出来才想起最想问的那句话没说。这不是你一个人的问题。这一页把复诊拆成“诊前准备—诊中怎么说—诊中问什么—回家记什么”四步，并给出一份可以直接打印的“一张纸”模板。照着用，至少能保证每次复诊把最重要的事说清楚。

一、诊前三天：把材料备齐

临时找东西最耽误时间。提前三天，把下面这些放进同一个袋子或文件夹：

- ☐ 正在吃的所有药：药盒、处方、或者一张写清药名和用法的清单
- ☐ 最近的化验单：血常规、肝肾功能、血糖血脂、心电图
- ☐ 上次的病历和量表报告
- ☐ 这半个月的症状记录或预警表
- ☐ 医保卡、就诊卡、身份证
- ☐ 一张纸，写着你这次最想问的三个问题

还有一件事容易被忽略：**把“这次最想解决的一个问题”写成一句话。** 比如“晚上幻听吵得睡不着”“吃完药手抖得拿不了筷子”“想问问能不能减药”。门诊时间有限，有一个明确的主诉，医生才能把有限的几分钟用在刀刃上。

如果本人不方便表达，家属可以陪同，但要提前商量好谁主说。两个人抢着说、互相纠正，医生反而抓不到重点。

二、诊中必说：五句话

医生问“最近怎么样”，回答“还行”是最常见也最亏的回答。可以按下面五句话的结构说：

说什么	为什么重要	可以这样说
症状的变化	医生需要趋势，不是印象	这两周幻听从每天一两次变成四五次，晚上多
对生活的影响	决定治疗强度	因为这个，我一周没去上班，白天不敢出门
服药情况	判断是药无效还是没吃	一直按时吃，只有两天忘了晚上的
副作用	决定要不要调方案	手抖，拿筷子不稳；便秘三天一次
你最担心的	让医生知道你的优先级	我怕这样下去又要住院

说的时候尽量具体：频率、时间、程度、和上周比是好了还是差了。避免“特别难受”“一点用都没有”这类没有刻度的描述。

如果症状涉及幻听的内容，可以直接说：“有个声音让我别出门，说外面有人等着我。”医生需要知道内容，不是因为你“说了会被抓走”，而是因为命令性幻听、被害妄想直接关系到风险评估。

三、诊中必问：八个问题

很多人出门才想起没问，可以把这张清单存在手机里，进诊室前看一眼。

- ☐ 这次的诊断或判断是什么？依据是什么？
- ☐ 现在这个药，主要指望它改善哪几个症状？
- ☐ 大概多久能看到变化？如果没变化，下一步怎么办？
- ☐ 有哪些副作用需要我特别留意，出现什么情况要马上联系你？
- ☐ 下次复诊前，我需要记录什么、做什么检查？
- ☐ 如果漏服了一次，应该怎么处理？
- ☐ 我能不能同时吃别的药、中药或保健品？有没有需要避开的？
- ☐ 什么情况下需要提前来，或者直接去急诊？

关于“漏服怎么处理”，一定要在诊室里问清楚，而不是上网搜。不同药物、不同服药频率的处理方式不一样，搜到的答案未必适用于你。

还有几个问题，适合在病情稳定时问，而不是等到危机时：

- ☐ 我的维持治疗大概要多久，什么情况下可以考虑减量？
- ☐ 如果需要长期治疗，对我工作、开车、怀孕分别有什么影响？
- ☐ 有没有适合我的心理社会干预或康复资源？

四、用药记录表

不需要每天写长篇，一张表记录“吃没吃、有没有不舒服”就够。药名和用法按处方抄，不要自己改。

药名（按处方抄）	服药情况（早/中/晚）	漏服或自减	不舒服的表现

填法：

- 在“服药情况”里按早、中、晚写“√”或“×”，自己在某个时段改过就写“减”或“加”。
- “不舒服的表现”写具体的：手抖、坐不住、口干、便秘、心慌、嗜睡、月经推迟、体重变化。
- 如果同时吃其他科的药、中药、保健品，也单独列一行，复诊时给医生看。

这张表的作用不是监督你，而是帮医生判断：症状没好转，是因为药不对，还是因为没吃进去；副作用是不是和某个药、某个时间点有关。

五、副作用：写具体，别写“难受”

模糊的说法	更有用的说法
难受	吃完两小时开始坐不住，必须一直走
没力气	早上起床要躺半小时才能起来，持续一周
手抖	拿筷子抖，写字歪，别人能看出来
便秘	三天一次，干结，需要开塞露
睡不好	凌晨三点醒，之后睡不着，白天困
月经不正常	两个月没来，上次也是吃药后开始的
体重涨了	三个月涨了 6 公斤，胃口明显变大

出现下面这些情况，不要等到复诊：

- 发热、咽痛、口腔溃疡、明显乏力（尤其服用氯氮平时）；
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗、心跳很快；
- 脖子突然转不动、眼睛往上翻、走路姿势异常；
- 坐立不安到无法静止、整夜走动；
- 吞咽困难、进食呛咳；
- 胸痛、心悸、晕厥；
- 严重便秘伴腹胀、呕吐、不排气。

六、氯氮平专页：血常规是处方的一部分

氯氮平对难治性精神分裂症有明确价值，但它有一个必须严肃对待的风险：**粒细胞缺乏**——一种让身体抵抗感染能力下降的血象变化。它不常见，但一旦发生可能危及生命，所以监测不是“附加项目”，而是处方本身的一部分。【指南】

需要记住的几条：

第一，按医生安排查血常规，不能因为“感觉还好”就跳过。 开始用药的阶段查得最密（通常每周一次，持续数月），之后按医生安排定期复查，多数方案为每月一次。具体频率以处方和当地监测要求为准。

第二，发热、咽痛、口腔溃疡、明显乏力，要立即查血常规。 这些是感染的常见表现，在粒细胞缺乏时可能是最早的信号。不要先吃退烧药观察两天。

第三，不要自行停药或自行减量。 突然停氯氮平可能引起症状反弹，也可能出现撤药相关的不适。任何调整都由医生决定。

第四，其他需要报告的情况： 胸闷、心悸、气短、发热（尤其用药早期，警惕心肌炎）；严重便秘、腹胀、不排气（警惕肠梗阻）；流涎严重；抽搐；尿潴留。

第五，把血常规结果按日期存好。 换医院、换医生时，这份记录很重要。

- ☐ 我知道下次查血常规的日期
- ☐ 我知道结果异常时该联系谁、怎么联系
- ☐ 我知道发热咽痛时要立即查血，不等到复诊
- ☐ 我知道不能自行停氯氮平
- ☐ 我的血常规结果按日期存好了

七、一张纸模板（可打印）

```
【复诊一张纸】  姓名：____  日期：____  复诊医院/医生：_______

一、这次最想解决的问题（一句话）：
_____

二、最近两周的变化
1. 症状：_____
2. 对生活的影响：_____
3. 睡眠：上床___ 入睡___分钟 夜醒___次 共___小时
4. 情绪（0-10）：___  最差的一天：___

三、用药（按处方抄）
药名 / 早 / 中 / 晚 / 漏服或自减 / 不舒服
_____
_____

四、副作用（具体写）：
_____

五、想问医生的问题
1. _____
2. _____
3. _____

六、医生这次说 / 调整：
_____
下次复诊：____月____日   下次检查：_____
```

打印出来，每次复诊带同一张，按日期归档，半年后回看会很有用。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 服用氯氮平后发热、咽痛、口腔溃疡、明显乏力：立即查血常规，不要等复诊。
- 出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗：警惕恶性综合征，立即停药并急诊。
- 出现木僵、拒食、缄默、长时间不动：警惕紧张症，急诊精神科评估。
- 出现吞咽困难、进食呛咳、呼吸困难：警惕噎食，立即急诊。
- 突然停药后出现严重失眠、激越、幻觉加重：尽快联系医生，不要自行加回原量。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.

- 中国严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

13.4 常见误区与高频问答

关于精神分裂症，流传最广的说法往往不是来自医生，而是来自电影、新闻和亲戚的转述。“吃药会成瘾”“得了病就废了”“不能结婚生孩子”，这些话一句一句堆起来，能把人堵在屋里不敢出门。这一页集中处理 30 条常见误区和 20 个高频问题，每条都给一句实质澄清，不给口号。读完你可以把它当查询页用，也可以转给正在劝你“别吃药”的人。

一、关于药物的 10 条误解

1. **“吃药会成瘾。”** 抗精神病药不属于成瘾性物质，不会越吃越多、不会为了“爽”而吃。但突然停药会出现失眠、激越、恶心等撤药样反应，并显著增加复发风险，所以“不能自己停”和“会成瘾”是两件事。【指南】

2. **“吃药会变傻、伤脑子。”** 让人显得迟钝的，常见是镇静作用、阴性症状和疾病本身的认知损害。药物相关的迟钝多数可逆，调整方案后能改善；不治疗，认知损害往往更重。

3. **“越困说明药越有效，镇静就是治病。”** 镇静是副作用，来自组胺等受体的作用；治疗作用主要来自对多巴胺系统的调节。不困不代表没效，很困也不代表效果好。

4. **“症状好了就可以停药。”** 症状消失只说明进入巩固期。停药后复发风险明显升高，减量要由医生按病程和复发史来计划。【指南】

5. **“副作用越大，说明药越管用。”** 副作用和疗效是两条线，没有“越难受越有效”的规律。副作用大，首先说明需要和医生讨论调整，而不是硬扛。

6. **“一种药没效，就自己加量或换药。”** 加量不等于增效，换药有交叉耐受和撤药问题。剂量和更换方式必须由医生决定，自行调整最容易换来一次复发。

7. **“打长效针是给不听话的人的惩罚。”** 长效针剂只是给药方式不同，适合记不住吃药、反复漏服、或愿意减少每天服药次数的人。它是选项，不是惩罚。

8. **“中药、保健品可以替代西药，而且没有副作用。”** 目前没有可靠证据支持用中药或保健品替代抗精神病药；它们同样可能伤肝伤肾、与西药相互作用。“天然”不等于“安全”。【待验证】

9. **“西药伤肝伤肾，宁可不吃。”** 所有有效药物都有代价，抗精神病药需要监测体重、血糖、血脂、心电图、催乳素和肝肾功能。监测的目的就是把代价控制在可接受范围内，而不是靠不吃药来“保护身体”。

10. **“吃上就一辈子停不掉。”** 治疗年限因人而异，有人长期维持，有人在稳定多年后由医生评估逐渐减量。把“可能需要长期治疗”说成“终身成瘾”，会让人在最该坚持的时候放弃。

二、关于暴力与“危险”的 6 条误解

11. **“精神分裂症患者都很暴力。”** 绝大多数患者并不暴力，他们成为暴力受害者的概率反而更高。把少数极端个案当成群体标签，既不符合事实，也让患者更不敢求助。【研究】

12. **“只要有幻听就会伤人。”** 幻听很常见，伤人的是少数。真正需要警惕的是命令性幻听、被害妄想叠加极度恐惧、物质使用、治疗中断、既往暴力史这些具体情境。

13. **“患者伤人不用负责，所以更危险。”** 刑事责任能力要由司法鉴定按具体情形判断，不是“有病就免责”。绝大多数患者在日常里遵守规则，担心“免责”而恐惧，是把法律问题误当成了临床问题。

14. **“患者只会伤别人，不会自杀。”** 恰恰相反，精神分裂症患者的自杀风险高于一般人群，抑郁、病耻感、幻觉、失业、孤独都是相关因素。自杀风险要单独评估，不能被“他不会伤害自己”掩盖。【指南】

15. **“得了病就会打家人、打孩子。”** 家庭冲突更多与沟通方式、酒精、未治疗的激越有关，而不是诊断本身。把患者默认成“家里的定时炸弹”，会让家庭关系先垮掉。

16. **“只要吃着药就不会出事。”** 药物能显著降低风险，但不是保险。停药、物质使用、重大应激、共病抑郁都可能让风险上升，需要持续评估，而不是“吃药了就放心”。

风险因素	常见情境	可以做的事
未治疗或自行停药	症状加重、失眠、多疑	尽快复诊，不自行加停
命令性幻听	声音命令伤害自己或他人	远离危险物品，立即急诊
被害妄想	坚信被追杀，准备“自卫”	降低刺激，不争辩，求助 120/110
物质使用	饮酒、大麻、兴奋剂后激越	戒断管理，告知医生
既往暴力史	近期冲突增多、易怒	制定安全计划，减少冲突场景

三、关于人生选择的 8 条误解

17. **“得了病就不能工作。”** 很多人能工作，只是需要调整节奏、岗位或工时。支持性就业的研究显示，配支持的工作比“先训练好再上班”更有效。【研究】

18. **“不能结婚。”** 法律没有禁止。婚姻是否稳定，更多取决于病情稳定程度、伴侣的理解、经济与照护安排，而不是诊断名称本身。

19. **“不能生孩子，因为一定会遗传。”** 遗传风险确实高于一般人群，但它是概率不是命运，多数患者的子女并不会患病。生育是个人与家庭的决定，医生能做的是把风险、用药调整和产后随访讲清楚。【研究】

20. **“要住一辈子院。”** 住院是急性期的安全措施。多数人稳定后在社区生活、门诊随访；长期住院的是少数，通常合并严重功能损害或缺乏照护条件。

21. **“精神病都是天才。”** 这种浪漫化否认了疾病带来的痛苦，也容易让人延误治疗。精神分裂症和创造力之间没有必然联系。

22. **“这病会传染。”** 不会。一起吃饭、生活、工作都不会传染。

23. **“是父母教育失败造成的。”** 家庭沟通会影响复发和康复，但不是病因。这个旧观点伤害了很多家庭，也掩盖了真正需要处理的问题。

24. **“得了病就回不到正常生活了。”** “正常”不是只有一种样子。有人回到原来的岗位，有人换了更适合的节奏，有人把生活重心放在关系和健康上。康复的目标可以重新定义。

四、关于治疗与照护的 6 条误解

25. **“心理治疗没用，就是聊聊天。”** 结构化的心理社会干预有具体内容：心理教育、CBTp（针对精神病性症状的认知行为治疗）、家庭干预、社交技能训练、认知矫正、职业康复。它们不能替代药物，但能改善症状应对、复发率和功能。【研究】

26. **“住院就是被关起来。”** 精神卫生法确立自愿住院原则，非自愿住院只适用于法定情形并需履行程序。病房有探视、通讯和活动安排，约束隔离有严格限制。具体权益见 11.3。【指南】

27. **“没有自知力就是装的、不配合。”** 缺乏自知力是疾病的一部分，很多人在急性期真的不认为自己有病。这不等于“故意作对”，也不该成为被指责的理由。

28. **“家人管得越严越好。”** 高频批评、过度控制和包办，与更高的复发率相关。稳定、少指责、有边界的支持，比“盯着管”更有帮助。【研究】

29. **“电休克是电击惩罚。”** 现代电休克在麻醉和肌松下进行，用于紧张症、严重拒食、高自杀风险、难治性病例等特定情况，是有严格适应证的治疗，不是惩罚。

30. **“精神病就是想不开、意志薄弱。”** 精神分裂症涉及神经发育、遗传、环境等多种因素，不是态度问题。让一个人“想开点”来消除幻听，和让他“想开点”退烧一样无效。

照顾者可以对照这份清单自查：

- ☐ 我有没有把症状当成“故意”
- ☐ 我有没有用“再不听话就送你住院”来威胁
- ☐ 我有没有替本人决定所有事
- ☐ 我有没有在冲突升级时先降低刺激、离开现场
- ☐ 我有没有给自己留出休息和支持
- ☐ 我有没有把“吃药”当成唯一的沟通内容

五、20 个高频问答

1. **症状消失了还要吃多久？** 通常还要经过巩固和维持阶段，具体时长由医生根据病程、复发次数和功能状态决定，不能自行减停。【指南】

2. **副作用受不了，能自己减一点吗？** 不能。先记录具体表现，尽快联系医生；多数副作用有应对办法，自行减量带来的复发风险更大。

3. **能不能只做心理治疗、不吃药？** 对多数精神病性症状，药物是基础。心理治疗是加法，不是替代；是否减药由医生判断。

4. **中药能不能和西药一起吃？** 需要先告诉医生具体成分。部分中药和保健品会影响药物代谢或肝肾功能，不能默认“一起吃不冲突”。【待验证】

5. **会不会遗传给孩子？** 风险比一般人群高，但不是必然。遗传咨询可以帮助理解概率，而不是给出“能生/不能生”的结论。

6. **能不能结婚？** 可以。建议在关系稳定、病情稳定时讨论，把复发应对、用药、经济安排提前说清楚。

7. **能不能怀孕生孩子？** 可以，但需要提前规划：孕前评估、药物调整、产科与精神科联合随访。不要自行停药，也不要因为怕药物而隐瞒怀孕。【指南】

8. **吃药期间能不能哺乳？** 需要个体化评估，取决于药物、剂量、婴儿情况。把问题交给产科和精神科一起判断，不要自己决定。

9. **能不能喝酒？** 建议避免。酒精会影响睡眠、情绪和药物代谢，也增加冲动和意外的风险。

10. **能不能抽烟？** 抽烟会影响部分药物的血药浓度，突然戒烟或突然大量吸烟都可能让症状波动。如要戒烟，告诉医生，可能需要调整剂量。

11. **能不能开车？** 取决于嗜睡、注意力、眩晕和幻觉的情况，也需要了解所用药物对驾驶的影响。稳定期也要谨慎，必要时问医生。

12. **能不能喝咖啡、浓茶？** 少量通常问题不大，但可能加重心慌、失眠和焦虑。下午以后尽量少喝。

13. **能不能运动？** 能，而且推荐。规律运动有助于体重、代谢、情绪和睡眠。从低强度开始，避免过度疲劳。

14. **能不能熬夜、上夜班？** 睡眠紊乱是复发的常见诱因。尽量固定作息；必须倒班时，和医生讨论如何安排服药与监测。

15. **幻听让我做事，怎么办？** 先判断内容是否指向伤害自己或他人。若是，立即远离危险物品并求助；若否，可以记录内容、推迟行动、把注意力转到具体事务上，并在复诊时告诉医生。

16. 家人不承认自己有病，怎么劝？ 不争辩“你有没有病”，从具体困难入手：“你最近睡不好，我们去看看睡眠”。必要时由医生、社区精防人员或信任的亲友参与。

17. 患者拒绝吃药怎么办？ 先了解原因：副作用、觉得没用、病耻感、忘记、经济压力。针对原因解决，比反复说教有效。若出现自伤伤人风险，立即急诊。

18. 要不要告诉单位或学校？ 由本人决定，可以分层披露：先讲需要什么便利，不必一次讲完诊断。法律对隐私和就业歧视有规定，具体以现行法律为准。【指南】

19. 复发了还能治好吗？ 多数复发是可以治疗的，越早处理效果越好。复发过一次，通常意味着需要更认真地做维持治疗和预警管理。

20. 需要终身服药吗？ 不一定。有人长期维持，有人在稳定多年后由医生评估减量。关键是“由医生计划”，而不是“自己感觉好了就停”。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：不要独处，拨打 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 出现命令性幻听、坚信被追杀并准备“先下手”：先保证安全，远离危险物品，拨打 120，必要时 110。
- 出现木僵、拒食、缄默、长时间不动：警惕紧张症，急诊精神科评估。
- 出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗：警惕恶性综合征，立即急诊。
- 服用氯氮平期间发热、咽痛、口腔溃疡：立即查血常规。
- 孕产期出现伤害自己或婴儿的念头：立即联系产科与精神科，必要时急诊。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平，施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

附录：术语与参考文献

本模块的篇目可以按顺序读，也可以按问题单独查。

A 术语表

这份表收了 60 个在精神分裂症资料里反复出现的词，用大白话解释，按主题分组、编号连续。适合读其他篇目时随手查：遇到看不懂的词，按编号或主题找到它，看完两三句就能接着读。它不是诊断标准，也不能用来给自己或家人“对号入座”。

怎么用这份术语表

分组	编号	收入什么
一、疾病、症状与鉴别	1 – 20	症状、病程分期、诊断与鉴别
二、评估、结局与依从	21 – 30	量表、缓解、康复、依从性、危机预案
三、药物与副作用	31 – 42	药物类别、锥体外系反应、代谢与心脏风险、氯氮平
四、心理社会干预	43 – 52	CBTp、家庭干预、技能训练、就业与个案管理
五、社会、法律与污名	53 – 60	污名、监护、非自愿住院、权益与社区服务

读之前可以先做三件事：

- ☐ 先看你要查的词属于哪一组，避免把“症状”和“诊断”混在一起
- ☐ 记住每条后面的标签：【指南】【研究】【临床经验】【待验证】
- ☐ 遇到与自己情况不符的解释，以面诊医生的判断为准

什么时候不要查表，直接联系医生

- 出现自杀念头、自伤行为，或说“我消失了对大家都好”
- 命令性幻听，声音让他做危险的事
- 木僵、缄默、拒食、违拗、蜡样屈曲（可能是紧张症）
- 高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗（可能是恶性综合征）
- 服氯氮平后发热、咽痛、口腔溃疡（需立即查血常规）
- 噎食、呼吸困难、抽搐、胸痛、晕厥

立即拨打 120（必要时 110）或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

一、疾病、症状与鉴别（1–20）

症状与病程（1–16）

1. **精神分裂症**：以思维、感知、情感和行为整合受损为主要特征的重性精神障碍，多在青少年晚期至成年早期起病。核心表现包括阳性症状、阴性症状和认知损害，病程常呈复发与缓解交替，需要长期治疗。
2. **阳性症状**：指正常人不该有、患者却多出来的表现，比如幻觉、妄想、思维紊乱、行为紊乱。“阳性”不是“好”的意思，只是“多出来”；这类症状对抗精神病药反应通常较好。
3. **阴性症状**：指正常人该有、患者却减少或缺失的表现：情感平淡、言语贫乏、意志缺乏、快感缺失、社交退缩。“阴性”也不是“坏”的意思，只是“少掉了”；它比阳性症状更影响长期功能。
4. **认知损害**：指注意、工作记忆、执行功能、加工速度和社会认知方面的下降。它不像幻觉那样显眼，却直接影响能不能上班、管钱、维持关系。
5. **幻觉**：在没有相应外界刺激时产生的真实感知，最常见是听幻觉，也可有视、触、嗅、味幻觉。对患者来说它是“真的听见了”，不是想象，也不是撒谎。
6. **命令性幻听**：幻听内容是在命令患者做某件事，可能是自伤、伤人或其他危险行为。这是需要立即处理的安全信号，不是“忍一忍就过去”，要马上联系医生或去急诊。
7. **妄想**：与事实不符、与文化背景不合、即使有相反证据仍坚持的信念。常见主题有被害、关系、被控制、夸大、嫉妒；靠讲道理无法纠正。
8. **思维形式障碍**：指思维的连贯性和逻辑性出问题，表现为说话跳跃、答非所问、话题脱轨、用词奇特，旁人听不懂。它和“想法内容错”（妄想）不同，是“思路本身乱了”。
9. **紧张症**：一组以精神运动异常为主的表现：木僵、缄默、拒食、违拗、蜡样屈曲、刻板动作，也可出现兴奋。它有脱水、血栓、衰竭等致命风险，需急诊精神科评估。
10. **前驱期**：指典型精神病性症状出现前的一段时期，可能有注意力下降、多疑、社交退缩、成绩下滑、说话变怪。这些变化不特异，容易被当成“青春期”或“压力大”。
11. **急性期**：症状最重、功能明显受损的阶段，治疗目标是尽快控制症状、保证安全。这个阶段常需要调整药物，有时需要住院。
12. **巩固期**：急性症状缓解后的一段时期，目标是防止症状反弹、让功能逐步恢复。症状“看起来好了”就停药，最容易在这个阶段出问题。
13. **维持期**：症状稳定后长期用药与随访的阶段，目标是预防复发、恢复生活。维持多久因人而异，减停必须由医生计划。
14. **复发**：症状在缓解后再次出现或加重。复发常有前兆，比如睡眠变少、多疑、退缩、说话变怪，停药是常见诱因之一。
15. **自知力**：指患者对自己有病、症状异常、需要治疗的认识程度。自知力差本身是症状的一部分，不是“嘴硬”或“不领情”。

16. **首发精神病**：指第一次出现精神病性发作。这一阶段治疗反应通常较好，也是预防长期功能损害的关键窗口。

诊断与鉴别（17–20）

17. **分裂情感性障碍**：同时符合精神分裂症和心境障碍（抑郁或躁狂）的特征，且心境症状与精神病性症状在时间上交织。它和精神分裂症是两个不同的诊断。
18. **妄想障碍**：以持续妄想为主要表现，其他功能相对保留，幻觉不明显。起病常较晚，病程与精神分裂症不同。
19. **物质所致精神病性障碍**：由酒精、大麻、兴奋剂等物质使用直接引起的精神病性症状。停用后症状可能消退，但仍需专业评估与随访。
20. **器质性精神病性障碍**：由脑部疾病、感染、内分泌或代谢问题、药物等躯体因素引起的精神病性症状。这类情况要先查躯体原因。

二、评估、结局与依从（21–30）

21. **缓解**：指核心症状明显减轻到很低的水平并维持一段时间。缓解不等于痊愈，也不等于可以停药。
22. **康复**：指在症状可能长期存在的情况下，恢复生活角色、关系、工作与意义感。康复的目标不是“回到病前”，而是找到能过下去的生活。
23. **难治性精神分裂症**：通常指经过两种或以上抗精神病药、足量足疗程治疗后效果仍不理想。这类情况需要重新评估诊断、依从性与共病，氯氮平常被考虑。
24. **依从性**：指按医嘱服药、复诊的程度。依从性差很少是“不听话”，更多与副作用、自知力、方案复杂、经济压力和病耻感有关。
25. PANSS：阳性与阴性症状量表，共 30 个条目，评估阳性症状、阴性症状和一般精神病理。多用于研究，临床上也用来追踪变化。
26. BPRS：简明精神病评定量表，条目较少，覆盖幻觉、妄想、焦虑、抑郁等。适合快速评估总体严重度。
27. SAPS：阳性症状评估量表，专门评幻觉、妄想、思维紊乱等阳性表现，常用于研究。
28. SANS：阴性症状评估量表，评情感平淡、意志缺乏、快感缺失等。它有助于区分阴性症状，但不能替代临床判断。
29. PSP：个人与社会功能量表，评自我照料、工作学习、社会关系、攻击行为等。分数越低，功能损害越重。
30. **危机预案**：事先写好的应对计划：出现哪些信号要联系谁、去哪家医院、谁陪同、怎么去。写下来的计划比临场决定可靠。

三、药物与副作用（31–42）

31. **抗精神病药**：治疗精神病性症状的主要药物，主要通过阻断多巴胺 D2 受体起效。它对阳性症状效果较明确，对阴性症状和认知损害作用有限。
32. **第一代抗精神病药**：如氯丙嗪、氟哌啶醇、舒必利等，主要阻断 D2 受体。锥体外系反应和迟发性运动障碍风险较高，但对阳性症状有效，价格较低。
33. **第二代抗精神病药**：如利培酮、奥氮平、喹硫平、阿立哌唑等，除 D2 外还作用于 5-HT2A 等受体。锥体外系反应相对少，但体重增加、血糖血脂异常、催乳素升高等风险更突出。
34. **锥体外系反应（EPS）**：药物影响运动系统引起的一组反应：急性肌张力障碍（脖子歪、眼睛上翻）、静坐不能、类帕金森表现（手抖、僵硬、动作慢）。多数可以处理，但要及时报告医生。
35. **迟发性运动障碍（TD）**：长期用药后出现的口面部不自主运动，如咂嘴、伸舌、咀嚼，也可累及四肢和躯干。它可能持续较久，早发现早处理很重要。
36. **恶性综合征（NMS）**：一种少见但可能致命的药物不良反应：高热、肌肉僵硬、意识改变、自主神经不稳定。处理原则是立即停药并急诊，不能在家观察。
37. **代谢综合征**：体重增加、腹型肥胖、血糖升高、血脂异常、血压升高的组合。部分抗精神病药会加重这些风险，需要定期监测。
38. **高催乳素血症**：催乳素升高，可表现为月经紊乱、溢乳、性欲下降、男性乳房发育、骨密度下降。多与药物阻断 D2 受体有关。
39. **QT 间期延长**：心电图上反映心室复极时间的指标延长，可能增加严重心律失常的风险。部分抗精神病药有影响，高危人群需要查心电图。
40. **氯氮平**：主要用于难治性精神分裂症的药物，疗效证据较强，但需要定期查血常规。发热、咽痛、口腔溃疡要立即查血，不能等下次复诊。
41. **粒细胞缺乏**：白细胞中的中性粒细胞严重减少，会使感染风险骤升。它是氯氮平最需要警惕的副作用，靠定期血常规发现。
42. **长效针剂（LAI）**：把药物做成肌肉注射的长效制剂，通常每两到四周注射一次。适合反复漏服、胃肠吸收不稳定的人，但不能替代评估与随访。

四、心理社会干预与康复（43–52）

43. **CBTp**：针对精神病性症状的认知行为治疗，帮助患者理解症状、检验信念、减少痛苦与回避。它不“消除”妄想，也不能替代药物。
44. **心理教育**：向患者和家属讲清疾病、治疗、副作用和复发信号。它看起来简单，却能提高依从性、减少复发。
45. **家庭干预**：以家庭为单位的结构化干预，包含信息、沟通训练、问题解决和目标设定。它不责怪家庭，而是把家庭变成支持系统。

46. **高情感表达（EE）**：指家属的批评多、敌意明显、过度卷入。它与更高的复发风险相关，是家庭干预的重点之一。
47. **社交技能训练**：通过示范、角色扮演、反馈，练习眼神、倾听、表达需求、拒绝和冲突处理。多为团体形式，也有一对一。
48. **认知矫正**：通过重复练习改善注意、记忆、执行功能等认知能力。对认知损害有一定帮助，但对日常功能的改善程度因人而异。
49. **支持性就业**：先把人安置到竞争性岗位，再由就业专员长期提供支持，不要求“先训练好再上班”。它是目前证据较强的职业康复模式。
50. **同伴支持**：由有类似经历的人提供陪伴、经验分享和希望。它不能替代专业治疗，但能减少孤立感。
51. **个案管理**：由一名个案管理员协调医疗、住房、就业、福利等资源，避免患者在各个环节之间被漏掉。适合需求复杂、容易脱访的人。
52. **主动性社区治疗（ACT）**：由多学科团队提供高频率、上门式的社区服务，适合反复住院、难以维持随访的人。它比常规门诊更密集。

五、社会、法律与污名（53–60）

53. **病耻感**：社会对某种疾病或人群的负面标签，以及由此带来的歧视与回避。它可以来自公众、制度，也可以被患者内化。
54. **内化污名**：患者把社会的负面看法变成对自己的评价，如“我是废人”“我不配”。它不是性格软弱，而是社会环境被搬进了心里。
55. **连带污名**：与患者关系密切的家属、朋友也受到歧视或回避。它让家庭倾向于隐瞒，也加重照护负担。
56. **监护**：为不能完全处理自己事务的人设立的法定安排，由监护人代为处理部分人身与财产事务。设立条件与权限以现行法律为准。
57. **非自愿住院**：在特定法定条件下，不经本人同意实施住院治疗。我国精神卫生法以自愿为原则，非自愿需符合法定情形与程序，以现行法律和当地政策为准。
58. **合理便利**：为消除障碍，在工作或学习环境做的调整，如弹性工时、安静工位、考试延时。它不是“特殊照顾”，而是让人能平等参与。
59. **精神残疾评定**：按国家残疾标准对精神障碍所致功能损害进行评定，结果与康复服务、福利和就业支持相关。具体流程以当地残联规定为准。
60. **社区精神卫生服务**：由社区卫生服务中心、精防医生等提供的随访、用药管理、康复与转介服务。它是长期治疗真正落地的环节。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- American Psychiatric Association. DSM-5-TR, 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

B 参考文献与指南版本

这一页列出本资料库主要依据的指南、诊断标准、机构科普与法律文本，说明每条用来支撑什么、发布或更新于哪一年、在本资料库里算什么证据分量。它也交代版本记录、怎么判断一条信息已经过时，以及免责声明。适合想核对出处、或想知道“这句话到底有多硬”的读者。

这份清单怎么用

三点说明：

- 本清单只列**真实存在、可以核对**的来源，不列自媒体、带货文和无出处的“国外最新研究”。
- 年份是发布或主要更新年份。指南会再更新，引用前请以官网当前版本为准。
- “本库级别”是本资料库为了排序方便自定的分级，**不是** NICE 或中国指南本身使用的分级方法。

> **什么时候不要查资料，直接联系医生**
>
> - 出现自杀念头、自伤行为，或说“我消失了对大家都好”
> - 命令性幻听，或明确威胁要伤害他人
> - 木僵、缄默、拒食、违拗（可能是紧张症）
> - 高热、肌肉僵硬、意识改变（可能是恶性综合征）
> - 服氯氮平后发热、咽痛、口腔溃疡（需立即查血常规）
> - 噎食、呼吸困难、抽搐、胸痛、晕厥
>
> 立即拨打 120（必要时 110）或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。查资料不能替代这些动作。

主要来源清单

临床指南

来源	年份	主要用途	本库级别
NICE CG178《成人精神病与精神分裂症的预防与管理》	2014（2020 更新）	成人治疗全程、家庭干预、心理社会干预、药物原则	A
NICE CG155《儿童与青少年精神病和精神分裂症的识别与管理》	2013	青少年起病、家庭与学校、用药监测原则	A
NICE NG181《复杂精神病成人的康复》	2020	康复服务、住宿支持、就业支持、服务衔接	A
NICE NG10《精神卫生、医疗与社区环境中暴力与攻击的短期管理》	2015	激越与攻击的现场处理、约束隔离的使用原则	A
《中国精神分裂症防治指南（第二版）》（赵靖平、施慎逊主编）	2015	本土诊疗常规、药物选择、康复与社区管理	A
APA《精神分裂症治疗实践指	2020	评估流程、药物策略、共病	A

来源	年份	主要用途	本库级别
南》第 3 版		处理	

诊断标准、机构资料与法律文本

来源	年份	主要用途	本库级别
APA《DSM-5-TR》	2022	诊断标准与病程标注	A（诊断标准）
WHO《ICD-11 临床描述与诊断指南》	ICD-11 于 2022 年生效	国际诊断分类，与 DSM 对照	A（诊断标准）
WHO 精神分裂症事实清单	网页版，持续更新	全球疾病负担、预后概述、去污名表述	C
NIMH 精神分裂症专题页	网页版，持续更新	面向公众的症状、治疗与研究概述	C
《中华人民共和国精神卫生法》	2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行	自愿原则、非自愿住院条件、隐私与权益	法律依据
中国严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）	2018	社区随访、登记管理、危机处置衔接	B
国家卫生健康委 12356 心理援助热线	2025 年起全国推行	心理支持与危机转介；地方热线以当地卫健委公布为准	服务信息

需要提醒的有两点。第一，**指南之间会有差异**：NICE 更强调成本效果与服务组织，中国指南更贴近本土药物可及性和社区体系，APA 指南在药物策略上更细。差异不等于谁错，遇到冲突时以面诊医生的个体化判断和最新版本为准。

第二，**法律与政策会变**。本页关于精神卫生法、监护、残疾评定、医保的表述只讲原则，不构成法律意见；具体条文、认定标准和办理流程，以现行法律和当地政策为准。

还有一点：清单里没列出的，不代表不存在。系统综述、卫生技术评估报告、药品说明书、地方精神卫生服务规范，都是可以查的来源；本清单只保留最常用、最容易核对的几类。引用时最好写清“哪一版、哪一年、用在哪一句”，而不是笼统地说“指南认为”。

证据等级怎么读

本资料库不用一套复杂的评级系统，只用四档，目的是让你一眼看出“这句话能拿来干什么”。

级别	大致含义	你可以怎么用	典型例子
A	有明确指南推荐或诊断标准支持	可以当作和医生讨论的依据	“家庭干预能降低复发风险”
B	国家工作规范或专业共识	可以了解流程与常规做法	社区随访频次、登记管理
C	权威机构面向公众的科普	用来理解概念，不用于决定治疗方案	疾病概况、症状概述
法律依据	法律文本本身	用来说明权利与程序，个案需专业咨询	自愿住院原则

除了来源级别，正文里还会出现五个标签：**【指南】**、**【研究】**、**【临床经验】**、**【待验证】**、**【个人体验】**。它们和上表不是一回事：上表看的是“这条信息来自哪里”，标签看的是“这条信息有多硬”。一条【研究】级别的内容，可能比某份旧指南的表述更新；一条【临床经验】也不是没用，只是不能当成普遍规律。

读的时候可以记住三句话：

- **A 级不等于对每个人都适用。** 指南给的是群体层面的建议，落到个人要结合年龄、体重、肝肾功能、共病、既往反应。
- **标签越弱，越需要个体化。** 【待验证】的内容适合保持开放，不适合据此改药。
- **来源新不等于结论对，来源老也不等于过时。** 关键是看有没有被更新版本替代。

还有一个常见误读：把“证据等级”当成“推荐强度”。同一份指南里，证据等级高但推荐强度弱的情况并不少见——某项干预确实有效，但成本太高、可及性差，指南可能只写“可以考虑”。反过来，某些强推荐背后未必有大规模试验，而是基于临床必要性和伦理考量。所以看到“A 级”时，正确的理解是“这条信息可靠”，而不是“这件事必须做”。

看到“某指南推荐”这句话时，先问三件事：哪一版、哪一年、针对哪一群人。缺了这三项，这句话基本无法核对。

版本记录与过时判断

版本	日期	主要变更	下次复核
V1.0	2026-10	建立 13 个模块、64 篇正文；统一体例、证据标签与安全声明	2027-10

判断一条信息是否过时，可以按下面的清单逐项看：

- ☐ 指南官网是否标注了更新版本或“已被替代”
- ☐ 药物说明书是否有新的警告、禁忌或监测要求
- ☐ 法律是否修订，地方政策是否调整（医保、残疾评定、社区管理）
- ☐ 页面自身是否标注了日期，日期是否超过三年
- ☐ 是否给出了原始出处，能否点开核对
- ☐ 是否与当前面诊医生的说法明显冲突
- ☐ 是否只有结论、没有条件和适用范围

前六项里只要有一项对不上，就值得先标注“待核”，再决定要不要照用。**不要把未核实的改动直接扩散到多个篇目。**

免责声明

本资料库仅用于科普学习，**不能替代精神科医生面诊、诊断与处方**。不可依据它判断病情、自行选药、增减或停用药物。文中涉及的药物剂量、疗程、监测频次，均需由医生结合个体情况决定。

文中案例均为合并、改写后的示意，不对应任何真实个人。诊断与用药记录属于敏感信息，分享前请想清楚范围。

指南、药物信息与法律政策都会更新。若发现本资料库与医生说法或最新指南不一致，**以面诊医生的个体化判断和最新版本为准**，并把差异告诉医生。发现错误时，请先在对应篇目标注“待核”，再集中修订。

参考来源

- NICE. Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management (CG178), 2014（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
- 赵靖平, 施慎逊 主编.《中国精神分裂症防治指南（第二版）》. 2015.
- WHO. Schizophrenia fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。